Optimal Untuk Negeri

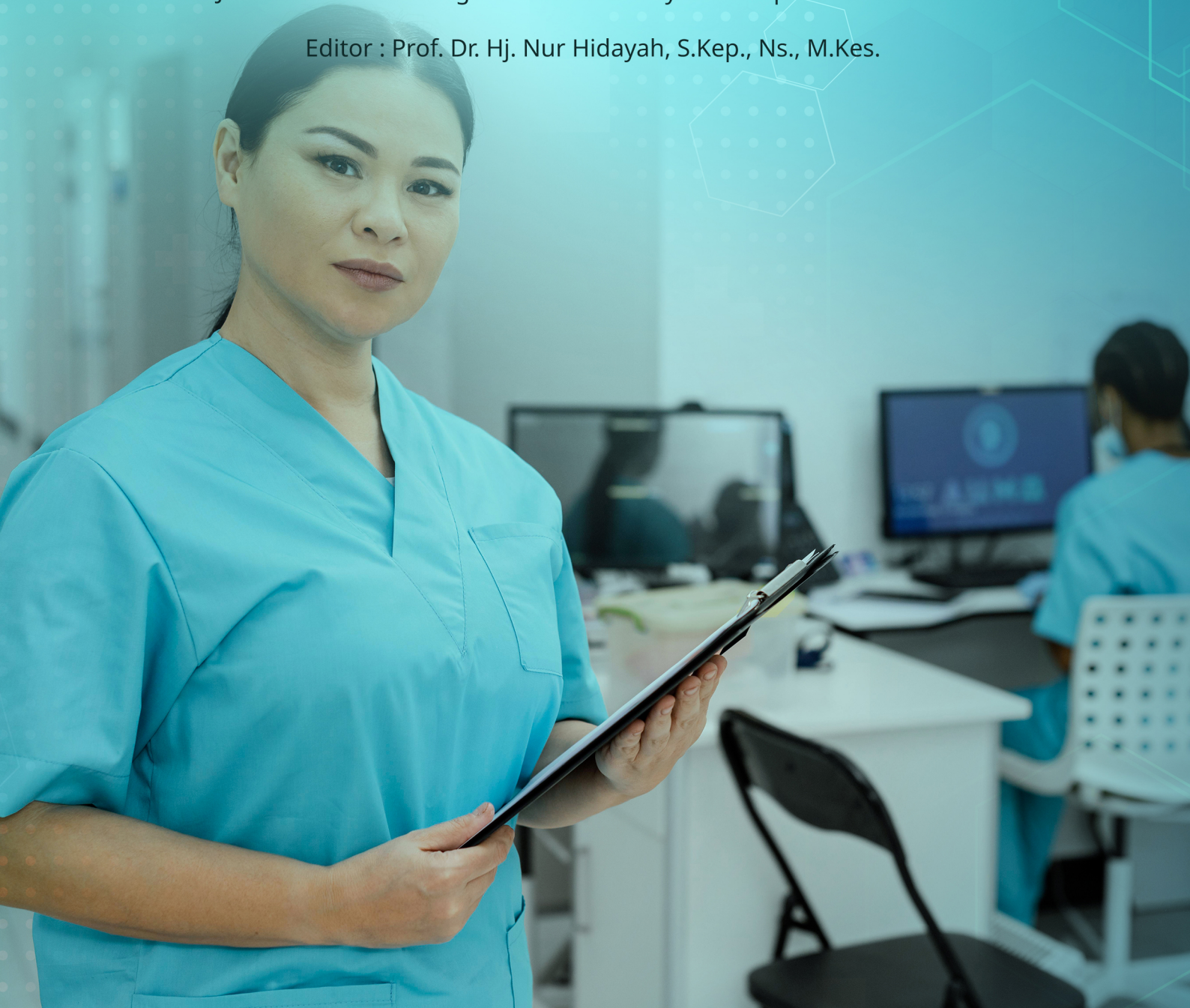
optimal

Buku Ajar

MANAJEMEN KEPERAWATAN

Aemilianus Mau • Muhammad Saefulloh • Devanda Faiqh Albyn
Junita Maratur Silitonga • Revi Yulia • Syaiful SKep • Endra Amalia

Editor : Prof. Dr. Hj. Nur Hidayah, S.Kep., Ns., M.Kes.



Buku Ajar :

Manajemen Keperawatan

Penulis:
Dr. Aemilianus Mau., S.Kep., Ns., M.Kep.
Muhammad Saefulloh, S.Kep., Ners., M.Kep.
Ns. Devanda Faiqh Albyn,M.Kep.,M.M(c).
Ns.Junita Maratur Silitonga,M.Kep.
Ns. Revi Yulia., M. Kep.
Syaiful SKep. Ns, MPd. MKes.
Ns. Endra Amalia, M. Kep.

Editor :
Prof. Dr. Hj. Nur Hidayah, S.Kep., Ns., M.Kes.

Optimal
Untuk
Negeri

Buku Ajar:
Manajemen Keperawatan

Penulis:
Dr. Aemilianus Mau., S.Kep., Ns., M.Kep.
Muhammad Saefulloh, S.Kep., Ners., M.Kep.
Ns. Devanda Faiqh Albyn,M.Kep.,M.M(c).
Ns.Junita Maratur Silitonga,M.Kep.
Ns. Revi Yulia., M. Kep.
Syaiful SKep. Ns, MPd. MKes.
Ns. Endra Amalia, M. Kep.

Editor : Prof. Dr. Hj. Nur Hidayah, S.Kep., Ns., M.Kes.

Desain Sampul: Ivan Zumarano
Penata Letak: Khoirul Anam

ISBN: 978-634-7756-74-9

Cetakan Pertama: Juli, 2026
Hak Cipta 2026
Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
Copyright © 2026
by Penerbit PT Optimal Untuk Negeri
All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.
Website : optimaluntuknegeri.com
Instagram : @bimbel.optimal
Tiktok : @maskokooo

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI
Kencana Tower Lt. Mezzanine
Jl. Raya Meruya Ilir No. 88
RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta
Anggota IKAPI No. 635/DKI/2025

Kata Pengantar

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, buku ajar berjudul Manajemen Keperawatan ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Buku ini disusun sebagai salah satu sumber pembelajaran bagi mahasiswa keperawatan, dosen, praktisi keperawatan, serta pihak-pihak yang memiliki perhatian terhadap pengelolaan pelayanan keperawatan yang bermutu, aman, efektif, dan berorientasi pada keselamatan pasien.

Manajemen keperawatan merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Perawat tidak hanya dituntut memiliki kemampuan klinis, tetapi juga perlu memahami prinsip-prinsip manajerial dalam mengelola mutu pelayanan, keselamatan pasien, sumber daya, dokumentasi, risiko klinis, serta standar pelayanan. Oleh karena itu, buku ajar ini diharapkan dapat membantu pembaca memahami konsep, prinsip, dan penerapan manajemen keperawatan dalam berbagai tatanan pelayanan kesehatan.

Materi dalam buku ini disusun secara sistematis ke dalam tujuh bab. Bab 1 membahas manajemen mutu pelayanan keperawatan sebagai dasar dalam peningkatan kualitas layanan. Bab 2 menguraikan keselamatan pasien dan manajemen risiko klinis yang menjadi aspek penting dalam pencegahan kejadian tidak diharapkan. Bab 3 membahas pengendalian infeksi dan keselamatan serta kesehatan kerja di pelayanan keperawatan. Bab 4 mengkaji manajemen sumber daya dan logistik keperawatan sebagai bagian dari efektivitas pelayanan. Bab 5 menjelaskan manajemen dokumentasi, informatika, dan rekam medis dalam mendukung kesinambungan asuhan keperawatan. Bab 6 membahas akreditasi fasilitas kesehatan dan standar keperawatan sebagai upaya pemenuhan mutu layanan. Bab 7 menyajikan studi kasus manajerial dan proyek mini peningkatan mutu sebagai bentuk penerapan konsep dalam situasi nyata.

Buku ajar ini disusun dengan memperhatikan kebutuhan pembelajaran, penguatan pemahaman konsep, serta keterkaitan antara teori dan praktik di lapangan. Melalui penyajian materi yang terstruktur, buku ini diharapkan dapat mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis, analitis, dan aplikatif dalam menghadapi berbagai permasalahan manajerial di bidang keperawatan. Selain itu, buku ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi tenaga keperawatan dalam meningkatkan profesionalisme dan mutu pelayanan.

Penulis menyadari bahwa buku ajar ini masih memiliki keterbatasan, baik dari segi isi, penyajian, maupun kedalaman pembahasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan buku ini pada edisi berikutnya.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan motivasi dalam proses penyusunan buku ajar ini.

Akhir kata, semoga buku ajar Manajemen Keperawatan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, khususnya dalam memahami dan mengembangkan manajemen keperawatan yang profesional, bermutu, beretika, dan berorientasi pada keselamatan pasien.

Penulis

Daftar Isi

Kata Pengantar ..... **iii**
Daftar Isi ..... **v**

BAB 1 MANAJEMEN MUTU PELAYANAN KEPERAWATAN **1**
A. Pendahuluan 5
B. Urgensi Peningkatan Mutu dalam Sistem Pelayanan Kesehatan di Indonesia 5
C. Kesenjangan Mutu dan Tantangan Sistem Kesehatan Nasional 6
D. Tujuan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan 6
E. Prinsip-Prinsip Peningkatan Mutu (Quality Improvement) 7
F. Peningkatan Mutu melalui Regulasi dan Akreditasi 9
G. Indikator Utama Pengukuran Mutu Rumah Sakit di Indonesia 10
H. Makna Strategis Indikator Mutu dan Hubungannya dengan JKN 10
I. Program Kendali Mutu dan Kendali Biaya (KMKB) 11
J. Peran Perawat dalam Sistem Pengukuran Mutu 11
K. Indikator Klinis serta Alat dan Keterampilan Peningkatan Proses 12
L. Langkah Umum dalam Peningkatan Mutu 12
M. Keselamatan pasien 21
N. Never events 24
O. Perawat profesional dan keselamatan pasien 25
P. Kerja Tim Interprofesional 27
Q. Peran Perawat Profesional dalam Peningkatan Kualitas 28
R. Ringkasan 28
Referensi **31**

BAB 2. KESELAMATAN PASIEN DAN MANAJEMEN RISIKO KLINIS **33**
A. Pendahuluan 36
B. Keselamatan Pasien 37
C. Manajemen Resiko Klinis Keselamatan Pasien 50
D. Kesimpulan 56
Glossarium **57**
Referensi **65**

BAB 3 PENGENDALIAN INFEKSI DAN K3 DI PELAYANAN KEPERAWATAN 68
A. Pendahuluan 71
B. RINGKASAN 104
Referensi 110

BAB 4 MANAJEMEN SUMBER DAYA DAN LOGISTIK KEPERAWATAN 117
A. Konsep Manajemen Sumber Daya 120
B. Mengidentifikasi Jenis Logistik Keperawatan 123
C. Karakteristik Logistik 124
D. KESIMPULAN 126
Referensi 129

BAB 5 MANAJEMEN DOKUMENTASI, INFORMATIKA,DAN REKAM MEDIS 132
A. MANAJEMEN DOKUMENTASI 135
B. INFORMATIKA 136
C. REKAM MEDIS 136
D. Aspek Hukum Rekam Medis 137
E. Hubungan Manajemen Dokumentasi, Informatika, dan Rekam Medis 137
F. RINGKASAN 153
Referensi 157

BAB 6 AKREDITASI FASILITAS KESEHATAN DAN STANDAR KEPERAWATAN .. 158
A. Pendahuluan 161
B. Konsep Akreditasi Fasilitas Kesehatan 162
C. Tujuan Akreditasi Fasilitas Kesehatan 163
D. Prinsip Dasar Akreditasi Pelayanan Kesehatan 163
E. Standar Akreditasi Rumah Sakit 163
F. Standar Keperawatan dalam Pelayanan Kesehatan 164
G. Peran Perawat dalam Mendukung Akreditasi 164
H. Tantangan Implementasi Standar Keperawatan dalam Akreditasi 165
I. DESAIN ASESMEN BERDASARKAN PIRAMIDA MILLER 173
J. Ringkasan 179
Glosarium 180
Referensi 181

BAB 7 STUDI KASUS MANAJERIAL DAN PROYEK MINI PENINGKATAN MUTU 183
A. Konsep Dasar Studi Kasus Manajerial 187
B. Konsep Dasar Proyek Mini Peningkatan Mutu 189
C. Data Layanan Kesehatan sebagai Dasar Analisis 190
D. Analisis Masalah Manajerial (S7.1) 193
E. Pengambilan Keputusan Manajerial Berbasis Eviden 195
F. Perumusan Alternatif Solusi 197
G. Proyek Mini Peningkatan Mutu (S7.2) 199
H. Metode Peningkatan Mutu: PDSA Cycle 201
I. Evaluasi dan Monitoring Mutu 202
J. Integrasi Patient Safety dan Manajemen Risiko 204
K. Implementasi dalam Praktik dan Pendidikan 205
L. Ringkasan 211
Referensi 213

Profil Penulis 216

BAB 1

MANAJEMEN MUTU PELAYANAN KEPERAWATAN

A. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menguasai konsep dasar manajemen keperawatan, peran perawat manajer, serta etika–legal dalam pengelolaan pelayanan.	CPMK-1; CPMK-2
CPL-2	Mampu menganalisis organisasi pelayanan keperawatan dan sistem layanan kesehatan untuk mendukung tata kelola dan kesinambungan layanan.	CPMK-2; CPMK-7
CPL-3	Mampu menerapkan kepemimpinan keperawatan, komunikasi efektif, kolaborasi, dan manajemen konflik serta perubahan dalam tim.	CPMK-3; CPMK-5
CPL-4	Mampu merencanakan dan mengelola SDM keperawatan (kebutuhan, penjadwalan, delegasi, supervisi) secara adil, aman, dan efisien.	CPMK-4; CPMK-5
CPL-5	Mampu menerapkan manajemen mutu, keselamatan pasien, manajemen risiko, PPI, dan K3 sebagai budaya kerja untuk peningkatan layanan.	CPMK-6; CPMK-7
CPL-6	Mampu memanfaatkan dokumentasi, informatika, standar–akreditasi, serta data kinerja untuk evaluasi, pelaporan, dan perbaikan mutu berkelanjutan.	CPMK-7; CPMK-2; CPMK-6

B. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menjelaskan konsep dasar manajemen keperawatan, fungsi manajemen, peran perawat manajer, serta etika–legal dalam pelayanan.
CPMK-2	Menganalisis organisasi pelayanan keperawatan dan sistem layanan kesehatan (tata kelola, standar, kebijakan) untuk mendukung pengambilan keputusan manajerial.
CPMK-3	Menerapkan kepemimpinan keperawatan, manajemen perubahan, komunikasi efektif, kolaborasi, dan manajemen konflik dalam pengelolaan tim.
CPMK-4	Merencanakan kebutuhan dan penjadwalan SDM keperawatan berdasarkan beban kerja, kompetensi, dan prinsip keadilan–keselamatan.
CPMK-5	Mengelola manajemen asuhan keperawatan melalui delegasi, supervisi, koordinasi, serta pemanfaatan sumber daya/logistik secara efisien.
CPMK-6	Menerapkan manajemen mutu, keselamatan pasien, manajemen risiko klinis, PPI, dan K3 dalam peningkatan kinerja pelayanan keperawatan.

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-7	Menggunakan dokumentasi, informatika, audit data, dan pelaporan untuk evaluasi kinerja serta menyusun proyek mini peningkatan mutu berbasis data.

C. Pemetaan

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 1. Manajemen Mutu Pelayanan Keperawatan	1.1 Menentukan indikator mutu keperawatan (struktur–proses–hasil) sesuai kebutuhan layanan.	1.2 Menyusun rencana perbaikan mutu berbasis analisis akar masalah dan target indikator.	CPMK-6	CPMK-7; CPMK-2

D. Asesmen (berbasis CPMK)

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-2	Tugas analisis organisasi & standar (paper ringkas)	Ketepatan pemetaan struktur/alur layanan dan ketepatan identifikasi gap terhadap standar (skor rubrik).	15	Dokumen analisis; matriks gap
CPMK-6	Simulasi fasilitasi/kemitraan (role play)	Kualitas fasilitasi partisipasi + kejelasan rencana kolaborasi/advokasi (skor rubrik).	15	Lembar penilaian; rencana kemitraan
CPMK-7	Portofolio laporan asuhan komunitas + refleksi	Kualitas evaluasi berbasis indikator (baseline–akhir) dan spesifikasi rencana perbaikan berkelanjutan.	15	Laporan akhir; jurnal refleksi

Rubrik CPMK-1

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
1.1 Ketepatan konsep fungsi manajemen (% benar)	<60% benar; miskonsepsi dominan	60–74% benar; miskonsepsi masih ada	75–89% benar; kesalahan minor	≥90% benar; konsisten
1.2 Ketepatan penerapan peran–akuntabilitas pada skenario	Keliru/tidak relevan	Relevan sebagian; alasan lemah	Tepat; alasan logis	Tepat; alasan kuat dan komprehensif

Rubrik CPMK-2

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
2.1 Ketepatan pemetaan struktur & alur layanan	Tidak akurat; komponen inti hilang	Cukup akurat; masih ada kekeliruan bermakna	Akurat; kekeliruan minor	Sangat akurat; komprehensif dan jelas
2.2 Ketepatan gap analysis & prioritas perbaikan	Gap tidak sesuai standar; prioritas acak	Gap sebagian tepat; prioritas kurang konsisten	Gap tepat; prioritas jelas	Gap sangat tepat; prioritas sangat logis & berbasis risiko

Rubrik CPMK-3

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
3.1 Kinerja kepemimpinan & manajemen perubahan (checklist)	≤60% perilaku tercapai; tidak terarah	61–75% tercapai; arah sebagian jelas	76–90% tercapai; terarah & konsisten	>90% tercapai; adaptif, memotivasi, terstruktur
3.2 Komunikasi efektif & resolusi konflik (checklist)	Konflik tidak tertangani; komunikasi tidak jelas	Ada upaya; solusi belum disepakati	Solusi disepakati; komunikasi runtut	Solusi kuat; komunikasi sangat efektif & menjaga hubungan kerja

Rubrik CPMK-4

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
4.1 Akurasi perhitungan kebutuhan tenaga	Banyak kesalahan; asumsi tidak jelas	Cukup tepat; masih ada kesalahan bermakna	Tepat; kesalahan minor	Sangat tepat; asumsi jelas & dapat dipertanggungjawabkan
4.2 Kualitas jadwal dinas (cakupan, aturan, pemerataan)	Cakupan tidak aman; melanggar aturan	Cakupan cukup; pemerataan kurang	Cakupan aman; aturan dipatuhi; cukup adil	Cakupan sangat aman; patuh aturan; sangat adil & minim risiko kelelahan

Rubrik CPMK-5

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
5.1 Ketepatan keputusan delegasi & rencana supervisi	Delegasi tidak sesuai kompetensi/risiko	Delegasi cukup sesuai; supervisi kurang spesifik	Delegasi sesuai; supervisi jelas	Delegasi sangat tepat; supervisi terukur & antisipatif risiko
5.2 Ketepatan rencana pengendalian logistik	Tidak berbasis kebutuhan; rawan kekosongan	Berbasis kebutuhan sebagian; kontrol kurang	Berbasis data; kontrol memadai	Berbasis data komprehensif; kontrol sangat efektif (minim stockout/overstock)

Rubrik CPMK-6

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
6.1 Ketepatan indikator & analisis temuan audit	Indikator tidak tepat; analisis tidak sesuai	Indikator cukup; analisis terbatas	Indikator tepat; analisis jelas	Indikator sangat tepat; analisis kritis berbasis data/tren
6.2 Kelayakan rencana mitigasi risiko/PPI/K3 (terukur)	Rencana umum; tidak terukur	Ada rencana; indikator belum jelas	Rencana spesifik; indikator terukur	Rencana sangat spesifik, terukur, realistis; prioritas berbasis risiko

Rubrik CPMK-7

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
7.1 Kelengkapan laporan berbasis data (baseline–target–hasil)	Data tidak lengkap; tidak dapat dievaluasi	Data cukup; hubungan baseline–hasil kurang jelas	Data lengkap; evaluasi jelas	Data sangat lengkap; evaluasi kuat dan transparan
7.2 Kualitas proyek mini peningkatan mutu (rencana–uji–evaluasi)	Tidak sistematis; tanpa evaluasi hasil	Sistematis sebagian; evaluasi terbatas	Sistematis; evaluasi hasil memadai	Sangat sistematis; evaluasi kuat; rekomendasi implementatif & berkelanjutan

A. Pendahuluan

Manajemen mutu dalam pelayanan keperawatan merupakan inti dari upaya rumah sakit untuk menjamin keselamatan pasien dan efektivitas asuhan. Fokus utama dari manajemen mutu adalah memastikan bahwa setiap tindakan keperawatan yang diberikan memenuhi standar profesional dan harapan pelanggan (pasien). Perawat memiliki peran sentral dalam proses ini, baik sebagai pemberi asuhan langsung maupun sebagai bagian dari sistem yang melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap kinerja pelayanan.

Bab ini akan mengulas urgensi peningkatan mutu di tengah tingginya risiko kesalahan medis dalam sistem kesehatan. Mahasiswa akan diajak untuk memahami definisi mutu dari berbagai perspektif, mengenali indikator-indikator klinis yang digunakan untuk mengukur kualitas layanan, serta mempelajari bagaimana proses kerja dapat dirancang ulang (*redesigned*) untuk meminimalkan risiko. Melalui pemahaman yang mendalam tentang akuntabilitas profesi, mahasiswa diharapkan mampu terlibat aktif dalam program Peningkatan Mutu (*Quality Improvement*) guna menciptakan sistem pelayanan yang lebih aman dan efisien

B. Urgensi Peningkatan Mutu dalam Sistem Pelayanan Kesehatan di Indonesia

Di Indonesia, kesadaran akan pentingnya mutu pelayanan kesehatan meningkat tajam seiring dengan implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan penguatan standar akreditasi rumah sakit. Meskipun data nasional mengenai kematian akibat kesalahan medis (*medical error*) tidak selalu terpublikasi seluas laporan IOM di Amerika Serikat, laporan dari Komite Nasional Keselamatan Pasien (KNKP) menunjukkan bahwa Insiden Keselamatan Pasien (IKP) masih menjadi tantangan besar. Berdasarkan data Kemenkes RI, ribuan insiden yang mencakup Kejadian Nyaris Cedera (KNC) hingga Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) dilaporkan setiap tahunnya, yang menegaskan bahwa risiko keselamatan pasien di Indonesia memerlukan penanganan serius (Kemenkes RI, 2022).

Beberapa faktor spesifik yang berkontribusi terhadap rendahnya mutu pelayanan di Indonesia antara lain:

1. Ketimpangan Distribusi Sumber Daya: Konsentrasi teknologi medis dan tenaga spesialis yang menumpuk di kota besar, sementara daerah terpencil kekurangan fasilitas dasar.
2. Variasi Standar Pelayanan: Belum meratanya kepatuhan terhadap Panduan Praktik Klinis (PPK) dan *Clinical Pathway* di berbagai fasyankes.

3. Beban Kerja dan Rasio Perawat: Beban kerja yang tinggi dan rasio perawat-pasien yang belum ideal di banyak rumah sakit daerah meningkatkan risiko terjadinya kelalaian dalam asuhan.

C. Kesenjangan Mutu dan Tantangan Sistem Kesehatan Nasional

Sejalan dengan visi global, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menjembatani kesenjangan mutu (*quality chasm*). Pemerintah melalui Rencana Strategis Kementerian Kesehatan dan UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023 telah menekankan transformasi kesehatan yang fokus pada mutu dan keselamatan pasien.

Namun, kesenjangan mutu di Indonesia masih terlihat jelas melalui beberapa fenomena berikut:

1. Kompleksitas Transformasi Kesehatan: Perubahan sistem dari manual ke digital (SatuSehat) yang belum merata di seluruh wilayah, menyebabkan fragmentasi data kesehatan pasien.
2. Sistem Koordinasi dan Rujukan: Belum optimalnya sistem rujukan terintegrasi yang seringkali menyebabkan keterlambatan penanganan pada kasus gawat darurat.
3. Perubahan Pola Penyakit: Meningkatnya beban Penyakit Tidak Menular (PTM) yang memerlukan manajemen asuhan jangka panjang dan terkoordinasi, sementara sistem masih dominan pada layanan kuratif jangka pendek.

Meskipun akreditasi rumah sakit (KARS/Lembaga Akreditasi lainnya) telah diwajibkan, beberapa indikator menunjukkan tantangan yang masih ada:

1. Kepatuhan Identifikasi Pasien: Studi di beberapa RSUD menunjukkan bahwa kepatuhan perawat dalam prosedur identifikasi dan komunikasi *handover* (SBAR) masih berfluktuasi, yang berpotensi menyebabkan kesalahan prosedur tindakan (Kemenkes RI, 2022).
2. Aksesibilitas vs Mutu: Fokus pada perluasan akses layanan (melalui BPJS Kesehatan) terkadang belum diimbangi dengan standar mutu yang seragam, sehingga muncul persepsi perbedaan kualitas layanan antara pasien umum dan pasien JKN.

D. Tujuan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan

Laporan *Quality Chasm* menetapkan enam tujuan utama peningkatan mutu, yang dikenal dengan akronim **STEEEP**, yaitu pelayanan kesehatan harus:

1. Safe (Aman): Mencegah cedera akibat pelayanan kesehatan
2. Timely (Tepat waktu): Mengurangi waktu tunggu dan keterlambatan

3. Effective (Efektif): Memberikan pelayanan berbasis bukti ilmiah
4. Efficient (Efisien): Menghindari pemborosan sumber daya
5. Equitable (Adil): Tidak membedakan kualitas pelayanan berdasarkan karakteristik individu
6. Patient-centered (Berpusat pada pasien): Menghargai nilai, kebutuhan, dan preferensi pasien

Sepuluh Aturan untuk Perbaikan Sistem Pelayanan Kesehatan

Untuk mendukung transformasi sistem kesehatan, IOM merumuskan 10 aturan utama yang harus menjadi pedoman, termasuk bagi perawat profesional:

1. Pelayanan berbasis hubungan penyembuhan berkelanjutan
   Pasien harus dapat menerima pelayanan kapan pun dibutuhkan melalui berbagai media.
2. Pelayanan disesuaikan dengan kebutuhan pasien
   Sistem harus responsif terhadap kebutuhan dan preferensi individu.
3. Pasien sebagai pusat kendali
   Pasien berhak menentukan tingkat keterlibatan dalam keputusan kesehatan.
4. Pengetahuan dibagikan secara terbuka
   Pasien memiliki akses penuh terhadap informasi kesehatan mereka.
5. Pengambilan keputusan berbasis bukti
   Pelayanan harus berdasarkan ilmu pengetahuan terbaik yang tersedia.
6. Keselamatan sebagai bagian dari system
   Sistem harus dirancang untuk mencegah dan mengurangi kesalahan.
7. Transparansi
   Informasi terkait mutu dan keselamatan harus tersedia bagi pasien dan keluarga.
8. Kebutuhan pasien diantisipasi
   Sistem harus proaktif, bukan hanya reaktif terhadap masalah.
9. Pemborosan diminimalkan secara berkelanjutan
   Sumber daya harus digunakan secara efisien.
10. Kolaborasi antar tenaga kesehatan menjadi prioritas
    Komunikasi dan kerja sama sangat penting untuk koordinasi pelayanan.

E. Prinsip-Prinsip Peningkatan Mutu (Quality Improvement)

Banyak istilah (*buzzwords*) digunakan untuk menggambarkan aktivitas yang berkaitan dengan peningkatan mutu (*quality improvement/QI*), seperti:

1. *Total Quality Management (TQM)*
2. *Continuous Quality Improvement (CQI)*
3. *Continuous Process Improvement*

4. *Statistical Process Control*
5. *Performance Improvement (PI)*

Namun, istilah-istilah tersebut tidak sepenting prinsip yang mendasarinya, yaitu: melakukan pengkajian dan perbaikan proses kerja dengan berfokus pada kebutuhan dan harapan pelanggan.

Secara umum, landasan utama QI terdiri dari tiga pilar, yaitu Mutu (Quality) , Pendekatan ilmiah (Scientific approach), dan Kerja tim terpadu ("All one team")

1. Mutu (Quality)

   Untuk memahami pentingnya mutu, perlu dilihat dari **perspektif pelanggan**. Mutu tidak hanya ditentukan oleh produk atau layanan yang diterima, tetapi juga oleh:

   a. Interaksi Personal Dengan Tenaga Kesehatan
   b. Pengalaman keseluruhan selama menerima pelayanan

   Pelayanan kesehatan sebenarnya merupakan **kombinasi (bundle)** antara produk dan layanan yang bertujuan memenuhi kebutuhan pasien. Jika pelayanan dan hasil yang diterima dianggap bernilai baik, maka akan tercipta kepuasan dan loyalitas pasien. Sebaliknya, seperti pada kasus vignette, pasien dapat memiliki persepsi negatif terhadap seluruh pengalaman perawatan akibat komplikasi yang sebenarnya dapat dicegah, seperti keterlambatan pulang karena infeksi.

2. Pendekatan Ilmiah (Scientific Approach)

   Pendekatan ilmiah menekankan bahwa keputusan dalam peningkatan mutu harus didasarkan pada data yang valid dan analisis yang tepat. Selain itu, tenaga kesehatan harus memahami konsep proses dan variasi dalam proses.

   a. Proses adalah rangkaian langkah yang saling terkait untuk menyelesaikan suatu pekerjaan
      (misalnya: dari penulisan resep hingga pemberian obat kepada pasien)
   b. Variasi proses (process variation) adalah perbedaan dalam pelaksanaan langkah-langkah tersebut atau faktor yang memengaruhinya

   Pemahaman terhadap variasi sangat penting untuk menentukan arah perbaikan.

   Jenis Variasi dalam Proses

   Terdapat dua jenis variasi dalam proses:

   a. Common Cause Variation (Variasi Penyebab Umum)
      1) Bersifat normal dan melekat dalam sistem
      2) Proses relatif stabil dan dapat diprediksi
      3) Perbaikan dilakukan dengan perubahan sistem secara keseluruhan
   b. Special Cause Variation (Variasi Penyebab Khusus)
      1) Bersifat spesifik dan tidak biasa
      2) Proses tidak stabil dan sulit diprediksi

3) Disebabkan oleh faktor tertentu yang dapat diidentifikasi

3. Satu Tim yang Terpadu (All One Team)

   Manajemen rumah sakit memberikan kepercayaan kepada tim yang menangani masalah infeksi kateter. Tim tersebut dianggap sebagai pihak yang paling memahami:

   a. Bagaimana proses perawatan pascaoperasi berlangsung
   b. Dimana terjadi kelemahan atau kegagalan dalam sistem

   Kepercayaan ini mendorong kolaborasi yang efektif dalam mengidentifikasi masalah dan merancang solusi perbaikan.

F. Peningkatan Mutu melalui Regulasi dan Akreditasi

Saat ini, hampir semua lembaga regulator dan badan akreditasi sukarela di bidang kesehatan mensyaratkan adanya peningkatan mutu (quality improvement/QI) dalam berbagai bentuk. *Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS)*, yang mengelola program Medicare di Amerika Serikat, menetapkan "conditions of participation" sebagai dasar mutu pelayanan. Selain itu, sebagian besar otoritas perizinan di tingkat negara bagian juga menetapkan standar QI yang wajib dipenuhi.

Salah satu organisasi yang memiliki fokus kuat terhadap standar mutu adalah *The Joint Commission (TJC)*, sebuah lembaga akreditasi sukarela di bidang pelayanan kesehatan, sebagaimana dijelaskan pada bagian berikut.

The Joint Commission

The Joint Commission (TJC) merupakan salah satu lembaga akreditasi pertama yang mengadopsi prinsip-prinsip QI sebagai persyaratan dalam akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan, khususnya rumah sakit. TJC memberikan akreditasi dan sertifikasi kepada lebih dari 21.000 organisasi dan program pelayanan kesehatan di Amerika Serikat, termasuk:

1. Rumah sakit
2. Fasilitas bedah rawat jalan
3. Layanan kesehatan jiwa
4. Layanan kesehatan di rumah (*home health care*)
5. Laboratorium
6. Pusat layanan keperawatan

Organisasi pelayanan kesehatan secara sukarela mengajukan akreditasi ke TJC untuk menunjukkan bahwa mereka telah memperoleh **"gold seal of approval"**, yaitu pengakuan bahwa organisasi tersebut telah memenuhi standar mutu dan keselamatan yang ditetapkan oleh TJC.

Standar TJC mencakup berbagai aspek penting, antara lain:

1. Keselamatan pasien
2. Hak pasien
3. Pelayanan atau terapi pasien
4. Pengendalian infeksi

Sistem akreditasi TJC tidak hanya menilai kemampuan organisasi dalam menyediakan pelayanan yang aman dan berkualitas tinggi, tetapi juga menuntut adanya bukti kinerja nyata dan komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan . Organisasi yang telah terakreditasi oleh TJC akan memperoleh status "deemed status", yaitu pengakuan otomatis telah memenuhi persyaratan dasar dari CMS.

G. Indikator Utama Pengukuran Mutu Rumah Sakit di Indonesia

Di Indonesia, penguatan mutu pelayanan kesehatan mengalami transformasi besar melalui Standar Akreditasi Rumah Sakit Kementerian Kesehatan (STARKES) yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan RI. Proses ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan memenuhi standar mutu dan keselamatan pasien yang seragam secara nasional.

Indikator Nasional Mutu (INM) Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) No. 30 Tahun 2022, setiap rumah sakit wajib melakukan pengukuran dan pelaporan Indikator Nasional Mutu (INM) yang dirancang untuk:

1. Memastikan Standarisasi Pelayanan: Memberikan kerangka kerja bagi rumah sakit dalam memberikan asuhan yang aman dan bermutu.
2. Transparansi Publik: Data INM dilaporkan secara periodik kepada Kementerian Kesehatan melalui aplikasi digital (SatuSehat atau aplikasi mutu Kemenkes).
3. Dasar Akreditasi: Capaian INM menjadi salah satu syarat mutlak dan pertimbangan utama bagi lembaga akreditasi (seperti KARS, LAM-KPRS, dll.) dalam menetapkan status akreditasi rumah sakit (Kemenkes RI, 2022).

H. Makna Strategis Indikator Mutu dan Hubungannya dengan JKN

Saat ini, pengukuran mutu di Indonesia tidak lagi hanya sekadar pemenuhan aspek administratif untuk akreditasi, tetapi memiliki dampak strategis pada keberlangsungan operasional rumah sakit, terutama dalam sistem jaminan kesehatan:

1. Kredensialing BPJS Kesehatan: Data mutu dan status akreditasi menjadi syarat utama bagi rumah sakit untuk bekerja sama (*contracting*) dengan BPJS Kesehatan.

2. Umpan Balik Pasien: Melalui aplikasi *Mobile JKN*, pasien dapat memberikan penilaian langsung terhadap layanan (KESSAN), yang kemudian digunakan sebagai salah satu parameter evaluasi kinerja rumah sakit.
3. Indikator Hasil Klinis: Fokus pergeseran dari sekadar jumlah kunjungan pasien menjadi kualitas hasil klinis, guna menekan angka komplikasi dan perawatan ulang (*readmission*) yang tidak perlu.

I. Program Kendali Mutu dan Kendali Biaya (KMKB)

Sebagai bagian dari implementasi Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), Indonesia menerapkan strategi yang serupa dengan *Value-Based Purchasing* melalui mekanisme Kendali Mutu dan Kendali Biaya:

1. Audit Medik dan Audit Klaim: BPJS Kesehatan bersama tim kendali mutu melakukan verifikasi bahwa pelayanan yang diberikan sesuai dengan panduan praktik klinis dan efisien secara biaya.
2. Sistem Pembayaran INA-CBGs: Perubahan sistem pembayaran dari berbasis tindakan individual (*fee-for-service*) menjadi berbasis paket kelompok diagnosis (prospektif). Hal ini mendorong rumah sakit untuk:
   a. Meningkatkan efisiensi proses internal.
   b. Menjaga mutu asuhan agar tidak terjadi pemborosan logistik medis.
   c. Mengoptimalkan *Clinical Pathway* untuk memastikan pasien sembuh sesuai dengan target waktu yang ditetapkan.
3. Sanksi dan Insentif: Rumah sakit yang tidak mampu menjaga standar mutu (misalnya kehilangan status akreditasi) secara otomatis akan terhenti kerja samanya dengan BPJS Kesehatan, yang berdampak pada hilangnya sumber pendapatan utama rumah sakit tersebut.

J. Peran Perawat dalam Sistem Pengukuran Mutu

Perawat memiliki peran yang sangat penting dalam sistem ini karena:

1. Terlibat langsung dalam manajemen asuhan pasien
2. Bekerja sama dengan tim interprofesional
3. Berperan dalam menginisiasi perubahan praktik
4. Memantau efektivitas pelayanan dan tindak lanjut pasien

Oleh karena itu, perawat perlu memahami dengan baik:

1. Indikator mutu nasional
2. Konsep *value-based purchasing*
3. Serta implementasinya dalam praktik klinik

K. Indikator Klinis serta Alat dan Keterampilan Peningkatan Proses

Landasan utama dalam proses pemantauan dan evaluasi yang disyaratkan oleh prinsip *quality improvement (QI)* adalah penggunaan **indikator klinis**, yaitu item yang dapat diukur untuk mencerminkan mutu pelayanan. Seperti halnya *National Hospital Inpatient Quality Measures*, indikator klinis merupakan aspek pelayanan klinis yang dapat diukur untuk menunjukkan sejauh mana pelayanan telah dilaksanakan sesuai standar. Indikator ini berfokus pada: tindakan klinis atau hasil (outcome) dari pelayanan klinis . Indikator tidak seharusnya berfokus pada prosedur yang hanya mendukung pelayanan klinis. Sebagai contoh:

1. Mengganti cairan infus pada troli merupakan prosedur pendukung
2. Memberikan cairan infus yang tepat dengan kecepatan yang sesuai resep merupakan tindakan klinis yang menjadi indikator mutu

Kedua hal tersebut dapat diukur, tetapi hanya yang kedua yang benar-benar merupakan indikator klinis.. Perlu dipahami bahwa indikator tidak secara langsung mendefinisikan mutu, tetapi berfungsi sebagai penunjuk untuk mengidentifikasi area yang memerlukan evaluasi dan perbaikan mutu.

Hubungan Indikator Klinis dengan Alat Peningkatan Proses

Indikator klinis membantu dalam mengidentifikasi tujuan peningkatan mutu, sementara itu, alat dan keterampilan peningkatan proses digunakan untuk: memahami proses kerja secara kuantitatif dan menganalisis dan memperbaiki proses tersebut Berbagai metode yang digunakan dalam peningkatan mutu di fasilitas pelayanan kesehatan meliputi:

1. Lean methodology
2. Lean Six Sigma
3. Failure Mode and Effects Analysis (FMEA)

Alat-alat seperti:

1. flowchart
2. Pareto chart
3. diagram sebab-akibat (fishbone)
4. run chart

digunakan dalam berbagai metode tersebut.

L. Langkah Umum dalam Peningkatan Mutu

Meskipun terdapat berbagai model peningkatan mutu, secara umum semua memiliki tahapan yang serupa, yaitu:

1. Menganalisis dan memahami proses secara jelas
2. Menentukan aspek penting dari proses yang perlu diperbaiki

3. Menetapkan target uji coba (*trial targets*) untuk perbaikan
4. Mengumpulkan dan memvisualisasikan data
5. Menginterpretasikan hasil
6. Mengimplementasikan tindakan perbaikan serta mengevaluasi efektivitasnya

Berbagai alat QI digunakan untuk mendukung setiap tahapan tersebut. Hasil analisis kemudian digunakan sebagai dasar dalam menentukan tindakan perbaikan yang tepat.

Monitoring Berkelanjutan

Setelah perbaikan dilakukan, diperlukan:

1. Pemantauan berkelanjutan
2. Evaluasi efektivitas perubahan

Hal ini penting untuk memastikan bahwa perbaikan yang dilakukan benar-benar memberikan dampak positif.

Implikasi bagi Perawat Profesional

Perawat profesional dituntut untuk:

1. Memahami berbagai model peningkatan mutu
2. Mampu menggunakan alat-alat qi dalam praktik
3. Berperan aktif dalam upaya peningkatan mutu pelayanan

Flowchart (Diagram Alir)

Analisis terhadap suatu proses kerja umumnya diawali dengan penyusunan flowchart (diagram alir) atau flow diagram. Alat ini sangat penting untuk:

1. Memetakan apa yang sebenarnya terjadi dalam suatu proses
2. Membandingkannya dengan apa yang seharusnya terjadi

Dengan demikian, flowchart membantu mengidentifikasi kesenjangan antara praktik aktual dan standar yang diharapkan.

Terdapat beberapa jenis flowchart yang masing-masing memiliki kegunaan tersendiri, antara lain:

1. Top-Down Flowchart

   Top-down flowchart menyajikan: langkah-langkah utama (*main steps*) serta sub-langkah (*substeps*) dalam suatu proses secara linier. Jenis flowchart ini digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai alur proses dari awal hingga akhir secara sederhana dan sistematis.

2. Deployment Flowchart

   Deployment flowchart menggambarkan: langkah-langkah dalam suatu proses berdasarkan pihak yang bertanggung jawab (misalnya tenaga kesehatan atau unit kerja tertentu). Flowchart ini sangat berguna untuk proses yang melibatkan banyak profesi atau unit dan meningkatkan pemahaman bersama tentang bagaimana proses berjalan secara keseluruhan

Contoh Penerapan

Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 10.1 dan 10.2, baik *top-down flowchart* maupun *deployment flowchart* dapat digunakan untuk memetakan proses: pemberian cairan intravena (IV) yang tepat dengan kecepatan yang sesuai

Makna dalam Peningkatan Mutu

Penggunaan flowchart memungkinkan tenaga kesehatan untuk:

a. Mengidentifikasi titik masalah dalam proses
b. Memahami hubungan antar langkah kerja
c. Merancang intervensi perbaikan yang lebih efektif

Kasus

Pemberian Obat Intravena (IV) Antibiotik pada Pasien Rawat Inap

3. Top-Down Flowchart



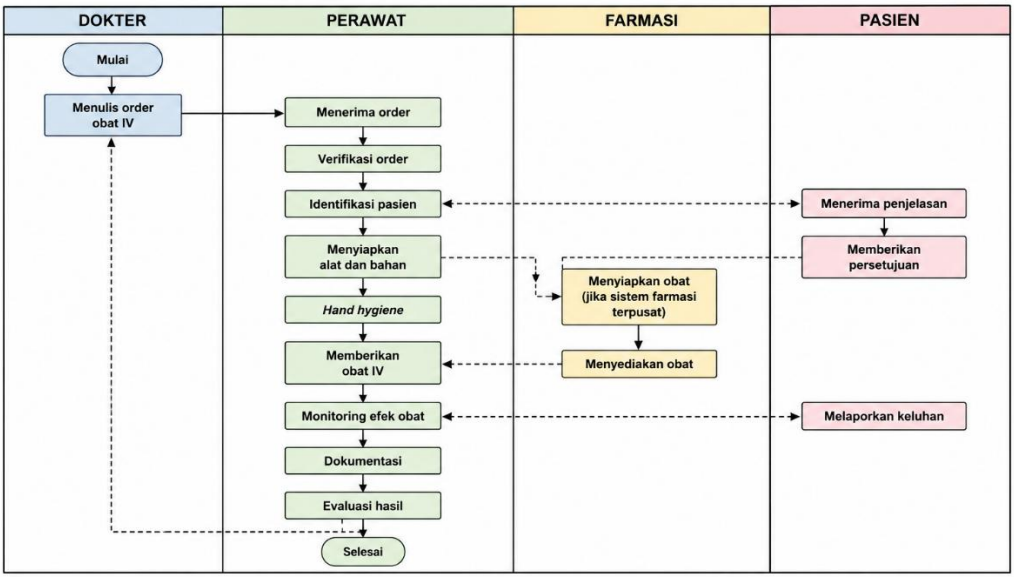
Gambar 1.1 Flowchart proses

Penjelasan

Flowchart ini:

- Menyederhanakan proses menjadi langkah utama
- Cocok untuk pemula/mahasiswa
- Fokus pada urutan tindakan keperawatan

4. Deployment Flowchart
   (Menunjukkan siapa melakukan apa dalam setiap langkah)



Gambar 1. 2 Flowchart Swimlane

Penjelasan

Flowchart ini:

- Menunjukkan kolaborasi interprofesional
- Mengidentifikasi potensi masalah (misalnya: keterlambatan farmasi)
- Sangat berguna untuk quality improvement (QI

Perbandingan kegunaan

Jenis Flowchart	**Kegunaan**
Top-Down	Memahami alur dasar proses
Deployment	Analisis kerja tim & identifikasi masalah sistem

Dari deployment flowchart, bisa ditemukan masalah seperti:

1) Keterlambatan obat dari farmasi
2) Kesalahan komunikasi antar profesi
3) Tidak adanya monitoring setelah pemberian

Ini bisa dikembangkan menjadi:

1) Root Cause Analysis (RCA)
2) Perbaikan SOP pemberian obat

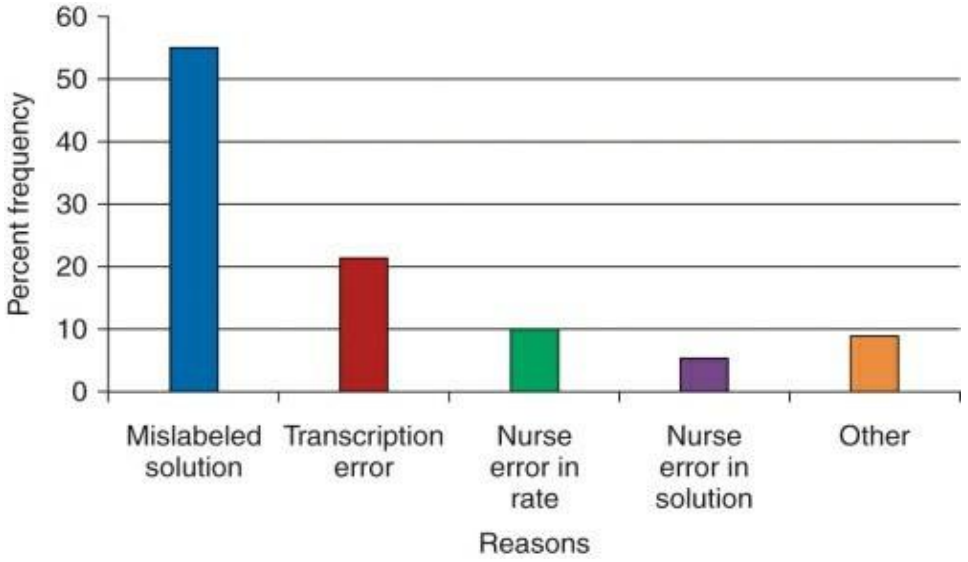
5. Pareto Chart (Diagram Pareto)

Untuk menentukan aspek-aspek utama yang perlu menjadi fokus dalam suatu proses, diagram Pareto merupakan alat yang sangat bermanfaat.

Pengumpulan data terkait masalah yang telah diketahui atau diperkirakan dalam suatu proses dapat membantu mengidentifikasi area prioritas perbaikan.

Diagram Pareto merupakan jenis diagram batang (bar chart), di mana tinggi batang menunjukkan frekuensi kejadian atau besarnya dampak masalah. Batang disusun dari yang paling tinggi ke paling rendah (urutan menurun) Dengan demikian, masalah yang paling sering terjadi atau paling berdampak akan terlihat dengan jelas.

Diagram ini didasarkan pada prinsip Pareto (80/20), yang menyatakan bahwa: sekitar 80% masalah dalam suatu proses atau sistem disebabkan oleh 20%



Gambar 1. 3 Diagram Pareto Koreksi Penyebab Kesalahan Pemberian Larutan Intravena

faktor penyebab utama. Oleh karena itu, dengan memfokuskan perbaikan pada sejumlah kecil penyebab utama, dapat diperoleh dampak perbaikan yang signifikan terhadap keseluruhan sistem.

Cause-and-Effect Diagram (Diagram Sebab-Akibat / Fishbone Diagram)

Diagram sebab-akibat merupakan alat penting lainnya yang digunakan untuk mengidentifikasi berbagai kemungkinan penyebab suatu masalah. Diagram ini menyajikan daftar penyebab potensial yang dikelompokkan dalam kategori tertentu untuk menunjukkan hubungan antara penyebab dan masalah yang terjadi . Kategori yang digunakan biasanya bersifat umum, kemudian dikembangkan menjadi rincian yang lebih spesifik untuk menjelaskan faktor-faktor yang mungkin menyebabkan masalah tersebut.

Diagram ini juga dikenal sebagai ***fishbone*** **diagram (diagram tulang ikan)** karena bentuknya menyerupai kerangka ikan.

Kegunaan dalam Peningkatan Mutu

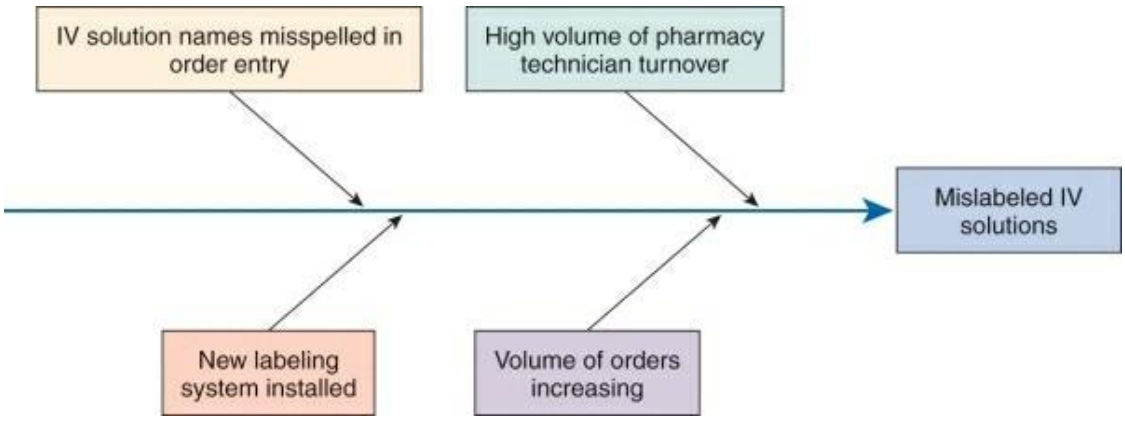
Diagram sebab-akibat sangat bermanfaat setelah area masalah utama telah diidentifikasi melalui diagram Pareto

Dengan kata lain:

1) **Pareto chart** → menentukan masalah prioritas
2) **Fishbone diagram** → menganalisis penyebab masalah tersebut

Contoh Aplikasi dalam Keperawatan

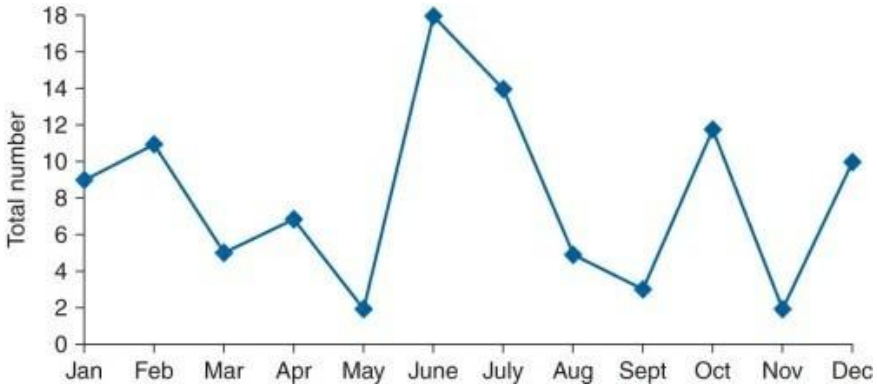
a. Pareto chart: Mengidentifikasi penyebab utama kesalahan pemberian cairan infus
b. Fishbone diagram: Menganalisis faktor penyebab, seperti:
   1) Faktor manusia (perawat)
   2) Metode/prosedur
   3) Alat/teknologi
   4) Lingkungan kerja



Gambar 1. 4 Diagram Sebab-Akibat dari Larutan Intravena yang Salah Label

Grafik Jalannya Proses

Mengukur data dari waktu ke waktu untuk mengevaluasi pola variasi proses biasanya cocok menggunakan alat seperti grafik jalannya proses (run chart) dan grafik kendali (control chart). Grafik jalannya proses, juga dikenal sebagai plot waktu, adalah grafik titik data saat mereka terjadi seiring waktu (Gbr. 22.5). Informasi yang berharga dapat diperoleh mengenai variasi proses melalui studi tren pada grafik jalannya proses. Grafik kendali adalah alat yang sedikit lebih canggih untuk membantu membedakan antara variasi sebab umum dan variasi sebab khusus. Grafik kendali pada dasarnya adalah grafik jalannya proses dengan batas kendali statistik yang ditambahkan.



Gambar 1. 5 Grafik Jalannya Proses Jumlah Larutan Intravena yang Salah Label

Memahami, meningkatkan, dan menstandarisasi proses perawatan

Proses yang distandarisasi, yang juga disebut sebagai "metode terbaik yang diketahui" atau "praktik terbaik," jika dikelola secara efektif, telah terbukti menjadi dasar untuk perbaikan di semua bidang bisnis saat ini, terutama dalam lingkungan perawatan klinis. Terdapat resistensi yang khas terhadap standarisasi praktik, terutama ketika melibatkan pemberian perawatan pasien, tetapi efek realistis dari perawatan tanpa standarisasi harus dipertimbangkan dalam konteks berikut seperti yang dijelaskan oleh Joiner (1994):

a. Sebagian besar karyawan menerima sedikit pelatihan tentang bagaimana melakukan pekerjaan mereka. Sebaliknya, mayoritas harus belajar dengan mengamati karyawan yang lebih berpengalaman.
b. Sebagian besar karyawan telah mengembangkan versi unik mereka sendiri dari prosedur umum yang mereka saksikan atau pelajari. Mereka berpikir, "Caraku adalah cara terbaik."
c. Perubahan pada prosedur terjadi secara sembarangan; individu terus-menerus mengubah detail untuk mengatasi masalah yang muncul atau dengan harapan menemukan metode yang lebih baik. Manipulasi terjadi secara luas.

Setiap pilar peningkatan kualitas dapat dengan mudah diterapkan pada situasi pemberi perawatan. Sekilas, dapat diasumsikan bahwa semua praktik perawatan didasarkan pada bukti ilmiah dan penelitian, dan meskipun banyak yang demikian, ada juga praktik lain yang ada hanya karena itulah cara praktisi tersebut awalnya dididik. Praktik-praktik yang berbasis penelitian, meskipun mewakili metode terbaik yang diketahui, mungkin tetap belum banyak diterapkan, sehingga menghasilkan kurangnya standarisasi.

Selama beberapa tahun terakhir, sejumlah metode telah digunakan di fasilitas kesehatan untuk mendukung standarisasi proses perawatan. Pedoman klinis, jalur kritis, dan protokol atau algoritma klinis adalah metode standarisasi yang lebih umum dan familiar. Meskipun istilah-istilah ini terkadang digunakan

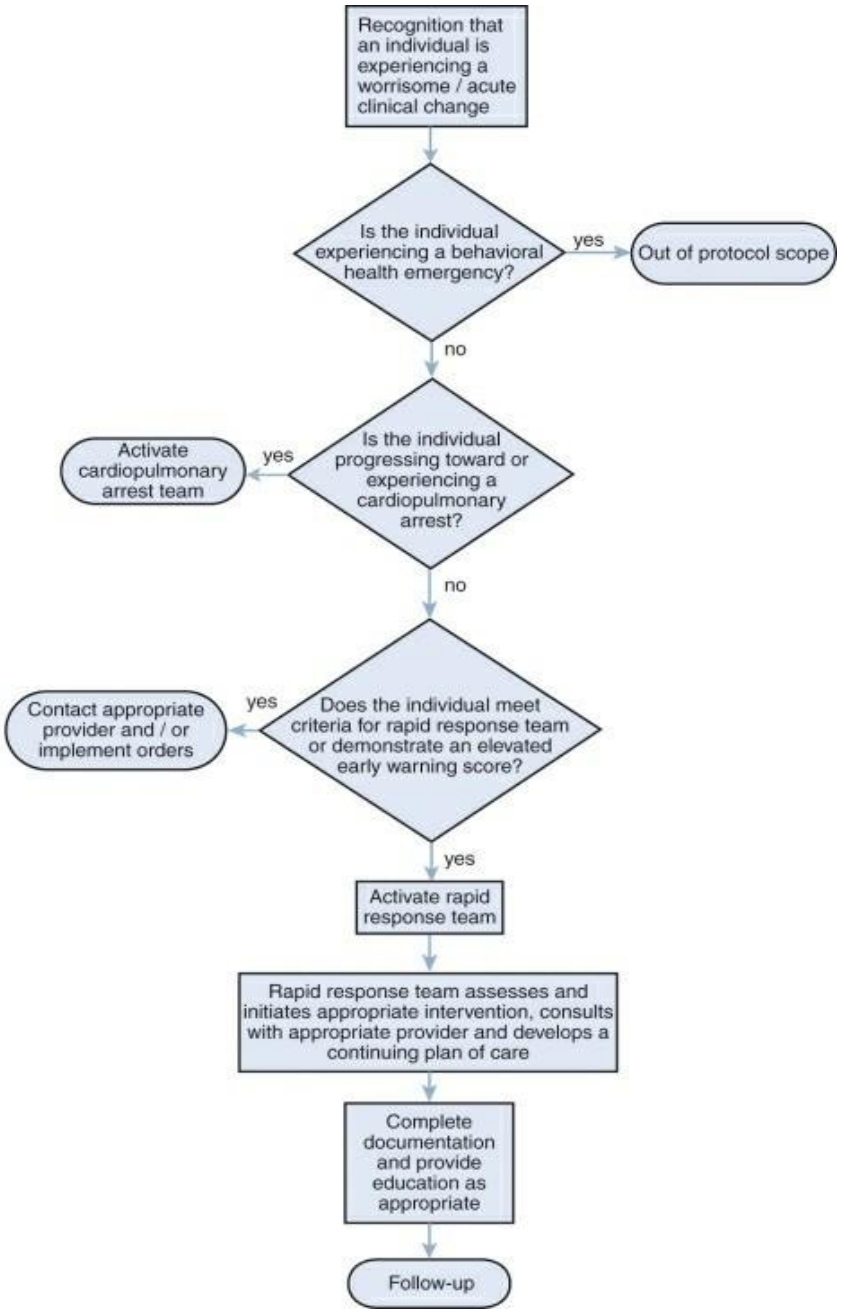
secara bergantian, berikut diberikan konteks untuk memahami perbedaan potensial di antara mereka.

Jalur klinis atau jalur kritis

Jalur klinis atau jalur kritis biasanya mendefinisikan urutan dan waktu intervensi yang optimal oleh dokter, perawat, dan anggota tim interprofesional lainnya saat memberikan perawatan untuk pasien dengan diagnosis atau prosedur tertentu, seperti pasien yang dirawat untuk operasi bypass arteri koroner. Jalur ini biasanya dikembangkan melalui upaya kolaboratif tim interprofesional, yang mencakup dokter, perawat, apoteker, dan lainnya, untuk meningkatkan kualitas dan nilai perawatan pasien yang diberikan. Beberapa manfaat paling jelas dari penggunaan jalur klinis antara lain: (1) pengurangan variasi dalam perawatan yang diberikan, (2) memfasilitasi dan mencapai hasil klinis yang diharapkan, (3) mengurangi keterlambatan perawatan dan lama tinggal di rumah sakit, dan (4) peningkatan efektivitas biaya perawatan yang diberikan sambil mempertahankan atau meningkatkan kepuasan pasien dan keluarga.

Protokol atau algoritma klinis

Protokol atau algoritma klinis berbeda dari jalur klinis karena lebih merepresentasikan jalur keputusan yang mungkin diambil oleh seorang praktisi selama episode atau kebutuhan tertentu. Misalnya, algoritma umum tersedia untuk pengobatan hipertensi, pemberian dukungan hidup dasar dan lanjutan, serta skrining diagnostik umum

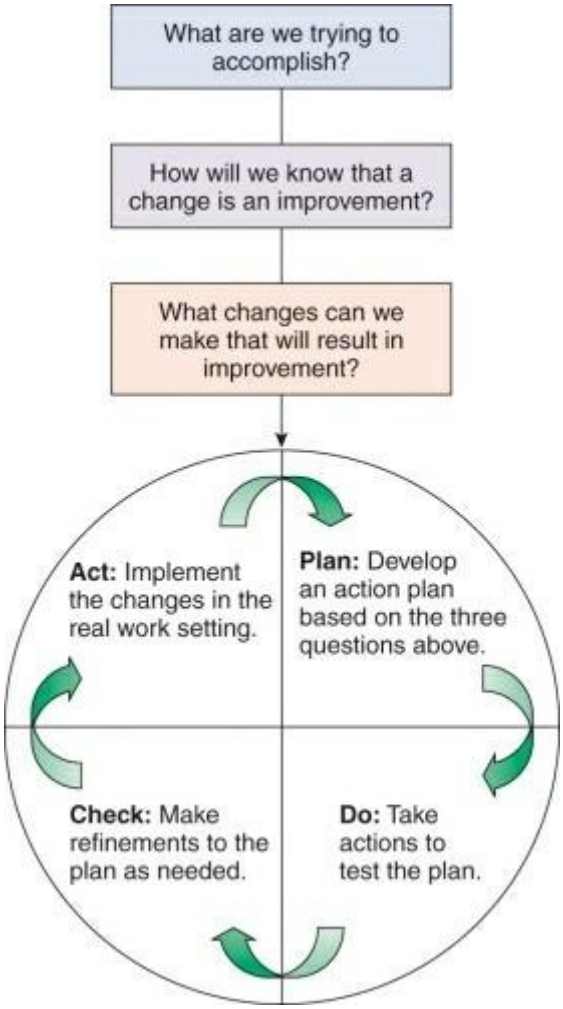


Gambar 1. 6 Algoritma Klinis—Protokol Kesehatan: Tim Respons Cepat

Pemikiran terobosan untuk meningkatkan kualitas

Sama seperti standarisasi yang kritis untuk fondasi perbaikan kesehatan, demikian pula konsep pemikiran terobosan dan penerapan cepat metode terbaik yang diketahui untuk praktik. Premis di balik pemikiran terobosan dan tindakan yang dihasilkannya bersifat tiga arah: (1) pengetahuan substansial ada tentang cara mencapai kinerja yang lebih baik daripada yang ada saat ini; (2) contoh kuat sudah ada dari organisasi yang telah menerapkan pengetahuan tersebut dan

berhasil mencapai peningkatan substansial; dan (3) taruhannya tinggi dan relevan dengan kebutuhan strategis paling penting di bidang kesehatan (Berwick, 1997).



Gambar 1. 7 Model Peningkatan Kualitas Institute for Healthcare Improvement (IHI)

M. Keselamatan pasien

Kebutuhan akan peningkatan kualitas (QI) paling terlihat pada area kesalahan dalam pelayanan kesehatan. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, laporan IOM *To Err Is Human: Building a Safer Health System* (2000) menempatkan isu kesalahan medis dan keselamatan pasien pada halaman banyak surat kabar nasional, agenda dewan pengurus fasilitas kesehatan, dan menjadi fokus utama legislasi pemerintah federal. Menanggapi perhatian terhadap keselamatan pasien dan kebutuhan akan data untuk lebih memahami isu prioritas, beberapa inisiatif nasional telah diterapkan dan dibahas dalam bagian berikut.

Institute for Safe Medication Practices

Salah satu hasil dari gerakan keselamatan pasien dan QI adalah pendirian *Institute for Safe Medication Practices* (ISMP), sebuah organisasi nirlaba yang kini dikenal luas sebagai sumber edukasi untuk pencegahan kesalahan penggunaan obat. ISMP menyediakan peninjauan independen, multidisipliner, dan ahli terhadap kesalahan yang dilaporkan melalui *ISMP Medication Errors Reporting Program* (MERP). Melalui MERP, tenaga kesehatan di seluruh negeri secara sukarela dan rahasia melaporkan kesalahan penggunaan obat dan kondisi berbahaya yang dapat menyebabkan kesalahan. Proses pelaporan sederhana dan mudah diakses oleh para klinisi. Semua informasi yang diperoleh dan strategi pencegahan kesalahan dibagikan dengan *U.S. Food and Drug Administration* (FDA).

ISMP juga mengembangkan *Medication Safety Self-Assessments* untuk memungkinkan perawat dan tenaga kesehatan lainnya menilai praktik keselamatan penggunaan obat di tempat kerja mereka. Alat ini berisi item yang membahas penggunaan obat di lingkungan klinis, penggunaan obat berisiko tinggi, serta perbaikan sistem dan langkah pengamanan yang direkomendasikan ISMP berdasarkan analisis kesalahan penggunaan obat (ISMP, 2017). Penilaian ini tersedia secara publik di situs web ISMP (https://www.ismp.org/self-assessments

Peran lembaga regulasi dan akreditasi dalam meningkatkan keselamatan pasien

Para pemimpin lembaga regulasi (misalnya, CMS) dan lembaga akreditasi (misalnya, TJC) telah mengembangkan standar dan program untuk meningkatkan keselamatan pasien. Tiga program semacam ini dibahas dalam bagian berikut.

Standar *sentinel event*

Sebagai salah satu respons terhadap meningkatnya perhatian pada keselamatan pasien, TJC menetapkan standar *sentinel event* pada tahun 2000. Standar ini, yang masih berlaku hingga sekarang, mengharuskan organisasi melaksanakan langkah-langkah tertentu untuk memahami sepenuhnya faktor dan sistem yang terkait dengan kejadian pasien yang merugikan. Langkah-langkah ini berpusat pada *root cause analysis (RCA)*, yang merupakan penerapan langsung dari prinsip dan metode peningkatan kualitas yang telah dijelaskan sebelumnya dalam bab ini. Tujuan dari *root cause analysis* adalah untuk memahami sistem yang bermasalah dalam organisasi sehingga perbaikan dapat ditentukan dan diterapkan untuk mencegah terjadinya kejadian serupa di masa mendatang. TJC memberikan keleluasaan bagi organisasi dalam menentukan kebijakan pengungkapan kejadian ini kepada komisi.

Tujuan keselamatan pasien

Tujuan keselamatan pasien nasional TJC bertujuan membantu organisasi yang terakreditasi menangani area kekhawatiran tertentu terkait keselamatan pasien. Tujuan ini didasarkan pada analisis berkelanjutan terhadap *sentinel event* yang dilaporkan dan akar penyebab yang diidentifikasi dari kejadian tersebut. Tinjauan tahunan terhadap tujuan ini umumnya menghasilkan modifikasi tujuan yang ada dan penciptaan tujuan baru, sebagaimana tercermin dalam daftar yang dipublikasikan untuk tahun 2018, yang memodifikasi persyaratan untuk rumah sakit, rumah sakit akses kritis, dan pusat perawatan keperawatan dalam kategori infeksi terkait pelayanan kesehatan (Box 22.1).

BOX 10.1 Tujuan Keselamatan Pasien Nasional Rumah Sakit, 2018

1. Meningkatkan akurasi identifikasi pasien
   - Gunakan setidaknya dua identitas pasien saat memberikan perawatan, pengobatan, dan layanan.
   - Hilangkan kesalahan transfusi yang terkait dengan kesalahan identifikasi pasien.
2. Meningkatkan efektivitas komunikasi antar penyedia perawatan
   - Laporkan hasil kritis dari tes dan prosedur diagnostik secara tepat waktu.
3. Meningkatkan keselamatan penggunaan obat-obatan
   - Labeli semua obat, wadah obat, dan larutan lainnya baik di dalam maupun di luar area steril dalam pengaturan perioperatif dan prosedural lainnya.
   - Kurangi kemungkinan bahaya bagi pasien yang terkait dengan penggunaan terapi antikoagulan.
   - Pertahankan dan komunikasikan informasi obat pasien yang akurat.
4. Mengurangi bahaya yang terkait dengan sistem alarm klinis
   - Tingkatkan keselamatan sistem alarm klinis.
5. Mengurangi risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan
   - Patuhi pedoman higienis tangan terbaru dari Centers for Disease Control and Prevention (CDC) atau pedoman higienis tangan terbaru dari World Health Organization (WHO).
   - Terapkan praktik berbasis bukti untuk mencegah infeksi terkait pelayanan kesehatan akibat organisme resisten obat pada rumah sakit perawatan akut/rumah sakit akses kritis.
   - Terapkan praktik berbasis bukti untuk mencegah infeksi aliran darah terkait kateter pusat.
   - Terapkan praktik berbasis bukti untuk mencegah infeksi pada lokasi bedah.
   - Terapkan praktik berbasis bukti untuk mencegah infeksi saluran kemih terkait kateter indwelling.

6. Rumah sakit mengidentifikasi risiko keselamatan yang melekat pada populasi pasiennya
   - Identifikasi pasien yang berisiko bunuh diri.
7. Protokol universal digunakan untuk mencegah operasi pada lokasi yang salah, prosedur yang salah, dan pasien yang salah
   - Lakukan proses verifikasi pra-prosedur.
   - Tandai lokasi prosedur.
   - Lakukan "procedure time-out" sebelum prosedur dilakukan

N. Never events

Pada tahun 2006, CMS mulai meneliti cara-cara agar program Medicare dapat membantu mengurangi atau menghilangkan terjadinya *never events* kesalahan serius dan mahal dalam pemberian layanan kesehatan yang seharusnya tidak pernah terjadi. Contoh dari *never events* termasuk operasi pada lokasi yang salah dan transfusi darah yang tidak sesuai, yang dapat menyebabkan cedera serius atau kematian pasien serta meningkatkan biaya bagi Medicare. CMS bekerja sama dengan National Quality Forum (NQF) untuk mengidentifikasi kondisi yang diperoleh di rumah sakit yang dianggap dapat dicegah secara wajar dan di mana biaya tambahan rawat inap untuk menangani kondisi tersebut tidak seharusnya dibayarkan. Box 22.2 menyajikan daftar terkini kondisi yang diperoleh di rumah sakit di mana Medicare tidak lagi memberikan pembayaran tambahan untuk perawatannya.

BOX 10.2 Never Events: Daftar Kondisi yang Didapat di Rumah Sakit oleh Centers for Medicare and Medicaid Services untuk Tahun 2018

1. Benda asing tertinggal setelah operasi
2. Emboli udara
3. Ketidakcocokan darah
4. Luka tekan tahap III dan IV
5. Jatuh dan trauma
6. Infeksi saluran kemih terkait kateter
7. Infeksi terkait kateter vaskular
8. Infeksi luka operasi—mediastinitis setelah *coronary artery bypass graft*
9. Manifestasi kontrol glikemik yang buruk
10. Tromboemboli vena dalam / emboli paru dengan penggantian total lutut atau panggul
11. Infeksi luka operasi—operasi bariatrik

12. Infeksi luka operasi setelah prosedur ortopedi tertentu pada tulang belakang, bahu, dan siku
13. Infeksi luka operasi setelah prosedur alat elektronik implantasi jantung
14. Pneumotoraks iatrogenik akibat kateterisasi vena

Mulai tahun fiskal CMS 2015 dan masih berlaku hingga saat ini, penalti penggantian biaya diterapkan pada rumah sakit yang berada di kuartil terbawah secara nasional untuk subset tertentu dari kondisi yang didapat di rumah sakit. Penalti ini berupa pemotongan 1% dari penggantian biaya tahunan Medicare Diagnosis-Related Group (DRG) dasar organisasi. Seperti Value-Based Purchasing, program ini merupakan hasil dari Patient Protection and Affordable Care Act tahun 2010.

O. Perawat profesional dan keselamatan pasien

Bagi perawat, tantangan dimulai dengan menjadikan peningkatan keselamatan pasien dan pengurangan kesalahan bukan hanya prioritas organisasi tetapi juga prioritas pribadi. Ini berarti mengadopsi pola pikir yang mengakui kompleksitas dan risiko tinggi dalam layanan kesehatan modern, menerapkan praktik terbaik yang distandarisasi, dan bekerja untuk menghilangkan *never events*. Dua fungsi keperawatan yang paling signifikan yang secara langsung memengaruhi keselamatan pasien, kualitas perawatan, dan hasilnya adalah:

1. Memantau untuk pengenalan dini kejadian merugikan, komplikasi, dan kesalahan.
2. Memulai penyebaran penyedia perawatan yang tepat untuk intervensi, respons, dan penyelamatan pasien secara tepat waktu dalam situasi tersebut.

Faktor penting yang mendukung kemampuan perawat untuk melaksanakan kedua fungsi ini adalah jumlah staf perawat. Meskipun penentuan tingkat staf yang tepat masih menjadi perdebatan, terdapat pengakuan luas bahwa terdapat hubungan yang kuat antara hasil pasien dan jumlah staf perawat (Martsolf et al., 2014; McHugh and Ma, 2013; Smeds Alenius et al., 2014; Tubbs-Cooley et al., 2013). Bab 13 membahas secara mendalam strategi yang dapat digunakan perawat untuk mempromosikan perawatan berkualitas dan lingkungan kerja yang aman.

Indikator kualitas keperawatan

Badan pengatur American Nurses Association (ANA) mendirikan National Database of Nursing Quality Indicators (NDNQI) pada tahun 1998 sebagai bagian dari inisiatif keselamatan dan kualitas ANA. Program basis data nasional ini mengumpulkan informasi tentang indikator-indikator tertentu yang sangat memengaruhi hasil klinis pasien untuk dua tujuan utama: (1) menyediakan data

perbandingan bagi organisasi kesehatan untuk mendukung kegiatan peningkatan kualitas (QI), dan (2) mengembangkan data nasional untuk lebih memahami hubungan antara jumlah staf perawat dan hasil pasien (Box 10.3).

NDNQI unik karena merupakan satu-satunya program pengukuran kualitas keperawatan nasional yang memungkinkan perbandingan kualitas keperawatan antara rumah sakit nasional, regional, dan negara bagian yang sejenis dan seukuran, dari perspektif tingkat unit. Per tahun 2017, 2.000 rumah sakit telah bergabung dengan basis data ini, dan laporan triwulanan disediakan kepada organisasi-organisasi ini untuk analisis proses perawatan dan sistem pendukung mereka terkait jumlah staf perawat (Press Ganey, 2017). Pada tahun 2014, basis data NDNQI diakuisisi oleh Press Ganey, penyedia nasional survei kepuasan pasien dan sumber daya strategis lainnya untuk organisasi kesehatan.

BOX 10.3 Indikator Kualitas Sensitif Keperawatan

Indikator Klinis – Struktur

1. Perputaran Perawat
2. Volume dan Aliran Pasien
3. Penerimaan, Pemindahan, dan Keluar Pasien
4. Throughput Unit Gawat Darurat
5. Pendidikan/ Sertifikasi Spesialis RN
6. Jumlah Staf dan Komposisi Keterampilan*

Proses

1. Koordinasi Perawatan
2. Pemakaian Alat/Perangkat
3. Jatuhnya Pasien*
4. Luka Tekan
5. Siklus Penilaian/Intervensi/Penilaian Ulang Nyeri Pediatrik (AIR)
6. Penggunaan Alat Restraint

Hasil

1. Kekerasan oleh Pasien Psikiatrik
2. Kekerasan terhadap Tenaga Keperawatan
3. Infeksi Saluran Kemih Terkait Kateter (CAUTI)
4. Infeksi Aliran Darah Terkait Kateter Sentral (CLABSI)
5. Readmisi Rumah Sakit
6. Organisme Multiresisten Obat (MDRO)
7. Infeksi C. difficile
8. Infeksi MRSA
9. Mengidentifikasi risiko jatuh pasien.

10. Menilai efektivitas protokol pencegahan jatuh, seperti pengawasan, penggunaan alat bantu, dan edukasi pasien.
11. Menyediakan data untuk perbaikan berkelanjutan dan peningkatan keselamatan pasien.

P. Kerja Tim Interprofesional

Sama pentingnya dalam mendukung keselamatan pasien adalah lingkungan kerja yang mendukung salin bergantung dan komunikasi efektif antara perawat dan profesional kesehatan lainnya. Sebagian besar perawat dan staf klinis lain mungkin menganggap mereka sudah bekerja dalam tim; namun, konsep kerja tim jarang diajarkan dalam program pendidikan tenaga kesehatan.

Perawatan pasien sangat bergantung pada komunikasi interprofesional yang efektif untuk mendukung koordinasi kegiatan yang meningkatkan efisiensi dan keselamatan.

Salah satu strategi untuk meningkatkan kerja tim interprofesional adalah TeamSTEPPS (Team Strategies and Tools to Enhance Performance and Patient Safety).

TeamSTEPPS dikembangkan oleh AHRQ dan Departemen Pertahanan AS sebagai sistem kerja tim berbasis bukti yang bertujuan mengoptimalkan hasil pasien dengan meningkatkan keterampilan komunikasi dan kerja tim di antara profesional kesehatan. Informasi lengkap tentang TeamSTEPPS, termasuk penilaian kesiapan dan materi pelatihan, tersedia di situs web resminya: http://teamstepps.ahrq.gov.

Kompetensi QSEN (Quality and Safety Education in Nursing)

Bab ini telah membahas kebutuhan penting untuk mentransformasi sistem kesehatan saat ini guna meningkatkan kualitas dan keselamatan pasien. Perawat muncul sebagai pemimpin dalam transformasi ini dan, sebagai bagian dari praktik keperawatan mereka, perlu mengintegrasikan enam kompetensi yang direkomendasikan oleh IOM (2003) sebagai esensial bagi semua tenaga kesehatan:

1. Perawatan berpusat pada pasien
2. Kerja tim dan kolaborasi
3. Praktik berbasis bukti
4. Peningkatan kualitas
5. Keselamatan
6. Informatika

Untuk mendukung pendidikan keperawatan terkait enam kompetensi ini, proyek nasional Quality and Safety Education for Nurses (QSEN) dibentuk dengan dukungan dari Robert Wood Johnson Foundation (Cronenwett et al., 2009).

Menunjukkan pentingnya enam kompetensi ini dalam praktik keperawatan, QSEN telah diintegrasikan ke dalam standar pendidikan keperawatan dan ujian lisensi perawat (American Association of Colleges of Nursing, 2008; Smith et al., 2007), sehingga semua perawat bertanggung jawab untuk kompeten di bidang-bidang ini.

Meskipun enam kompetensi ini mungkin terdengar familiar bagi perawat, penting untuk memahami mereka sesuai maksud IOM, agar semua disiplin ilmu (misalnya keperawatan, kedokteran, farmasi) memiliki kerangka acuan yang sama dalam mengintegrasikan kompetensi ke dalam praktik. Tabel 10.1 menyajikan setiap kompetensi dengan definisi serta contoh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang terkait. Situs web QSEN (http://www.qsen.org) merupakan sumber yang baik, menyediakan informasi lengkap tentang setiap kompetensi, termasuk bibliografi beranotasi, strategi pengajaran yang ditinjau sejawat, dan video instruksional. Pembaca dianjurkan untuk mengunjungi situs QSEN untuk mempelajari lebih lanjut tentang kompetensi ini, yang esensial bagi praktik keperawatan saat ini.

Q. Peran Perawat Profesional dalam Peningkatan Kualitas

Terdapat banyak pelajaran bagi semua perawat dari salah satu mentor asli keselamatan pasien dan peningkatan kualitas, Florence Nightingale. Nightingale menggunakan data untuk mendukung upayanya dalam mengurangi kejadian dan penyebaran infeksi di bangsal pasien yang menjadi tanggung jawabnya selama Perang Krimea. Hasil dari pekerjaannya adalah pergeseran budaya kesehatan yang lebih luas pada saat itu.

Fokus saat ini pada kualitas dan keselamatan pasien dapat menghasilkan pergeseran budaya baru dalam pelayanan kesehatan, di mana nilai bersama dan tujuan dari semua pihak yang terlibat adalah membangun sistem kesehatan yang tidak membahayakan.

Perawat berada dalam posisi ideal untuk memimpin perubahan budaya ini.

Peningkatan kualitas seharusnya tidak dianggap sebagai fungsi terpisah dari peran penyedia perawatan, melainkan bagian yang berkelanjutan dari peran profesional bagi semua tenaga kesehatan.

R. Ringkasan

Bagi perawat yang baru lulus saat ini, tantangannya adalah memanfaatkan semua sarana yang tersedia untuk menyempurnakan pengetahuan dan keterampilan yang secara fundamental diperlukan agar dapat bekerja sama dengan semua anggota tim interprofesional dalam upaya perbaikan berkelanjutan di bidang pelayanan kesehatan.

Sama pentingnya dengan kemampuan klinis, misalnya mengetahui gejala ketoasidosis diabetik atau cara memberikan suntikan, adalah pemahaman tentang prinsip dasar peningkatan kualitas (QI), perbaikan proses, dan variasi; penggunaan indikator klinis, alat perbaikan proses, dan proses perawatan yang distandarisasi; serta penerapan keselamatan pasien dalam setiap aspek perawatan.

Setiap perawat seharusnya memasuki praktik profesional dengan kesadaran akan akuntabilitas terhadap kualitas perawatan yang diberikan oleh organisasi kesehatan dan mengambil peran kepemimpinan untuk melaksanakan perbaikan agar pelayanan kesehatan menjadi aman, tepat waktu, efektif, efisien, adil, dan berpusat pada pasien.

LATIHAN MANDIRI: MINI AUDIT MANAJEMEN MUTU & KESELAMATAN

Skenario Kasus

Anda adalah seorang Ketua Tim di Ruang Rawat Inap Bedah. Berdasarkan laporan triwulan terakhir, ditemukan peningkatan angka Infeksi Daerah Operasi (IDO) sebesar 3% dan terdapat 2 laporan insiden tertusuk jarum bekas (*needle stick injury*) pada perawat pelaksana. Kepala Ruangan meminta Anda melakukan "Mini Audit" selama satu shift untuk mengidentifikasi akar masalah pada aspek PPI (Pencegahan dan Pengendalian Infeksi) dan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja). Saat melakukan observasi, Anda menemukan:

1. 3 dari 5 perawat tidak melakukan *hand hygiene* langkah ke-2 (sebelum tindakan aseptik).
2. Wadah limbah tajam (*safety box*) di ruang tindakan sudah terisi penuh melebihi garis batas (3/4), namun belum diganti.
3. Perawat sering melakukan *re-capping* (menutup kembali) jarum suntik setelah digunakan karena posisi *safety box* yang jauh dari bed pasien.

PRODUK 1: LEMBAR AUDIT (CONTOH INSTRUMEN)

No	Kriteria Audit (Elemen Penilaian)	Patuh	Tidak	Keterangan
1	**Kepatuhan Cuci Tangan (PPI)**			
	Perawat melakukan 5 Moment Hand Hygiene dengan benar.	[ ]	[x]	60% tidak patuh moment ke-2.
2	**Manajemen Limbah Tajam (K3)**			
	Safety box tidak terisi lebih dari 3/4 bagian.	[ ]	[x]	Melebihi batas aman.
3	**Prosedur Injeksi Aman (Patient Safety)**			

No	Kriteria Audit (Elemen Penilaian)	Patuh	Tidak	Keterangan
	Perawat tidak melakukan *re-capping* jarum bekas.	[ ]	[x]	Ditemukan teknik *re-capping*.

PRODUK 2: RINGKASAN TEMUAN & ANALISIS RISIKO

- **Ringkasan Temuan:** Terdapat kegagalan sistem pada kepatuhan fasilitasi APD/Limbah dan rendahnya kesadaran perilaku aseptik.
- **Analisis Risiko (Metode Fishbone/Penyebab):**
  - **Man:** Kurangnya re-edukasi PPI dan persepsi keliru bahwa *re-capping* lebih cepat.
  - **Material:** Jumlah *safety box* terbatas dan tidak tersedia di setiap troli tindakan.
  - **Method:** SOP pendelegasian pembuangan limbah tajam tidak berjalan (staf menunggu petugas kebersihan untuk mengganti *box*).

PRODUK 3: RENCANA MITIGASI & INDIKATOR KEBERHASILAN

Masalah	Rencana Mitigasi (Intervensi)	Indikator Penilaian (Target)
Risiko Infeksi (IDO)	Audit kepatuhan *hand hygiene* mendadak dan pengadaan *handrub* di setiap bed pasien.	Kepatuhan *Hand Hygiene* mencapai 100% dalam 1 bulan.
Cedera Tusukan Jarum	Pengadaan *safety box* ukuran kecil untuk setiap troli injeksi dan pelarangan *re-capping*.	*Zero Accident* (Angka tertusuk jarum 0) dalam triwulan depan.
Paparan Limbah	Sosialisasi ulang pembuangan limbah tajam bagi perawat dan petugas kebersihan.	Tidak ada *safety box* yang terisi > 3/4 saat audit harian.

Referensi

Agency for Healthcare Research and Quality. National healthcare quality report, 2013 . Available at: https://archive.ahrq.gov/research/findings/nhqrdr/n 2014, May; Publication No. 14-0005. AHRQRetrieved from

Agency for Healthcare Research and Quality. National healthcare quality and disparities report, 2016 . Available at: http://www.ahrq.gov/research/findings/nhqrdr/ind 2017, July; Publication No. 17-0001-1-EF. AHRQRetrieved from

American Association of Colleges of Nursing. The essentials of baccalaureate education for professional nursing practice . Washington, DC: American Association of Colleges of Nursing 2008;

Berwick D. The breakthrough series . Quality Connection 1997;6(2):11.

Cronenwett L, Sherwood G, Gelmon S.B. Improving quality and safety education the QSEN learning collaborative . Nursing Outlook 2009;57(6):304-312.

In: Institute of Medicine Kohn L.T, Corrigan J.M, Donaldson M.S. To err is human Building a safer health system . Washington, DC: National Academies Press 2000;

Institute of Medicine. Crossing the quality chasm a new health system for the 21st century . Washington, DC: National Academy Press 2001;

In: Institute of Medicine Greiner A.C, Knebel E. Health professions education A bridge to quality . Washington, DC: National Academies Press 2003;

Institute of Medicine. Preventing medication errors Quality chasm series . Available at: https://www.nap.edu/read/11623/chapter/1 2007; Retrieved from

Institute for Safe Medication Practices. ISMP self assessments . Available at: http://www.ismp.org/selfassessments 2017; Retrieved from

James J.T. A new, evidence-based estimate of patient harms associated with hospital care . Journal of Patient Safety 2013;9(3):122-128.

Joiner B.L. Fourth generation management . New York: McGraw-Hill 1994;

Kementerian Kesehatan RI. (2022). *Laporan Nasional Komite Nasional Keselamatan Pasien Rumah Sakit*. Jakarta: Kemenkes RI.

Kementerian Kesehatan RI. (2023). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*. Jakarta

Kementerian Kesehatan RI. (2023). *Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/1128/2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit*. Jakarta.

Langley G.J, Nolan K.M, Nolan T.W, Moen R.D, Norman C.L, Provost L.P. The Improvement Guide A Practical Approach to Enhancing Organizational

Performance . 2nd ed. San Francisco: Jossey-Bass 2009;

Marquis, B. L., & Huston, C. J. (2021). *Leadership roles and management functions in nursing: Theory and application* (10th ed.). Wolters Kluwer.

Martsolf G.R, Auerbach D, Benevent R, Stocks C, Jiang H.J, Pearson M.L, et al. Examining the value of inpatient nurse staffing An assessment of quality and patient care costs . Medical Care 2014;52(11):982-988.

McHugh M.D, Ma C. Hospital nursing and 30 day readmissions among Medicare patients with heart failure, acute myocardial infarction and pneumonia . Medical Care 2013;51(1):52-59.

PMK No. 30 Tahun 2022 tentang Indikator Nasional Mutu

Smeds Alenius L, Tishelman C, Runesdotter S, Lindqvist R. Staffing and resource adequacy strongly related to RNs' assessment of patient safety a national study of RNs working in acute-care hospitals in Sweden . BMJ Quality & Safety 2014;23:242-249.

Smith E.L, Cronenwett L, Sherwood G. Current assessments of quality and safety education in nursing . Nursing Outlook 2007;55(3):132-137.

The Joint Commission. Sentinel events . Available at: https://www.jointcommission.org/sentinel_event_p 2017; (website)

The Joint Commission. About the Joint Commission . Available at: https://www.jointcommission.org/about_us/about_ 2017; Retrieved from

Tubbs-Cooley H.L, Cimiotti J.P, Silber J.H, Sloane D.M, Aiken L.H. An observational study of nurse staffing ratios and hospital readmission among children admitted for common conditions . BMJ Quality and Safety 2013;22(9):735-742.

BAB 2.

KESELAMATAN PASIEN DAN MANAJEMEN RISIKO KLINIS

A. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menguasai konsep dasar manajemen keperawatan, peran perawat manajer, serta etika–legal dalam pengelolaan pelayanan.	CPMK-1; CPMK-2
CPL-2	Mampu menganalisis organisasi pelayanan keperawatan dan sistem layanan kesehatan untuk mendukung tata kelola dan kesinambungan layanan.	CPMK-2; CPMK-7
CPL-3	Mampu menerapkan kepemimpinan keperawatan, komunikasi efektif, kolaborasi, dan manajemen konflik serta perubahan dalam tim.	CPMK-3; CPMK-5
CPL-4	Mampu merencanakan dan mengelola SDM keperawatan (kebutuhan, penjadwalan, delegasi, supervisi) secara adil, aman, dan efisien.	CPMK-4; CPMK-5
CPL-5	Mampu menerapkan manajemen mutu, keselamatan pasien, manajemen risiko, PPI, dan K3 sebagai budaya kerja untuk peningkatan layanan.	CPMK-6; CPMK-7
CPL-6	Mampu memanfaatkan dokumentasi, informatika, standar–akreditasi, serta data kinerja untuk evaluasi, pelaporan, dan perbaikan mutu berkelanjutan.	CPMK-7; CPMK-2; CPMK-6

B. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menjelaskan konsep dasar manajemen keperawatan, fungsi manajemen, peran perawat manajer, serta etika–legal dalam pelayanan.
CPMK-2	Menganalisis organisasi pelayanan keperawatan dan sistem layanan kesehatan (tata kelola, standar, kebijakan) untuk mendukung pengambilan keputusan manajerial.
CPMK-3	Menerapkan kepemimpinan keperawatan, manajemen perubahan, komunikasi efektif, kolaborasi, dan manajemen konflik dalam pengelolaan tim.
CPMK-4	Merencanakan kebutuhan dan penjadwalan SDM keperawatan berdasarkan beban kerja, kompetensi, dan prinsip keadilan–keselamatan.
CPMK-5	Mengelola manajemen asuhan keperawatan melalui delegasi, supervisi, koordinasi, serta pemanfaatan sumber daya/logistik secara efisien.
CPMK-6	Menerapkan manajemen mutu, keselamatan pasien, manajemen risiko klinis, PPI, dan K3 dalam peningkatan kinerja pelayanan keperawatan.

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-7	Menggunakan dokumentasi, informatika, audit data, dan pelaporan untuk evaluasi kinerja serta menyusun proyek mini peningkatan mutu berbasis data.

D. Pemetaan

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 2. Keselamatan Pasien dan Manajemen Risiko Klinis	2.1 Mengidentifikasi risiko klinis dan memprioritaskan mitigasi berdasarkan tingkat dampak dan probabilitas.	2.2 Menyusun tindakan pencegahan insiden dan pelaporan insiden secara terstruktur.	CPMK-6	CPMK-1; CPMK-7

E. Asesmen (berbasis CPMK)

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-1	Ujian tulis (CBT/essay terstruktur)	Persentase jawaban benar konsep fungsi manajemen dan akurasi penerapan peran–akuntabilitas pada skenario.	10	Nilai ujian; lembar jawaban
CPMK-6	Simulasi fasilitasi/kemitraan (role play)	Kualitas fasilitasi partisipasi + kejelasan rencana kolaborasi/advokasi (skor rubrik).	15	Lembar penilaian; rencana kemitraan
CPMK-7	Portofolio laporan asuhan komunitas + refleksi	Kualitas evaluasi berbasis indikator (baseline–akhir) dan spesifikasi rencana perbaikan berkelanjutan.	15	Laporan akhir; jurnal refleksi

Rubrik CPMK-1

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
1.1 Ketepatan konsep fungsi manajemen (% benar)	<60% benar; miskonsepsi dominan	60–74% benar; miskonsepsi masih ada	75–89% benar; kesalahan minor	≥90% benar; konsisten
1.2 Ketepatan penerapan peran–akuntabilitas pada skenario	Keliru/tidak relevan	Relevan sebagian; alasan lemah	Tepat; alasan logis	Tepat; alasan kuat dan komprehensif

Rubrik CPMK-2

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
2.1 Ketepatan pemetaan struktur & alur layanan	Tidak akurat; komponen inti hilang	Cukup akurat; masih ada kekeliruan bermakna	Akurat; kekeliruan minor	Sangat akurat; komprehensif dan jelas
2.2 Ketepatan gap analysis & prioritas perbaikan	Gap tidak sesuai standar; prioritas acak	Gap sebagian tepat; prioritas kurang konsisten	Gap tepat; prioritas jelas	Gap sangat tepat; prioritas sangat logis & berbasis risiko

Rubrik CPMK-3

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
3.1 Kinerja kepemimpinan & manajemen perubahan (checklist)	≤60% perilaku tercapai; tidak terarah	61–75% tercapai; arah sebagian jelas	76–90% tercapai; terarah & konsisten	>90% tercapai; adaptif, memotivasi, terstruktur
3.2 Komunikasi efektif & resolusi konflik (checklist)	Konflik tidak tertangani; komunikasi tidak jelas	Ada upaya; solusi belum disepakati	Solusi disepakati; komunikasi runtut	Solusi kuat; komunikasi sangat efektif & menjaga hubungan kerja

Rubrik CPMK-4

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
4.1 Akurasi perhitungan kebutuhan tenaga	Banyak kesalahan; asumsi tidak jelas	Cukup tepat; masih ada kesalahan bermakna	Tepat; kesalahan minor	Sangat tepat; asumsi jelas & dapat dipertanggungjawabkan
4.2 Kualitas jadwal dinas (cakupan, aturan, pemerataan)	Cakupan tidak aman; melanggar aturan	Cakupan cukup; pemerataan kurang	Cakupan aman; aturan dipatuhi; cukup adil	Cakupan sangat aman; patuh aturan; sangat adil & minim risiko kelelahan

Rubrik CPMK-5

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
5.1 Ketepatan keputusan delegasi & rencana supervisi	Delegasi tidak sesuai kompetensi/risiko	Delegasi cukup sesuai; supervisi kurang spesifik	Delegasi sesuai; supervisi jelas	Delegasi sangat tepat; supervisi terukur & antisipatif risiko
5.2 Ketepatan rencana pengendalian logistik	Tidak berbasis kebutuhan; rawan kekosongan	Berbasis kebutuhan sebagian; kontrol kurang	Berbasis data; kontrol memadai	Berbasis data komprehensif; kontrol sangat efektif (minim stockout/overstock)

Rubrik CPMK-6

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
6.1 Ketepatan indikator & analisis temuan audit	Indikator tidak tepat; analisis tidak sesuai	Indikator cukup; analisis terbatas	Indikator tepat; analisis jelas	Indikator sangat tepat; analisis kritis berbasis data/tren
6.2 Kelayakan rencana mitigasi risiko/PPI/K3 (terukur)	Rencana umum; tidak terukur	Ada rencana; indikator belum jelas	Rencana spesifik; indikator terukur	Rencana sangat spesifik, terukur, realistis; prioritas berbasis risiko

Rubrik CPMK-7

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
7.1 Kelengkapan laporan berbasis data (baseline–target–hasil)	Data tidak lengkap; tidak dapat dievaluasi	Data cukup; hubungan baseline–hasil kurang jelas	Data lengkap; evaluasi jelas	Data sangat lengkap; evaluasi kuat dan transparan
7.2 Kualitas proyek mini peningkatan mutu (rencana–uji–evaluasi)	Tidak sistematis; tanpa evaluasi hasil	Sistematis sebagian; evaluasi terbatas	Sistematis; evaluasi hasil memadai	Sangat sistematis; evaluasi kuat; rekomendasi implementatif & berkelanjutan

A. Pendahuluan

Keselamatan pasien (*patient safety*) merupakan salah satu pilar utama dan penting dalam sistem pelayanan kesehatan. Upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan tidak dapat dilepaskan dari kemampuan institusi dalam mencegah terjadinya cedera yang tidak perlu akibat tindakan yang dilakukan tenaga kesehatan.

World Health Organization (WHO) menegaskan bahwa keselamatan pasien adalah upaya sistematis untuk mengurangi risiko bahaya yang dapat dicegah selama proses pelayanan kesehatan hingga tingkat yang dapat diterima.

Tingginya angka kejadian insiden keselamatan pasien menunjukkan bahwa sistem pelayanan kesehatan masih memiliki banyak celah yang berpotensi menimbulkan kesalahan. Insiden ini tidak hanya berdampak pada pasien, tetapi juga pada tenaga kesehatan, organisasi rumah sakit, serta sistem kesehatan secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan komprehensif yang mencakup pencegahan insiden serta sistem pelaporan yang efektif sebagai dasar pembelajaran organisasi.

Pelaporan insiden keselamatan pasien menjadi elemen penting dalam siklus peningkatan mutu karena memungkinkan identifikasi akar masalah dan perbaikan sistem secara berkelanjutan., sehingga kejadian serupa tidak akan terulang lagi atau terjadi pada pasien yang berbeda.

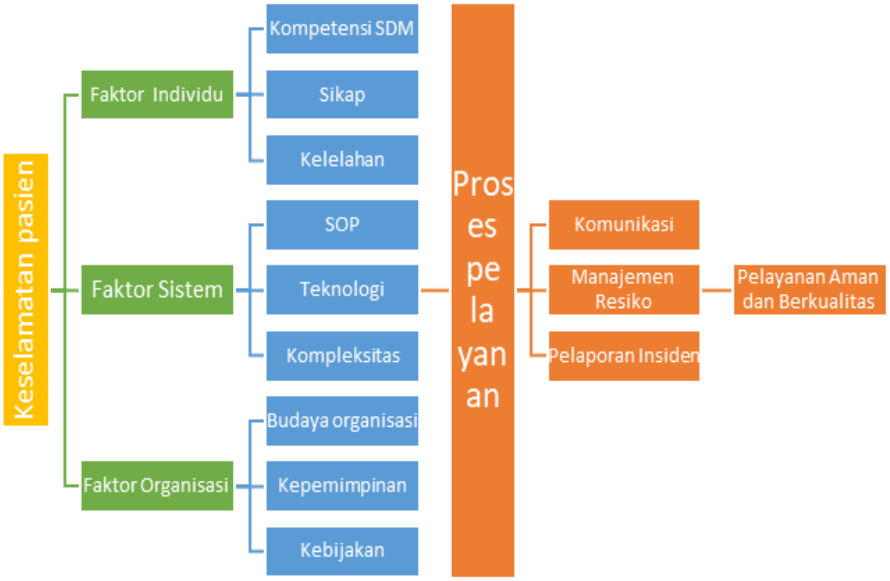
B. Keselamatan Pasien

1. Konsep keselamatan pasien berbasis sistem

   Secara konseptual, keselamatan pasien berkembang dari pendekatan individual menuju pendekatan sistem (*system-based approach*). Keselamatan pasien dipandang sebagai disiplin ilmu yang mengintegrasikan ilmu keselamatan (*safety science*) ke dalam pelayanan kesehatan untuk mencegah kesalahan dan meminimalkan dampaknya.

   Menurut Emanuel et al. (2008), keselamatan pasien merupakan suatu disiplin dalam pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk menciptakan sistem pelayanan yang dapat dipercaya melalui minimalisasi kejadian tidak diharapkan dan optimalisasi pemulihan ketika insiden terjadi.

   WHO (2024) mendefinisikan keselamatan pasien sebagai suatu kerangka kerja dari aktivitas terorganisasi yang mencakup budaya, proses, prosedur, perilaku, dan teknologi untuk menurunkan risiko serta mencegah cedera yang dapat dihindari



Gambar 2. 1 Diagram keselamatan pasien berbasis sistem

Berdasarkan gambar 2.1 menggambarkan bahwa keselamatan pasien merupakan suatu sistem yang kompleks dan multidimensional, yang dipengaruhi oleh tiga domain utama, yaitu faktor individu, faktor sistem, dan faktor organisasi, yang kemudian berinteraksi dalam proses pelayanan kesehatan untuk menghasilkan pelayanan yang aman dan berkualitas.

a. Faktor yang mempengaruhi keselamatan pasien

Ada tiga factor yang mempengaruhi keselamatan pasien, yaitu individu, system, dan organisasi

1) Faktor Individu

Faktor individu mencakup karakteristik tenaga kesehatan yang secara langsung mempengaruhi kualitas pelayanan, meliputi kompetensi sumber daya manusia (SDM), sikap atau perilaku, dan tingkat kelelahan.

Kompetensi SDM merupakan determinan utama dalam keselamatan pasien, karena tenaga kesehatan yang memiliki pengetahuan dan keterampilan klinis yang memadai akan mampu melakukan tindakan secara tepat dan mengurangi risiko kesalahan (Carayon et al., 2020). Selain itu, sikap atau perilaku profesional yang mencerminkan kepatuhan terhadap standar dan etika juga berkontribusi terhadap peningkatan keselamatan pasien.

Kelelahan (*fatigue*), terutama akibat beban kerja tinggi dan jam kerja panjang, terbukti meningkatkan risiko kesalahan medis. Studi menunjukkan bahwa kelelahan dapat menurunkan fungsi kognitif, konsentrasi, dan pengambilan keputusan klinis (WHO, 2021). Oleh karena itu, manajemen

beban kerja menjadi aspek yang sangat penting dalam menciptakan dan menjaga keselamatan pasien.

2) Faktor Sistem

Faktor sistem mencakup elemen struktural dan operasional dalam pelayanan kesehatan, seperti standar operasional prosedur (SOP), teknologi, dan kompleksitas sistem pelayanan.

SOP berfungsi sebagai panduan dalam pelaksanaan tindakan klinis yang konsisten dan aman. Ketidakpatuhan terhadap SOP sering kali menjadi penyebab utama kejadian tidak diharapkan. Teknologi kesehatan, seperti sistem informasi rumah sakit dan alat medis, dapat meningkatkan akurasi dan efisiensi pelayanan, namun juga berpotensi menimbulkan risiko baru jika tidak digunakan secara tepat (Carayon et al., 2020).

Kompleksitas sistem pelayanan kesehatan yang melibatkan berbagai profesi dan prosedur meningkatkan potensi terjadinya kesalahan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan human factors engineering untuk mendesain sistem yang sesuai dengan kemampuan manusia (WHO, 2021).

3) Faktor Organisasi

Faktor organisasi meliputi budaya organisasi, kepemimpinan, dan kebijakan yang mendukung implementasi keselamatan pasien. Budaya keselamatan (*safety culture*) merupakan elemen kunci yang mendorong tenaga kesehatan untuk melaporkan insiden tanpa rasa takut (*non-blaming culture*). Organisasi dengan budaya keselamatan yang kuat cenderung memiliki tingkat insiden yang lebih rendah (Reis et al., 2018).

Kepemimpinan yang efektif berperan dalam menciptakan lingkungan kerja yang mendukung keselamatan pasien melalui penyediaan sumber daya, pelatihan, serta penguatan kebijakan.

Kebijakan organisasi juga harus selaras dengan standar nasional dan internasional dalam keselamatan pasien. Kebijakan organisasi harus tertuang dalam AD ART, peraturan atau keputusan dapat dalam bentuk standar atau prosedur yang berlaku di lingkungan rumah sakit.

b. Proses Pelayanan sebagai Mediator

Ketiga faktor yang mempengaruhi tersebut berinteraksi dalam proses pelayanan kesehatan, yang terdiri dari:

1) Komunikasi

Komunikasi yang efektif antar tenaga kesehatan merupakan faktor krusial dalam mencegah kesalahan medis. Kegagalan komunikasi merupakan salah satu penyebab utama adverse events. Penggunaan

metode standar seperti SBAR (Situation, Background, Assessment, Recommendation) terbukti meningkatkan kejelasan komunikasi klinis.

2) Manajemen Risiko

Manajemen risiko melibatkan proses identifikasi, analisis, dan pengendalian risiko dalam pelayanan kesehatan. Pendekatan proaktif seperti *Failure Mode and Effects Analysis* (FMEA) dan pendekatan reaktif seperti *Root Cause Analysis* (RCA) digunakan untuk mencegah kejadian berulang.

3) Pelaporan Insiden

Sistem pelaporan insiden memungkinkan organisasi untuk belajar dari kesalahan. Pelaporan yang efektif harus didukung oleh budaya yang tidak menyalahkan serta sistem yang mudah diakses. Menurut WHO (2021), pembelajaran dari insiden merupakan strategi utama dalam meningkatkan keselamatan pasien secara berkelanjutan.

c. Pelayanan Aman dan Berkualitas

Interaksi antara faktor individu, sistem, dan organisasi melalui proses pelayanan akan menghasilkan outcome berupa pelayanan kesehatan yang aman dan berkualitas. Pelayanan yang aman ditandai dengan minimnya kejadian tidak diharapkan, tidak adanya cedera yang dapat dicegah, dan tingginya kepatuhan terhadap standar.

Sementara itu, kualitas pelayanan mencakup efektivitas, efisiensi, dan kepuasan pasien. Keselamatan pasien menjadi fondasi utama dalam pencapaian mutu pelayanan kesehatan (WHO, 2021).

d. Analisis Konseptual

Berdasarkan diagram tersebut, dapat disusun model konseptual sebagai berikut:

1) Pendekatan Sistem (System Approach)

Keselamatan pasien tidak dapat dijelaskan hanya dari satu faktor, melainkan merupakan hasil interaksi kompleks antara manusia, sistem, dan organisasi.

2) Model Input–Prosess–Output (IPO)

- **Input:** Faktor individu, sistem, organisasi
- **Proses:** Komunikasi, manajemen risiko, pelaporan insiden
- **Output:** Pelayanan aman dan berkualitas

3) Teori Human Factors

Menekankan bahwa kesalahan terjadi akibat ketidaksesuaian antara manusia dan sistem kerja, sehingga solusi harus berfokus pada perbaikan sistem, bukan menyalahkan individu.

4) Safety Culture Framework

Budaya keselamatan menjadi mediator utama yang menghubungkan kebijakan organisasi dengan praktik klinis.

Dengan demikian, peningkatan keselamatan pasien harus dilakukan secara holistik melalui peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, perbaikan sistem pelayanan dan penguatan budaya organisasi. Ketiganya harus diperbaiki secara bersama-sama seiring sejalan.

2. Definisi Keselamatan Pasien

WHO (2024) mendefinisikan keselamatan pasien sebagai kerangka kerja aktivitas terorganisasi untuk mengurangi risiko dan mencegah cedera dalam pelayanan kesehatan. Institute of Medicine (IOM) mengartikan keselamatan sebagai kondisi yang bebas dari cedera yang tidak disengaja akibat pelayanan kesehatan. Dan Emanuel et al. (2008) menjelaskan keselamatan pasien sebagai disiplin ilmu yang bertujuan menciptakan sistem pelayanan yang aman dan dapat dipercaya. Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa keselamatan pasien adalah "Suatu sistem terintegrasi dalam pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk mencegah, mengurangi, dan mengelola risiko cedera akibat proses pelayanan kesehatan."

3. Tujuan dan prinsip keselamatan pasien

Keselamatan pasien (patient safety) merupakan komponen fundamental dalam sistem pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap intervensi klinis yang diberikan kepada pasien berlangsung secara aman, efektif, dan bebas dari risiko cedera yang dapat dicegah. Secara konseptual, tujuan keselamatan pasien tidak hanya berorientasi pada pencegahan kesalahan, tetapi juga pada peningkatan mutu pelayanan secara menyeluruh. Menurut WHO (2021), keselamatan pasien bertujuan untuk meminimalkan risiko dan mencegah cedera yang tidak perlu dalam pelayanan kesehatan melalui sistem yang terorganisasi dan berkelanjutan. Adapun tujuan utama keselamatan pasien yaitu mencegah cidera akibat pelayanan kesehatan, meningkatkan kualitas pelayanan, menurunkan angka kejadian yang tidak diharapkan (KTD), dan meningkatkan kepercayaan masyarakat

a. Mencegah Cedera Akibat Pelayanan Kesehatan

Tujuan utama keselamatan pasien adalah mencegah terjadinya cedera yang diakibatkan oleh kesalahan dalam proses pelayanan kesehatan, baik yang bersifat kesalahan tindakan (*errors of commission*) maupun kelalaian (*errors of omission*). Cedera yang dimaksud meliputi cedera fisik, psikologis, maupun komplikasi klinis yang sebenarnya dapat dihindari. Pendekatan keselamatan pasien menekankan pada identifikasi risiko secara dini, penerapan standar

prosedur operasional (SOP), serta penggunaan praktik berbasis bukti (evidence-based practice). Dengan demikian, pelayanan kesehatan tidak hanya berfokus pada penyembuhan penyakit, tetapi juga pada pencegahan dampak negatif dari intervensi yang dilakukan (Carayon et al., 2020). Secara konseptual, pencegahan cedera ini sejalan dengan prinsip *"primum non nocere"* (*first, do no harm*) dalam praktik kesehatan.

b. Meningkatkan Kualitas Pelayanan

Keselamatan pasien merupakan indikator utama dalam penilaian mutu pelayanan kesehatan. Pelayanan yang aman akan meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kesinambungan asuhan keperawatan.

Menurut Institute of Medicine (IOM), kualitas pelayanan kesehatan mencakup enam dimensi, yaitu: aman (safe), efektif (effective), berpusat pada pasien (patient-centered), tepat waktu (timely), efisien (efficient), dan adil (equitable). Dalam hal ini, keselamatan pasien menjadi fondasi utama dari seluruh dimensi tersebut. Implementasi program keselamatan pasien, seperti penerapan International Patient Safety Goals (IPSG), terbukti mampu meningkatkan mutu pelayanan melalui penurunan kesalahan medis, peningkatan kepatuhan terhadap standar, dan perbaikan koordinasi tim kesehatan.

Dengan demikian, keselamatan pasien tidak dapat dipisahkan dari upaya peningkatan kualitas pelayanan secara keseluruhan (WHO, 2021).

c. Menurunkan Angka Kejadian Tidak Diharapkan (KTD)

Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) atau adverse events merupakan indikator penting dalam evaluasi keselamatan pasien. Tujuan keselamatan pasien adalah menurunkan angka kejadian tersebut melalui pendekatan sistematis yang meliputi:

1) Identifikasi dan analisis risiko
2) Pelaporan insiden keselamatan
3) Pembelajaran dari kesalahan (*learning organization*)
4) Implementasi tindakan pencegahan

Pendekatan ini didukung oleh teori Swiss Cheese Model dari Reason (2000), yang menjelaskan bahwa kesalahan terjadi akibat kegagalan berlapis dalam sistem. Oleh karena itu, upaya pencegahan harus dilakukan pada berbagai lapisan sistem pelayanan. Penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar kejadian tidak diharapkan dapat dicegah jika sistem keselamatan pasien diterapkan secara optimal (AHRQ, 2022). Dengan demikian, fokus utama bukan hanya pada penanganan insiden, tetapi pada pencegahan kejadian berulang, dengan pasien sama ataupun berbeda.

d. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat

Keselamatan pasien juga memiliki implikasi sosial yang signifikan, yaitu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pelayanan kesehatan. Kepercayaan (trust) merupakan faktor penting dalam hubungan antara pasien dan tenaga kesehatan, serta menjadi indikator keberhasilan pelayanan kesehatan.

Pelayanan yang aman dan transparan akan meningkatkan kepuasan pasien, loyalitas pasien, dan reputasi institusi kesehatan. Sebaliknya, kejadian tidak diharapkan yang tidak dikelola dengan baik dapat menurunkan kepercayaan masyarakat dan berdampak pada citra organisasi. Oleh karena itu, penerapan keselamatan pasien harus disertai dengan komunikasi terbuka, pelaporan insiden yang transparan, serta akuntabilitas organisasi (WHO, 2021).

4. Sasaran Keselamatan Pasien

Sasaran keselamatan pasien merupakan standar global yang dikembangkan untuk mengurangi risiko cedera pada pasien selama proses pelayanan kesehatan. Sasaran ini diadopsi secara luas dari *International Patient Safety Goals (IPSG)* yang ditetapkan oleh *Joint Commission International* (JCI) dan diperkuat oleh *World Health Organization* (WHO).

IPSG berfungsi sebagai kerangka kerja sistematis dalam meningkatkan keselamatan pasien melalui pendekatan berbasis risiko dan pencegahan kesalahan yang dapat dicegah (*preventable harm*). Sasaran ini mencerminkan area kritis dalam pelayanan kesehatan yang paling rentan terhadap kejadian tidak diharapkan (KTD).

a. Identifikasi Pasien Secara Tepat

Identifikasi pasien yang akurat merupakan langkah fundamental dalam keselamatan pasien. Kesalahan identifikasi dapat menyebabkan berbagai insiden serius, seperti pemberian obat yang salah, tindakan medis yang tidak sesuai, hingga kesalahan prosedur. Standar internasional mensyaratkan penggunaan minimal dua identitas pasien, seperti:

1) Nama lengkap
2) Tanggal lahir
3) Nomor rekam medis

Identifikasi tidak boleh menggunakan nomor kamar atau lokasi pasien sebagai identitas utama. Jika mendapat ada nama pasien dan tempat tanggal lahir yang sama maka yang dijasikan patokan adalah nomor rekam medis. Proses ini harus dilakukan sebelum:

1) Pemberian obat
2) Pengambilan specimen

3) Tindakan atau prosedur

Menurut WHO (2021), kegagalan dalam identifikasi pasien merupakan salah satu penyebab utama adverse events di fasilitas kesehatan. Oleh karena itu, sistem identifikasi yang terstandarisasi, seperti penggunaan gelang identitas, sangat penting untuk meminimalkan risiko kesalahan.

Tabel 2. 1 Warna Gelang Pasien di Rumah Sakit

No	Warna Gelang	Makna / Identifikasi	Keterangan Klinis	Tindakan Keperawatan
1	Biru / Pink	Identitas pasien Biru=Laki-laki Pink=Perempuan	Berisi nama, tanggal lahir, nomor RM	Wajib pada semua pasien, verifikasi sebelum tindakan
2	Kuning	Risiko jatuh	Pasien dengan gangguan mobilitas, lansia, efek obat	Pasang side rail, edukasi keluarga, pengawasan ketat
3	Merah	Alergi	Obat, makanan, lateks, dll	Hindari alergen, dokumentasi jelas
4	Ungu	DNR (*Do Not Resuscitate*)	Tidak dilakukan resusitasi	Pastikan informed consent dan dokumentasi lengkap
5	Hijau	Prosedur atau perawatan khusus	Pasien yang boleh dipindahkan ke ruang rawat tertentu atau pasien noninfeksi yang sudah bisa menjalani perawatan	Terapkan kewaspadaan sesuai kondisi

No	Warna Gelang	Makna / Identifikasi	Keterangan Klinis	Tindakan Keperawatan
			lebih lanjut tanpa risiko penularan penyakit	
6	Orange	Penyakit menular atau yang membutuhkan isolasi khusus selama perawatan.	Peringatan bagi tenaga kesehatan dan pengunjung agar berhati-hati saat berinteraksi dengan pasien	Protokol pencegahan infeksi yang ketat.

b. Komunikasi Efektif

Komunikasi yang tidak efektif merupakan faktor utama dalam terjadinya kesalahan medis. Oleh karena itu, peningkatan komunikasi efektif menjadi salah satu sasaran utama keselamatan pasien. Pendekatan yang umum digunakan adalah metode SBAR (*Situation, Background, Assessment, Recommendation*).

Metode SBAR merupakan suatu kerangka komunikasi terstruktur yang digunakan oleh tenaga kesehatan untuk menyampaikan informasi klinis secara sistematis, ringkas, dan akurat. SBAR dirancang untuk meningkatkan kejelasan komunikasi, terutama dalam situasi kritis seperti handover, konsultasi, maupun pelaporan kondisi pasien (AHRQ, 2023). Penggunaan SBAR diakui secara luas oleh organisasi internasional seperti WHO, Joint Commission, dan Institute for Healthcare Improvement sebagai strategi efektif dalam meningkatkan keselamatan pasien melalui pengurangan kesalahan komunikasi (Shahid & Thomas, 2018) . Secara konseptual, SBAR berfungsi sebagai alat untuk:

1) Menstandarkan komunikasi antarprofesi
2) Meningkatkan *situational awareness*
3) Mengurangi ambiguitas informasi klinis
4) Mendukung pengambilan keputusan klinis berbasis data

Komponen SBAR

1) Situation (Situasi)

   Komponen Situation merupakan bagian awal komunikasi yang berisi deskripsi singkat mengenai kondisi pasien saat ini. Informasi yang disampaikan harus spesifik, jelas, dan langsung pada masalah utama. Isi utama:

   - Identitas pasien
   - Masalah utama saat ini
   - Perubahan kondisi terbaru

   Contoh:

   "Pasien Ny. A, usia 35 tahun, mengalami penurunan tekanan darah secara tiba-tiba."

   Secara teoritis, tahap ini bertujuan untuk membangun *attention focus* pada penerima informasi sehingga dapat segera memahami urgensi kondisi pasien (Rholetter, 2024) .

2) Background (Latar Belakang)

   Komponen Background berisi informasi klinis yang relevan dengan kondisi pasien saat ini, termasuk riwayat penyakit, diagnosis medis, terapi yang sedang dijalani, serta data penunjang lainnya.

   Isi utama:

   - Riwayat penyakit
   - Diagnosis medis
   - Terapi atau tindakan sebelumnya
   - Hasil pemeriksaan penunjang

   Contoh:

   "Pasien memiliki riwayat hipertensi dan sedang menjalani terapi antihipertensi."

   Tahap ini berfungsi memberikan konteks klinis sehingga penerima informasi dapat memahami kondisi pasien secara komprehensif dan tidak terfragmentasi.

3) Assessment (Penilaian)

   Komponen Assessment merupakan interpretasi klinis tenaga kesehatan terhadap kondisi pasien berdasarkan data objektif dan subjektif. Isi utama:

   - Hasil pengkajian (*vital sign*, kondisi klinis)
   - Analisis masalah
   - Dugaan diagnosis keperawatan atau medis

   Contoh:

"Berdasarkan hasil pengkajian, pasien mengalami hipotensi kemungkinan akibat efek samping obat."

Pada tahap ini, kemampuan berpikir kritis sangat diperlukan karena tenaga kesehatan harus mengintegrasikan data klinis menjadi suatu kesimpulan yang bermakna (Putri & Afandi, 2023) .

4) Recommendation (Rekomendasi)

Komponen Recommendation merupakan usulan tindakan atau intervensi yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah pasien.

Isi utama:

- Permintaan tindakan (misalnya: evaluasi dokter, pemeriksaan tambahan)
- Rencana tindak lanjut
- Saran intervensi klinis

Contoh:

"Saya merekomendasikan pemberian cairan intravena dan evaluasi segera oleh dokter."

Tahap ini mencerminkan peran aktif tenaga kesehatan dalam pengambilan keputusan klinis dan kolaborasi interprofesional.

Selain itu, komunikasi verbal harus diverifikasi melalui teknik *read-back* atau *repeat-back*, terutama pada perintah medis yang bersifat kritis. Dalam budaya masyarakat diistilahkan dengan TBaK (Tulis lengkap dan jelas sesuai pokok masalah, Baca tuntas dan pahami, Konfirmasikan kembali). *Joint Commission International* (2023) menekankan bahwa komunikasi yang efektif berkontribusi signifikan terhadap peningkatan keselamatan pasien dan penurunan kesalahan klinis.

c. Keamanan Obat (Medication Safety)

Kesalahan dalam pemberian obat (*medication error*) merupakan salah satu jenis insiden keselamatan pasien yang paling sering terjadi. Oleh karena itu, keamanan obat menjadi prioritas utama dalam sasaran keselamatan pasien. Strategi yang diterapkan meliputi:

- Penerapan prinsip **8 benar pemberian obat** (obat, dosis, pasien, waktu, cara, persiapan, evaluasi respon, dokumentasi)
- Pengelolaan obat berisiko tinggi (*high-alert medications*): tampilan dan nama yang mirip (*look alike sound alike*), konsentrasi tinggi, sedative, narkotik,
- Pelabelan yang jelas dan standar, baku dan berlaku umum
- Penyimpanan obat yang aman, mudah diakses oleh perawat

Selain itu, sistem *double check* dan penggunaan teknologi seperti *barcode medication administration* (BCMA) dapat meningkatkan akurasi

pemberian obat. Menurut AHRQ (2022), sebagian besar kesalahan obat dapat dicegah melalui sistem yang terstandarisasi dan pelatihan tenaga kesehatan.

d. Tepat Lokasi, Prosedur, dan Pasien Operasi

Kesalahan dalam tindakan bedah, seperti operasi pada lokasi yang salah (*wrong-site surgery*), merupakan kejadian serius yang dapat berdampak fatal. Oleh karena itu, diperlukan sistem verifikasi yang ketat sebelum tindakan operasi. Pendekatan yang digunakan meliputi:

- Proses verifikasi pra-operasi: identitas, diagnosis medis, premedikasi, cukur, gigi palsu, perhiasan, riwayat kesehatan, riwayat pengobatan, golongan darah,
- Penandaan lokasi operasi (site marking): distal, medialis, proksimal, lateral,
- Time-out sebelum prosedur dimulai

Time-out merupakan proses konfirmasi terakhir yang melibatkan seluruh tim bedah untuk memastikan:

- Identitas pasien
- Lokasi operasi
- Jenis prosedur

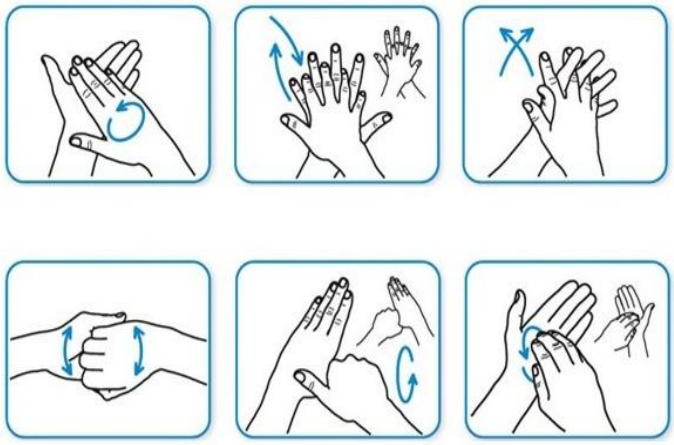
WHO melalui *Surgical Safety Checklist* menekankan bahwa implementasi checklist ini dapat menurunkan angka komplikasi dan mortalitas pasca operasi secara signifikan.

e. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi

Infeksi terkait pelayanan kesehatan (*Healthcare-Associated Infections/HAIs*) merupakan salah satu penyebab utama morbiditas dan mortalitas di rumah sakit. Oleh karena itu, pencegahan infeksi menjadi sasaran penting dalam keselamatan pasien. Strategi utama meliputi:

- Kepatuhan terhadap hand hygiene: di air mengalir, menggunakan sabun/handscrub, six steps, five moment
- Penggunaan alat pelindung diri (APD)
- Sterilisasi alat medis
- Pengelolaan limbah medis

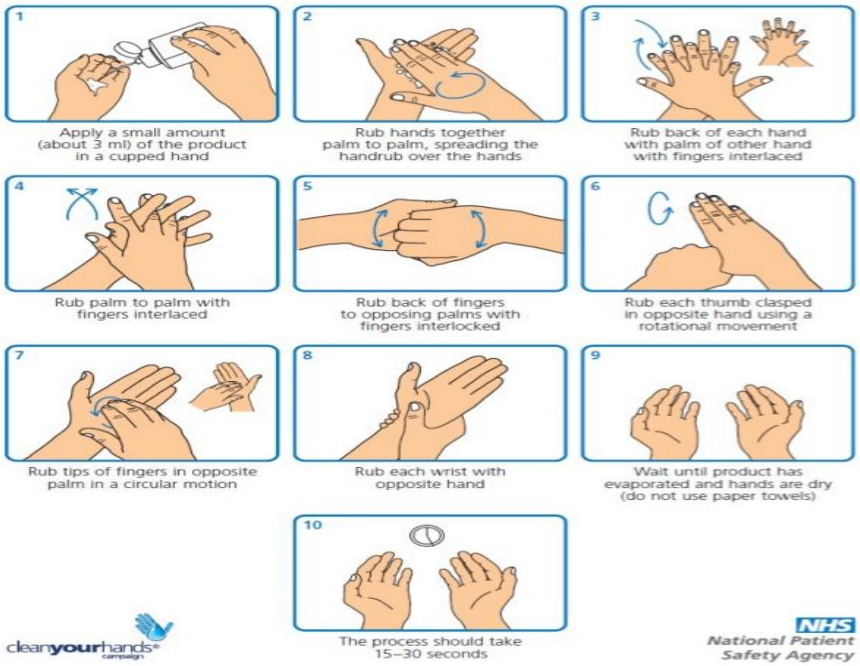
WHO (2021) menegaskan bahwa praktik kebersihan tangan yang tepat merupakan intervensi paling efektif dalam mencegah infeksi di fasilitas kesehatan.



Gambar 2. 2 Gerakan 6 langkah mencuci tangan yang benar



Gambar 2. 3 momen mencuci tangan



Gambar 2. 4 Gerakan mencuci tangan yang benar menggunakan handscrub

f. Pencegahan Pasien Jatuh

Pasien jatuh merupakan kejadian yang sering terjadi di rumah sakit dan dapat menyebabkan cedera serius, seperti fraktur atau trauma kepala. Oleh karena itu, pencegahan pasien jatuh menjadi bagian integral dari keselamatan pasien. Upaya pencegahan meliputi:

- Penilaian risiko jatuh menggunakan instrumen standar (misalnya Morse Fall Scale)
- Pemasangan gelang risiko jatuh
- Pengawasan pasien berisiko tinggi
- Modifikasi lingkungan (penerangan, lantai tidak licin, pegangan)

AHRQ (2022) menyatakan bahwa sebagian besar kejadian jatuh dapat dicegah melalui intervensi berbasis risiko dan peningkatan kewaspadaan tenaga kesehatan.

C. Manajemen Resiko Klinis Keselamatan Pasien

1. Insiden Keselamatan Pasien

Insiden keselamatan pasien adalah kejadian yang tidak disengaja yang dapat mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan cedera pada pasien. Insiden keselamatan pasien sering terjadi akibat kegagalan sistem, komunikasi yang tidak efektif, serta kurangnya kepatuhan terhadap standar prosedur (Dhamanti et al., 2019). Klasifikasi insiden kesselamatan pasien meliputi : Kejadian

Tidak Diharapkan (KTD), Kejadian Nyaris Cedera (*near miss*), Kejadian Tidak Cedera (KTC), dan Kejadian Sentinel.

a. Kejadian Tidak Diharapkan (KTD)

Kejadian Tidak Diharapkan (*Adverse Event*) adalah insiden yang mengakibatkan cedera pada pasien akibat tindakan medis atau karena tidak dilakukannya tindakan yang seharusnya dilakukan, bukan karena penyakit dasar pasien. KTD merupakan indikator penting dalam evaluasi mutu pelayanan karena menunjukkan adanya kegagalan sistem pelayanan kesehatan. Karakteristik KTD:

1) Menimbulkan cedera (ringan hingga berat)
2) Dapat dicegah (*preventable*) atau tidak dapat dicegah
3) Berhubungan dengan proses pelayanan kesehatan

Contoh:

1) Kesalahan pemberian obat dosis tinggi yang menyebabkan hipotensi
2) Infeksi nosokomial akibat prosedur tidak aseptic
3) Pasien jatuh hingga mengalami fraktur

Implikasi:

KTD memerlukan analisis mendalam, seperti *Root Cause Analysis (RCA)*, untuk mengidentifikasi akar masalah dan mencegah kejadian berulang.

b. Kejadian Nyaris Cedera (Near Miss)

Kejadian Nyaris Cedera (*Near Miss*) adalah insiden yang belum sampai mengenai pasien sehingga tidak menimbulkan cedera, baik karena keberuntungan maupun karena adanya intervensi tepat waktu. Near miss merupakan sumber pembelajaran yang sangat penting karena mencerminkan adanya potensi kesalahan dalam sistem. Karakteristik Near Miss:

1) Tidak mencapai pasien atau tidak menimbulkan dampak
2) Dapat terdeteksi sebelum terjadi cedera
3) Menunjukkan adanya celah dalam sistem

Contoh:

1) Obat yang salah terdeteksi sebelum diberikan kepada pasien
2) Label pasien tertukar tetapi diketahui sebelum tindakan dilakukan

Implikasi:

Pelaporan near miss sangat dianjurkan karena dapat digunakan untuk mencegah terjadinya KTD di masa mendatang.

c. Kejadian Tidak Cedera (KTC)

Kejadian Tidak Cedera (*No Harm Incident*) adalah insiden yang sudah terjadi dan mengenai pasien, tetapi tidak menimbulkan cedera atau dampak klinis yang signifikan. KTC menunjukkan bahwa sistem pelayanan masih

memiliki kelemahan meskipun belum menimbulkan dampak yang merugikan. Karakteristik KTC (*No Harm Incident*)**:**

1) Insiden mencapai pasien
2) Tidak menimbulkan cedera
3) Potensial menjadi KTD jika tidak diperbaiki

Contoh:

1) Pemberian obat yang tidak sesuai waktu tetapi tidak menimbulkan efek
2) Kesalahan prosedur yang tidak berdampak klinis

Implikasi:

KTC perlu dianalisis untuk mencegah terjadinya insiden yang lebih serius di masa depan.

d. Kejadian Sentinel (Sentinel Event)

Kejadian Sentinel adalah insiden keselamatan pasien yang sangat serius yang mengakibatkan kematian, cedera permanen, atau cedera berat yang memerlukan intervensi segera. Kejadian ini disebut "sentinel" karena menjadi tanda adanya masalah serius dalam sistem pelayanan yang memerlukan investigasi segera.

Karakteristik kejadian entinel (Sentinel Event):

1) Dampak sangat berat (kematian atau kecacatan permanen)
2) Tidak dapat diterima (*never event*)
3) Memerlukan investigasi segera dan komprehensif

Contoh:

1) Operasi pada sisi tubuh yang salah (*wrong site surgery*)
2) Kematian akibat kesalahan pemberian obat
3) Bayi tertukar di rumah sakit

Implikasi:

Kejadian sentinel wajib dilakukan *Root Cause Analysis (RCA)* dan dilaporkan ke otoritas terkait sebagai bagian dari sistem pembelajaran nasional.

Tabel 2. 2 Deskripsi Singkat Insiden Keselamatan Pasien

Jenis Insiden	**Definisi**	**Dampak pada Pasien**	**Karakteristik Utama**	**Contoh Kasus**	**Tindak Lanjut**
Kejadian Tidak Diharapkan (KTD)	Insiden yang menyebabkan cedera pada pasien	Ada cedera (ringan–berat)	Terjadi pada pasien, berdampak klinis, dapat	Overdosis obat menyebabkan hipotensi;	Investigasi mendalam (RCA),

Jenis Insiden	Definisi	Dampak pada Pasien	Karakteristik Utama	Contoh Kasus	Tindak Lanjut
	akibat tindakan medis atau kelalaian		dicegah atau tidak	pasien jatuh mengalami fraktur	perbaikan sistem
Kejadian Nyaris Cedera (Near Miss)	Insiden yang belum mencapai pasien sehingga tidak menimbulkan cedera	Tidak ada cedera	Terhenti sebelum mencapai pasien, terdeteksi dini	Obat salah terdeteksi sebelum diberikan	Analisis sederhana, perbaikan sistem pencegahan
Kejadian Tidak Cedera (KTC)	Insiden yang terjadi pada pasien tetapi tidak menimbulkan cedera	Tidak ada cedera	Sudah mencapai pasien, tidak berdampak klinis	Obat diberikan tidak sesuai waktu tetapi tanpa efek	Evaluasi sistem, pencegahan kejadian berulang
Kejadian Sentinel	Insiden serius yang menyebabkan kematian atau cedera permanen	Cedera berat / kematian	Bersifat fatal, tidak dapat diterima (*never event*)	Operasi sisi salah; kematian akibat kesalahan obat	RCA komprehensif, pelaporan wajib, tindakan korektif segera

2. Prinsip Umum Pencegahan Insiden Keselamatan Pasien

Pencegahan insiden keselamatan pasien tidak hanya berfokus pada individu tenaga kesehatan, tetapi juga pada sistem pelayanan secara menyeluruh. Pencegahan bertujuan supaya kejadian insiden tidak terulang kembali baik pada pasien yang sama maupun berbeda.

a. Pendekatan Sistem (System Approach)

Prinsip utama dalam pencegahan insiden adalah memahami bahwa kesalahan lebih sering disebabkan oleh kelemahan sistem daripada kesalahan individu. Sistem yang tidak efektif (alur kerja, komunikasi, SOP) meningkatkan

risiko kesalahan, sehingga fokus pada perbaikan sistem, bukan menyalahkan individu (*no blame culture*). Aspek yang harus dilakukan adalah Standarisasi prosedur, Penyusunan SOP yang jelas, dan Pengawasan sistem kerja.

b. Budaya Keselamatan (Safety Culture)

Budaya keselamatan adalah nilai, sikap, dan perilaku yang mendukung terciptanya pelayanan yang aman. Ciri keselamatan sudah menjadi budaya yaitu: Terbuka dalam melaporkan kesalahan, Tidak menghukum pelapor, dan Fokus pada pembelajaran. Pelaporan insiden secara sukarela, Diskusi kasus (*case* Implementasinya meliputi *review*), dan Pelatihan keselamatan pasien

c. Identifikasi Risiko Secara Proaktif

Pencegahan dilakukan dengan mengidentifikasi potensi risiko sebelum terjadi insiden. Metode yang digunakan yaitu *Risk assessment*, Audit klinis, dan *Failure Mode and Effect Analysis* (FMEA). Contoh: Pengkajian risiko pasien jatuh, Pengkajian risiko kesalahan pemberian obat

d. Komunikasi Efektif

Komunikasi yang tidak efektif merupakan salah satu penyebab utama insiden keselamatan pasien. Strategi yang digunakan meliputi: Penggunaan metode SBAR (*Situation, Background, Assessment, Recommendation*), Dokumentasi yang jelas, dan Verifikasi ulang informasi. Contoh penerapanya pada saat serah terima pasien (*handover*), instruksi dokter kepada perawat

e. Standarisasi Prosedur dan Praktik Klinis

Standarisasi bertujuan mengurangi variasi tindakan yang dapat menimbulkan kesalahan. Bentuk standar antara lain *Clinical pathway*, SOP, dan Checklist keselamatan. Contoh penerapanya yaitu: Checklist operasi (*surgical safety checklist*), Prosedur pemberian obat

f. Penggunaan Teknologi untuk Keselamatan Pasien

Teknologi dapat membantu mengurangi kesalahan manusia. Contoh penggunaan teknologi yaitu Sistem rekam medis elektronik, Barcode obat, dan Alarm monitoring pasien. Manfaat penggunaan teknologi antara lain: mengurangi kesalahan identifikasi, meningkatkan akurasi data.

g. Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan

Tenaga kesehatan harus memiliki kompetensi dalam keselamatan pasien. Fokus pelatihan pada pencegahan infeksi, keselamatan obat, dan manajemen risiko. Pendidikan dan pelatihan dilaksanakan secara berkelanjutan dan kontinyu untuk seluruh tenaga kesehatan.

h. Pelaporan dan Pembelajaran dari Insiden

Pelaporan insiden sangat penting untuk mencegah kejadian berulang. Prinsip pelaporan tidak menghukum, bersifat rahasia, dan fokus pada

perbaikan sistem. Tindak lanjut dari pelaporan yaitu analisis akar masalah (*Root Cause Analysis / RCA*) dan perbaikan sistem

3. Sistem Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien

   Sistem pelaporan insiden merupakan mekanisme penting dalam peningkatan mutu pelayanan. Pelaporan yang baik akan menjadi jalan untuk perbaikan masa berikutnya.

   a. Tujuan pelaporan

      Pelaporan insiden keselamatan pasien memiliki tujuan:

      1) Mengidentifikasi kesalahan
      2) Menganalisis penyebab
      3) Mencegah kejadian berulang

   b. Karakteristik sistem pelaporan yang efektif

      Pelaporan yang efektif mempunyai karateristik sebagai berikut:

      1) Non-punitive, tidak bersifat menghukum
      2) Rahasia, hanya diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
      3) Mudah digunakan, informatif yang meliputi jenis kejadian, siapa yang terlibat, kapan, dimana, mengapa bisa terjadi, dan proses kejadianya
      4) Tepat waktu, segera membuat laporan ketika ada insiden
      5) Memberikan umpan balik, menjadi pelajaran bagi pengambil kebijakan

   c. Alur Pelaporan Insiden di Rumah Sakit

      Supaya insiden dapat tertangani dengan baik, maka alur pelaporan ahrus jelas, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

      1) Pelaporan internal oleh tenaga kesehatan
      2) Analisis insiden (RCA untuk kasus berat)
      3) Tindak lanjut dan perbaikan sistem
      4) Pelaporan eksternal (nasional)

   d. Hambatan Pelaporan Insiden

      Seringkali insiden keselamatan pasien tidak dilaporkan, karena:

      1) Takut disalahkan, labeling sering menjadi dampak yang paling banyak terjadi sehingga pelaku lebih memilih diam tidak melaporkan daripada harus menjadi pihak yang disalahkan.
      2) Kurangnya pengetahuan, beban kerja yang tinggi kadang menjadi penyebab tenaga kesehatan sulit berbagi fokus perhatian terhadap aspek lain.
      3) Budaya organisasi yang lemah. Kurangnya perhatian terhadap visi, misi dan tujuan organisasi menjadikan budaya organisasi kurang solid.
      4) Sistem pelaporan yang kompleks, rumit dan kurangnya sosialisasi sistem pelaporan sering menjadi hambatan ketika akan melaporkan insiden

D. Kesimpulan

Keselamatan pasien adalah suatu sistem dalam pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya cedera akibat kesalahan atau kelalaian dalam proses asuhan. Upaya ini mencakup penerapan standar seperti identifikasi pasien yang tepat, komunikasi efektif (misalnya SBAR), keamanan penggunaan obat, ketepatan prosedur, pencegahan infeksi, dan pencegahan risiko jatuh. Keselamatan pasien juga menekankan budaya tidak saling menyalahkan (*no blaming culture*), pelaporan insiden secara terbuka, serta pembelajaran berkelanjutan dari setiap kejadian untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.

Manajemen risiko klinis merupakan proses sistematis yang dilakukan untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko yang dapat membahayakan pasien selama pelayanan kesehatan. Tahapannya meliputi identifikasi risiko, analisis tingkat kemungkinan dan dampak, penentuan prioritas risiko, serta implementasi strategi pengendalian seperti penyusunan SOP, pelatihan tenaga kesehatan, dan monitoring berkelanjutan. Dengan penerapan manajemen risiko klinis yang efektif, potensi terjadinya insiden dapat diminimalkan, sehingga keselamatan pasien sebagai tujuan utama pelayanan kesehatan dapat tercapai secara optimal.

Glossarium

AD ART : Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga
Anti-HBs : Antibody to Hepatitis B Surface Antigen
Anti-HCV : Antibody to Hepatitis C Virus
Anti-HIV : Antibody to Human Immunodeficiency Virus
BCMA : *Barcode Medication Administration*
FMEA : Failure Mode and Effect Analysis
HAIs *: Healthcare-Associated Infections*
HBIG : Hepatitis B Immunoglobulin
HbsAg : Hepatitis B Surface Antigen
HBV : Hepatitis B Virus
IOM : Institute of Medicine
IPO : Input Process Output
IPSG *: International Patient Safety Goals*
JCI : Joint Commission International
K3 : Keselamatan Kesehatan Kerja
KTC : Kejadian Tidak Cedera
KTD : Kejadian Tidak Diharapkan
PEP HIV : Post-Exposure Prophylaxis for Human Immunodeficiency Virus
PPI : Pencegahan dan Pengendalian Infeksi
RCA *: Root Cause Analysis*
RS : Rumah Sakit
SBAR : Situation, Background, Assessment, Recommendation
SDM : Sumber Daya Manusia
SOP : Standard Operational Procedure
WHO : World Health Organization

SOP PENANGANAN KEJADIAN TIDAK DIINGINKAN (KTD)
(TERTUSUK JARUM BEKAS PASIEN)

1. Tujuan
   Menetapkan prosedur standar penanganan kejadian tertusuk jarum bekas pasien agar risiko infeksi menular dapat diminimalkan dan pelaporan dilakukan secara tepat dan cepat.
2. Ruang Lingkup
   SOP ini berlaku untuk seluruh tenaga kesehatan dan staf rumah sakit yang berisiko terkena tertusuk jarum bekas pasien.
3. Definisi
   Tertusuk jarum bekas pasien adalah kejadian tidak diinginkan yang terjadi akibat tertusuk alat tajam (jarum suntik, jarum infus, dll) yang sudah digunakan pada pasien.
4. Prosedur

No	Langkah Kerja	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
1	**Tindakan awal:** Cuci luka dengan air mengalir dan sabun antiseptik	Tenaga kesehatan yang tertusuk	Segera setelah kejadian
2	Laporkan kejadian ke atasan langsung dan Tim K3RS/Tim PPI	Tenaga kesehatan yang tertusuk	Maksimal 1 jam setelah kejadian
3	Isi Formulir Laporan KTD tertusuk jarum bekas pasien	Tenaga kesehatan yang tertusuk	Maksimal 2 jam setelah kejadian
4	Evaluasi risiko oleh dokter K3:	Dokter K3 / IGD	Dalam 24 jam setelah laporan

No	Langkah Kerja	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
	pemeriksaan darah (HBsAg, Anti-HBs, Anti-HCV, Anti-HIV) petugas dan sumber		
5	Pemberian profilaksis (vaksin HBV, HBIG, PEP HIV) bila diperlukan	Dokter K3	Sesuai hasil evaluasi risiko
6	Dokumentasi dan rekam medis	Tenaga kesehatan K3RS dan bagian rekam medis	Segera setelah tindakan
7	Monitoring lanjutan: pemeriksaan ulang darah di 6 minggu, 3 bulan, 6 bulan	Dokter K3	Sesuai jadwal monitoring
8	Investigasi dan analisis kejadian	Tim Mutu/K3RS/PPI	Dalam 7 hari kerja
9	Tindak lanjut perbaikan sistem (pelatihan, revisi SOP, penggunaan safety devices)	Manajemen RS dan Tim Mutu	Berkelanjutan

5. Dokumentasi
   a) Formulir Laporan KTD tertusuk jarum bekas pasien
   b) Rekam medis petugas yang terkena
   c) Laporan investigasi dan rekomendasi perbaikan
6. Penutup
   SOP ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan harus dipatuhi seluruh staf rumah sakit untuk menjamin keselamatan kerja dan mutu pelayanan.

FORMULIR LAPORAN KEJADIAN TIDAK DIINGINKAN (KTD)

Rumah Sakit [Nama RS]

No. Laporan : .....

Tanggal Kejadian : .....

Waktu Kejadian : .....

Tempat Kejadian : .....

A. Data Pelapor

Nama : .....

Jabatan : .....

Unit Kerja : .....

Nomor Kontak : .....

B. Kronologi Kejadian

Deskripsi kejadian (jelaskan secara singkat dan jelas): 5W +1 H

C. Data Pasien Sumber (Jika Diketahui)

Nama Pasien : .....

Nomor Rekam Medis : .....

Diagnosa : .....

D. Jenis Alat Tajam

Jenis Jarum : ☐ Jarum Suntik ☐ Jarum Infus ☐ Jarum Lainnya: _____

Kondisi Alat : ☐ Terpakai ☐ Baru

E. Tindakan Awal yang Dilakukan

☐ Cuci Luka dengan Sabun dan Air Mengalir

☐ Melaporkan Kejadian

☐ Mengisi Formulir Laporan

☐ Mendapatkan Pemeriksaan/Dokter K3

☐ Mendapatkan Profilaksis (Vaksin/PEP)

F. Pemeriksaan Laboratorium (Isi oleh Dokter K3)

Pemeriksaan	**Hasil Awal**	**Tanggal Pemeriksaan**	**Hasil Monitoring**	**Tanggal Pemeriksaan**
HBsAg Petugas				
Anti-HBs Petugas				
Anti-HCV Petugas				

Anti-HIV Petugas				
HBsAg Pasien				
Anti-HCV Pasien				
Anti-HIV Pasien				

G. Tindak Lanjut

Tindakan yang diberikan: ☐ Vaksin HBV ☐ HBIG ☐ PEP HIV ☐ Lainnya: _____

Tanggal Pemberian : .....

H. Penanggung Jawab Pelaporan

Nama :

Jabatan :

Tanda Tangan :

Tanggal :

EVALUASI CAPAIAN PEMBELAJARAN

AKTIVITAS 1 — KNOWS HOW

a. Mini Case (Diskusi Kelompok)

   Seorang pasien lansia dirawat di ruang rawat inap dengan diagnosis stroke. Pasien mengalami jatuh saat hendak ke kamar mandi tanpa pendamping. Tidak ada cedera serius, namun pasien mengeluh nyeri ringan.

   Tugas Mahasiswa:

   1. Identifikasi jenis insiden keselamatan pasien
   2. Analisis faktor risiko yang berkontribusi
   3. Tentukan prioritas tindakan pencegahan
   4. Identifikasi *red flags* yang harus diwaspadai

b. Mini Case (Diskusi Kelompok)

   Seorang perempuan, 20 tahun, dirawat dengan trauma kepala berat. Pasien direncanakan operasi dengan indikasi subdural hematom. Hasil pengkajian kesadaran sopor, GCS 11, pasien gelisah, kadang melakukan gerakan yang tidak terkontrol. Apa warna gelang tambahan untuk kondisi pasien tersebut?

   Tugas Mahasiswa:

   1. Identifikasi kondisi pasien
   2. Identifikasi berbagai warna gelang sesuai kondisi pasien
   3. Analisis warna gelang yang tepat untuk pasien tersebut
   4. Identifikasi *red flags* yang harus diwaspadai

AKTIVITAS 2 — SHOWS HOW

Simulasi / Skill Lab

Mahasiswa melakukan simulasi:

a. Identifikasi risiko pasien jatuh
b. Edukasi pasien dan keluarga
c. Simulasi pelaporan insiden menggunakan formulir

Fokus:

a. Urutan tindakan
b. Komunikasi efektif
c. Keselamatan pasien

ASESMEN (PIRAMIDA MILLER)

Level Miller	Metode
Knows / Knows How	Self-check + analisis kasus
Shows How	OSCE keselamatan pasien

Referensi

Adnyani, N. L. G. S., Nugraha, I. N. A., & Rudiartha, I. G. L. M. (2022). Evaluasi pelaporan insiden keselamatan pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Karangasem: Evaluation of reporting patient safety incident at Karangasem Regional General Hospital. *Jurnal Ilmiah Keperawatan (Scientific Journal of Nursing)*, *8*(4), 537-549.

Carayon, P., Kleinschmidt, P., Hose, B. Z., & Salwei, M. (2020). Human factors and ergonomics in health care and patient safety from the perspective of medical residents. *Textbook of patient safety and clinical risk management*, 81-89.

Carayon, P., Kleinschmidt, P., Hose, B. Z., & Salwei, M. (2020). Human factors and ergonomics in health care and patient safety from the perspective of medical residents. *Textbook of patient safety and clinical risk management*, 81-89.

Dhamanti, I., Leggat, S., Barraclough, S., & Tjahjono, B. (2019). Patient safety incident reporting in Indonesia: an analysis using World Health Organization characteristics for successful reporting. *Risk management and healthcare policy*, 331-338.

Donaldson, M. S., Corrigan, J. M., & Kohn, L. T. (Eds.). (2000). To err is human: building a safer health system.

Goekcimen, K., Schwendimann, R., Pfeiffer, Y., Mohr, G., Jaeger, C., & Mueller, S. (2023). Addressing patient safety hazards using critical incident reporting in hospitals: a systematic review. *Journal of Patient Safety*, *19*(1), e1-e8.

Gqaleni, T. M., Mkhize, S. W., & Chironda, G. (2024). Patient safety incident reporting and learning guidelines implemented by health care professionals in specialized care units: Scoping review. *Journal of Medical Internet Research*, *26*, e48580.

Gupta, M., Ramakrishana, A., Mahmood, L. S., Ranapurwala, M., Modi, C., Joshi, S., ... & Pandya, H. V. (2024). Designing and validating an interprofessional module on patient safety in India centred on International Patient Safety Goals.

Hughes, R. (2008). Patient safety and quality: An evidence-based handbook for nurses.

Indriyani, I., Shaluhiyah, Z., & Lestantyo, D. (2026). Implementation of the International Patient Safety Goals in Efforts to Reduce the Risk of Patient Falls in Hospitals: A Behavioral Perspective. *Contagion: Scientific Periodical Journal of Public Health and Coastal Health*, *8*(1), 79-93.

Koskiniemi, S., Syyrilä, T., Hämeen-Anttila, K., Mikkonen, S., Manias, E., Rafferty, A. M., ... & Härkänen, M. (2025). Patient safety incident reporting software: A

cross-sectional survey of nurses and other users' perspectives. *Journal of Advanced Nursing*, *81*(9), 5401-5413.

Kumah, A. (2025). Adverse event reporting and patient safety: the role of a just culture. *Frontiers in Health Services*, *5*, 1581516.Kusuma, R., et al. (2024). Barriers to patient safety incident reporting.

Kurniawati, N. Y., Kep, M., Rusmini, S., Milwati, S., Kp, S., Arruum, D., ... & KKK, M. (2025). *Buku Ajar Manajemen Patient Safety*. Optimal Untuk Negeri.

Listiowati, E., Arini, M., Nurmansyah, M. I., Rachmawati, E., & Samsudin, A. (2024). Patient Safety Incident Reporting Challenges in Indonesian Private Hospitals. *Global Medical & Health Communication (GMHC)*, *12*(1), 18-25.

Narayan, A. K., Foster, N., Kadom, N., Scott, J. A., Flores, E. J., Broder, J. C., ... & Burstin, H. (2025). Six steps to improving health equity using quality improvement and patient safety tools. *Radiology*, *314*(2), e232750.

Nurdin, D. A., & Wibowo, A. (2021). Barriers to reporting patient safety incident in health care workers: integrative literature review. *Indonesian Journal of Health Administration*, *9*(2), 210-217.

Purwarini, J. (2024). Application of patient safety incident reporting system in hospitals: Literature review. *Jurnal Mutiara Ners*, *7*(1), 22-29.

Putri, F. N. (2023). *Gambaran Pelaksanaan Identifikasi Pasien Hypertension Berdasarkan Sasaran Keselamatan Pasien (SKP) di Rumah Sakit Dadi Keluarga Ciamis* (Doctoral dissertation, POLITEKNIK KESEHATAN TASIKMALAYA).

Reis, C. T., Paiva, S. G., & Sousa, P. (2018). The patient safety culture: a systematic review by characteristics of hospital survey on patient safety culture dimensions. *International Journal for Quality in Health Care*, *30*(9), 660-677.

Rosen, A. K., & Rivard, P. E. (2025). Moving the needle on measurement of patient safety: the evolving role of the agency for healthcare research and quality (AHRQ) Patient safety indicators. *Joint Commission Journal on Quality and Patient Safety*, *51*(3), 229-231.

Sakit, K. K. P. R. (2015). Pedoman Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien (IKP)(Patient Safety Incident Report). *Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit*, *25*.

Sakit, K. A. R. (2017). Standar nasional akreditasi rumah sakit edisi 1. *Jakarta: Komisi Akreditasi Rumah Sakit*, 217-225.

Susanto, A., & Handiyani, H. (2023). Analisis Determinan Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien Oleh Perawat Di Rumah Sakit: Tinjauan Sistimatik: Determinant Analysis Of Patient Safety Incident Reporting By Nurses In Hospital: A Systematic Review. *Quality: Jurnal Kesehatan*, *17*(1), 52-63.

Tristantia, A. D. (2018). Evaluasi Sistem Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien Di Rumah Sakit. *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia*, *6*(2), 83-94.Vincent, C. (2020). *Patient safety*. Wiley Blackwell.

World Health Organization. (2021). *Global patient safety action plan 2021-2030: towards eliminating avoidable harm in health care*. World Health Organization.

BAB 3

PENGENDALIAN INFEKSI DAN K3 DI PELAYANAN KEPERAWATAN

A. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menguasai konsep dasar manajemen keperawatan, peran perawat manajer, serta etika–legal dalam pengelolaan pelayanan.	CPMK-1; CPMK-2
CPL-2	Mampu menganalisis organisasi pelayanan keperawatan dan sistem layanan kesehatan untuk mendukung tata kelola dan kesinambungan layanan.	CPMK-2; CPMK-7
CPL-3	Mampu menerapkan kepemimpinan keperawatan, komunikasi efektif, kolaborasi, dan manajemen konflik serta perubahan dalam tim.	CPMK-3; CPMK-5
CPL-4	Mampu merencanakan dan mengelola SDM keperawatan (kebutuhan, penjadwalan, delegasi, supervisi) secara adil, aman, dan efisien.	CPMK-4; CPMK-5
CPL-5	Mampu menerapkan manajemen mutu, keselamatan pasien, manajemen risiko, PPI, dan K3 sebagai budaya kerja untuk peningkatan layanan.	CPMK-6; CPMK-7
CPL-6	Mampu memanfaatkan dokumentasi, informatika, standar–akreditasi, serta data kinerja untuk evaluasi, pelaporan, dan perbaikan mutu berkelanjutan.	CPMK-7; CPMK-2; CPMK-6

B. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menjelaskan konsep dasar manajemen keperawatan, fungsi manajemen, peran perawat manajer, serta etika–legal dalam pelayanan.
CPMK-2	Menganalisis organisasi pelayanan keperawatan dan sistem layanan kesehatan (tata kelola, standar, kebijakan) untuk mendukung pengambilan keputusan manajerial.
CPMK-3	Menerapkan kepemimpinan keperawatan, manajemen perubahan, komunikasi efektif, kolaborasi, dan manajemen konflik dalam pengelolaan tim.
CPMK-4	Merencanakan kebutuhan dan penjadwalan SDM keperawatan berdasarkan beban kerja, kompetensi, dan prinsip keadilan–keselamatan.
CPMK-5	Mengelola manajemen asuhan keperawatan melalui delegasi, supervisi, koordinasi, serta pemanfaatan sumber daya/logistik secara efisien.
CPMK-6	Menerapkan manajemen mutu, keselamatan pasien, manajemen risiko klinis, PPI, dan K3 dalam peningkatan kinerja pelayanan keperawatan.

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-7	Menggunakan dokumentasi, informatika, audit data, dan pelaporan untuk evaluasi kinerja serta menyusun proyek mini peningkatan mutu berbasis data.

E. Pemetaan

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 3. Pengendalian Infeksi dan K3 di Pelayanan Keperawatan	3.1 Menerapkan langkah PPI pada kegiatan keperawatan dan pemantauan kepatuhan prosedur.	3.2 Menyusun langkah K3 untuk pencegahan cedera kerja dan paparan risiko di unit layanan.	CPMK-6	CPMK-5; CPMK-1

F. Asesmen (berbasis CPMK)

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-1	Ujian tulis (CBT/essay terstruktur)	Persentase jawaban benar konsep fungsi manajemen dan akurasi penerapan peran–akuntabilitas pada skenario.	10	Nilai ujian; lembar jawaban
CPMK-5	Studi kasus delegasi–supervisi & logistik	Ketepatan keputusan delegasi dan rencana supervisi, serta ketepatan rencana pengendalian logistik (skor rubrik).	15	Laporan kasus; rencana delegasi; rencana logistik
CPMK-6	Simulasi fasilitasi/kemitraan (role play)	Kualitas fasilitasi partisipasi + kejelasan rencana kolaborasi/advokasi (skor rubrik).	15	Lembar penilaian; rencana kemitraan

Rubrik CPMK-1

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
1.1 Ketepatan konsep fungsi manajemen (% benar)	<60% benar; miskonsepsi dominan	60–74% benar; miskonsepsi masih ada	75–89% benar; kesalahan minor	≥90% benar; konsisten
1.2 Ketepatan penerapan peran–akuntabilitas pada skenario	Keliru/tidak relevan	Relevan sebagian; alasan lemah	Tepat; alasan logis	Tepat; alasan kuat dan komprehensif

Rubrik CPMK-2

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
2.1 Ketepatan pemetaan struktur & alur layanan	Tidak akurat; komponen inti hilang	Cukup akurat; masih ada kekeliruan bermakna	Akurat; kekeliruan minor	Sangat akurat; komprehensif dan jelas
2.2 Ketepatan gap analysis & prioritas perbaikan	Gap tidak sesuai standar; prioritas acak	Gap sebagian tepat; prioritas kurang konsisten	Gap tepat; prioritas jelas	Gap sangat tepat; prioritas sangat logis & berbasis risiko

Rubrik CPMK-3

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
3.1 Kinerja kepemimpinan & manajemen perubahan (checklist)	≤60% perilaku tercapai; tidak terarah	61–75% tercapai; arah sebagian jelas	76–90% tercapai; terarah & konsisten	>90% tercapai; adaptif, memotivasi, terstruktur
3.2 Komunikasi efektif & resolusi konflik (checklist)	Konflik tidak tertangani; komunikasi tidak jelas	Ada upaya; solusi belum disepakati	Solusi disepakati; komunikasi runtut	Solusi kuat; komunikasi sangat efektif & menjaga hubungan kerja

Rubrik CPMK-4

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
4.1 Akurasi perhitungan kebutuhan tenaga	Banyak kesalahan; asumsi tidak jelas	Cukup tepat; masih ada kesalahan bermakna	Tepat; kesalahan minor	Sangat tepat; asumsi jelas & dapat dipertanggungjawabkan
4.2 Kualitas jadwal dinas (cakupan, aturan, pemerataan)	Cakupan tidak aman; melanggar aturan	Cakupan cukup; pemerataan kurang	Cakupan aman; aturan dipatuhi; cukup adil	Cakupan sangat aman; patuh aturan; sangat adil & minim risiko kelelahan

Rubrik CPMK-5

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
5.1 Ketepatan keputusan delegasi & rencana supervisi	Delegasi tidak sesuai kompetensi/risiko	Delegasi cukup sesuai; supervisi kurang spesifik	Delegasi sesuai; supervisi jelas	Delegasi sangat tepat; supervisi terukur & antisipatif risiko
5.2 Ketepatan rencana pengendalian logistik	Tidak berbasis kebutuhan; rawan kekosongan	Berbasis kebutuhan sebagian; kontrol kurang	Berbasis data; kontrol memadai	Berbasis data komprehensif; kontrol sangat efektif (minim stockout/overstock)

Rubrik CPMK-6

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
6.1 Ketepatan indikator & analisis temuan audit	Indikator tidak tepat; analisis tidak sesuai	Indikator cukup; analisis terbatas	Indikator tepat; analisis jelas	Indikator sangat tepat; analisis kritis berbasis data/tren
6.2 Kelayakan rencana mitigasi risiko/PPI/K3 (terukur)	Rencana umum; tidak terukur	Ada rencana; indikator belum jelas	Rencana spesifik; indikator terukur	Rencana sangat spesifik, terukur, realistis; prioritas berbasis risiko

Rubrik CPMK-7

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
7.1 Kelengkapan laporan berbasis data (baseline–target–hasil)	Data tidak lengkap; tidak dapat dievaluasi	Data cukup; hubungan baseline–hasil kurang jelas	Data lengkap; evaluasi jelas	Data sangat lengkap; evaluasi kuat dan transparan
7.2 Kualitas proyek mini peningkatan mutu (rencana–uji–evaluasi)	Tidak sistematis; tanpa evaluasi hasil	Sistematis sebagian; evaluasi terbatas	Sistematis; evaluasi hasil memadai	Sangat sistematis; evaluasi kuat; rekomendasi implementatif & berkelanjutan

A. Pendahuluan

Pengendalian Infeksi dalam sektor industri dikenal dengan istilah pajanan/hazard Biologi *pest control* atau lebih dikenal dengan *Toxicology control* dengan pendekatan CDC dan standarisasi ABOHN , Pentingnya K3 dalam Keperawatan berperan sangat krusial dalam buku ini tertuang sudut pandang

bagaimana pelayanan keperawatan dalam aspek "pengendalian infeksi dan K3" di sektor Industri.

Kesehatan dan keselamatan kerja (K3) adalah suatu pemikiran dan upaya dalam menjamin keutuhan dan kemampuan jasmani maupun rohani tenaga kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salah satu isu global yang sangat berhubungan dengan kualitas pelayanan kesehatan begitupun di area keperawatan.

Menurut Permenkes no 66 tahun 2016 keselamatan dan kesehatan kerja di area rumah sakit merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan bagi karyawan rumah sakit termasuk perawat, pasien, pendamping pasien, pengunjung maupun lingkungan rumah sakit melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja di rumah sakit.

K3 di industri menurut Kemnaker adalah serangkaian upaya (sesuai UU No. 1/1970 & PP No. 50/2012) untuk menjamin keselamatan pekerja dan aset, melalui identifikasi bahaya, manajemen risiko (HIRARC), dan pelatihan Ahli K3 Umum untuk mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

Kesehatan dan keselamatan kerja (K3) merupakan sebuah upaya dalam melindungi hal-hal yang berbahaya agar semua orang yang berada pada lingkungan kerja selalu dalam keadaan aman dan sehat. Menciptakan lingkungan untuk bekerja yang aman dan sehat akan meminimalisir terjadinya insiden atau kecelakaan yang dapat menyebabkan absen kerja yang berkepanjangan serta biaya yang signifikan bagi perusahaan.

Tenaga kerja yang terluka atau sakit dapat menghambat produktivitas serta mengganggu tugas. Penyelenggaraan keselamatan kerja pada dasarnya bertujuan untuk menemukan kelemahan yang ada dan kemungkinan terjadinya kecelakaan di lingkungan kerja.

Kesehatan kerja mencakup berbagai bidang spesialisasi. Perawat dan dokter kesehatan kerja sepertihalnya Kedokteran Okupasi degan gelar Sp.OK maupun M.KKK sedangkan bagi perawat M.Kep (Okupasi/OHN) belum ada di Indonesia adapun kegiatan mereka diantaranya melakukan kegiatan pengawasan medis bersamaan dengan diagnosis dan pengobatan cedera dan penyakit terkait pekerjaan.

Epidemiolog dan toksikolog kerja seringkali berperan sebagai pendukung bagi para profesional kedokteran kerja dan ahli higiene industri. Epidemiolog kerja memberikan dukungan untuk menilai insiden dan prevalensi penyakit terkait pekerjaan.

Toksikolog kerja mengevaluasi efek zat kimia terhadap kesehatan di tempat kerja berdasarkan temuan toksikologi. Para profesional kesehatan ini terlibat dalam mengembangkan informasi komunikasi bahaya, menetapkan tingkat paparan yang

aman seperti batas paparan kerja, dan membantu dalam penilaian potensi efek kesehatan terkait pekerjaan dari situasi paparan bahan kimia.

Peran berbagai profesional ini dapat tumpang tindih dan tim multidisiplin dapat terlibat untuk menangani masalah kesehatan kerja yang kompleks. Para profesional yang bekerja di berbagai aspek bidang kesehatan kerja ini memiliki kebutuhan yang sama untuk mengakses informasi yang berkaitan dengan toksikologi dan efek kesehatan buruk dari bahan kimia.

Menurut ABOHN dalam "*The Career Guide to Occupational Health Nursing*" Pengendalian Infeksi – adalah disiplin ilmu yang berkaitan dengan pencegahan infeksi terkait perawatan kesehatan dan menangani faktor-faktor yang berkaitan dengan penyebaran infeksi di lingkungan perawatan kesehatan (baik antar pasien, dari pasien ke staf, dan dari staf ke pasien, atau antar staf), termasuk pencegahan, pemantauan, dan investigasi penyebaran infeksi yang terbukti atau dicurigai di lingkungan perawatan kesehatan tertentu, dan manajemen wabah.

Setiap peran digunakan saat melakukan aktivitas kesehatan kerja dasar, aktivitas tempat kerja ini meliputi kesehatan dan kesejahteraan, manajemen kasus, ergonomi, keselamatan kerja, pengendalian infeksi, kesiapsiagaan bencana, dan lainnya seperti kesehatan perjalanan. Dalam kategori luas ini, survei terbaru yang dilakukan oleh ABOHN (*American Board for Occupational Health Nurses, Inc.)*

Berikut Gambaran Infection Prefention dengan Occupational Healh dalam pelayanan Keperawatan:

Tabel 3. 1 Perbandingan Fungsi Infection Prevention dan Occupational Health

Function	Infection Prevention	Occupational Health
Primary Focus	Preventing health care-associated infections	Promoting employee health and safety
Contact Tracing	Identifies exposed staff based on patient interactions	Notifies exposed staff, monitors symptoms, arranges testing
Vaccination Monitoring	Tracks adherence and uptake rates	Administers vaccines and maintains records
Respiratory Protection	Oversees program policies and personal protective equipment protocols	Conducts fit testing and ensures staff compliance
Exposure Management	Investigates infectious exposures (eg, tuberculosis, COVID-19, bloodborne pathogens)	Manages staff follow-up, testing, and prophylaxis
Injury Reporting	May assist with infection-related injuries (eg, needlesticks)	Handles all workplace injuries (eg, sprains, fractures, chemical splashes)
Policy Development	Develop infection control policies and procedures	Develop employee health and safety protocols
Education & Training	Provides infection control training to staff	Provides training on workplace safety and injury prevention
Surveillance	Monitors infection trends and outbreaks	Tracks employee illness trends and absenteeism
Regulatory Compliance	Ensures compliance with CDC, US Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS), and The Joint Commission standards	Ensures compliance with CDC, Occupational Safety and Health Administration, CMS, The Joint Commission, and other employee health regulations

Berdasarkan tabel diatas pelayanan keperawatan bisa digambarkan dalam imlementasi 2(Dua) Sektor yakni sektor FASYANKES (Fasilitas pelayanan Kesehatan dan Industri, dalam sektor FASYANKES subject berfokus pada Pasien dan Kepatuhan Perawat dalam melakukan SOP pencegahan dan pengendalian Infeksi atau sering di kenal dengan jabatannya sebagai IPCN (*Infection Prefention Control Nurse*) sedangkan di sektor industry bersubject pada pekerja, perawat bisa berposisi sebagai paramedic, industria nurse, maupun *Occupational Health Nurse* (OHN) dalam pengimplementasian *Occupational Health Programe* yang berfokus pada program Kesehatan Pekerja meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif terhadap pekerja dan lingkungan kerjanya. Dalam pelaksanaannya, OHN mengintegrasikan ilmu keperawatan dengan prinsip-prinsip kesehatan dan keselamatan kerja (K3), guna menciptakan tempat kerja yang sehat, aman, dan produktif. Namun dalam praktiknya di Indonesia masih minm OHN yang di

pekerjakan pada FASYANKES namun lebih kepada jabatan PMKP (Pemngendali Mutu dan Keselamatan Pasien) dan K3RS sedangkan di Singapura sudah banyak FASYANKESnya yang memberdayakan posisi tersebut.

Dalam kurikulim Ners Indonesia AIPNI 2021 sudah tertera cukup baik dan cukup Aplikatif di lapangan/ industry pada "Keseelamatan Pasien dan K3" di bidang Keperawatan Manajemen dengan perluasan subject "Pasien" berlaku sama dengan "Pekerja", selain itu bidang keperawatan memang lebih aplikatif jika diterapkan di Industri sebagaimana OHN dituntut untuk mengerti berbagai bidang keilmuan seperti Manajemen Ekonomi-Bisnis Perusahaan, Manajemen Operasional-Standarisasi Klinik Industri, Hukum, Lingkungan, Gizi, Sosial-Perilaku-lingkungan, Keperawatan-Medical-Epidemologi "Kesehatan Kerja", berikut tabel kurikullum AIPNI 2021:

Tabel 3. 2 Ruang Lingkup Materi Keselamatan Pasien dan Keselamatan Kesehatan Kerja (K3)

1. Prinsip dan konsep keselamatan pasien 2. Pengaruh faktor lingkungan dan manusia pada keselamatan pasien 3. Cara untuk meningkatkan keselamatan pasien dengan menggunakan metode peningkatan kualitas 4. EBP untuk peningkatankeselamatan pasien 5. Budaya dalam lingkup kerja perawat dalam peningkatan keselamatan pasien 6. Penyebab terjadinya *adverse events*terkait prosedur invasif 7. K3 dalam keperawatan: pentingnya, tujuan, manfaat, & etika. 8. Ruang lingkup K3 dalam keperawatan 9. Kebijakan K3 yang berkaitan dengan keperawatan di Indonesia 10. Konsep dasar K3: sehat, kesehatan kerja, risiko &*hazard* dalam pemberian asuhan keperawatan (somatik, perilaku, lingkungan, ergonomik, pengorganisasian pekerjaan, budaya kerja) 11. Risiko &*hazard* dalam proses keperawatan (pengkajian – perencanaan, implementasi, evaluasi) 12. Peran manajemen risiko dalam keselamatan pasien: Proses dan hirarki 13. Manajemen risiko K3 di dalam dan luar gedung 14. Mengenali, dan berespons terhadap *adverse events* 15. Penggunaan teknologi dalam peningkatan keselamatan pasien 16. Peran kerja tim untuk keselamatan pasien 17. Peran pasien dan keluarga sebagai *partner* di pelayanan kesehatan untuk mencegah terjadinya bahaya dan *adverse events* 18. Penyakit akibat kerja pada perawat: penyakit menular & tidak menular 19. Penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja pada perawat 20. Upaya pencegahan penyakit akibat kerja pada perawat 21. Upaya mencegah dan meminimalkan risiko dan *hazard* pada tahap pengkajian – perencanaan – implementasi - evaluasi asuhan keperawatan 22. Upaya memutus rantai infeksi: *precaution, medication safety*	Keselamatan Pasien dan Keselamatan Kesehatan Kerja

Bahan Kajian/Pengetahuan yang dipelajari	MATA KULIAH
23. Upaya mencegah *hazard* fisik-radiasi-kimia 24. Upaya mempertahankan ergonomik pada posisi berbaring, duduk, berdiri, dan berjalan 25. Upaya mencegah *hazard* psikososial	

Berikut dasar Hukum yang wajib dipedomani sebagai Pelaksana Pelayanan Keperawatan di sektor Industri:

- Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja

- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Kesehatan Dan Besaran Tarif Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja
- Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyakit Akibat Kerja
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No: Per.03/Men/1982 Tentang Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Pelayanan Kesehatan Penyakit Akibat Kerja

BPJS Ketenagakerjaan Catat 4.410 Kasus Penyakit Akibat Kerja Hingga Mei 2025, BPJS Ketenagakerjaan bekerja sama dengan 6.299 fasilitas kesehatan (PLKK) di seluruh Indonesia, termasuk rumah sakit, klinik, dan puskesmas, untuk memastikan penanganan medis peserta berjalan cepat dan tepat. Dalam prosedurnya, kasus dugaan PAK dapat dilaporkan oleh pekerja, keluarga, serikat pekerja, maupun fasilitas kesehatan, dan harus disampaikan maksimal 2×24 jam sejak diagnosis ditegakkan. Data yang dipaparkan menunjukkan hingga Mei 2025 terdapat 323.652 kasus kecelakaan kerja dengan 134.207 tenaga kerja terdampak. Sementara itu, pelaporan penyakit akibat kerja (PAK) mencapai 4.410 kasus dengan nilai klaim lebih dari Rp51 miliar. Peningkatan signifikan sempat terjadi pada tahun 2021-2022 akibat pandemi COVID-19 yang banyak menimpa tenaga kesehatan.BPJS Ketenagakerjaan berharap perusahaan, serikat pekerja, dan pekerja semakin memahami hak serta prosedur dalam melaporkan kecelakaan maupun penyakit akibat kerja, sehingga tercipta perlindungan yang komprehensif dan hubungan industrial yang harmonis.

Tabel 3. 3 Daftar Penyakit Kerja yang Spesifik

Daftar Penyakit Akibat Kerja yang Spesifik pada Pekerjaan Tertentu

Daftar Penyakit Akibat Kerja yang Spesifik pada Pekerjaan Tertentu (konsensus Tatalaksana Penyakit Akibat Kerja, Kemenkes Tahun 2019)

No	Jenis penyakit akibat kerja	Diagnosa Okupasi	ICD X	Tanda Khas	Agen/ Pajanan	Pekerjaan	Lama Pajanan	Faktor Individu	Faktor lain di luar pekerjaan	Kategori Penetapan Diagnosa
1	Tuberkulosis	TB Paru Akibat Kerja	TB Paru (A15.0)	Tidak Ada	Mycobacterium Tuberculosis dari manusia yang terinfeksi	Tenaga kesehatan yang melayani pasien TB, Petugas laboratorium memeriksa spesimen pasien TB, Tenaga non kesehatandi fasilitas kesehatan yang kontak dengan pasien/spesimen TB	Minimal 1 bulan	Tidak Ada	Tidak ada kontak dengan penderita TBdi luar tempat kerja.	A1 dan A2
2	Kanker disebab-kan oleh asbestos	Mesothelioma Akibat Kerja	Mesothelioma pleura (C45.0)	Tidak Ada	Asbes	Pekerja pada industri asbes, pekerja konstruksi, pekerja bengkel otomotif,	masa laten > 15tahun, durasi pajanan tidak ber- pengaruh	Tidak Ada	Tidak ada riwayat menggunakan atap asbes di luar tempat kerja, Tidak tinggal di area sekitar industri asbes	A2
3	Pneumokoniosis yang disebabkan oleh asbestos	Asbestosis Akibat Kerja	Pneumoconiosis karena asbes dan serat mineral lainnya/Asbestosis (J61)	Pleural plaque	Asbes	Pekerja pada industri asbes, pekerja konstruk-si, pekerja bengkel automotif,	masa laten > 15tahun, durasi pajanan minimal 15 tahun	Tidak Ada	Tidak ada riwayat mengguna- kan atap asbes di luar tempat kerja, Tidak tinggal di area sekitarindustri asbes	A2
4	Asma yang	Asma	Asma,	Gejala	Debu	Pembuat roti, kue dan makanan	Tidakber-	Tidak	Tidak ada alergen di	A1 dan A2
	dise-babkan oleh penyebab sensi- tisasi atau zat iritan yang dikenal dalam proses pekerjaan	Akibat Kerja	tidak ditentukan (J45.9)	timbul setelah terpajan dan berkurang apabila menghindaripajanan.	Tepung, Detergen bubuk yang mengan-dung enzym,Serbuk sari, Debu Semen	lain yang mengandung tepung, pekerja perusahaan pembuatdeterjen bubuk, Pekerja laundy, Pedagang bunga, Pekerja meubel,	pengaruh	ada riwayat asma atau alergi sebelum- nya	luar pekerjaan yang dapat menyebabkan timbulnya asma	
5	Dermatitis kontakiritan yang disebabkan oleh zat iritan yang timbuldari aktivitas pekerjaan, tidak termasuk dalam penyebab lain; dan	Dermatitis kontak iritan akibatkerja	Dermatitis kontak iritan kelompok agen penyebab utama: Sabun / Deterjen, Pelarut, Minyak dan pelumas, produk minyak bumi, Asam, alkali, Semen, garam logam, terak dan kaca wol (L.24)	Gejala berkurang apa-bila menghindari agen penyebab, morfologi lesi sesuai dengan pajanan pada area kontak,	Sabun / Deterjen, Pelarut, Minyak dan pelumas, produk minyak bumi, Asam,alkali, Semen, garam logam,terak dan kaca wol atau bahan iritan lainnya.	Pekerjaan yang menggunakan bahanpajanan yang bersifatiritan. Pekerja di ling-kungan basah (*wet workers* sepertinelayan, pembantu rumah tangga, penjual ikan, dll), Pekerja semen, Penata rambut,	DurasiTidak ber- pengaruh	Tidak ada	tidak ada kontak dengan bahan iritan yang berada di luar tempatkerja	A1 dan A2

6	Dermatitis kontakalergika dan urtikaria yang disebabkan oleh faktor penyebab alergi lain yang timbul dari aktivitas pekerja-an yang tidak termasuk dalam penyebab lain	Dermatitis kontak alergi akibat kerja	Dermatitis kontak alergi kelompok agen penyebab utama: antibiotik, pengawet, tanaman dan pohon, antiseptik, produk karet, pewarna, perekat dan agen bonding, logam (L23)	Area kontak sesuai dengan pajanan, tidak lang-sung timbul setelah kontak	Produk karet, pe-warna, perekat dan agen bonding, logam	Pekerja logam, penya-dap karet, Pekerja kebun yang menggu-nakan sarung tangan karet, Penyamak kulit, pekerja pembuat sepatu , pekerja tekstil di bagian pewarnaan, penata rambut,	-	Tidak ada	Tidak ada kontak dengan bahan pajanan di luar tempat kerja	A2
7	Penyakit yang disebabkan oleh faktor biologi laindi tempat kerja	Varicella Akibat Kerja	Varicella zoster virus dari manu- sia (B01)	Tidak Ada	Virus Varicella zoster	Tenaga kesehatan yang melayani pasien varicella	minimal14 hari setelah kontak	Tidak ada	Tidak kontak dengan penderita varicella di luar tempat kerja.	A1 dan A2
8	*Carpal tunnel syndrome* karena periode	*Carpal Tunnel Syndrom*	*Carpal Tunnel Syndrom* (G.56.0)	Tidak Ada	Gerakan berulang-ulang (gerak repetitif),	Dokter gigi,Pekerja dengan alat Jack Hammer, Pekerja mengetik, Tukang potong daging (butcher), pekerja gergaji	Minimal8 bulan	Tidak ada obesitas, tidak ada kehamilan,	Tidak ada aktifitas lain di luar peker- jaan yang dapat menyebabkan CTS	A1 dan A2
	berke-panjangan dengan gerak repetitif yang mengerahkan tenaga, pekerjaanyang melibatkan getaran, posisi ekstrim pada pergelangan tangan,	Akibat Kerja			pekerjaan yang meli-batkan ge-taran, Posisi ekstrim pada per-gelangan tangan terutama kombinasi dari risiko tersebut	(sawmill), pekerja perakitan (manufacture), pekerja pelinting rokok dengan tangan,pemain musik drum dan pekerja lainnya yang terpajan gerakan berulang (gerak repetitif), getaran, posisi ekstrim pada pergelangan tangan		tidak ada riwayat dislipide-mia, hiper-tensi, DM, Rheuma-thoid Arthritis dan tidak ada riwa-yat cidera pada per-gelangan tangan	seperti gerakan repetitif, pekerjaan yang melibat- kan getaran, posisi ekstrim pada perge- langan tangan	
9	Penyakit otot dan kerangka lain	Nyeri Punggung Bawah Sederhana Akibat Kerja	*Simple LBP* (M54.5)	*Keluhan ter-jadi segera setelah angkat angkut saat bekerja*	*Manual handling, whole body vibration*	Perawat yang angkat angkut pasien, Pengendara alat berat, Pekerja kuli panggul, penerbang helikopter, pramu-gari/pramugara mekanik pesawat, Anak Buah Kapal bagian mesin	Bersifatakut segera setelah terpaja-nan	Tidak ada riwayat trauma tulang punggung sebelum-nya, tidak ada riwa-yat RA/OApad a tu- lang pung-gung se-belumnya.	Tidak ada aktivitas *manual handling* dan *whole body vibration* di luar pekerjaan.	A1
10	Penyakit otot dankerangka lain	HNP Akibat Kerja	Kelainan Lumbal dan Diskus Interverte-bralis lain-nya dengan	Hasil rontgen Lesi di L3, L4, L5 Terjadi segera sete- lah posisi	*Manual handling, whole body vibration*	Perawat yang angkat angkut pasien, Pengendara alat berat, Pekerja kuli panggul, penerbang helikopter, pramugari/ pramugara, mekanik pesawat, Anak Buah Kapal bagian mesin	Bersifatakut segera setelah terpaja-nan	Tidak ada riwayat trauma tulang punggung sebelum-nya, tidak ada riwa-yat	Tidak ada aktivitas *manual handling* dan *whole body vibration* di luar pekerjaan	A2

			radikulopati (M51.1)	angkat ang-kut saat bekerja				RΛ/OΛpada tu- lang pung-gung se-belumnya.		
11	Penyakit yang disebabkan olehradiasi optik, meliputi ultra violet, radiasi elektromagnetik(visible light), infra merah, termasuk laser	Katarak Juvenilis Akibat Kerja	Katarak lainnya (H.26.8)	Tidak ada	*Ultra Violet, Infrared, Microwave, Pengion Radiasi*	Pengelas, Pekerjaan dengan paparan radiasi pengion dari mesin x-ray, reaktor nuklir, pandai besi, blower kaca, penerbang dan pekerja di landasan pesawat.	Minimal6 Bulan	Tidak ada riwayat trauma mata sebelumnya, Tidak ada riwayat DM sebelumnya	-	Λ1 dan Λ2
12	Penyakit yang disebabkan oleh radiasioptik, meliputi ultra violet, radiasi elektromagnetik(visible light), infra merah, termasuk laser	*Keratitis Exposure*	Photokera- titis (H16.1)	Gejala tim- bul segera setelah terpapar *exposure* las	*UV, infrared*	Welders, Pekerja peleburan logam, Pekerja *glass blower*,Pekerja yang ter- papar UV, *laser grade*3-4 (panjang gelombang 532 - 1064 nm)	Timbul < 24 jam setelah terpapar	Tidak ada	Tidak ada	Λ1
13	Kerusakan pendengaran yang disebabkan oleh kebisingan	Tuli sensorineural akibat bising di tempat kerja *(NoiseInduced Hearing Loss)*	Efek kebisingan padatelinga bagian dalam (H83.3)	*Sensoryne - ural Hearing Loss.* Pemeriksa - an audiometri nada murni didapatkan tuli sensorine - ural pada frekuensi antara 3000 – 6000 Hz	Bising berlebih	Pekerja drilling, Pekerja bengkel, Pengemudi alat berat,Pekerja kamar mesin kapal, Pekerja ruang mesin kompresor hiperbarik, Teknisi pesawat, Penerbang helikopter Pekerja di landasan pesawat, tenaga kesehatan evakuasi medis udaraPandai besi, Personil militer dan kepolisianyang menggunakan senjata api. Pekerjaanlainnya yang terpaparbising tinggi.	-	Tidak ditemukan riwayat genetik pada telinga, riwayat minum obat (ototoksik), infeksi telinga kronik), trauma kepala,	Tidak ada hobi mendengarkan musik keras, menembak,dan lain lain	Λ1 dan Λ2
14	Penyakit yang disebabkan oleh udara bertekanan atau udara yang didekompresi;	Otitic barotrauma akibat kerja	Aero otitic barotrauma (T70.0)	Tidakada	Perubahan Tekanan	Penerbang, Awak ka- bin dan atlet dirgan- tara, penyelam, tena- ga kesehatan pendamping ruang udaraHypobarik dan Hyperbarik (TOHB), Pekerja di bawah tanah (Compressed Air Worker (CAW)), tenaga kesehatan evakuasi medis udara	Bersifatakut segera setelah terpaja-nan	Tidak ada	Tidak ada	Λ2
15	Penyakit yang disebabkan oleh udara bertekanan atau udara yang didekompresi	Sinus baro trauma akibat kerja	Sinus baro trauma (T70.1)	Tidakada	Perubahan Tekanan	Penerbang, Awak ka- bin dan atlet dirgan- tara, penyelam, tena- ga kesehatan pendamping ruang udaraHypobarik dan Hyperbarik (TOHB), Pekerja di bawah tanah (Compressed Air Worker (CAW)), tenaga kesehatan	Bersifatakut segera setelah terpaja-nan	Tidak ada	Tidak ada	Λ2

	;					evakuasi medis udara				
16	Penyakit yang disebabkan oleh udara bertekanan atau udara yang didekompresi	Barotrauma (Mata, Saluran Cerna Saluran Na-pas, Kulit, Gigi) Akibat Kerja	Efek dari tekanan udara dan tekanan air, tidak spe- sifik (T70.9)	Tidakada	Perubahan Tekanan	Penerbang, Awak kabin dan atlet dir- gantara, penyelam, tenaga kesehatan pendamping ruang udara Hypobarik dan Hyperbarik (TOHB), Pekerja di bawah tanah *(Compressed Air Worker (CAW),* tenaga kesehatan evakuasi medis udara	Bersifat akut segera setelah terpajanan	Tidak ada	Tidak ada	A2
17	Penyakit yang disebabkan oleh udara bertekanan atau udara yang didekompresi	Penyakit Dekompresi Akibat Kerja *(Caisson Disease)*	*Caisson disease/ decompres- sion sickness* (T70.3)	Tidakada	Perubahan Tekanan	Penerbang, Awak ka- bin dan atlet dirgan- tara, penyelam, tena- ga kesehatan pendamping ruang udaraHypobarik dan Hyperbarik (TOHB), Pekerja di bawah tanah (Compressed Air Worker (CAW)), tenaga kesehatan evakuasi medis udara	Bersifatakut segera setelah terpaja-nan	Tidak ada	Tidak ada	A2
18	Virus Hepatitis	Hepatitis B Akibat kerja	Hepatitis B Akut (B16)	Pernah mengalami *needle stickinjury* dari pasien Hepatitis B	Virus Hepa- titis B dari darah dan/ cairan tubuh yang terin- feksi	Tenaga kesehatan yang merawat pasien, tenaga laboratorium,	kurangdari 6 bulan	Tidak ada riwayat Hepatitis B sebelum-nya (Peme- riksaan se- belumnya negatif)	Tidak ada riwayat transfusi darah	A2
19	Virus	Hepatiti	Hepatitis	Pernah	Virus Hepa-	Tenaga kesehatan yang merawat	kurangdari 6	Tidak ada	Tidak ada riwayat	A2

	Hepatitis	s C Akibat kerja	C Akut (B17.0)	mengalami *needle stickinjury* dari pasien Hepatitis C	titis C dari darah dan/ cairan tubuh yang terin- feksi	pasien, tenaga laboratorium,	bulan	riwayat Hepatitis C sebelum-nya (Peme- riksaan se- belumnya negatif)	transfusi darah	
20	Kelainan saluran pernafasan atas yang disebabkan oleh sensitisasi atau iritasi zat yang ada dalam proses pekerjaan	Rhinitis dan Rhinosi nu- sitis Akibat Kerja	Rhinitis Akut (J00)	-	Debu	Pekerja di pabrik semen, pabrik *textile*, pertambangan batubara, pekerja di pabrik asbes,	Segera setelah terpajan	Tidak ada riwayat alergi sebelumnya	Tidak ada pajanan /debu laindi luar pekerjan.	A1
21	Penyakit saluran pernafasan lain di mana ada hubungan langsung antara paparan faktor risiko yangmuncul akibat aktivitas	*Laryngitis* Akut Akibat Kerja	*Laryngitis* Akut (J04.0)	Suara serak setelah pengguna- an suara berlebihansaat bekerja	Penggunaanpita suara berlebihan	Penyanyi, presenter, pembaca berita, guru, dosen, pekerjaan lain yang menggunakan suara berlebihan.	Segera setelah penggu- naan suara berlebih-an	Tidak ada	-	A1 dan A2
	pekerjaan dengan penyakit yang dialami oleh pekerja yang dibuktikan secarailmiah dengan menggunakan metode yang tepat									

Kasus diagnosa kecelakaan kerja di Indonesia sangat bervariasi, didominasi oleh terjatuh dari ketinggian, cedera mesin, dan tertimpa benda berat, seringkali fatal. Diagnosa medis umumnya meliputi fraktur (patah tulang), luka robek, trauma kepala, hingga gangguan otot (MSDs). Penyebab utamanya adalah kurangnya APD, unsafe action, dan unsafe condition.

Berikut adalah poin-poin penting terkait diagnosa kecelakaan kerja:
Jenis Diagnosa Medis Terumum:

1. Trauma Fisik: Fraktur (patah tulang), dislokasi sendi, luka robek, dan luka bakar.
2. Cedera Muskuloskeletal: Nyeri otot, cedera tulang belakang akibat posisi kerja salah, atau mengangkat beban berlebihan.
3. Trauma Organ Dalam/Kepala: Cedera kepala berat atau organ dalam akibat tertimpa benda berat atau jatuh dari ketinggian.

Contoh Kasus Spesifik:

- Jatuh dari Ketinggian: Pekerja proyek pembangunan gedung jatuh dari lantai tinggi karena tidak menggunakan pengaman (safety harness), sering berakibat fatal.
- Terjepit Mesin: Cedera pada tangan atau kaki akibat terperangkap dalam mesin produksi yang tidak memiliki guarding (pelindung).
- Tertimpa Benda: Kecelakaan di area konstruksi/proyek saat benda material jatuh dari lantai atas.

Penyebab :

- Unsafe Action (Tindakan Tidak Aman): Tidak memakai APD, bekerja terburu-buru, atau kurang konsentrasi.
- Unsafe Condition (Kondisi Tidak Aman): Lingkungan licin, alat kerja rusak, atau tidak adanya SOP yang jelas.

Kecelakaan kerja harus segera dilaporkan untuk penanganan medis dan klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) ke BPJS Ketenagakerjaan.

Berdasarkan penjabaran PAK dan KK diatas implementasi Pengendalian Infeksi dan K3 dalam pelayanan Keperawatan sektor Industri cukup kompleks seperti terkait kasus pasien kecelakaan kerja kita bisa menggunakan pendekatan asuhan keperawatan Kegawatdaruratan sedangkan untuk Penanganan Penyakit akibat kerja menggunakan asuhan keperawatan KMB, untuk kasus reproduksi menggunakan askep maternitas, untuk program promkes menggunakan komunitas, untuk program optimasi pelayanan Kesehatan kerja dan pengembanga klinik menggunakan Manajemen, untuk kasus pekerja rehabilitasi post perobatan penyakit kronis menggunakan askep onkologi sehingga disaranken agar OHN ini independent/tersendiri seperti halnya dinegara maju, mulai vokasi,s1,ns, s2,s3 dengan bidang/departemen keperawatan Kesehatan kerja. Sekaligus diharapkan para instansi Pendidikan agar melebarken Kerjasama dengan sektor industry sebagai wadah praktik klinik mahasiswa keperawatan. Hingga organisasi PPNI mulai menadvokasikan perlunya perkembangan kurikulum mata kuliah K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) dan pasien safety (PPNI, 2023), Dalam bab ini penulis

mengseting askep yang terintegrasi dengan implementasi K3 Industri dan berbagai contoh kasus serta praktik secara *Evidance Base Practice of Nursing* (EBPN).

Contoh :

Asuhan Keperawatan pada Pekerja dengan Dermatitis Akibat Kerja (DAK)

Teori Dasar

Dermatitis pada pekerja perkebunan umumnya adalah dermatitis kontak (iritan/alergi) akibat paparan bahan kimia seperti pestisida dan pupuk, atau getah tanaman. Gejalanya meliputi ruam merah, gatal parah, dan kulit kering/pecah-pecah. Pencegahan utama adalah penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap, seperti sarung tangan dan pakaian panjang.

Penyebab Utama Dermatitis pada Pekerja Perkebunan:

- Paparan Pestisida & Pupuk: Bahan kimia ini memicu dermatitis kontak iritan atau alergi pada kulit.
- Getah Tanaman/Pohon: Kontak langsung dengan getah (misal: pohon sawit, karet).
- Faktor Lingkungan: Panas matahari dan kelembapan tinggi, keringat, serta gesekan mekanis.
- Penggunaan APD yang Minim: Pekerja yang tidak memakai sarung tangan atau pakaian pelindung lebih berisiko 2,35 kali lipat.

Gejala Dermatitis:

- Ruam merah yang gatal, kulit terasa terbakar, pecah-pecah, bengkak, atau melepuh.

Pencegahan dan Pengelolaan:

- Alat Pelindung Diri (APD): Wajib menggunakan sarung tangan (karet/nitril), sepatu bot, apron, dan pakaian lengan panjang saat menangani pupuk atau pestisida.
- Kebersihan Diri: Segera mencuci tangan dan area kulit yang terpapar dengan sabun setelah bekerja.
- Penggunaan Pelembap: Menggunakan krim emolien untuk menjaga kelembapan kulit.
- Pelatihan Keselamatan: Pekerja perlu mendapatkan edukasi mengenai teknik penggunaan bahan kimia yang aman.

Aktivitas 1 — *Knows How*

Mini-case tertulis (diskusi kelompok)

Contoh:

Seorang pekerja perusahaan agroforestry datang ke pelayanan kesehatan dengan keluhan gatal dan kemerahan pada tangan setelah sering mencuci tangan saat bekerja. Hasil pengkajian: tampak dermatitis kontak iritan pada tangan akibat paparan berulang air dan sabun, tanpa tanda infeksi, sehingga diperlukan edukasi pencegahan iritasi dan perlindungan kulit. Apa edukasi yang paling tepat pada kasus tersebut?

A. Oleskan salep tanpa penjelasan cara pemakaian
B. Sarankan obat herbal dan alami sebagai terapi utama
C. Ajarkan cuci tangan 5 langkah setiap kali agar lebih bersih
D. Kolaborasi dengan dokter untuk pemberian antihistamin rutin
E. Anjurkan menggunakan pelembab kulit dan memakai sarung tangan saat bekerja

Mahasiswa diminta berdiskusi dalam kelompok kecil untuk menganalisis kondisi pada kasus tersebut.

Pertanyaan Diskusi

1. Identifikasi tanda dan gejala yang menunjukkan bahwa pekerja mengalami Dermatitis.
2. Tentukan derajat dehidrasi yang mungkin terjadi pada Pekerja berdasarkan data pengkajian.
3. Identifikasi faktor risiko yang dapat memperburuk kondisi Pekerja.
4. Jelaskan tindakan keperawatan awal yang harus dilakukan oleh perawat pada kasus tersebut.

Diskusikan jawaban bersama anggota kelompok dan presentasikan hasil diskusi di kelas.

Aktivitas 2 — *Shows How*

Simulasi/skill lab kala II

Fokus urutan tindakan + komunikasi + keselamatan

Catatan untuk penulis:

- Tidak loncat ke ujian
- Mahasiswa naik tangga kompetensi

Asesmen (Piramida Miller)

Level Miller	Metode
Knows / Knows How	Self-check + analisis mini-case
Shows How	OSCE Asuhan Kala II

Catatan untuk penulis:

- Karena CP Bab = *mendemonstrasikan* OSCE logis, bukan dipaksakan

OSCE Ringkas + Critical Items

Critical Items (WAJIB LULUS)

1. *Case Management & Complaiace* : Pemahaman Regulasi Hukum Kesehatan dan Ketenagakerjaan
2. *Infection Control/Survailance:* Pemahaman K3 dan Keselamatan pasien sektor Industri
3. *Adaministration & Research*: Pemahaman Manajemen-Operasional-Standarisasi-Pengambangan Klinik
4. *Injury/Ilness Care* : Pemahaman Pelayanan Keperawatan-Medis-Kesehatan Kerja
5. *Business Skills*: Pemahaman Alur Proses Produksi/Bisnis & Keuangan Perusahaan
6. *Health Promotion & Consultant* : Pemahaman ilmu Lingkungan-Humaniora-Epidemologi

TEMPLATE SOAL OSCE KEPERAWATAN

No.	Komponen	Isi
1	Nomor station	…… (Dikosongkan)
2	Judul station	Asuhan Keperawatan pada Pekerja dengan Dermatitis Akibat Kerja (DAK)
3	Waktu yang dibutuhkan	10 menit
4	Tujuan station	Menilai kemampuan peserta ujian dalam melakukan pengkajian fokus, penegakan diagnosis dan perencanaan keperawatan, serta edukasi dan demonstrasi pemberian Salep,pelembab,dan penggunaan APD saat bekerja.
5	Kompetensi	1. Komunikasi, edukasi, dan konseling 2. Pengkajian 3. Diagnosa dan perencanaan 4. Implementasi 5. Evaluasi 6. Perilaku professional
6	Kategori	1. Cairan dan elektrolit 2. Eliminasi 3. Nutrisi 4. Aman dan nyaman 5. Psikososial
7	Instruksi untuk peserta ujian	SKENARIO KLINIK: Seorang pekerja perusahaan agroforestry datang ke pelayanan kesehatan dengan keluhan gatal dan kemerahan pada tangan setelah sering mencuci tangan saat bekerja. Hasil pengkajian: tampak dermatitis kontak iritan pada tangan akibat paparan berulang air dan sabun, tanpa tanda infeksi, sehingga diperlukan edukasi pencegahan iritasi dan perlindungan kulit. TUGAS: 1. Lakukan pengkajian fokus berdasarkan skenario tersebut pada KS. 2. Tuliskan diagnosis keperawatan pada lembar jawab berdasarkan skenario di atas dan hasil validasi pengkajian fokus.

No.	Komponen	Isi
		3. Tuliskan perencanaan keperawatan pada lembar jawab berdasarkan skenario. 4. Lakukan edukasi dan demonstrasi cara pemberian pelembab kulit dan memakai sarung tangan saat bekerja
8	Instruksi untuk penguji	SKENARIO KLINIK: Seorang pekerja perusahaan agroforestry datang ke pelayanan kesehatan dengan keluhan gatal dan kemerahan pada tangan setelah sering mencuci tangan saat bekerja. Hasil pengkajian: tampak dermatitis kontak iritan pada tangan akibat paparan berulang air dan sabun, tanpa tanda infeksi, sehingga diperlukan edukasi pencegahan iritasi dan perlindungan kulit. TUGAS: 1. Lakukan pengkajian fokus berdasarkan skenario tersebut pada KS. 2. Tuliskan diagnosis keperawatan pada lembar jawab berdasarkan skenario di atas dan hasil validasi pengkajian fokus. 3. Tuliskan perencanaan keperawatan pada lembar jawab berdasarkan skenario. 4. Lakukan edukasi dan demonstrasi cara pemberian pelembab kulit dan memakai sarung tangan saat bekerja. INSTRUKSI PENGUJI: 1. Menilai ketepatan peserta dalam menentukan pengkajian fokus tambahan, eliputi anamnesis riwayat pekerjaan, paparan zat iritan/alergen (bahan kimia, basah), penggunaan APD, dan riwayat atopi. Pemeriksaan fisik fokus pada lokasi, bentuk lesi (kemerahan, gatal, lenting), dan durasi paparan. 2. Menilai kemampuan peserta dalam menuliskan label Diagnosis prioritas meliputi Gangguan Integritas Kulit/Jaringan, Gangguan Rasa Nyaman (Gatal), Risiko Infeksi, dan Defisit Pengetahuan mengenai tindakan pencegahan di tempat kerja. 3. Menilai kemampuan peserta dalam menuliskan intervensi keperawatan yang sesuai, seperti Tindakan edukasi penggunaan APD (sarung tangan), penggunaan pelembap/emolien,

No.	Komponen	Isi
		manajemen kulit (mandi air hangat), serta edukasi mengenai faktor risiko lingkungan kerja untuk mencegah kekambuhan. 4. Menilai ketepatan penampilan peserta dalam edukasi dan demonstrasi pemberian edukasi penggunaan APD (sarung tangan), penggunaan pelembap/emolien, manajemen kulit (mandi air hangat), serta edukasi mengenai faktor risiko lingkungan kerja untuk mencegah kekambuhan. 5. Monitor perilaku profesional peserta. 6. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interupsi ataupun bertanya kepada peserta selain yang ditentukan.
9	Instruksi untuk klien standar	Hal-hal yang perlu dicantumkan di antaranya: 1. Identitas pasien sesuai kasus: Divisi atau bidang kerja 2. Riwayat penyakit sekarang: DCU (*Daily Check Up*), FFT (*Fit For Task*), *Health Survailance* 3. Riwayat penyakit sebelumnya: MCU (*Medical Check Up*), RTW (*Return to Work*), HRA (*Health Risk Assesment)* 4. Rawat jalan saat ini adalah hari pertama, dan ini merupakan rawat inap pertama. 4. Riwayat penyakit keluarga: di keluarga tidak ada yang mengalami keluhan yang sama. 5. Riwayat kebiasaan sosial: Safety Behaviour, JSA (Job Safety Analysis), Kepatuhan IK/SOP Kerja 6. Harapan terhadap penyakit: Pasien berharap sempat sembuh dan patuh akan SOP kerja 7. Bila peserta menanyakan DAK, jawaban KS: sejak 3 haru yang lalu mengalami gatal-gatal melepuh 8. Bila peserta menanyakan manfaat APD dan Kepatuhan SOP Kerja, jawaban KS:Jarang menggunakan karna ribet saat bekerja menggunakan APD.
10	Setting station	Ruang Klinik Industri - Tempat tidur pasien - pen light, hanscoon - KS berperan sebagai pasien - Laboran - Penguji

No.	Komponen	Isi
		Tata letak ruang: 1. Tempat tidur dan manekin Pekerja 2. Kursi KS 3. Meja penguji 4. Kursi penguji 5. Pintu masuk 6. Troli alat 7. Wastafel/handrub 8. Tempat sampah 9. Kursi laboran
11	Peralatan yang dibutuhkan	Peralatan: 1. Sarung tangan bersih 2. Handrub/hand sanitizer 3. Tisu 4. Bengkok 5. Pengalas 6. Obat/Salep 7. Pen Light 8. Gelas/cangkir kecil 9. Sendok teh atau spuit oral 10. Lembar jawaban peserta Laboran ada. 11. Sarung Tangan Peran laboran: merapikan ulang alat-alat setelah digunakan peserta, dan memastikan set ujian siap untuk peserta selanjutnya sebelum peserta masuk ruang ujian.
12	Penulis	. ...
13	Referensi	Tim Pokja SDKI DPP PPNI (2017) Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia: Definisi dan Indikator Diagnostik. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. Tim Pokja SIKI DPP PPNI (2019) Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. Tim Pokja SLKI DPP PPNI (2019) Standar Luaran Keperawatan Indonesia: Definisi dan Kriteria Hasil Keperawatan. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI.

No.	Komponen	Isi
		Tim Pokja Pedoman SPO Keperawatan DPP PPNI (2021) Pedoman Standar Prosedur Operasional Keperawatan. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI.

SOP EDUKASI DAN DEMONSTRASI PEMBERIAN OBAT MELALUI KULIT

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
A	Tahap Pra interaksi				
1	Mengecek catatan medis dan catatan keperawatan				
2	Menyiapkan alat dan perlengkapan: a. Sarung tangan bersih bila perlu b. Handrub/sabun cuci tangan c. Salep d. Air matang sesuai petunjuk kemasan e. Gelas ukur/wadah bersih f. Gelas/cangkir/sendok atau spuit oral g. Tisu h. Bengkok/pengalas bila perlu				
3	Mencuci tangan				
B	Tahap Orientasi				
4	Menyampaikan salam terapeutik				
5	Menyampaikan nama dan peran perawat				
6	Mengecek identitas pasien, minimal nama Pekerja dan tanggal lahir/umur secara aktif				
7	Menyampaikan maksud dan tujuan serta kontrak waktu				
8	Memberi kesempatan bertanya				
9	Memulai tindakan dengan baik				
10	Menjaga privasi dan kenyamanan Pekerja serta ibu				

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
C	Tahap Kerja (No. 11 s.d. 28: sistematis)				
11	Melakukan hand hygiene				
12	Menggunakan sarung tangan bersih bila ada risiko kontak dengan cairan tubuh				
13	Mengidentifikasi frekuensi BAB cair, muntah, intake cairan, jumlah urin, dan tanda dehidrasi				
14	Mengidentifikasi kemampuan Pekerja untuk minum dan kesiapan ibu menerima edukasi				
15	Mengatur posisi Pekerja nyaman, dapat dipangku ibu atau posisi duduk/semi-Fowler sesuai kondisi				
16	Menjelaskan tujuan pemberian oralit untuk mengganti cairan dan elektrolit yang hilang				
17	Memeriksa oralit dan menyiapkan air matang sesuai petunjuk kemasan				
18	Mendemonstrasikan cara menggunakan salep				
19	Menjelaskan dan mendemonstrasikan pemberian salep dan pelembab kulit				
20	Menjelaskan bahwa bila pasien merasa gatal				
21	Menganjurkan pemberian salep setelah mandi dan tidak boleh				

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
	terkena air dan Edukasi pentingnya penggunaan APD saat bekerja				
22	Menjelaskan tanda bahaya yang harus segera dilaporkan atau dibawa ke fasilitas kesehatan: Kulit bersisik, kering, pecah-pecah (fissure), kulit menebal, dan menjadi kehitaman.				
25	Meminta pasien mengulang kembali penjelasan yang sudah diberikan				
26	Meminta pasien mendemonstrasikan kembali cara pemberian oralit dengan benar				
27	Merapikan pasien dan alat-alat yang digunakan				
28	Melepaskan sarung tangan bila digunakan dan melakukan kebersihan tangan 6 langkah				
D	Tahap Terminasi				
29	Menyimpulkan kegiatan				
30	Mengevaluasi respons pasien secara subjektif dan objektif				
31	Memberikan reinforcement positif				
32	Membuat kontrak waktu selanjutnya				
33	Mengakhiri tindakan dengan baik				

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
E	Tahap Dokumentasi				
34	Mencatat hari, tanggal, jam, hasil pengkajian singkat, kegiatan edukasi dan demonstrasi pemberian salep dan Pentingnya APD saat bekerja, respons pasien, serta tindak lanjut				
F	Penampilan Profesional				
35	Aman, nyaman, teliti, cermat, tepat, responsive				

DOPS (Does)

DOPS di Lahan Praktik

- Observasi langsung pada Asuhan Keperawatan Pekerja dengan DAK
- Checklist + umpan balik singkat
- Keputusan: kompeten / supervisi / remedial

Catatan untuk penulis:

- Dari simulasi → praktik nyata
- Bukti performa sesungguhnya

Komponen	**Deskripsi**	**Contoh pada Kasus Pekerja dengan DAK**
Metode penilaian	Mini-CEX merupakan penilaian berbasis observasi langsung terhadap performa klinik mahasiswa dalam encounter singkat, terfokus, dan nyata di lahan praktik.	Pembimbing mengamati secara langsung interaksi mahasiswa saat memberikan asuhan awal pada Pekerja yang mengalami DAK di ruang perawatan Pekerja.
Tujuan penilaian	Menilai kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan pengkajian, pemeriksaan fisik terfokus, penalaran klinik, komunikasi, edukasi, dan profesionalisme dalam satu pertemuan klinik.	Mahasiswa tidak hanya dinilai dari pengetahuannya tentang DAK, tetapi juga dari kemampuannya melakukan pengkajian, menjelaskan kondisi Pekerja, dan menyampaikan rencana asuhan kepada Pasien.
Kasus klinik	Kasus dipilih dari situasi nyata yang sering ditemukan di lahan praktik dan sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah atau tahap profesi.	Seorang Pekerja usia 20 tahun dirawat dengan DAK
Aktivitas mahasiswa yang diamati	Mahasiswa melakukan encounter klinik secara utuh sejak awal interaksi sampai penjelasan rencana tindakan.	Mahasiswa memperkenalkan diri, melakukan pengkajian singkat namun terarah, memeriksa tanda akut dan kronis DAK, menjelaskan kondisi DAK, Pemberian Salep dan Kepatuhan APD Kerja observasi dan follow up kondisi DAK, serta edukasi tentang bahaya penyakit akibat kerja

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Pekerja dengan DAK
		DAK, pencegahan hingga proses penyembuhan.
Aspek yang dinilai	Aspek yang dinilai meliputi anamnesis atau pengkajian, pemeriksaan fisik terfokus, penalaran klinik, komunikasi terapeutik, edukasi pekerja hingga pimpinan manajemen, profesionalisme, dan organisasi tindakan.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menggali frekuensi DAK, muntah, intake cairan, jumlah urin, mengenali tanda dehidrasi, menjelaskan oralit dengan bahasa sederhana, dan menjaga komunikasi yang baik dengan Pasien.
Fokus observasi pembimbing	Pembimbing menilai kualitas performa klinik mahasiswa secara langsung menggunakan format Mini-CEX yang terstruktur.	Pembimbing memperhatikan apakah mahasiswa mampu menghubungkan data klinik dengan masalah prioritas, misalnya gangguan integritas kulit, serta mampu memberikan edukasi yang tepat dan aman kepada pasien dan pimpinan manajemen.
Umpan balik	Umpan balik diberikan segera setelah observasi, bersifat singkat, spesifik, dan berorientasi pada perbaikan performa.	Pembimbing dapat menyampaikan bahwa mahasiswa sudah baik dalam komunikasi dan identifikasi tanda dehidrasi, tetapi masih perlu memperdalam pengkajian intake-output dan memperjelas penjelasan tentang tanda bahaya.
Keputusan penilaian	Hasil Mini-CEX digunakan untuk menentukan tingkat performa mahasiswa dalam praktik klinik.	Mahasiswa dinyatakan kompeten apabila mampu melakukan encounter klinik secara runtut, aman, komunikatif, dan tepat. Mahasiswa dinyatakan perlu supervisi apabila masih membutuhkan arahan pada beberapa bagian. Mahasiswa dinyatakan remedial apabila performanya belum memenuhi standar minimal.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Pekerja dengan DAK
Makna dalam OBE	Mini-CEX memberikan bukti autentik bahwa mahasiswa mampu menunjukkan capaian pembelajaran pada level does.	Pada kasus Pekerja dengan DAK, mahasiswa dinilai bukan hanya memahami teori, tetapi mampu menerapkan asuhan keperawatan secara langsung, aman, tepat, dan profesional di lahan praktik.

Portofolio

Bukti yang dikumpulkan

- OSCE + DOPS
- Catatan kasus singkat
- Refleksi patient safety
- Feedback CI/dosen

Catatan untuk penulis:

- Bukan sekali ujian
- Bukti konsistensi kompetensi

Tabel 3. 4 Portofolio pada Asuhan Keperawatan Pekerja dengan DAK

Komponen	**Deskripsi**	**Contoh pada Kasus Pekerja dengan DAK**
Hakikat portofolio	Portofolio merupakan kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan dan pencapaian kompetensi mahasiswa secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam OBE, portofolio digunakan untuk menilai performa nyata mahasiswa dari waktu ke waktu, bukan hanya dari satu kali ujian.	Pada asuhan keperawatan Pekerja dengan DAK, portofolio memuat bukti bahwa mahasiswa mampu melakukan pengkajian, menetapkan masalah keperawatan, memberikan edukasi, menjaga keselamatan pasien, serta memperbaiki performa berdasarkan umpan balik.
Tujuan portofolio	Portofolio bertujuan mendokumentasikan proses belajar, capaian kompetensi, refleksi diri, dan tindak lanjut perbaikan mahasiswa selama praktik.	Mahasiswa tidak hanya menunjukkan bahwa ia pernah merawat Pekerja dengan DAK, tetapi juga menunjukkan bagaimana kemampuannya berkembang setelah mendapat masukan dari dosen atau CI.
OSCE dan DOPS	OSCE dan DOPS dapat menjadi bagian penting dalam portofolio karena memberikan bukti keterampilan terstruktur di laboratorium dan bukti performa nyata di lahan praktik.	OSCE dapat memuat hasil ujian keterampilan edukasi pemberian oralit, sedangkan DOPS memuat hasil observasi langsung saat mahasiswa melakukan asuhan pada Pekerja

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Pekerja dengan DAK
		dengan DAK di ruang rawat Pekerja.
Catatan kasus singkat	Catatan kasus singkat berisi ringkasan kasus pasien yang pernah ditangani mahasiswa, data penting, masalah keperawatan, intervensi utama, dan hasil yang dicapai.	Mahasiswa menuliskan ringkasan kasus Pekerja usia 20 tahun dengan DAK, frekuensi , diagnosis keperawatan prioritas, intervensi hidrasi, edukasi oralit, dan evaluasi respons Pekerja.
Refleksi patient safety	Refleksi patient safety menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi kesalahan, dan menyusun langkah pencegahan dalam asuhan keperawatan.	Mahasiswa merefleksikan pentingnya memantau tanda dehidrasi, mencatat intake-output dengan teliti, memastikan oralit diberikan dengan cara yang benar, dan mengenali tanda bahaya yang membutuhkan pelaporan segera.
Feedback CI/dosen	Umpan balik dari Clinical Instructor (CI) atau dosen menjadi bukti pembinaan yang menunjukkan area kekuatan dan area yang masih perlu ditingkatkan.	CI menuliskan bahwa mahasiswa sudah baik dalam komunikasi dengan ibu Pekerja dan edukasi oralit, tetapi masih perlu meningkatkan ketelitian dalam pengkajian jumlah urin dan dokumentasi cairan masuk-keluar.
Karakteristik penilaian	Portofolio bukan penilaian sekali selesai, tetapi kumpulan bukti yang dibangun secara berulang dan berkesinambungan. Penekanan utamanya adalah konsistensi performa mahasiswa.	Mahasiswa dinilai bukan hanya dari satu kasus DAK, tetapi dari beberapa pengalaman belajar yang menunjukkan bahwa ia konsisten mampu melakukan asuhan keperawatan Pekerja secara aman, tepat, dan profesional.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Pekerja dengan DAK
Bukti konsistensi kompetensi	Portofolio memperlihatkan apakah mahasiswa mampu mempertahankan mutu performa pada berbagai kesempatan praktik dan pada waktu yang berbeda.	Dari hasil OSCE, DOPS, catatan kasus, refleksi, dan umpan balik, terlihat bahwa mahasiswa secara konsisten mampu melakukan pengkajian dehidrasi, edukasi oralit, dan komunikasi terapeutik dengan keluarga Pekerja.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, portofolio memberikan bukti autentik bahwa capaian pembelajaran tidak hanya dimiliki secara teoritis, tetapi benar-benar tampak dalam performa yang berulang, berkembang, dan terdokumentasi.	Pada asuhan keperawatan Pekerja dengan DAK, portofolio menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya paham konsep DAK, tetapi juga konsisten mampu menerapkannya dalam praktik klinik nyata.

Tabel 3. 5 Case Report pada Asuhan Keperawatan Pekerja dengan DAK

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Pekerja dengan DAK
Hakikat case report	Case report merupakan laporan singkat dan sistematis tentang satu kasus pasien yang ditangani mahasiswa selama praktik klinik. Dalam OBE, case report berfungsi sebagai bukti kemampuan mahasiswa dalam memahami, menganalisis, dan mendokumentasikan kasus secara ilmiah dan klinis.	Mahasiswa menyusun laporan singkat tentang seorang Pekerja usia 20 tahun yang dirawat dengan DAK, muntah, mukosa mulut kering, mata sedikit cekung, dan tampak lemas.
Tujuan	Case report bertujuan menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan data pengkajian, masalah keperawatan, rencana tindakan, implementasi, dan evaluasi hasil asuhan.	Mahasiswa tidak hanya menuliskan data pasien, tetapi juga menjelaskan masalah prioritas, tindakan yang diberikan, dan perkembangan kondisi Pekerja setelah intervensi.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Pekerja dengan DAK
Isi laporan	Isi case report biasanya mencakup identitas singkat pasien, keluhan utama, data subjektif dan objektif, analisis masalah, diagnosis keperawatan, intervensi, implementasi, evaluasi, dan pembelajaran dari kasus.	Pada kasus DAK, mahasiswa menuliskan tanda gejala DAK Seperti ruam merah, gatal parah, kulit kering/pecah-pecah, lepuhan berisi cairan, sensasi terbakar, dan penebalan kulit (likenifikasi)
Fokus penilaian	Penilaian difokuskan pada ketepatan pengkajian, relevansi analisis masalah, logika penalaran klinik, ketepatan intervensi, dan kemampuan mengevaluasi hasil asuhan.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menghubungkan data kehilangan cairan dengan masalah utama, memilih intervensi yang tepat, dan menilai respons Pekerja setelah pemberian cairan.
Nilai edukatif	Case report membantu mahasiswa mengembangkan clinical reasoning, keterampilan dokumentasi, dan kebiasaan merefleksikan praktik klinik secara ilmiah.	Dari kasus DAK, mahasiswa belajar bahwa pengkajian intake-output, tanda dehidrasi, dan edukasi keluarga merupakan bagian yang sangat penting dalam asuhan keperawatan Pekerja.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, case report menjadi bukti bahwa mahasiswa mampu menerapkan teori ke dalam analisis kasus nyata secara sistematis dan bertanggung jawab.	Mahasiswa menunjukkan bahwa ia tidak hanya memahami konsep DAK pada Pekerja, tetapi juga mampu menyusun laporan kasus yang menggambarkan asuhan keperawatan secara utuh.

Tabel 3. 6 Refleksi Patient Safety pada Asuhan Keperawatan Pekerja dengan DAK

Komponen	**Deskripsi**	**Contoh pada Kasus Pekerja dengan DAK**
Hakikat refleksi patient safety	Refleksi patient safety merupakan tulisan singkat yang menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi masalah, dan merencPekerjaan tindakan pencegahan.	Pada kasus Pekerja dengan DAK, mahasiswa merefleksikan bahwa kehilangan cairan yang cepat dapat menyebabkan perburukan kondisi bila tidak dikenali dan ditangani dengan tepat.
Tujuan	Refleksi ini bertujuan menumbuhkan kesadaran mahasiswa bahwa keselamatan pasien merupakan bagian penting dari setiap tindakan keperawatan.	Mahasiswa memahami bahwa kesalahan kecil, seperti kurang teliti memantau intake-output atau terlambat mengenali tanda dehidrasi, dapat berdampak besar pada keselamatan Pekerja.
Fokus refleksi	Fokus refleksi meliputi identifikasi risiko, analisis penyebab, tindakan pencegahan, dan pembelajaran yang diperoleh mahasiswa dari pengalaman klinik.	Mahasiswa menuliskan bahwa risiko utama pada pasien ini adalah dehidrasi, ketidakseimbangan elektrolit, dan keterlambatan penanganan bila keluarga tidak memahami tanda bahaya.
Risiko yang diidentifikasi	Mahasiswa perlu menunjukkan kemampuan mengenali situasi yang berpotensi membahayakan pasien.	Risiko yang dapat diidentifikasi antara lain penurunan status hidrasi, berkurangnya jumlah urin, muntah berulang, kesalahan pemberian oralit, dan keterlambatan pelaporan tanda bahaya.
Tindakan pencegahan	Mahasiswa menjelaskan langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko keselamatan pasien.	Mahasiswa menuliskan pentingnya memantau tanda dehidrasi secara berkala, mencatat intake-output dengan teliti, menjelaskan cara pemberian oralit yang benar, serta

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Pekerja dengan DAK
		mengedukasi ibu tentang tanda bahaya.
Pembelajaran mahasiswa	Refleksi harus menunjukkan apa yang dipelajari mahasiswa dan bagaimana hal itu akan memengaruhi praktik berikutnya.	Mahasiswa menyadari bahwa pada Pekerja dengan DAK, pengkajian yang teliti, komunikasi yang jelas kepada keluarga, dan pemantauan berulang merupakan bagian penting untuk menjaga keselamatan pasien.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, refleksi patient safety menunjukkan perkembangan sikap profesional, tanggung jawab klinik, dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa terhadap keselamatan pasien.	Mahasiswa membuktikan bahwa ia tidak hanya melakukan tindakan, tetapi juga mampu mengevaluasi risiko dan meningkatkan kualitas praktik keperawatan Pekerja secara berkelanjutan.

B. RINGKASAN

Bab ini menekankan bahwa DAK pada Pekerja merupakan masalah klinis yang sangat sering dijumpai dan dapat berkembang cepat menjadi kondisi berbahaya apabila tidak dikenali serta ditangani secara tepat. Fokus utama asuhan keperawatan Pekerja dengan DAK adalah Asuhan keperawatan pekerja dengan DAK (Dermatitis Kontak Akuntan/Akibat Kerja) berfokus pada pengkajian paparan zat iritan/alergen, identifikasi diagnosis seperti gangguan integritas kulit, manajemen lingkungan kerja, edukasi penggunaan APD (Alat Pelindung Diri), serta evaluasi penyembuhan lesi.

Asuhan Keperawatan Dermatitis Akibat Kerja (DAK):

Pengkajian:

- Riwayat Pekerjaan: Mengidentifikasi bahan kimia, fisik, atau biologis di tempat kerja (misalnya: semen, sabun, oli, sarung tangan karet).
- Riwayat Penyakit: Lokasi lesi, waktu munculnya (biasanya membaik saat libur kerja), dan gejala (gatal, kemerahan, melepuh).
- Pemeriksaan Fisik: Inspeksi kulit (eritema, edema, papul, vesikel).

Diagnosa Keperawatan (SDKI):

- Gangguan Integritas Kulit/Jaringan berhubungan dengan bahan kimia iritan.
- Nyeri Akut/Kronis berhubungan dengan inflamasi kulit.
- Risiko Infeksi berhubungan dengan kerusakan pertahanan tubuh kulit.

Intervensi Keperawatan:

- Manajemen Lingkungan: Edukasi penggunaan APD yang tepat (sarung tangan, masker, apron) dan penyediaan sarana cuci tangan.
- Manajemen Dermatitis: Membersihkan area terdampak, kompres dingin, dan aplikasi salep/krim sesuai instruksi dokter.
- Edukasi Pekerja: Menghindari alergen spesifik, menjaga kelembaban kulit (penggunaan emollient), dan melaporkan gejala dini.

Evaluasi:

- Integritas kulit kembali normal.
- Penurunan tingkat nyeri/gatal.
- Kepatuhan penggunaan APD meningkat.
- Intervensi ini bertujuan untuk meminimalkan paparan, mengobati dermatitis, dan mencegah kekambuhan di lingkungan kerja.

Asuhan keperawatan pekerja dengan dermatitis akibat kerja (DAK) bertujuan untuk mengurangi iritasi, mencegah infeksi sekunder, memulihkan integritas kulit, sekaligus memutus rantai paparan penyebab di tempat kerja. Berikut kerangka ASKEP DAK berbasis **pendekatan keperawatan okupasional**.

1. Pengkajian

   Fokus pada hubungan antara gejala kulit dan kondisi kerja:

   - Identifikasi riwayat pekerjaan: jenis pekerjaan, bahan kimia/sabun/air/cepat, jam kerja, frekuensi cuci tangan, dan penggunaan APD.
   - Fokus lesi: lokasi umum tangan, lengan, pergelangan tangan, atau wajah; kemerahan, bengkak, bula, pelepasan kulit, rasa panas, nyeri, atau gatal hebat.
   - Pengaruh terhadap fungsi kerja dan kualitas hidup: gangguan aktivitas, nyeri, rasa malu, penurunan produktivitas.

2. Diagnosa keperawatan utama

   Beberapa diagnosa keperawatan yang sering muncul pada pekerja dengan DAK:

   - Gangguan integritas kulit berhubungan dengan kontak berulang bahan iritan/alergen kerja, ditandai kemerahan, erosi/fisura, bula, dan nyeri.
   - Nyeri akut berhubungan dengan inflamasi kulit dan spasm otot karena menggaruk.
   - Gangguan rasa nyaman: pruritus (gatal) berhubungan dengan peradangan kulit dan paparan iritan.
   - Risiko infeksi berhubungan dengan lesi kulit terbuka dan kontak dengan bahan kotor.
   - Kurang pengetahuan berhubungan dengan cara pencegahan dan pengelolaan DAK di tempat kerja.

3. Intervensi keperawatan

   - Intervensi dapat disusun berdasarkan diagnosa, dengan menekankan aspek okupasional (pencegahan dan modifikasi lingkungan kerja).

     a. Integritas kulit dan luka

        - Evaluasi kulit: bersihkan lesi dengan air hangat atau larutan salin, hindari sabun desinfektif keras.
        - Kompres basah: untuk lesi basah, kompres salin selama 10–15 menit 2× sehari untuk mengurangi eksudat dan edema.
        - Obat topikal: bantu administrasi kortikosteroid topikal ringan (mis. hidrokortison 1%) sesuai anjuran dokter, oleskan tipis pada area kulit yang kering/eritema.
        - Hindari garukan: edukasi untuk memotong kuku pendek, gunakan sarung tangan katun saat tidur jika perlu.

     b. Nyeri dan gatal

        - Kolaborasi farmakologis: jelaskan penggunaan antipruritik atau antihistamin (oral) sesuai resep.
        - Non-farmakologis: gunakan kompres dingin (bukan es langsung), hindari suhu panas ekstrem dan aktivitas yang memicu keringat berlebih.

c. Pencegahan dan perlindungan di tempat kerja

Identifikasi dan eliminasi sumber iritan: bekerja sama dengan dokter kerja/IKK untuk identifikasi bahan iritan (solven, detergen, logam, lateks, dll.) dan rekomendasi modifikasi proses kerja.

- Penggunaan APD yang tepat: pelatihan pemakaian sarung tangan tahan kimia, pelindung lengan, pelindung wajah, dan penggantian secara berkala.
- Teknik cuci tangan yang aman: anjurkan penggunaan sabun pH seimbang, hindari menggosok kulit terlalu keras dan keringkan dengan handuk lembut.

d. Edukasi dan peningkatan pengetahuan

- Edukasi tentang DAK: jelaskan penyebab, faktor pencetus, tanda dini eksaserbasi, dan pentingnya pengobatan dini.
- Self-care kulit: penggunaan pelembab non-aromatik, penghindaran paparan iritan di rumah (pembersih, deterjen, kosmetik), serta jadwal pengobatan teratur.
- Pelaporan dan follow-up: anjurkan pekerja untuk melaporkan perubahan lesi kulit kepada perawat kerja/dokter kerja dan segera datang ulang bila terjadi pembengkakan, nanah, atau demam (tanda infeksi).

e. Mendukung produktivitas dan kualitas hidup

- Evaluasi kemampuan kerja: bantu proses penilaian fungsi kerja dan kemungkinan modifikasi tugas (misalnya rotasi jabatan sementara atau penggunaan teknologi pelindung tambahan).
- Dukungan psikososial: beri ruang bagi pekerja untuk mengekspresikan rasa malu, kecemasan, atau stres akibat perubahan penampilan kulit.

4. Contoh singkat rencana tindakan (format ASKEP)

- Misalnya untuk diagnosa: Gangguan integritas kulit berhubungan dengan kontak berulang bahan iritan kerja:
- Tujuan jangka pendek: dalam 3–5 hari, luka tampak lebih kering, rasa nyeri/gatal berkurang, pekerja mampu mendemonstrasikan cara memakai sarung tangan dan melembabkan kulit.

Intervensi:

- Bersihkan area lesi dengan salin, hindari sabun keras.
- Oleskan krim kortikosteroid tipis sesuai resep.
- Ajarkan penggunaan APD dan pelembab kulit sebelum dan sesudah kerja.
- Rujuk ke dokter kerja/dermatologi bila lesi tidak membaik dalam 1–2 minggu.

Tabel 3. 7 Red Flags & Eskalasi Asuhan Keperawatan Pekerja dengan DAK

Red flags	**Makna klinis**	**Tindakan eskalasi**
Pekerja merasakan gatal disertai nyeri dan ruam merah pada kulit	Peradangan kulit akibat kontak berulang dengan zat iritan atau alergen di tempat kerja, yang menunjukkan kerusakan pertahanan kulit dan risiko progresi menjadi lesi lebih berat atau infeksi sekunder.	Meningkatkan intensitas penanganan dan segera merujuk atau melibatkan dokter saat gejala meluas atau tidak membaik dengan terapi awa
Timbul rasa perih	Tanda inflamasi aktif dan iritasi pada lapisan kulit yang sudah mengalami kerusakan	Tindakan eskalasi perlu ditingkatkan dari penanganan mandiri ke penanganan medis terstruktur. Eskalasi berarti **mempercepat rujukan ke dokter Kesehatan kerja / dokter okupasi**, Sp.OK sekaligus memperketat isolasi terhadap bahan iritan.
Kondisi luka melepuh, pembesaran dan penyebaran bula, luka membasah/erosi	Tanda peradangan kulit yang lebih berat dan kerusakan struktur epidermis akibat iritasi atau alergi berulang di tempat kerja	Segera ditingkatkan penanganannya (eskalasi) baik secara klinis maupun di tingkat kebijakan kerja
Lesi kulit berupa likenifikasi (kulit menebal)	**tanda perjalanan penyakit yang kronis dan akibat iritasi berulang jangka panjang**. Secara praktis, likenifikasi menunjukkan bahwa inflamasi kulit sudah berlangsung lama, didukung oleh paparan iritan/alergen secara terus-menerus di tempat kerja (misalnya sabun, detergen, pelarut,	tindakan eskalasi harus lebih agresif dan kolaboratif. Eskalasi berarti: meningkatkan intensitas terapi, melibatkan dokter (khususnya dokter kulit/okupasi), sekaligus memperkuat intervensi di tempat kerja

Red flags	Makna klinis	Tindakan eskalasi
	atau kerja diareal basah yang cukup lama)	
Terlihat papula, skuama (bersisik), eritema ringan, dan seringkali disertai erosi akibat garukan	bahwa kulit sedang mengalami peradangan kronis akibat iritasi atau alergi berulang karena paparan bahan di tempat kerja, dengan adanya komponen mekanis (garukan) yang memperberat kelainan.	Hentikan sementara kontak iritan, Perawatan luka + kulit, Pengurangan gatal dan garukan, Eskalasi ke dokter spesialis (dermatologi / dokter kerja lanjutan), beri skor FFT *Temporary Un Fit* guna memfokusken proses penyembuhan hingga *Return To Work*

Form Checklist

Nama Mahasiswa : _____

NIM : _____

Tanggal : _____

Tempat Praktik / Skill Lab : _____

Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	Saya sudah bisa menjelaskan pengertian DAK pada Pekerja secara sederhana	☐	☐	_____
2	Saya sudah bisa melakukan pengkajian fokus pada Pekerja dengan DAK	☐	☐	_____
3	Saya sudah bisa mengkaji frekuensi dan karakteristik BAB cair	☐	☐	_____
4	Saya sudah bisa mengkaji adanya tanda Akut DAK pada Pekerja	☐	☐	_____
5	Saya sudah bisa mengenali tanda Kronis DAK pada Pekerja	☐	☐	_____
6	Saya sudah bisa mengidentifikasi masalah keperawatan prioritas pada Pekerja dengan DAK	☐	☐	_____
7	Saya sudah bisa menyusun rencana asuhan keperawatan dasar pada Pekerja dengan DAK	☐	☐	_____
8	Saya sudah bisa memantau status DCU Pekerja	☐	☐	_____

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
9	Saya sudah bisa memberikan edukasi tentang pemberian Obat Kulit & Kepatuhan APD	☐	☐	_____
10	Saya sudah bisa menganjurkan Pekerja untuk Istirahat dan Tertip berobat	☐	☐	_____
11	Saya sudah bisa menjelaskan tanda bahaya pada Pekerja dengan DAK kepada Pimpinan dan Manajemen	☐	☐	_____
12	Saya sudah bisa menentukan kapan harus melakukan eskalasi atau melapor	☐	☐	_____
13	Saya sudah bisa berkomunikasi terapeutik dengan Pekerja	☐	☐	_____
14	Saya sudah bisa melakukan dokumentasi singkat asuhan keperawatan Pekerja dengan DAK	☐	☐	_____
15	Saya sudah bisa menunjukkan sikap profesional, aman, teliti, dan responsif saat merawat Pekerja dengan DAK	☐	☐	_____

Refleksi singkat mahasiswa:

Referensi

Widyani, Y., & Hutahaean, S. (2024). Nursing Burnout to Infection Prevention and Control Measures Inpatient. Jurnal Ilmiah Kesehatan (JIKA), 6(1), 36–44. https://doi.org/10.36590/jika.v6i1.616

https://www.infectioncontroltoday.com/view/how-infection-prevention-occupational-health-intersect-health-care-facilities

Kurikulum Pendidikan Ners Indonesia, Asosiasi Institusi Pendidikan Ners Indonesia (AIPNI) 2021

Robi Rojaya Simbolon, et.al 2024; Occupational Safety And Health (OSH) Implementation As A Determinant Of Work Productivity Optimization , PAJAMKEU - VOLUME. 1, NO.3 JUNI 2024, E-ISSN : 3046-9848, DAN P-ISSN : 3046-899X, HAL. 17-31

2009, Information Resources in Toxicology (Fourth Edition) Andrew Maier

The Nurse's Role in Toxicology, Genevieve Kornbacher, R.N., C.O.H.N; Presented at the AAIN Pre-Conference Continuing Education Program, Industrial Hygiene and Toxicology, Cincinnati, Ohio, April 25 & 26, 1976

Ferdinan sihombing, et.al 2023; BUKU AJAR KESELAMATAN PASIEN DAN KESELAMATAN KESEHATAN KERJA, ISBN: 978-623-151-262-8, Penerbit: EUREKA MEDIA AKSARA

American Board for Occupational Health Nurses, Inc. 201 E. Ogden Ave., Suite 114 Hinsdale, Il 60521 630-789-5799

Jolene Beitz & Castro, 2010; Integrating Environmental Health Into Nurse Practitioner Training—Childhood Pesticide Exposure Risk Assessment, Prevention, and Management, AAOHN JOURNAL • VOL. 58, NO. 8, 349-355, BUSINESS AND LEADERSHIP, Copyright © American Association of Occupational Health Nurses, Inc.

Mohamed aqiel dalvie & Jonny myers,2009; More about Occupational and environmental healthVol.27 No.11, www.Occupational_health_concerns_with_pesticides_in_ag.pdf

National Pesticide Practice Skills Guidelines for Medical & Nursing Practice A Project of the National Strategies for Health Care Providers: Pesticides Initiative, January 2003, The National Environmental Education & Training Foundation 1707 H Street,NW,Suite 900 Washington,DC 20006-3915,Extensive resources on pesticides can be found at www.neetf.org/Health/Resources/healthcare.ht

Elkhalifa SM, Altilmisani NM, Albishri F, Gad HA, Al-Dubai TA and Al-Wesabi EO, 2024. Overview of quality control and safety in public health pest

laboratory in Jeddah, Saudi Arabia. International Journal of Agriculture, https://doi.org/10.47278/journal.ijab/2024.091

Wulandari, M., Sriwahyuni, S., and Gunawan, D. (2023). Quality Management of Health Services on Patient Satisfaction at Montella Private Hospital West Aceh

District. Medalion journal: Medical Research, Nursing, Health and Midwife Participation, 4(2), 49–64.

https://www.cdc.gov/infection-control/hcp/core-practices/index.

Amirullah, A., Asriwati, A., Nyorong, M., Nur'aini, N., & Maryanti, E. (2022). Analysis of Infection Prevention and Control Program Implementation on Nurses in the Room Dr. Fauziah Bireuen Hospitals Makasaar. Journal of Community Health Provision, 2(3), 163-173. https://doi.org/10.55885/jchp.v2i3.147

Ngatu NR, Kanbara S, Wansu-Mapong C, Tonduangu DK, Leon-Kabamba N, Nsadi-Fwene B, Mindje-Kolomba B, Tshimpi A, Kanda K, Okai C, Suzuki H, Michel-Kabamba N, Balenda-Matondo G, Miyatake N, Nishiyama A, Kuwahara T, Harusato A. Occupational Infection Prevention Among Nurses and Laboratory Technicians Amidst Multiple Health Emergencies in Outbreak-Prone Country, D.R. Congo. Trop Med Infect Dis. 2026 Jan 2;11(1):14. https://doi.org/10.3390/tropicalmed11010014 PMID: 41591223; PMCID: PMC12845926.

Sivaram Shanmugam,2023; The Role of Occupational Health Nurses in Employee Health and Safety, International Journal of Public Health and Safety, Volume 8:4, ISSN: 2736-6189, https://www.hilarispublisher.com/open-access/the-role-of-occupational-health-nurses-in-employee-health-and-safety.pdf

Widianto, E.P., Maisyaroh, A., & Fibriansari, R.D. 2018 ; ORIGINAL RESEARCH : PROACTIVE PUBLIC HEALTH APPROACH TO PREVENTION OF OCCUPATIONAL DISEASE ON FARMERS IN LUMAJANG, International Conference of Kerta Cendekia Nursing Academy. Copyright © 2019 September; 1: 95-101 , Accepted: August 4, 2019 , http://ejournal-kertacendekia.id/index.php/ICKCNA/ , DOI. 10.5281/zenodo.3365519, © 2019 INTERNATIONAL CONFERENCE OF KERTA CENDEKIA NURSING ACADEMY

La Torre G, D'Andreano F, Lecce G, et al. The Occupational Health Nurse and his/here role in the prevention of work-related diseases: results of an observational study. Annali di Igiene : Medicina Preventiva e di Comunita. 2020 Jan-Feb;32(1):3-15. DOI: 10.7416/ai.2020.2325. PMID: 31713572.

Yeni Widyani & Serri Hutahaean, 2024; Nursing Burnout to Infection Prevention and Control Measures Inpatient, Vol. 6, No. 1, April 2024, pp 36-44,

https://doi.org/10.36590/jika.v6i1.616 , http://salnesia.id/index.php/jika , jika@salnesia.id, p-ISSN: 2337-9847, e-ISSN: 2686-2883 Penerbit: Sarana Ilmu Indonesia (salnesia)

PPNI, 2025; News: Perawat RSU Aisyiyah Diteliti Dosen Politeknik Aisyiyah Fokus Risiko Gangguan Muskuloskeletal, https://ppni-inna.org/

M Nur Sholikin & Herawati, 2020; (Legal Aspects of Occupational Safety and Health for Medical and Health Workers During the Pandemic, Majalah Hukum Nasional Volume 50 Nomor 2, P-ISSN: 0126-0227; E-ISSN: 2772 – 0664, DOI : 10.33331/mhn, https://mhn.bphn.go.id

https://mediaperawat.id/appoki-akademi-praktisi-perawat-okupasi-indonesia-menjawab-penantian-2-dekade-akhirnya-memiliki-organisasi-sdm-occupational-health-nurse-ohn-pertama-di-indonesia/

https://businessasia.co.id/appoki-bakal-lakukan-sertifikasi-sdm-ohn-dan-paramedis-di-indonesia/

https://mediaperawat.id/appoki-soroti-pentingnya-implementasi-ebpn-dalam-praktik-dan-pengembangan-ohn/

Ziana Walidah,et.al.,(2024);Studi Kasus Pelaksanaan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) di Kawasan PT Gunbuster Nickel Industry, Aliansi : Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora, Volume. 1, No. 3 May 2024, e- ISSN: 3031-9706; p- ISSN: 3031-9684, Hal 163-171, DOI: https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i3.186

Alfiansyah, R., Mukhlisin, M., & Rahayu, S. (2025). Analisis Risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan Menggunakan Metode *Hazard Identification, Risk Assessment, Determining Control* (HIRADC) di Rumah Sakit X Karawang. Jurnal Teknik Industri Terintegrasi (JUTIN), 8(3), 2879–2879, https://doi.org/10.31004/jutin.v8i3.47148

Andi Sarbiah, (2023); Penerapan Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Karyawan, Health Information : Jurnal Penelitian, Vol. 15 No. 2 : Suplemen

Ferial, R. M. (2020). PENERAPAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS COVID-19 PADA AREA KERJA PT. SEMEN PADANG. JESS (*Journal of Education on Social Science*), 4(2).

Ririn,et.al. (2023); PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP), PENERBIT CV. EUREKA MEDIA AKSARA , ISBN : 978-623-151-704-3

Togu,et.al., (2025); *Factors Affecting the Implementation of OSH in Nurses in the Emergency Department of RSUD dr. Soedarso West Kalimantan Province in 2025*, JURNAL KESMAS DAN GIZI (JKG) , E-ISSN: 2655-0849 , Jurnal

Kesmas dan Gizi (JKG), Volume 7, Nomor 2, https://ejournal.medistra.ac.id/index.php/JKG .

Seally,et.al.,(2020); *ASSOCIATED NURSER BEHAVIOUR AND COMPLIANCE WITH THE USE OF SELF- PROTECTIVE EQUIPMENT IN PREVENTION OF NOSOCOMIAL INFECTIONS IN INPATIENT ROOM Dr. R. M DJOELHAM BINJAI IN 2020*, *Journal of Healthcare Technology and Medicine*, Vol. 6 No. 2 Oktober 2020, Universitas Ubudiyah Indonesia, e-ISSN : 2615-109X 1142

European Agency for Safety and Health at Work, 2013; Priorities for occupational safety and health Health at Work research in Europe: 2013-2020

Luxembourg: Publications Office of the European Union, ISBN: 978-92-9240-068-2, doi: 10.2802/25457

FOHNEU,2012; Occupational Health Nursing Education, Practice and Profile in the EU countries. Education Group, FOHNEU FINAL REPORT. www.fohneu.org

WHO, 2001; The Role of the Occupational Health Nurse in Workplace Health Management WHO Regional Office for Europe, Copenhagen.

NIOSH Malaysia, 2024; Course Title: Occupational Health Nurse , Institut Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan Negara National Institute Of Occupational Safety And Health Kurikulum Kursus Course Curriculum, Url: Www.Niosh.Com.My , Revision No.: Pdd130228

Devanda,et.al, 2025; Book Chapter : RUANG LINGKUP KEPERAWATAN JILID 1, ISBN: 978-623-512-628-9, Penerbit Media Sains Indonesia

Devanda,et.al,2025; BUKU AJAR MANAJEMEN PATIENT SAFETY, ISBN: 978-634-7426-43-7, Penerbit: PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Albyn Devanda Faiqh, Irfandi Rahman, Ali Sadikin Pandiang, 2024;"Exploring the Integration of Theory and Practice for OHN Practitioners and Educators in

Response to Industry Labor Needs", Journal: Journal of Nursing Innovation, Volume: 3, Issue: 3, Pages: 96-104

Albyn, Devanda Faiqh; Permana, Septian Dwi; Rifanto, Eko Adi,2025;"Qualitative Research, Exploratory Phenomenological Study: The Impact of Artificial

intelligence (AI) and Digihealth Transformation in Occupational Health Nurse Practice for the development of OH Programs",Source: The 2 nd UDS

International Conference On Health Sciences, Transforming the Future of Health Care Though Potential Artificial Intelligence", Volume: 1, Issue: 1, Pages: 396, Publisher: https://journal.uds.ac.id/udsproceeding/index

Anny W Malau, Devanda Faiqh Albyn, Daben Suhendi, Sugeng Riyadi,2025;"Qualitative Research: Phenomenological Study of The

Development of OHN From The Perspective of OHNPractitioners In Indonesia And OHN Diaspora"Journal: Journal of Nursing Innovation, Volume: 4, Issue: Original Research, Pages: 1-7, Publisher: Journal of Nursing Innovation (JNI)

Devanda Faiqh Albyn, 2025;"APPOKI: Lembaga Keilmuan OHN di Indonesia Sangat Kurang"https://improvement.co.id/appoki-lembaga-keilmuan-ohn-diindonesia-sangat-kurang/

Devanda Faiqh Albyn, Denny Achkanul Hak, Didit Ribowo,2024;"Qualitatif Research: The Needs Urgency Occupational Health Nurse (OHN) Manpower to support Pembelajaran Berbasis Kasus Dan Problem-Based Learning Pada Program S1 & Profesi Ners Health and Wellness Programe at Indonesian Company", Medical: Jurnal

Kesehatan Dan Kedokteran, Vol. 1, No. 2, Desember, 2024, hlm. 62-67

Devanda Faiqh Albyn,2024;"APPOKI (Akademi Praktisi Perawat Okupasi Indonesia) Pembuka Paradigma Peluang Kerja Perawat di Sektor Industri/Perusahaan

sebagai SDM K3" Source: Mediaperawat.id, URL https://mediaperawat.id/appoki-akademi-praktisi-perawat-okupasi-indonesia-pembuka-paradigma-peluag-kerja-perawat-di-sektor-industri-perusahaan-sebagai-sdm-k3/

Devanda Faiqh Albyn,2024;"Optimalisasi Disitribusi Tenaga Kesehatan sebagai Sdm K3 Occupational Health Nurses dalam Implementasi Csr/Tjsl Perusahaan"Book

Devanda Faiqh Albyn,2025;"APPOKI Soroti Pentingnya Implementasi EBPN dalam Praktik dan Pengembangan OHN", https://mediaperawat.id/appoki-soroti-pentingnya-implementasi-ebpn-dalam-praktik-dan-pengembangan-ohn/

Devanda Faiqh Albyn,2025;"Innovation in Occupational Health Nursing Education E-Learning APPOKI: Descriptive Study on Improving Applicable OHN

Competence Base Practice in Indonesia", 3rd Global Nursing Congress-2025, Manilla, Philippines, Publisher: IFERP Life Science, ISBN 978-93-92106-64-4

Devanda Faiqh Albyn,2025;"STUDI KUALITATIF: FAKTOR – FAKTOR YANG MENYEBABKAN PERAWAT FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN BERALIH

KARIR MENJADI PERAWAT DI INDUSTRI",Journal: Book of Abstract of Trend and Issue in Healthcare, ISSN: 3047-3195,Volume: 2, Issue: 2, Pages: 92-93,

Publisher: PT Nuansa Fajar Cemerlang

Devanda Faiqh Albyn,et.al, 2025;"@ohnurseedu Digital Platform healthcare innovation OHN education opens up a paradigm of job opportunities for

nurses in companies based on Evidence Base Practice Healthcare OHN practice and services in Indonesia" Journal: Journal of Nursing Innovation (JNI), Volume: 4, Issue: 2, Pages: 58-63, Publisher: Journal of Nursing Innovation (JNI)

Devanda, Irfandi Rahman, Ali Sadikin Pandiangan,2024; "Exploratory Phenomenological Study : Justification for OHN Practitioners In Industry and

OHN Lecturers at Universities/Institutes to Synergize Relevant OHN Theory and Practice According to the Needs of Employment in the Company/Industry"

Journal: Journal of Nursing Innovation", Volume:3, Issue:3, Pages:3, Publisher: Journal of Nursing , https://ejournal.infermia.com/index.php/JNI/article/view/45

Bunga Rampai Tren Dan Inovasi Pendidikan Keperawatan: Kurikulum, Praktik Klinik, Dan Pengembangan Profesional Ners Di Indonesia Innovation

Devanda,et.al,2024;"Fenomenology Study: The role of Occupational Health Nurses (OHN) in Emergency and Disaster Services, Qualitative Research",Babali

Emergency and Disaster Research Vol. 1 No. 2 (2023): December

Devanda,et.al,2024;"Buku Ensiklopedi Occupational Health Nursing", Publisher: Deepublisher, ISBN: 978-623-02-8416-8

Devanda,et.al,2025;"BUKU AJAR MANAJEMEN PATIENT SAFETY",Publisher: Optimal Untuk Negeri,ISBN : 978-634-7426-43-7

Devanda,et.al,2025;"ENSIKLOPEDIA PROFESI KESEHATAN KESELAMATAN KERJA DI INDUSTRI (MENGENAL PELUANG KERJA DI BIDANG K3)",Publisher: Media

Sains Indonesia, ISBN: 978-623-512-787-3

Devanda,et.al,2025;"PARAMEDIC SITE (TEORI DAN APLIKASI)",Media Sains Indonesia, ISBN: 978-623-512-613-5

Devanda,et.al,2025;"QUALITATIVE RESEARCH, EXPLORATORY PHENOMENOLOGY STUDY: JOB OPPORTUNITIES FOR NURSES AS OHN AND PARAMEDICS IN

MINING COMPANIES FROM A WELFARE ASPECT POINT OF VIEW" Conference: 4th PontiPekerja International Health Conference, ISSN: 3090 - 5117, Volume: 1,

Issue: 1, Pages:11

Devanda; Lujeng; Wibowo, Tri Suryo; Yamini, Ulfa; Samosir, Emyranda,2025;"The Perspectives of Nursing Lecturers and Students Regarding Job Opportunities

and Nursing Courses in Industry/Companies as Workers As Part Of Occupational Health And Safety: Qualitative Study",Journal: Journal of Nursing

Innovation (JNI), Volume: 4, Issue: 1, Pages:26-29, Publisher: Journal of Nursing Innovation (JNI)

Devanda,2024; Green Leader: Trend Kepemimpinan Hijau Masa Kini (Teori, Praktek, dan Analisis), ISBN : 978-623-516-852-4, Publisher: Eureka Media Aksara ,

https://penerbiteureka.com/2024/11/09/green-leader-trend-kepemimpinan-hijau-masa-kini-teori-praktek-dan-analisis/

Kisaki & Hikaru (2024). Collaboration in Occupational Health Nursing: A Concept Analysis Review. https://doi.org/10.1177/21650799241291235

National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine 2021. The Future of

Nola & Janet (2025) Book: Evidance Based Practice For Nurse, Appraisial and

Application of Research, 6th Edition

Nursing 2020-2030: Charting a Path to Achieve Health Equity. Washington, DC

Ruhrer, B. (2016). The Value of Occupational Health Nursing. https://doi.org/10.17615/eqmy-8d31

Sue,etal. (2024) Integrating nurse practitioners into primary healthcare to advance health equity through a social justice lens: An integrative review. https://doi.org/10.1111/jan.16093

Sutrisno Devanda, Hasdar,2024;"Qualitative Research: Phenomenological Study "The Existence of Occupational Health Nurse (OHN) Profession in Indonesia,

Evidence-Based Practice" Conference: 6TH CONFERENCE OF COMMUNITY EMPOWERMENT FOR HEALTH 2024 "MULTI-HELIX COMMUNITY

EMPOWERMENT" Pages:33

The National Academies Press. https://doi.org/10.17226/25982

Zehra & Ali (2023) Update on occupational health nursing through 21st century requirements: A three-round Delphi Study https://doi.org/10.1016/j.nedt.2022.105657

https://spkep-spsi.org/bpjs-ketenagakerjaan-catat-4-410-kasus-penyakit-akibat-kerja-hingga-mei-2025/

Ana Puji Astuti, S.Kep., Ns., M.Kes., dkk., 2026; Bank Soal UKOM Keperawatan Terstandar Nasional Berbasis Kasus & Pembahasan Mendalam , ISBN : 978-634-7556-39-4 , Penerbit: PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

BAB 4

MANAJEMEN SUMBER DAYA DAN LOGISTIK KEPERAWATAN

A. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menguasai konsep dasar manajemen keperawatan, peran perawat manajer, serta etika–legal dalam pengelolaan pelayanan.	CPMK-1; CPMK-2
CPL-2	Mampu menganalisis organisasi pelayanan keperawatan dan sistem layanan kesehatan untuk mendukung tata kelola dan kesinambungan layanan.	CPMK-2; CPMK-7
CPL-3	Mampu menerapkan kepemimpinan keperawatan, komunikasi efektif, kolaborasi, dan manajemen konflik serta perubahan dalam tim.	CPMK-3; CPMK-5
CPL-4	Mampu merencanakan dan mengelola SDM keperawatan (kebutuhan, penjadwalan, delegasi, supervisi) secara adil, aman, dan efisien.	CPMK-4; CPMK-5
CPL-5	Mampu menerapkan manajemen mutu, keselamatan pasien, manajemen risiko, PPI, dan K3 sebagai budaya kerja untuk peningkatan layanan.	CPMK-6; CPMK-7
CPL-6	Mampu memanfaatkan dokumentasi, informatika, standar–akreditasi, serta data kinerja untuk evaluasi, pelaporan, dan perbaikan mutu berkelanjutan.	CPMK-7; CPMK-2; CPMK-6

B. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menjelaskan konsep dasar manajemen keperawatan, fungsi manajemen, peran perawat manajer, serta etika–legal dalam pelayanan.
CPMK-2	Menganalisis organisasi pelayanan keperawatan dan sistem layanan kesehatan (tata kelola, standar, kebijakan) untuk mendukung pengambilan keputusan manajerial.
CPMK-3	Menerapkan kepemimpinan keperawatan, manajemen perubahan, komunikasi efektif, kolaborasi, dan manajemen konflik dalam pengelolaan tim.
CPMK-4	Merencanakan kebutuhan dan penjadwalan SDM keperawatan berdasarkan beban kerja, kompetensi, dan prinsip keadilan–keselamatan.
CPMK-5	Mengelola manajemen asuhan keperawatan melalui delegasi, supervisi, koordinasi, serta pemanfaatan sumber daya/logistik secara efisien.
CPMK-6	Menerapkan manajemen mutu, keselamatan pasien, manajemen risiko klinis, PPI, dan K3 dalam peningkatan kinerja pelayanan keperawatan.

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-7	Menggunakan dokumentasi, informatika, audit data, dan pelaporan untuk evaluasi kinerja serta menyusun proyek mini peningkatan mutu berbasis data.

F. Pemetaan

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 4. Manajemen Sumber Daya dan Logistik Keperawatan	4.1 Menentukan kebutuhan logistik prioritas berdasarkan beban layanan dan keselamatan pasien.	4.2 Menyusun pengendalian persediaan (pencatatan, pemantauan, pencegahan kekosongan/overstock) berbasis data.	CPMK-5	CPMK-4; CPMK-6

G. Asesmen (berbasis CPMK)

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-4	Penugasan perencanaan SDM & jadwal dinas	Akurasi perhitungan kebutuhan tenaga dan kualitas jadwal (cakupan layanan, kepatuhan aturan, pemerataan) (skor rubrik).	15	Perhitungan SDM; jadwal dinas
CPMK-5	Studi kasus delegasi–supervisi & logistik	Ketepatan keputusan delegasi dan rencana supervisi, serta ketepatan rencana pengendalian logistik (skor rubrik).	15	Laporan kasus; rencana delegasi; rencana logistik
CPMK-6	Simulasi fasilitasi/kemitraan (role play)	Kualitas fasilitasi partisipasi + kejelasan rencana kolaborasi/advokasi (skor rubrik).	15	Lembar penilaian; rencana kemitraan

Rubrik CPMK-1

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
1.1 Ketepatan konsep fungsi manajemen (% benar)	<60% benar; miskonsepsi dominan	60–74% benar; miskonsepsi masih ada	75–89% benar; kesalahan minor	≥90% benar; konsisten
1.2 Ketepatan penerapan peran–akuntabilitas pada skenario	Keliru/tidak relevan	Relevan sebagian; alasan lemah	Tepat; alasan logis	Tepat; alasan kuat dan komprehensif

Rubrik CPMK-2

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
2.1 Ketepatan pemetaan struktur & alur layanan	Tidak akurat; komponen inti hilang	Cukup akurat; masih ada kekeliruan bermakna	Akurat; kekeliruan minor	Sangat akurat; komprehensif dan jelas
2.2 Ketepatan gap analysis & prioritas perbaikan	Gap tidak sesuai standar; prioritas acak	Gap sebagian tepat; prioritas kurang konsisten	Gap tepat; prioritas jelas	Gap sangat tepat; prioritas sangat logis & berbasis risiko

Rubrik CPMK-3

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
3.1 Kinerja kepemimpinan & manajemen perubahan (checklist)	≤60% perilaku tercapai; tidak terarah	61–75% tercapai; arah sebagian jelas	76–90% tercapai; terarah & konsisten	>90% tercapai; adaptif, memotivasi, terstruktur
3.2 Komunikasi efektif & resolusi konflik (checklist)	Konflik tidak tertangani; komunikasi tidak jelas	Ada upaya; solusi belum disepakati	Solusi disepakati; komunikasi runtut	Solusi kuat; komunikasi sangat efektif & menjaga hubungan kerja

Rubrik CPMK-4

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
4.1 Akurasi perhitungan kebutuhan tenaga	Banyak kesalahan; asumsi tidak jelas	Cukup tepat; masih ada kesalahan bermakna	Tepat; kesalahan minor	Sangat tepat; asumsi jelas & dapat dipertanggungjawabkan
4.2 Kualitas jadwal dinas (cakupan, aturan, pemerataan)	Cakupan tidak aman; melanggar aturan	Cakupan cukup; pemerataan kurang	Cakupan aman; aturan dipatuhi; cukup adil	Cakupan sangat aman; patuh aturan; sangat adil & minim risiko kelelahan

Rubrik CPMK-5

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
5.1 Ketepatan keputusan delegasi & rencana supervisi	Delegasi tidak sesuai kompetensi/risiko	Delegasi cukup sesuai; supervisi kurang spesifik	Delegasi sesuai; supervisi jelas	Delegasi sangat tepat; supervisi terukur & antisipatif risiko
5.2 Ketepatan rencana pengendalian logistik	Tidak berbasis kebutuhan; rawan kekosongan	Berbasis kebutuhan sebagian; kontrol kurang	Berbasis data; kontrol memadai	Berbasis data komprehensif; kontrol sangat efektif (minim stockout/overstock)

Rubrik CPMK-6

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
6.1 Ketepatan indikator & analisis temuan audit	Indikator tidak tepat; analisis tidak sesuai	Indikator cukup; analisis terbatas	Indikator tepat; analisis jelas	Indikator sangat tepat; analisis kritis berbasis data/tren
6.2 Kelayakan rencana mitigasi risiko/PPI/K3 (terukur)	Rencana umum; tidak terukur	Ada rencana; indikator belum jelas	Rencana spesifik; indikator terukur	Rencana sangat spesifik, terukur, realistis; prioritas berbasis risiko

Rubrik CPMK-7

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
7.1 Kelengkapan laporan berbasis data (baseline–target–hasil)	Data tidak lengkap; tidak dapat dievaluasi	Data cukup; hubungan baseline–hasil kurang jelas	Data lengkap; evaluasi jelas	Data sangat lengkap; evaluasi kuat dan transparan
7.2 Kualitas proyek mini peningkatan mutu (rencana–uji–evaluasi)	Tidak sistematis; tanpa evaluasi hasil	Sistematis sebagian; evaluasi terbatas	Sistematis; evaluasi hasil memadai	Sangat sistematis; evaluasi kuat; rekomendasi implementatif & berkelanjutan

A. Konsep Manajemen Sumber Daya

1. Pengertian

Manajemen sumber daya dan logistik keperawatan merupakan suatu proses sistematis yang mencakup kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengendalian seluruh sumber daya yang digunakan dalam

pelayanan keperawatan. Sumber daya tersebut meliputi tenaga keperawatan, sarana dan prasarana, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, serta sistem informasi yang mendukung pelayanan kesehatan.

Menurut Nursalam (2017), manajemen keperawatan adalah suatu proses bekerja melalui tenaga keperawatan untuk memberikan asuhan keperawatan secara profesional dengan tujuan mencapai pelayanan yang bermutu. Definisi ini menekankan bahwa manajemen keperawatan tidak hanya berfokus pada tugas klinis, tetapi juga pada kemampuan mengelola tenaga kerja dan sumber daya secara efektif.

Menurut World Health Organization (2020), manajemen logistik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk memastikan ketersediaan produk kesehatan secara tepat waktu, dalam jumlah yang cukup, dengan kualitas yang baik, serta biaya yang efisien. Hal ini menunjukkan bahwa logistik merupakan bagian penting dalam sistem pelayanan kesehatan yang tidak dapat dipisahkan dari praktik keperawatan.

Selain itu, menurut Marquis & Huston (2015), manajemen keperawatan merupakan suatu proses yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Pendapat lain dikemukakan oleh Huber (2017), yang menyatakan bahwa manajemen keperawatan berfokus pada pengelolaan sumber daya manusia dan material dalam pelayanan kesehatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan keselamatan pasien.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber daya dan logistik keperawatan adalah suatu proses terpadu yang bertujuan untuk mengelola seluruh sumber daya secara efektif, efisien, dan terkoordinasi guna mendukung pelayanan keperawatan yang berkualitas.

Dalam praktiknya, manajemen ini memiliki peran strategis karena berkaitan langsung dengan mutu pelayanan kesehatan. Ketersediaan alat dan bahan medis yang memadai akan mempercepat tindakan keperawatan, sedangkan kekurangan logistik dapat menyebabkan keterlambatan pelayanan dan meningkatkan risiko terhadap pasien.

Selain itu, manajemen sumber daya juga berkaitan erat dengan efisiensi penggunaan anggaran. Pengelolaan yang tidak tepat dapat menyebabkan pemborosan, sedangkan pengelolaan yang baik akan meningkatkan efektivitas pelayanan serta mengurangi biaya operasional.

Dengan demikian, manajemen sumber daya dan logistik keperawatan merupakan komponen penting dalam sistem pelayanan kesehatan yang harus dikelola secara profesional dan berkelanjutan

2. Tujuan

   Tujuan manajemen sumber daya dan logistik keperawatan adalah untuk menjamin ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan serta meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.

   Secara rinci tujuan tersebut meliputi:

   a. Menjamin ketersediaan alat dan bahan medis
   b. Meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan
   c. Menjamin keselamatan pasien (patient safety)
   d. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya
   e. Mengurangi pemborosan
   f. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan
   g. Mendukung kelancaran operasional pelayanan kesehatan
   h. Meningkatkan kepuasan pasien

3. Fungsi Manajemen (POAC)

   Planning

   Menentukan kebutuhan alat dan tenaga

   Organizing

   Membagi tugas dan tanggung jawab

   Actuating

   Pelaksanaan penggunaan alat

   Controlling

   Pengawasan dan evaluasi

4. Jenis Sumber Daya

   JENIS SUMBER DAYA

   Sumber daya dalam keperawatan merupakan seluruh komponen yang digunakan dalam proses pelayanan kesehatan. Pengelolaan sumber daya yang baik akan meningkatkan kualitas pelayanan serta efisiensi kerja.

   Sumber Daya Manusia (SDM)

   SDM merupakan komponen utama dalam pelayanan keperawatan. Perawat harus memiliki kompetensi yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional.

   Pengelolaan SDM mencakup:

   - Perencanaan tenaga kerja
   - Rekrutmen
   - Pelatihan

- Evaluasi kinerja

5. Sarana dan Prasarana
   Meliputi fasilitas fisik seperti ruang rawat, tempat tidur pasien, dan lingkungan pelayanan.
6. Alat Kesehatan
   Digunakan dalam tindakan medis dan harus selalu dalam kondisi baik.
7. Bahan Medis Habis Pakai
   Seperti sarung tangan, kasa, dan cairan infus.
8. Teknologi Informasi
   Mendukung efisiensi pelayanan melalui digitalisasi.
9. Sumber Daya Finansial
   Dana untuk operasional pelayanan kesehatan.
10. Sumber Daya Waktu
    Waktu sebagai faktor penting dalam pelayanan cepat dan tepat.

B. Mengidentifikasi Jenis Logistik Keperawatan

1. Pengertian Logistik Keperawatan
   Logistik keperawatan adalah pengelolaan barang dan alat kesehatan yang digunakan dalam pelayanan keperawatan.
2. Jenis Logistik
   a. Logistik Medis
   b. Obat-obatan
   c. Alat kesehatan (infus set, kateter, dll)
3. Logistik Non Medis
   a. Linen
   b. Alat kebersihan
   c. ATK
4. Logistik Habis Pakai
   a. Sarung tangan
   b. Spuit
   c. Kassa
5. Logistik Tidak Habis Pakai
   a. Tensimeter
   b. Stetoskop
   c. Bed pasien

C. Karakteristik Logistik

1. Memiliki masa pakai
2. Memerlukan penyimpanan khusus
3. Harus sesuai standar keselamatan pasien
4. Jenis Logistik

   Logistik keperawatan merupakan sistem pengelolaan alat dan bahan medis yang digunakan dalam pelayanan kesehatan. Sistem ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua kebutuhan pelayanan tersedia secara tepat waktu, dalam jumlah yang cukup, dan dalam kondisi yang baik.

   Tahapan Logistik:

   a. Perencanaan
   b. Pengadaan
   c. Penyimpanan
   d. Distribusi
   e. Pengendalian

   Prinsip Logistik:

   a. Tepat jenis
   b. Tepat jumlah
   c. Tepat waktu
   d. Tepat tempat
   e. Tepat biaya

   Permasalahan Logistik:

   a. Kekurangan stok
   b. Kelebihan stok
   c. Distribusi lambat

   Dampak:

   a. Keterlambatan tindakan
   b. Risiko keselamatan pasien
5. Siklus Logistik

   Perencanaan → Pengadaan → Penyimpanan → Distribusi → Penggunaan → Evaluasi
6. Patient Safety

   Kesalahan logistik dapat menyebabkan:

   - Infeksi
   - Keterlambatan terapi
   - Cedera pasien

7. IMPLEMENTASI DI RUMAH SAKIT

Manajemen logistik dilakukan melalui:

- Kepala ruangan
- Tim logistik
- Sistem pencatatan

Mengambil Keputusan dalam Keterbatasan Alat

A. Konsep Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan adalah proses memilih tindakan terbaik dari beberapa alternatif dalam kondisi tertentu.

B. Prinsip Pengambilan Keputusan

1. Prioritas keselamatan pasien
2. Berdasarkan kebutuhan paling mendesak
3. Menggunakan clinical judgment

C. Langkah-langkah

1. Identifikasi masalah
2. Kumpulkan data
3. Tentukan alternatif
4. Pilih tindakan terbaik
5. Evaluasi hasil

D. Contoh Kasus

Di ruang rawat hanya tersedia 1 oksigen, sedangkan ada 2 pasien sesak.

Keputusan Perawat:

- Prioritaskan pasien dengan kondisi lebih berat (SpO_2 rendah) Kolaborasi dengan tim untuk tambahan alat
- Monitoring ketat pasien lainnya

E. Mengevaluasi Sistem Logistik

- **Pengertian Evaluasi**

Evaluasi adalah proses menilai apakah sistem logistik berjalan sesuai standar dan tujuan.

- **Indikator Evaluasi**
  - Ketersediaan alat
  - Ketepatan penggunaan
  - Tidak terjadi kekosongan stok
  - Tidak ada alat kadaluarsa
  - Efisiensi biaya
- **Metode Evaluasi**
  - Audit logistik
  - Stock opname

- Laporan penggunaan
- Supervisi

- **Masalah Umum**
  - Stock out (kehabisan)
  - Overstock
  - Barang kadaluarsa
  - Pencatatan tidak akurat
- **Tindak Lanjut**
  - Perbaikan sistem pencatatan
  - Pelatihan petugas
  - Penguatan SOP

D. KESIMPULAN

Manajemen sumber daya dan logistik keperawatan sangat penting dalam menjamin mutu pelayanan. Perawat harus mampu:

- Mengelola sumber daya secara optimal
- Menggunakan logistik secara efektif
- Mengambil keputusan dalam kondisi terbatas
- Melakukan evaluasi berkelanjutan

CONTOH KASUS

Kasus 1

Seorang pasien laki-laki usia 50 tahun datang ke IGD dengan kondisi dehidrasi berat. Tanda vital menunjukkan tekanan darah 90/60 mmHg dan nadi 110x/menit. Dokter menginstruksikan pemasangan infus segera.

Namun, saat tindakan akan dilakukan, infus set tidak tersedia. Stok cairan infus juga terbatas. Hal ini menyebabkan keterlambatan tindakan yang berisiko memperburuk kondisi pasien.

Identifikasi Masalah

- Kekurangan alat kesehatan
- Keterlambatan distribusi
- Monitoring stok tidak optimal
- Kurangnya koordinasi

Analisis

Terjadi kegagalan pada:

- Perencanaan
- Distribusi
- Pengendalian logistik

Dampak: keterlambatan tindakan dan risiko keselamatan pasien.

Tindakan Keperawatan

- Monitoring pasien
- Koordinasi logistik
- Mencari alat alternatif
- Dokumentasi

Tindakan Manajerial

- Evaluasi sistem
- Perbaikan distribusi
- Penambahan stok cadangan

Dampak

Jika tidak ditangani:

- Kondisi pasien memburuk
- Pelayanan terganggu
- Risiko malpraktik

Kasus Lanjutan

Pasien membutuhkan antibiotik IV, tetapi obat tidak tersedia. Terjadi keterlambatan terapi.

Solusi

- Koordinasi farmasi

- Sistem distribusi cepat
- Stok minimal ruangan

SOAL UKOM

1. Tujuan logistik adalah…
   Jawaban: Menjamin ketersediaan alat
2. Risiko penyimpanan salah…
   Jawaban: Infeksi
3. Prioritas alat terbatas…
   Jawaban: Pasien kritis

PENUTUP

Manajemen sumber daya dan logistik keperawatan sangat penting dalam meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.

Referensi

American Nurses Association. (2016). Nursing Administration: Scope and Standards of Practice (2nd ed.). Silver Spring: ANA.

Anggraini, D., & Sari, R. (2020). Manajemen logistik dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit. Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia, 8(2), 120–128.

Arikunto, S. (2013). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.

Armstrong, M. (2014). Armstrong's Handbook of Human Resource Management Practice (13th ed.). London: Kogan Page.

Asmadi. (2008). Konsep Dasar Keperawatan. Jakarta: EGC.

Azwar, A. (2010). Pengantar Administrasi Kesehatan. Jakarta: Binarupa Aksara.

Departemen Kesehatan Republik Indonesia. (2009). Sistem Kesehatan Nasional. Jakarta: Depkes RI.

Dessler, G. (2013). Human Resource Management (13th ed.). New Jersey: Pearson

Finkler, S. A., Ward, D. M., & Baker, J. J. (2018). Financial Management for Nurse Managers and Executives (5th ed.). St. Louis: Elsevier.

Fitriani, Y. (2019). Pengaruh manajemen sumber daya manusia terhadap kinerja perawat di rumah sakit. Jurnal Keperawatan Indonesia, 22(1), 45–53.

Gillies, D. A. (1996). Nursing Management: A Systems Approach (3rd ed.). Philadelphia: W.B. Saunders Company.

Hastuti, P. (2021). Evaluasi sistem logistik farmasi di rumah sakit pemerintah. Jurnal Manajemen Kesehatan, 9(1), 67–75.

Hidayat, A. A. A. (2014). Pengantar Konsep Dasar Keperawatan. Jakarta: Salemba Medika.

Hidayat, A. A. A. (2017). Metode Penelitian Keperawatan dan Teknik Analisis Data. Jakarta: Salemba Medika.

Huber, D. (2017). Leadership and Nursing Care Management (6th ed.). St. Louis: Elsevier.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2016). Pedoman Manajemen Logistik Obat di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Jakarta: Kemenkes RI.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2019). Pedoman Manajemen Logistik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Jakarta: Kemenkes RI.

Kotler, P., & Keller, K. L. (2012). Marketing Management (14th ed.). New Jersey: Pearson Education.

Lestari, W. (2018). Hubungan ketersediaan alat kesehatan dengan kualitas pelayanan keperawatan. Jurnal Ilmu Keperawatan, 6(2), 89–97.

Marquis, B. L., & Huston, C. J. (2015). Leadership Roles and Management Functions in Nursing: Theory and Application (8th ed.). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.

Marwansyah. (2016). Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: Alfabeta.

Mintzberg, H. (2009). Managing. San Francisco: Berrett-Koehler Publishers.

Mubarak, W. I., & Chayatin, N. (2009). Ilmu Kesehatan Masyarakat: Teori dan Aplikasi. Jakarta: Salemba Medika.

Notoatmodjo, S. (2010). Ilmu Kesehatan Masyarakat. Jakarta: Rineka Cipta.

Notoatmodjo, S. (2012). Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta.

Nursalam. (2017). Manajemen Keperawatan: Aplikasi dalam Praktik Keperawatan Profesional (Edisi 5). Jakarta: Salemba Medika.

Porter, M. E. (2008). Competitive Strategy. New York: Free Press.

Pratama, A., & Yuliana, S. (2022). Efektivitas manajemen logistik dalam pelayanan keperawatan. Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia, 17(1), 34–42.

Rahmawati, D. (2020). Analisis manajemen logistik di instalasi gawat darurat. Jurnal Keperawatan Klinis, 5(3), 150–158.

Rivai, V. (2015). Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan. Jakarta: Rajawali Pers.

Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2013). Organizational Behavior (15th ed.). New Jersey: Pearson Education.

Saputra, R. (2021). Pengaruh manajemen logistik terhadap keselamatan pasien. Jurnal Administrasi Rumah Sakit Indonesia, 7(2), 101–110.

Sari, M., & Handayani, L. (2019). Pengelolaan bahan medis habis pakai di rumah sakit. Jurnal Keperawatan dan Kesehatan, 10(2), 77–85.

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sujarweni, V. W. (2014). Metodologi Penelitian Keperawatan. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Sullivan, E. J., & Decker, P. J. (2009). Effective Leadership and Management in Nursing (7th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson.

Sutrisno, E. (2016). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Kencana.

Swanburg, R. C., & Swanburg, R. J. (2000). Introductory Management and Leadership for Nurses (3rd ed.). Boston: Jones & Bartlett Publishers

UNICEF. (2018). Supply Chain Handbook: A Practical Guide for Health Commodities. New York: UNICEF.

USAID. (2015). The Logistics Handbook: A Practical Guide for Supply Chain Managers. Arlington: USAID.

Utami, N. (2022). Evaluasi distribusi logistik dalam pelayanan kesehatan. Jurnal Kesehatan Indonesia, 12(1), 55–63.

World Health Organization. (2011). Medical Supply Chains and Logistics Systems: A Guide for Health Facilities. Geneva: WHO.

World Health Organization. (2020). Health Logistics Management: A Practical Guide for Health Systems. Geneva: WHO Press.

Wulandari, T. (2020). Peran manajemen sumber daya dalam meningkatkan mutu pelayanan keperawatan. Jurnal Ilmu Kesehatan, 8(2), 140–148.

Yoder-Wise, P. S. (2014). Leading and Managing in Nursing (5th ed.). St. Louis: Elsevier Mosby.

BAB 5

MANAJEMEN DOKUMENTASI, INFORMATIKA,DAN REKAM MEDIS

A. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menguasai konsep dasar manajemen keperawatan, peran perawat manajer, serta etika–legal dalam pengelolaan pelayanan.	CPMK-1; CPMK-2
CPL-2	Mampu menganalisis organisasi pelayanan keperawatan dan sistem layanan kesehatan untuk mendukung tata kelola dan kesinambungan layanan.	CPMK-2; CPMK-7
CPL-3	Mampu menerapkan kepemimpinan keperawatan, komunikasi efektif, kolaborasi, dan manajemen konflik serta perubahan dalam tim.	CPMK-3; CPMK-5
CPL-4	Mampu merencanakan dan mengelola SDM keperawatan (kebutuhan, penjadwalan, delegasi, supervisi) secara adil, aman, dan efisien.	CPMK-4; CPMK-5
CPL-5	Mampu menerapkan manajemen mutu, keselamatan pasien, manajemen risiko, PPI, dan K3 sebagai budaya kerja untuk peningkatan layanan.	CPMK-6; CPMK-7
CPL-6	Mampu memanfaatkan dokumentasi, informatika, standar–akreditasi, serta data kinerja untuk evaluasi, pelaporan, dan perbaikan mutu berkelanjutan.	CPMK-7; CPMK-2; CPMK-6

B. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menjelaskan konsep dasar manajemen keperawatan, fungsi manajemen, peran perawat manajer, serta etika–legal dalam pelayanan.
CPMK-2	Menganalisis organisasi pelayanan keperawatan dan sistem layanan kesehatan (tata kelola, standar, kebijakan) untuk mendukung pengambilan keputusan manajerial.
CPMK-3	Menerapkan kepemimpinan keperawatan, manajemen perubahan, komunikasi efektif, kolaborasi, dan manajemen konflik dalam pengelolaan tim.
CPMK-4	Merencanakan kebutuhan dan penjadwalan SDM keperawatan berdasarkan beban kerja, kompetensi, dan prinsip keadilan–keselamatan.
CPMK-5	Mengelola manajemen asuhan keperawatan melalui delegasi, supervisi, koordinasi, serta pemanfaatan sumber daya/logistik secara efisien.
CPMK-6	Menerapkan manajemen mutu, keselamatan pasien, manajemen risiko klinis, PPI, dan K3 dalam peningkatan kinerja pelayanan keperawatan.

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-7	Menggunakan dokumentasi, informatika, audit data, dan pelaporan untuk evaluasi kinerja serta menyusun proyek mini peningkatan mutu berbasis data.

G. Pemetaan

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 5. Manajemen Dokumentasi, Informatika, dan Rekam Medis	5.1 Menetapkan standar dokumentasi keperawatan yang lengkap, tepat waktu, dan dapat diaudit.	5.2 Memanfaatkan data/informatika untuk pelaporan kinerja dan pengambilan keputusan manajerial.	CPMK-7	CPMK-2; CPMK-6

H. Asesmen (berbasis CPMK)

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-2	Tugas analisis organisasi & standar (paper ringkas)	Ketepatan pemetaan struktur/alur layanan dan ketepatan identifikasi gap terhadap standar (skor rubrik).	15	Dokumen analisis; matriks gap
CPMK-6	Simulasi fasilitasi/kemitraan (role play)	Kualitas fasilitasi partisipasi + kejelasan rencana kolaborasi/advokasi (skor rubrik).	15	Lembar penilaian; rencana kemitraan
CPMK-7	Proyek mini peningkatan mutu + portofolio laporan	Kelengkapan laporan berbasis data (baseline–target–hasil) dan kualitas rekomendasi perbaikan terukur.	15	Laporan proyek; portofolio data; refleksi

Rubrik CPMK-1

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
1.1 Ketepatan konsep fungsi manajemen (% benar)	<60% benar; miskonsepsi dominan	60–74% benar; miskonsepsi masih ada	75–89% benar; kesalahan minor	≥90% benar; konsisten
1.2 Ketepatan penerapan peran–akuntabilitas pada skenario	Keliru/tidak relevan	Relevan sebagian; alasan lemah	Tepat; alasan logis	Tepat; alasan kuat dan komprehensif

Rubrik CPMK-2

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
2.1 Ketepatan pemetaan struktur & alur layanan	Tidak akurat; komponen inti hilang	Cukup akurat; masih ada kekeliruan bermakna	Akurat; kekeliruan minor	Sangat akurat; komprehensif dan jelas
2.2 Ketepatan gap analysis & prioritas perbaikan	Gap tidak sesuai standar; prioritas acak	Gap sebagian tepat; prioritas kurang konsisten	Gap tepat; prioritas jelas	Gap sangat tepat; prioritas sangat logis & berbasis risiko

Rubrik CPMK-3

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
3.1 Kinerja kepemimpinan & manajemen perubahan (checklist)	≤60% perilaku tercapai; tidak terarah	61–75% tercapai; arah sebagian jelas	76–90% tercapai; terarah & konsisten	>90% tercapai; adaptif, memotivasi, terstruktur
3.2 Komunikasi efektif & resolusi konflik (checklist)	Konflik tidak tertangani; komunikasi tidak jelas	Ada upaya; solusi belum disepakati	Solusi disepakati; komunikasi runtut	Solusi kuat; komunikasi sangat efektif & menjaga hubungan kerja

Rubrik CPMK-4

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
4.1 Akurasi perhitungan kebutuhan tenaga	Banyak kesalahan; asumsi tidak jelas	Cukup tepat; masih ada kesalahan bermakna	Tepat; kesalahan minor	Sangat tepat; asumsi jelas & dapat dipertanggungjawabkan
4.2 Kualitas jadwal dinas (cakupan, aturan, pemerataan)	Cakupan tidak aman; melanggar aturan	Cakupan cukup; pemerataan kurang	Cakupan aman; aturan dipatuhi; cukup adil	Cakupan sangat aman; patuh aturan; sangat adil & minim risiko kelelahan

Rubrik CPMK-5

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
5.1 Ketepatan keputusan delegasi & rencana supervisi	Delegasi tidak sesuai kompetensi/risiko	Delegasi cukup sesuai; supervisi kurang spesifik	Delegasi sesuai; supervisi jelas	Delegasi sangat tepat; supervisi terukur & antisipatif risiko
5.2 Ketepatan rencana pengendalian logistik	Tidak berbasis kebutuhan; rawan kekosongan	Berbasis kebutuhan sebagian; kontrol kurang	Berbasis data; kontrol memadai	Berbasis data komprehensif; kontrol sangat efektif (minim stockout/overstock)

Rubrik CPMK-6

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
6.1 Ketepatan indikator & analisis temuan audit	Indikator tidak tepat; analisis tidak sesuai	Indikator cukup; analisis terbatas	Indikator tepat; analisis jelas	Indikator sangat tepat; analisis kritis berbasis data/tren
6.2 Kelayakan rencana mitigasi risiko/PPI/K3 (terukur)	Rencana umum; tidak terukur	Ada rencana; indikator belum jelas	Rencana spesifik; indikator terukur	Rencana sangat spesifik, terukur, realistis; prioritas berbasis risiko

Rubrik CPMK-7

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
7.1 Kelengkapan laporan berbasis data (baseline–target–hasil)	Data tidak lengkap; tidak dapat dievaluasi	Data cukup; hubungan baseline–hasil kurang jelas	Data lengkap; evaluasi jelas	Data sangat lengkap; evaluasi kuat dan transparan
7.2 Kualitas proyek mini peningkatan mutu (rencana–uji–evaluasi)	Tidak sistematis; tanpa evaluasi hasil	Sistematis sebagian; evaluasi terbatas	Sistematis; evaluasi hasil memadai	Sangat sistematis; evaluasi kuat; rekomendasi implementatif & berkelanjutan

A. MANAJEMEN DOKUMENTASI

Manajemen dokumentasi merupakan proses sistematis dalam mengelola dokumen mulai dari penciptaan, penggunaan, penyimpanan, hingga pemusnahan. Dalam pelayanan kesehatan, manajemen dokumentasi memiliki peran penting

dalam menjamin ketersediaan informasi yang akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pengelolaan rekam medis yang baik sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan kesehatan. "Pengelolaan rekam medis yang baik dapat meningkatkan kinerja petugas serta mendukung efektivitas pelayanan kesehatan" (Asia et al., 2024, hlm. 60). Hal ini menunjukkan bahwa sistem dokumentasi yang terstruktur mampu meningkatkan efisiensi kerja petugas.

Selain itu, penggunaan sistem berbasis teknologi dalam pengelolaan dokumen juga memberikan kemudahan dalam proses pengolahan data. Sistem informasi pengolahan data rekam medis elektronik mampu menunjang pelaporan dan pengelolaan data pasien secara lebih efektif (Hermawan et al., 2024). Dengan demikian, manajemen dokumentasi yang baik tidak hanya mendukung administrasi, tetapi juga meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.

B. INFORMATIKA

Informatika kesehatan merupakan bidang ilmu yang menggabungkan teknologi informasi dengan pelayanan kesehatan untuk meningkatkan kualitas layanan. Pemanfaatan teknologi dalam sistem kesehatan memungkinkan pengolahan data menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien.

"Penerapan teknologi informasi dalam rekam medis memberikan kemudahan dalam akses data serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan" (Suryanto & Subekti, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi sangat membantu tenaga medis dalam mengakses data pasien secara real-time.

Rekam medis elektronik juga menjadi bagian penting dalam transformasi digital di bidang kesehatan. "Rekam medis elektronik merupakan bagian penting dalam transformasi digital pelayanan kesehatan di Indonesia" (Ariyanto & Andriyanto, 2024). Dengan adanya sistem digital, proses pencatatan dan penyimpanan data menjadi lebih terintegrasi.

Selain itu, implementasi teknologi digital dalam pelayanan kesehatan memberikan dampak positif terhadap efektivitas dan efisiensi layanan (Hansen & Oktamianti, 2024). Oleh karena itu, informatika kesehatan menjadi komponen penting dalam pengembangan sistem pelayanan kesehatan modern.

C. REKAM MEDIS

Rekam medis adalah dokumen yang berisi informasi lengkap mengenai identitas pasien, hasil pemeriksaan, diagnosis, tindakan, serta pelayanan kesehatan

yang diberikan. Rekam medis memiliki peran penting sebagai sumber informasi utama dalam proses pelayanan kesehatan.

"Penerapan rekam medis elektronik dapat meningkatkan efisiensi kerja perekam medis dalam memberikan pelayanan kepada pasien" (Tasbihah & Yunengsih, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan sistem elektronik mampu mempercepat proses pelayanan.

Selain itu, kesiapan fasilitas kesehatan menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi sistem rekam medis elektronik. "Kesiapan fasilitas kesehatan menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi rekam medis elektronik" (Wati et al., 2024). Oleh karena itu, diperlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai.

Sistem rekam medis elektronik juga mempermudah proses pelaporan dan analisis data kesehatan secara lebih akurat (Aulia et al., 2024). Dengan demikian, rekam medis tidak hanya berfungsi sebagai catatan pelayanan, tetapi juga sebagai sumber data untuk pengambilan keputusan.

D. Aspek Hukum Rekam Medis

Rekam medis memiliki aspek hukum yang sangat penting dalam pelayanan kesehatan. Dokumen ini tidak hanya digunakan sebagai catatan medis, tetapi juga sebagai alat bukti hukum dalam berbagai kasus yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan.

"Penerapan regulasi rekam medis berpengaruh terhadap efektivitas pelayanan kesehatan serta perlindungan hukum bagi tenaga medis" (Siregar, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan rekam medis harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dengan adanya regulasi yang jelas, rekam medis dapat memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan serta menjamin hak pasien dalam mendapatkan pelayanan yang berkualitas.

E. Hubungan Manajemen Dokumentasi, Informatika, dan Rekam Medis

Ketiga konsep, yaitu manajemen dokumentasi, informatika kesehatan, dan rekam medis, memiliki hubungan yang sangat erat dalam sistem pelayanan kesehatan. Manajemen dokumentasi berperan dalam mengatur pengelolaan data, informatika kesehatan menyediakan teknologi untuk pengolahan data, sedangkan rekam medis menjadi sumber utama informasi pasien.

Integrasi antara ketiga aspek tersebut mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Pemanfaatan teknologi informasi dalam

pengelolaan rekam medis terbukti meningkatkan efisiensi, akurasi, dan keamanan data (Hansen & Oktamianti, 2024).

Dengan demikian, penerapan manajemen dokumentasi yang baik, didukung oleh sistem informatika yang canggih, serta penggunaan rekam medis yang optimal akan menghasilkan pelayanan kesehatan yang efektif, efisien, dan berkualitas.

Aktivitas 1 — *Knows How*

Mini-case

Rumah Sakit Sejahtera merupakan salah satu rumah sakit umum yang sedang berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai permasalahan dalam pengelolaan rekam medis.

Saat ini, rumah sakit masih menggunakan sistem campuran, yaitu rekam medis manual (berkas kertas) dan sebagian sudah menggunakan sistem elektronik. Kondisi ini menyebabkan beberapa kendala, antara lain:

1. Berkas rekam medis sering sulit ditemukan
2. Terjadi keterlambatan pelayanan karena data pasien tidak tersedia tepat waktu
3. Adanya duplikasi data pasien
4. Petugas mengalami kesulitan dalam pengolahan laporan

Selain itu, sistem informasi yang digunakan belum terintegrasi dengan baik antar bagian (poli, laboratorium, dan farmasi), sehingga data pasien tidak tersinkronisasi secara optimal.

Permasalahan

Berdasarkan kasus di atas, terdapat beberapa permasalahan utama:

1. Sistem manajemen dokumentasi yang belum optimal
2. Kurangnya pemanfaatan informatika kesehatan secara maksimal
3. Pengelolaan rekam medis yang belum terintegrasi
4. Rendahnya efisiensi dan kualitas pelayanan kesehatan

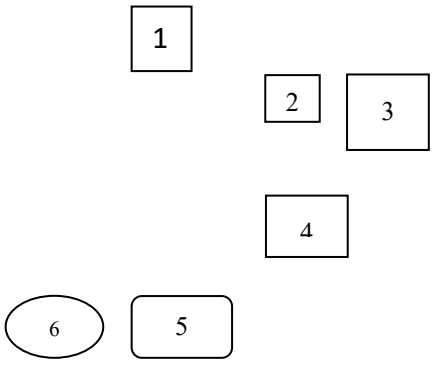
Pertanyaan Diskusi

1. Apa saja masalah utama dalam pengelolaan rekam medis pada kasus tersebut?
2. Bagaimana peran manajemen dokumentasi dalam mengatasi masalah tersebut?
3. Apa dampak dari sistem informatika yang tidak terintegrasi terhadap pelayanan kesehatan?
4. Bagaimana solusi penerapan rekam medis elektronik (RME) pada kasus ini?
5. Apa saja langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit tersebut?

TEMPLATE SOAL OSCE KEPERAWATAN

1.	Nomor station	
2.	Judul station	Pemberian Nutrisi *Pertube* pada bayi di ruang perinatologi
3.	Waktu yang dibutuhkan	15 menit.
4.	Tujuan station	Menilai kemampuan peserta uji dalam melakukan pengkajian kebutuhan nutrisi, menegakan diagnose, melakukan tindakan pemenuhan Nutrisi melalui OGT dengan menunjukan perilaku profesional
5.	Kompetensi	1. Komunikasi, edukasi, dan konseling **2. Pengkajian** **3. Diagnosa dan perencanaan** **4. Implementasi** 5. Evaluasi **6. Perilaku professional**
6.	Kategori	1. Oksigenasi 2. Sirkulasi 3. Cairan dan elektrolit **4. Nutrisi** 5. Aman dan nyaman 6. Psikososial 7. Eliminasi 8. Aktivitas dan istirahat 9. Seksual dan reproduksi
7	Instruksi untuk Peserta Ujian	**SKENARIO KLINIK:** Seorang perempuan, usia 5 hari, datang ke rumah sakit dengan keluhan langit-langit mulut yang terluka. pasien lahir cukup bulan, BBL 2800 gram. Ibu pasien mengatakan pasien tidak bisa menyusui dan sulit menelan. Hasil pemeriksaan pasien tampak rewel, terus menangis, ubun-ubun teraba datar dan lembut, mukosa mulut lembab, perut teraba lembut, bising usus + frekuensi nadi 122x/menit, frekuensi nafas 43x/menit, suhu 37˚C. **TUGAS :** 1. Lakukan pengkajian nutrisi

		2. Sampaikan secara lisan kepada penguji diagnose keperwatan utama pasien tersebut. 3. Lakukan pemberian nutrisi mellaui OGT
8	Instruksi untuk Penguji	**SKENARIO KLINIK:** Seorang bayi laki-laki, usia 5 hari, datang ke rumah sakit dengan keluhan langit-langit mulut yang terluka. pasien lahir cukup bulan, BBL 2800 gram. Ibu pasien mengatakan pasien tidak bisa menyusui dan sulit menelan. Hasil pemeriksaan pasien tampak rewel, terus menangis, BB sekarang 2600gr, bising usus hiperaktif, membran mukosa pucat. **TUGAS :** 1. Lakukan pengkajian nutrisi 2. Sampaikan secara lisan kepada penguji diagnose keperwatan utama pasien tersebut. 3. Lakukan pemberian nutrisi mellaui OGT **INSTRUKSI PENGUJI:** 1. Menilai kemapuan peserta dalam melakuka pemeriksaan status nutrisi. 2. Menilai dignosa keperawatan utama yang disampaikan peserta : defisit nutris b.d ketidakmampuan menelan makanan. 3. Mengamati dan menilai penempilan peserta saat melakukan pemberian nutrisi melalui OGT. 4. Mengobservasi perilaku professional
9	Instruksi untuk klien standar/ manekin	**Pasien 1 : KS** Nama Ibu : Ny. A Rentang usia : 5 hari Jenis kelamin : Perempuan Pekerjaan : ibu rumah tangga Pendidikan terakhir : SMA **Pasien 2 : Manaekin bayi yang sudah terpasang OGT** Nama : by. Aira Rentang usia : 5 hari

		Jenis kelamin **:** perempuan **Riwayat penyakit sekarang** • Keluhan utama : tidak bisa menyusu dan menelan • Sejak kapan :sejak kemarin • Perjalanan penyakit: langit-langit mulut bayi terluka, sehingga bayi tidak bisa menyusu dan menelan sejak hari kedua • Keluhan lain : tidak ada • Kondisi fisik : normal dan tampak rewel **Riwayat penyakit dahulu:** **Riwayat penyakit keluarga:** - **Riwayat kebiasaan sosial:** - **Peran yang harus dilakukan:** - KS memerankan sebagai ibu rumah tangga yang sednag mendampingi anaknya yang dirawat di rumah sakit
10	Setting	Seting ruang rawat  Keterangan : 1. Meja alat 2. Manekin 3. KS 4. Penguji 5. Troley 6. Tempat sampah
11	Peralatan yang dibutuhkan	1 Meja dan kursi penguji 1 buah 2 Troley 1 buah 3 Bed pemeriksaan 1 set 4 Tempat sampah 1 buah 5 Manakin bayi 1 buah 6 Timbangan bayi 1 buah 7 Spuit sesuai dg kebutuhan minum (spuit 10 cc) 1 buah 8 Bengkok 1 buah 9 Handuk kecil 1 buah

		10 Tisu 1 kotak 11 ASI/susu formula didalam botol 1botol Petugas laboran: 1. Menyiapkan alat yang dibutuhkan. 2. Merapikan alat yang sudah digunakan. 3. Membuang sampah.
12	Penulis	Ns. Revi Yulia, M.Kep
13	Referensi	PPNI (2021). Pedoman Standar Operasional Prosedur Keperawatan, Edisi 1. Jakarta: PPNI.

SOP Pemberian Makan Melalui OGT (Oral Gastric Tube)

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
A	**Tahap Pra Interaksi**				
1	Kaji Kebutuhan nutrisi bayi				
2	Siapkan alat dan nutrisi/susu yang di butuhkan				
3	Cuci tangan				
B	**Tahap Orientasi**				
4	Berikan salam				
5	Jelaskan tujuan dan prosedur tindakan				
6	Jaga privasi				
C	**Tahap Kerja**				
7	Cuci tangan				
8	Atur posisi pasien senyaman mungkin				
9	Pasang pengalas				
10	Letakkan bengkok				
11	Periksa sisa makan di lambung dengan menggunakan spuit yang diaspirasikan ke pipa lambung. Jika residu tidak ada atau sedikit, berikan nutrisi melalui OGT.				
12	Buka klem atau penutup OGT				
13	Pasangkan spuit pada pangkal pipa				
14	Masukkan air matang kurang lebih 2 cc				
15	Berikan ASI/susu formula sesuai program, Bila ada obat, masukkan obat kemudian bilas dengan air minum.				
16	Klem pipa penduga				
17	Catat hasil dan respon bayi selama pemberian makan				
D	**Tahap terminasi**				
18	Evaluasi respon klien				
19	Kontrak untuk kegiatan selanjutnya				
20	Bereskan alat				
21	Cuci tangan				
22	Dokumentasikan tindakan dan respon bayi/anak				
E	Tahap Dokumentasi				
23	Mencatat hari, tanggal, jam, hasil pengkajian singkat, kegiatan edukasi dan demonstrasi pemberian oralit, respons ibu dan anak, serta tindak lanjut				
F	Penampilan Profesional				

24	Aman, nyaman, teliti, cermat, tepat, responsif				

Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) pada Asuhan Keperawatan Anak dengan gangguan pemenuhan nutrisi

Komponen	**Deskripsi**	**Contoh pada Kasus Anak dengan Diare**
Metode penilaian	Mini-CEX merupakan penilaian berbasis observasi langsung terhadap performa klinik mahasiswa dalam encounter singkat, terfokus, dan nyata di lahan praktik.	Pembimbing mengamati secara langsung interaksi mahasiswa saat memberikan asuhan awal pada anak yang mengalami gangguan pemenuhan nutrisi di ruang perawatan perinatologi
Tujuan penilaian	Menilai kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan pengkajian, pemeriksaan fisik terfokus, penalaran klinik, komunikasi, edukasi, dan profesionalisme dalam satu pertemuan klinik.	Mahasiswa tidak hanya dinilai dari pengetahuannya tentang gangguan pemenuhan nutrisi, tetapi juga dari kemampuannya melakukan pengkajian, menjelaskan kondisi anak, dan menyampaikan rencana asuhan kepada ibu pasien.
Kasus klinik	Kasus dipilih dari situasi nyata yang sering ditemukan di lahan praktik dan sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah atau tahap profesi.	Seorang bayi perempuan, usia 5 hari, datang ke rumah sakit dengan keluhan langit-langit mulut yang terluka. pasien lahir cukup bulan, BBL 2800 gram. Ibu pasien mengatakan pasien tidak bisa menyusui dan sulit menelan. Hasil pemeriksaan pasien tampak rewel, terus menangis, ubun-ubun teraba datar dan lembut, mukosa mulut lembab, perut teraba lembut, bising usus + frekuensi nadi 122x/menit, frekuensi nafas 43x/menit, suhu 37˚C.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Anak dengan Diare
Aktivitas mahasiswa yang diamati	Mahasiswa melakukan encounter klinik secara utuh sejak awal interaksi sampai penjelasan rencana tindakan.	Mahasiswa memperkenalkan diri, melakukan pengkajian singkat namun terarah, memeriksa tanda malnutrisi, menjelaskan kondisi gangguan pemenuhan nutrisi, lalu menyampaikan rencana pemantauan nutrsi, pemberian makan/ susu melalui OGT, observasi adanya refluks, dan terlepasnya selang OGT
Aspek yang dinilai	Aspek yang dinilai meliputi anamnesis atau pengkajian, pemeriksaan fisik terfokus, penalaran klinik, komunikasi terapeutik, edukasi keluarga, profesionalisme, dan organisasi tindakan.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menggali informasi tentang h gangguan pemenuhan nutrisi , cara mengkaji kepatenan selang OGT, menjaga komunikasi yang baik dengan ibu pasien.
Fokus observasi pembimbing	Pembimbing menilai kualitas performa klinik mahasiswa secara langsung menggunakan format Mini-CEX yang terstruktur.	Pembimbing memperhatikan apakah mahasiswa mampu menghubungkan data klinik dengan masalah prioritas, misalnya defisit nutrisi.
Umpan balik	Umpan balik diberikan segera setelah observasi, bersifat singkat, spesifik, dan berorientasi pada perbaikan performa.	Pembimbing dapat menyampaikan bahwa mahasiswa sudah baik dalam komunikasi dan identifikasi tanda dehidrasi, tetapi masih perlu memperdalam pengkajian nutrisi
Keputusan penilaian	Hasil Mini-CEX digunakan untuk menentukan tingkat performa mahasiswa dalam praktik klinik.	Mahasiswa dinyatakan kompeten apabila mampu melakukan encounter klinik secara runtut, aman, komunikatif, dan tepat. Mahasiswa dinyatakan perlu supervisi apabila masih membutuhkan arahan pada beberapa bagian. Mahasiswa dinyatakan remedial apabila

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Anak dengan Diare
		performanya belum memenuhi standar minimal.
Makna dalam OBE	Mini-CEX memberikan bukti autentik bahwa mahasiswa mampu menunjukkan capaian pembelajaran pada level does.	Pada kasus anak dengan gangguan nutrisi , mahasiswa dinilai bukan hanya memahami teori, tetapi mampu menerapkan asuhan keperawatan secara langsung, aman, tepat, dan profesional di lahan praktik.

Tabel 5. 1 Portofolio pada Asuhan Keperawatan Anak dengan gangguan pemenuhan nutrisi

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Anak dengan Diare
Hakikat portofolio	Portofolio merupakan kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan dan pencapaian kompetensi mahasiswa secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam OBE, portofolio digunakan untuk menilai performa nyata mahasiswa dari waktu ke waktu, bukan hanya dari satu kali ujian.	Pada asuhan keperawatan anak dengan gangguan pemenuhan nutrisi , portofolio memuat bukti bahwa mahasiswa mampu melakukan pengkajian, menetapkan masalah keperawatan, memberikan edukasi, menjaga keselamatan pasien, serta memperbaiki performa berdasarkan umpan balik.
Tujuan portofolio	Portofolio bertujuan mendokumentasikan proses belajar, capaian kompetensi, refleksi diri, dan tindak lanjut perbaikan mahasiswa selama praktik.	Mahasiswa tidak hanya menunjukkan bahwa ia pernah merawat anak dengan gangguan pemenuhan nutrisi, tetapi juga menunjukkan bagaimana kemampuannya berkembang setelah mendapat masukan dari dosen atau CI.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Anak dengan Diare
OSCE dan DOPS	OSCE dan DOPS dapat menjadi bagian penting dalam portofolio karena memberikan bukti keterampilan terstruktur di laboratorium dan bukti performa nyata di lahan praktik.	OSCE dapat memuat hasil ujian keterampilan pemberian makan melalui OGT sedangkan DOPS memuat hasil observasi langsung saat mahasiswa melakukan asuhan pada anak dengan gangguan pemenuhan nutrisi di ruang rawat anak.
Catatan kasus singkat	Catatan kasus singkat berisi ringkasan kasus pasien yang pernah ditangani mahasiswa, data penting, masalah keperawatan, intervensi utama, dan hasil yang dicapai.	Mahasiswa menuliskan ringkasan kasus Seorang bayi perempuan, usia 5 hari, datang ke rumah sakit dengan keluhan langit-langit mulut yang terluka. pasien lahir cukup bulan, BBL 2800 gram. Ibu pasien mengatakan pasien tidak bisa menyusui dan sulit menelan. Hasil pemeriksaan pasien tampak rewel, terus menangis, ubun-ubun teraba datar dan lembut, mukosa mulut lembab, perut teraba lembut, bising usus + frekuensi nadi 122x/menit, frekuensi nafas 43x/menit, suhu 37˚C diagnosis keperawatan prioritas, intervensi pemenuhan nutrisi, dan evaluasi respons anak.
Refleksi patient safety	Refleksi patient safety menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi kesalahan, dan menyusun langkah pencegahan dalam asuhan keperawatan.	Mahasiswa merefleksikan pentingnya memantau tanda gangguan nutrisi, mencatat jumlah asi yang masuk,berat badab setelah lahir dan sekarang memastikan selng OGT terpasang dengan baik dan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Anak dengan Diare
		mengenali tanda bahaya yang membutuhkan pelaporan segera.
Feedback CI/dosen	Umpan balik dari Clinical Instructor (CI) atau dosen menjadi bukti pembinaan yang menunjukkan area kekuatan dan area yang masih perlu ditingkatkan.	CI menuliskan bahwa mahasiswa sudah baik dalam komunikasi dengan ibu anak tetapi masih perlu meningkatkan ketelitian dalam pengkajian berat badan bayi, kepatenan slang OGT, adanya refluks.
Karakteristik penilaian	Portofolio bukan penilaian sekali selesai, tetapi kumpulan bukti yang dibangun secara berulang dan berkesinambungan. Penekanan utamanya adalah konsistensi performa mahasiswa.	Mahasiswa dinilai bukan hanya dari satu kasus gangguan nutrisi, tetapi dari beberapa pengalaman belajar yang menunjukkan bahwa ia konsisten mampu melakukan asuhan keperawatan anak secara aman, tepat, dan profesional.
Bukti konsistensi kompetensi	Portofolio memperlihatkan apakah mahasiswa mampu mempertahankan mutu performa pada berbagai kesempatan praktik dan pada waktu yang berbeda.	Dari hasil OSCE, DOPS, catatan kasus, refleksi, dan umpan balik, terlihat bahwa mahasiswa secara konsisten mampu melakukan pengkajian nutrisi, dan komunikasi terapeutik dengan keluarga anak.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, portofolio memberikan bukti autentik bahwa capaian pembelajaran tidak hanya dimiliki secara teoritis, tetapi benar-benar tampak dalam performa yang berulang, berkembang, dan terdokumentasi.	Pada asuhan keperawatan anak dengan gangguan pemenuhan nutrisi, portofolio menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya paham konsep nutrisi, tetapi juga konsisten mampu menerapkannya dalam praktik klinik nyata.

Tabel 5. 2 Case Report pada Asuhan Keperawatan Anak dengan Diare

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Anak dengan Diare
Hakikat case report	Case report merupakan laporan singkat dan sistematis tentang satu kasus pasien yang ditangani mahasiswa selama praktik klinik. Dalam OBE, case report berfungsi sebagai bukti kemampuan mahasiswa dalam memahami, menganalisis, dan mendokumentasikan kasus secara ilmiah dan klinis.	Seorang bayi perempuan, usia 5 hari, datang ke rumah sakit dengan keluhan langit-langit mulut yang terluka. pasien lahir cukup bulan, BBL 2800 gram. Ibu pasien mengatakan pasien tidak bisa menyusui dan sulit menelan. Hasil pemeriksaan pasien tampak rewel, terus menangis, ubun-ubun teraba datar dan lembut, mukosa mulut lembab, perut teraba lembut, bising usus + frekuensi nadi 122x/menit, frekuensi nafas 43x/menit, suhu 37˚C
Tujuan	Case report bertujuan menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan data pengkajian, masalah keperawatan, rencana tindakan, implementasi, dan evaluasi hasil asuhan.	Mahasiswa tidak hanya menuliskan data pasien, tetapi juga menjelaskan masalah prioritas, tindakan yang diberikan, dan perkembangan kondisi anak setelah intervensi.
Isi laporan	Isi case report biasanya mencakup identitas singkat pasien, keluhan utama, data subjektif dan objektif, analisis masalah, diagnosis keperawatan, intervensi, implementasi, evaluasi, dan pembelajaran dari kasus.	Pada kasus gangguan pemenuhan nutrisi, mahasiswa menuliskan berat badan bayi baru lahir, berat badan sekarang, ubun – ubun teraba datar, bising usus dan frekuensi nadi 122x/menit, frekuensi nafas 43x/menit, suhu 37˚C
Fokus penilaian	Penilaian difokuskan pada ketepatan pengkajian, relevansi analisis masalah, logika penalaran klinik, ketepatan intervensi, dan	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menghubungkan data gangguan pemenuhan nutrisi dengan masalah utama, memilih intervensi

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Anak dengan Diare
	kemampuan mengevaluasi hasil asuhan.	yang tepat, dan menilai respons anak setelah pemberian minum melalui slang OGT.
Nilai edukatif	Case report membantu mahasiswa mengembangkan clinical reasoning, keterampilan dokumentasi, dan kebiasaan merefleksikan praktik klinik secara ilmiah.	Dari kasus gangguan pemenuhan nutrisi, mahasiswa belajar bahwa pengkajian nutrisi, tanda-tanda malnutrisi, merupakan bagian yang sangat penting dalam asuhan keperawatan anak.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, case report menjadi bukti bahwa mahasiswa mampu menerapkan teori ke dalam analisis kasus nyata secara sistematis dan bertanggung jawab.	Mahasiswa menunjukkan bahwa ia tidak hanya memahami konsep nutrisi pada anak, tetapi juga mampu menyusun laporan kasus yang menggambarkan asuhan keperawatan secara utuh.

Tabel 5. 3 Refleksi Patient Safety pada Asuhan Keperawatan Anak dengan Diare

Komponen	**Deskripsi**	**Contoh pada Kasus Anak dengan Diare**
Hakikat refleksi patient safety	Refleksi patient safety merupakan tulisan singkat yang menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi masalah, dan merencanakan tindakan pencegahan.	Pada kasus anak dengan gangguan pemenuhan nutrisi, mahasiswa merefleksikan bahwa kekurangan nutrisi yang cepat dapat menyebabkan perburukan kondisi bila tidak dikenali dan ditangani dengan tepat.
Tujuan	Refleksi ini bertujuan menumbuhkan kesadaran mahasiswa bahwa keselamatan pasien merupakan bagian penting dari setiap tindakan keperawatan.	Mahasiswa memahami bahwa kesalahan kecil, seperti kurang teliti memamntau berat badan atau terlambat mengenali tanda gangguan pemenuhan nutrisi, dapat

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Anak dengan Diare
		berdampak besar pada keselamatan anak.
Fokus refleksi	Fokus refleksi meliputi identifikasi risiko, analisis penyebab, tindakan pencegahan, dan pembelajaran yang diperoleh mahasiswa dari pengalaman klinik.	Mahasiswa menuliskan bahwa risiko utama pada pasien ini adalah gangguan nutrisi, ketidakmampuan menelan
Risiko yang diidentifikasi	Mahasiswa perlu menunjukkan kemampuan mengenali situasi yang berpotensi membahayakan pasien.	Risiko yang dapat diidentifikasi antara lain penurunan status nutrisi, menurunnya berat badan kepatenan selang OGT, adanya refluks. dan keterlambatan pelaporan tanda bahaya.
Tindakan pencegahan	Mahasiswa menjelaskan langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko keselamatan pasien.	Mahasiswa menuliskan pentingnya memantau tanda gangguan nutrisi secara berkala, mencatat intake yang tidak adekuat dengan teliti, menjelaskan cara pemberian pemberian makan melalui selang OGT yang benar, serta mengedukasi ibu tentang tanda bahaya.
Pembelajaran mahasiswa	Refleksi harus menunjukkan apa yang dipelajari mahasiswa dan bagaimana hal itu akan memengaruhi praktik berikutnya.	Mahasiswa menyadari bahwa pada anak dengan gangguan pemenuhan nutrisi, pengkajian yang teliti, komunikasi yang jelas kepada keluarga, dan pemantauan berulang merupakan bagian penting untuk menjaga keselamatan pasien.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, refleksi patient safety menunjukkan perkembangan sikap profesional, tanggung jawab	Mahasiswa membuktikan bahwa ia tidak hanya melakukan tindakan, tetapi juga mampu mengevaluasi risiko dan meningkatkan kualitas

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Anak dengan Diare
	klinik, dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa terhadap keselamatan pasien.	praktik keperawatan anak secara berkelanjutan.

F. RINGKASAN

Manajemen dokumentasi berperan dalam pengelolaan arsip secara sistematis, nformatika kesehatan membantu pengolahan data secara digital. Rekam medis menjadi sumber utama informasi pasien. Ketiga aspek tersebut saling terintegrasi dalam meningkatkan mutu pelayanan Kesehatan

informatika kesehatan merupakan integrasi antara ilmu komputer dan pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Manajemen dokumentasi berperan dalam pengelolaan arsip secara sistematis, Informatika kesehatan membantu pengolahan data secara digital. Rekam medis menjadi sumber utama informasi pasien. Ketiga aspek tersebut saling terintegrasi dalam meningkatkan mutu pelayanan Kesehatan

Manajemen dokumentasi dalam pelayanan kesehatan berperan penting dalam menjaga kualitas informasi pasien. Pengelolaan dokumen yang baik akan meningkatkan efisiensi kerja serta meminimalisir kesalahan administrasi. Rekam medis merupakan sumber utama informasi pasien yang digunakan dalam proses pelayanan kesehatan. Penerapan regulasi terkait rekam medis sangat berpengaruh terhadap efektivitas pelayanan kesehatan serta perlindungan hukum bagi tenaga medis dan pasien. Penggabungan sistem informasi dengan rekam medis elektronik mampu meningkatkan kualitas pelayanan serta efisiensi operasional di fasilitas Kesehatan.

Kasus Rumah Sakit Sejahtera menunjukkan bahwa pengelolaan rekam medis yang tidak optimal dapat berdampak pada kualitas pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan integrasi antara manajemen dokumentasi, informatika kesehatan, dan rekam medis untuk menciptakan sistem pelayanan yang efektif, efisien, dan aman.

Kasus ini menunjukkan bahwa dokumentasi rekam medis yang tidak lengkap dapat berdampak langsung pada kualitas pelayanan pasien. Tidak tercatatnya data berat badan dan asupan nutrisi menyebabkan tenaga kesehatan kesulitan dalam memantau perkembangan kondisi pasien.

Dari aspek informatika, sistem yang tidak terintegrasi antara dokter, perawat, dan ahli gizi menghambat aliran informasi. Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam intervensi nutrisi yang seharusnya segera diberikan.

Selain itu, manajemen dokumentasi yang kurang baik mengakibatkan informasi penting tidak terdokumentasi secara sistematis dan lengkap.

Tabel 5. 4 Red Flags & Eskalasi

Red flags	Makna klinis	Tindakan eskalasi
Berat badan tidak naik / turun	Asupan kalori tidak cukup atau ada gangguan penyerapan	Segera laporkan ke perawat penanggung jawab/preseptor/dokter, lakukan pemantauan ketat, siapkan penanganan lanjutan
Bayi lemas, kurang aktif	Kekurangan energi (kalori) → tubuh masuk fase hemat energi	Eskalasi segera, jangan menunda observasi lanjutan
Tidak mau minum atau tidak mampu minum	Risiko tinggi kekurangan nutrisi semakin berat	Segera laporkan dan evaluasi kebutuhan nutrisi lanjutan
Menolak menyusu / makan	Gangguan refleks hisap-telan	Laporkan segera, pantau status nutrisi, siapkan evaluasi terapi lebih lanjut
Kulit pucat / kuning berlebihan	hiperbilirubinemia (gangguan hati atau pemecahan sel darah)	Laporkan, cek kadar bilirubin
Menangis lemah / tidak kuat	Energi sangat rendah Bisa menunjukkan kondisi serius seperti Malnutrisi berat	Segera eskalasi untuk evaluasi medis lebih lanjut

Form Checklist

Nama Mahasiswa : _____

NIM : _____

Tanggal : _____

Tempat Praktik / Skill Lab : _____

Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	Saya sudah bisa menjelaskan pengertian gangguan nutrisi pada anak secara sederhana	☐	☐	_____
2	Saya sudah bisa melakukan pengkajian fokus pada anak dengan gangguan pemenuhan nutrisi	☐	☐	_____
3	Saya sudah bisa mengkaji frekuensi nadi, pernafasan dan suhu bayi	☐	☐	_____
4	Saya sudah bisa mengkaji adanya tanda – tanda gannguan pemenuhan nutrisi	☐	☐	_____
5	Saya sudah bisa mengenali tanda hiperbilirubin pada bayi	☐	☐	_____
6	Saya sudah bisa mengidentifikasi masalah keperawatan prioritas pada anak dengan gangguan pemenuhan nutrisi	☐	☐	_____
7	Saya sudah bisa menyusun rencana asuhan keperawatan dasar pada anak dengan gangguan pemenuhan nutrisi	☐	☐	_____
8	Saya sudah bisa memantau status nutrisi pada anak	☐	☐	_____
11	Saya sudah bisa menjelaskan tanda bahaya pada anak dengan gangguan pemenuhan nutrisi	☐	☐	_____
12	Saya sudah bisa menentukan kapan harus melakukan eskalasi atau melapor	☐	☐	_____
13	Saya sudah bisa berkomunikasi terapeutik dengan anak dan keluarga	☐	☐	_____
14	Saya sudah bisa melakukan dokumentasi singkat asuhan keperawatan anak dengan diare	☐	☐	_____
15	Saya sudah bisa menunjukkan sikap profesional, aman, teliti, dan responsif saat merawat anak dengan diare	☐	☐	_____

Refleksi singkat mahasiswa:

Referensi

Asia, P. F., Happy, P. D., Laela, I., & Muniroh. (2024). Transformasi pelayanan rekam medis dan dampaknya terhadap kinerja petugas di rumah sakit Pelabuhan Jakarta. *Infokes: Jurnal Ilmiah Rekam Medis dan Informatika Kesehatan, 14*(1), 58–64. https://doi.org/10.47701/infokes.v14i1.3541

Ariyanto, A., & Andriyanto, A. (2024). Implementasi rekam medis elektronik di institusi pelayanan kesehatan di Indonesia. *Jurnal Insan Cendekia, 11*(1). https://doi.org/10.35874/jic.v11i1.1332

Tasbihah, F., & Yunengsih, Y. (2024). Penerapan rekam medis elektronik dalam menunjang efektivitas kerja perekam medis di rumah sakit. *Jurnal Indonesia: Manajemen Informatika dan Komunikasi, 5*(3). https://doi.org/10.35870/jimik.v5i3.946

Hermawan, P. P., Abdussalaam, F., & Sari, I. (2024). Perancangan sistem informasi pengolahan data rekam medis elektronik guna menunjang pelaporan rawat jalan. *Jurnal Indonesia: Manajemen Informatika dan Komunikasi, 5*(3).

Wati, R., Igiany, P. D., & Pertiwi, J. (2024). Analisis kesiapan implementasi rekam medis elektronik di Puskesmas Baki. *PREPOTIF: Jurnal Kesehatan Masyarakat, 8*(1), 663–670. https://doi.org/10.31004/prepotif.v8i1.26515

Suryanto, H., & Subekti, H. (2024). Penerapan teknologi informasi dalam penyelenggaraan rekam medis di RSUD Ngudi Waluyo Wlingi Blitar. *Jurnal Repositor, 2*(7). https://doi.org/10.22219/repositor.v2i7.30755

Aulia, L., Sufyana, C. M., & Sari, I. (2024). Perancangan sistem informasi rekam medis elektronik dalam pelaporan 10 besar penyakit rawat inap. *Decode: Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi, 4*(2), 533–546. https://doi.org/10.51454/decode.v4i2.589

Hansen, L., & Oktamianti, P. (2024). Implementation of electronic medical records and its implications for the effectiveness of health services in Indonesia: Narrative review. *Jurnal Health Sains, 6*(9). https://doi.org/10.46799/jhs.v6i9.2704

Siregar, R. A. (2023). Penerapan peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang rekam medis terhadap efektivitas pelayanan kesehatan. *Jurnal Ilmiah Hukum Kesehatan, 5*(2). https://doi.org/10.46924/jihk.v5i2.182

BAB 6

AKREDITASI FASILITAS KESEHATAN DAN STANDAR KEPERAWATAN

A. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menguasai konsep dasar manajemen keperawatan, peran perawat manajer, serta etika–legal dalam pengelolaan pelayanan.	CPMK-1; CPMK-2
CPL-2	Mampu menganalisis organisasi pelayanan keperawatan dan sistem layanan kesehatan untuk mendukung tata kelola dan kesinambungan layanan.	CPMK-2; CPMK-7
CPL-3	Mampu menerapkan kepemimpinan keperawatan, komunikasi efektif, kolaborasi, dan manajemen konflik serta perubahan dalam tim.	CPMK-3; CPMK-5
CPL-4	Mampu merencanakan dan mengelola SDM keperawatan (kebutuhan, penjadwalan, delegasi, supervisi) secara adil, aman, dan efisien.	CPMK-4; CPMK-5
CPL-5	Mampu menerapkan manajemen mutu, keselamatan pasien, manajemen risiko, PPI, dan K3 sebagai budaya kerja untuk peningkatan layanan.	CPMK-6; CPMK-7
CPL-6	Mampu memanfaatkan dokumentasi, informatika, standar–akreditasi, serta data kinerja untuk evaluasi, pelaporan, dan perbaikan mutu berkelanjutan.	CPMK-7; CPMK-2; CPMK-6

B. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menjelaskan konsep dasar manajemen keperawatan, fungsi manajemen, peran perawat manajer, serta etika–legal dalam pelayanan.
CPMK-2	Menganalisis organisasi pelayanan keperawatan dan sistem layanan kesehatan (tata kelola, standar, kebijakan) untuk mendukung pengambilan keputusan manajerial.
CPMK-3	Menerapkan kepemimpinan keperawatan, manajemen perubahan, komunikasi efektif, kolaborasi, dan manajemen konflik dalam pengelolaan tim.
CPMK-4	Merencanakan kebutuhan dan penjadwalan SDM keperawatan berdasarkan beban kerja, kompetensi, dan prinsip keadilan–keselamatan.
CPMK-5	Mengelola manajemen asuhan keperawatan melalui delegasi, supervisi, koordinasi, serta pemanfaatan sumber daya/logistik secara efisien.
CPMK-6	Menerapkan manajemen mutu, keselamatan pasien, manajemen risiko klinis, PPI, dan K3 dalam peningkatan kinerja pelayanan keperawatan.

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-7	Menggunakan dokumentasi, informatika, audit data, dan pelaporan untuk evaluasi kinerja serta menyusun proyek mini peningkatan mutu berbasis data.

H. Pemetaan

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 6. Akreditasi Fasilitas Kesehatan dan Standar Keperawatan	6.1 Mengidentifikasi elemen standar keperawatan yang relevan untuk kesiapan akreditasi.	6.2 Menyusun rencana pemenuhan standar berbasis gap analysis dan prioritas perbaikan.	CPMK-2	CPMK-6; CPMK-7

I. Asesmen (berbasis CPMK)

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-2	Tugas analisis organisasi & standar (paper ringkas)	Ketepatan pemetaan struktur/alur layanan dan ketepatan identifikasi gap terhadap standar (skor rubrik).	15	Dokumen analisis; matriks gap
CPMK-6	Simulasi fasilitasi/kemitraan (role play)	Kualitas fasilitasi partisipasi + kejelasan rencana kolaborasi/advokasi (skor rubrik).	15	Lembar penilaian; rencana kemitraan
CPMK-7	Proyek mini peningkatan mutu + portofolio laporan	Kelengkapan laporan berbasis data (baseline–target–hasil) dan kualitas rekomendasi perbaikan terukur.	15	Laporan proyek; portofolio data; refleksi

Rubrik CPMK-1

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
1.1 Ketepatan konsep fungsi manajemen (% benar)	<60% benar; miskonsepsi dominan	60–74% benar; miskonsepsi masih ada	75–89% benar; kesalahan minor	≥90% benar; konsisten
1.2 Ketepatan penerapan peran–akuntabilitas pada skenario	Keliru/tidak relevan	Relevan sebagian; alasan lemah	Tepat; alasan logis	Tepat; alasan kuat dan komprehensif

Rubrik CPMK-2

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
2.1 Ketepatan pemetaan struktur & alur layanan	Tidak akurat; komponen inti hilang	Cukup akurat; masih ada kekeliruan bermakna	Akurat; kekeliruan minor	Sangat akurat; komprehensif dan jelas
2.2 Ketepatan gap analysis & prioritas perbaikan	Gap tidak sesuai standar; prioritas acak	Gap sebagian tepat; prioritas kurang konsisten	Gap tepat; prioritas jelas	Gap sangat tepat; prioritas sangat logis & berbasis risiko

Rubrik CPMK-3

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
3.1 Kinerja kepemimpinan & manajemen perubahan (checklist)	≤60% perilaku tercapai; tidak terarah	61–75% tercapai; arah sebagian jelas	76–90% tercapai; terarah & konsisten	>90% tercapai; adaptif, memotivasi, terstruktur
3.2 Komunikasi efektif & resolusi konflik (checklist)	Konflik tidak tertangani; komunikasi tidak jelas	Ada upaya; solusi belum disepakati	Solusi disepakati; komunikasi runtut	Solusi kuat; komunikasi sangat efektif & menjaga hubungan kerja

Rubrik CPMK-4

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
4.1 Akurasi perhitungan kebutuhan tenaga	Banyak kesalahan; asumsi tidak jelas	Cukup tepat; masih ada kesalahan bermakna	Tepat; kesalahan minor	Sangat tepat; asumsi jelas & dapat dipertanggungjawabkan
4.2 Kualitas jadwal dinas (cakupan, aturan, pemerataan)	Cakupan tidak aman; melanggar aturan	Cakupan cukup; pemerataan kurang	Cakupan aman; aturan dipatuhi; cukup adil	Cakupan sangat aman; patuh aturan; sangat adil & minim risiko kelelahan

Rubrik CPMK-5

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
5.1 Ketepatan keputusan delegasi & rencana supervisi	Delegasi tidak sesuai kompetensi/risiko	Delegasi cukup sesuai; supervisi kurang spesifik	Delegasi sesuai; supervisi jelas	Delegasi sangat tepat; supervisi terukur & antisipatif risiko
5.2 Ketepatan rencana pengendalian logistik	Tidak berbasis kebutuhan; rawan kekosongan	Berbasis kebutuhan sebagian; kontrol kurang	Berbasis data; kontrol memadai	Berbasis data komprehensif; kontrol sangat efektif (minim stockout/overstock)

Rubrik CPMK-6

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
6.1 Ketepatan indikator & analisis temuan audit	Indikator tidak tepat; analisis tidak sesuai	Indikator cukup; analisis terbatas	Indikator tepat; analisis jelas	Indikator sangat tepat; analisis kritis berbasis data/tren
6.2 Kelayakan rencana mitigasi risiko/PPI/K3 (terukur)	Rencana umum; tidak terukur	Ada rencana; indikator belum jelas	Rencana spesifik; indikator terukur	Rencana sangat spesifik, terukur, realistis; prioritas berbasis risiko

Rubrik CPMK-7

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
7.1 Kelengkapan laporan berbasis data (baseline–target–hasil)	Data tidak lengkap; tidak dapat dievaluasi	Data cukup; hubungan baseline–hasil kurang jelas	Data lengkap; evaluasi jelas	Data sangat lengkap; evaluasi kuat dan transparan
7.2 Kualitas proyek mini peningkatan mutu (rencana–uji–evaluasi)	Tidak sistematis; tanpa evaluasi hasil	Sistematis sebagian; evaluasi terbatas	Sistematis; evaluasi hasil memadai	Sangat sistematis; evaluasi kuat; rekomendasi implementatif & berkelanjutan

A. Pendahuluan

Pelayanan kesehatan yang berkualitas merupakan tuntutan utama dalam sistem pelayanan kesehatan modern. Salah satu mekanisme untuk menjamin mutu pelayanan tersebut adalah melalui proses akreditasi fasilitas kesehatan. Akreditasi merupakan proses penilaian eksternal yang sistematis terhadap institusi pelayanan

kesehatan berdasarkan standar yang telah ditetapkan untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan aman, bermutu, dan berorientasi pada keselamatan pasien (World Health Organization, 2022).

Dalam praktik keperawatan, akreditasi memiliki peran penting karena perawat merupakan tenaga kesehatan yang paling lama berinteraksi dengan pasien selama proses pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, standar keperawatan harus selaras dengan standar akreditasi guna memastikan pelayanan keperawatan yang profesional, efektif, dan berpusat pada pasien (Huber, 2021).

Di Indonesia, akreditasi fasilitas kesehatan dilakukan oleh lembaga yang ditunjuk pemerintah seperti Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) untuk rumah sakit dan lembaga akreditasi lainnya untuk fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Proses akreditasi tidak hanya menilai struktur organisasi dan sarana prasarana, tetapi juga proses pelayanan, kompetensi tenaga kesehatan, serta luaran pelayanan kesehatan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022).

Bab ini membahas konsep akreditasi fasilitas kesehatan, tujuan dan manfaat akreditasi, standar akreditasi rumah sakit, serta implementasi standar keperawatan dalam mendukung mutu pelayanan kesehatan.

B. Konsep Akreditasi Fasilitas Kesehatan

Akreditasi fasilitas kesehatan adalah proses penilaian yang dilakukan secara independen oleh lembaga akreditasi terhadap fasilitas pelayanan kesehatan untuk menilai kesesuaian pelayanan dengan standar yang telah ditetapkan (Shaw et al., 2019).

Akreditasi bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan melalui penerapan standar yang berfokus pada keselamatan pasien, efektivitas pelayanan, serta peningkatan kinerja tenaga kesehatan.

Menurut Greenfield dan Braithwaite (2018), akreditasi merupakan salah satu strategi manajemen mutu yang paling efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit karena melibatkan proses evaluasi berkelanjutan, perbaikan sistem, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Dalam konteks manajemen keperawatan, akreditasi menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa pelayanan keperawatan dilaksanakan sesuai standar profesi, standar operasional prosedur, serta prinsip keselamatan pasien.

C. Tujuan Akreditasi Fasilitas Kesehatan

Akreditasi fasilitas kesehatan memiliki beberapa tujuan utama, antara lain:

1. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan Akreditasi mendorong fasilitas kesehatan untuk menerapkan standar pelayanan yang berkualitas dan berorientasi pada keselamatan pasien.
2. Menjamin keselamatan pasien (keselamatan pasien) Salah satu fokus utama akreditasi adalah penerapan standar keselamatan pasien dalam setiap proses pelayanan kesehatan.
3. Meningkatkan kinerja tenaga kesehatan Akreditasi mendorong tenaga kesehatan, termasuk perawat, untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan.
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat Fasilitas kesehatan yang telah terakreditasi cenderung lebih dipercaya oleh masyarakat karena dianggap memiliki standar pelayanan yang baik.
5. Mendorong perbaikan berkelanjutan (continuous quality improvement) Akreditasi bukan sekadar penilaian sesaat, tetapi merupakan proses yang mendorong perbaikan mutu pelayanan secara terus-menerus (Kemenkes RI, 2022).

D. Prinsip Dasar Akreditasi Pelayanan Kesehatan

Beberapa prinsip dasar dalam akreditasi fasilitas kesehatan meliputi:

1. Berorientasi pada keselamatan pasien : Seluruh proses pelayanan kesehatan harus mengutamakan keselamatan pasien melalui penerapan standar keselamatan pasien.
2. Berbasis standar mutu pelayanan : Akreditasi menggunakan standar pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan secara nasional maupun internasional.
3. Penilaian secara objektif dan independen : Proses penilaian dilakukan oleh surveyor yang independen dan memiliki kompetensi di bidangnya.
4. Berkelanjutan : Akreditasi bukan hanya kegiatan evaluasi sesaat, tetapi merupakan proses peningkatan mutu yang berkelanjutan (Shaw et al., 2019).

E. Standar Akreditasi Rumah Sakit

Standar akreditasi rumah sakit di Indonesia mengacu pada standar yang ditetapkan oleh KARS dan diselaraskan dengan standar internasional seperti Joint Commission International (JCI).

Beberapa kelompok standar akreditasi rumah sakit antara lain:

1. Sasaran keselamatan pasien (SKP)

2. Pelayanan berfokus pada pasien
3. Manajemen rumah sakit
4. Manajemen fasilitas dan keselamatan
5. Peningkatan mutu dan keselamatan pasien
6. Manajemen sumber daya manusia
7. Manajemen informasi
8. Pendidikan pasien dan keluarga

Standar tersebut dirancang untuk memastikan bahwa seluruh aspek pelayanan kesehatan berjalan secara efektif, aman, dan berkualitas (KARS, 2022).

F. Standar Keperawatan dalam Pelayanan Kesehatan

Standar keperawatan merupakan pedoman praktik profesional yang digunakan oleh perawat dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Standar ini mencakup standar praktik, standar kompetensi, serta standar etika profesi (American Nurses Association, 2021).

Secara umum, standar praktik keperawatan meliputi:

1. Pengkajian (assessment): Perawat mengumpulkan data kesehatan pasien secara sistematis.
2. Diagnosis keperawatan : Perawat menganalisis data untuk mengidentifikasi masalah kesehatan pasien.
3. Perencanaan (planning) : Perawat menyusun rencana asuhan keperawatan berdasarkan kebutuhan pasien.
4. Implementasi: Perawat melaksanakan intervensi keperawatan sesuai rencana yang telah disusun.
5. Evaluasi : Perawat menilai efektivitas intervensi yang telah dilakukan.

   Standar ini menjadi dasar bagi perawat dalam memberikan asuhan keperawatan yang aman, efektif, dan profesional.

G. Peran Perawat dalam Mendukung Akreditasi

Perawat memiliki peran strategis dalam keberhasilan akreditasi fasilitas kesehatan. Beberapa peran perawat antara lain:

1. Penerapan standar asuhan keperawatan

   Perawat harus memastikan bahwa seluruh proses asuhan keperawatan dilaksanakan sesuai standar profesi dan standar operasional prosedur.
2. Dokumentasi keperawatan

   Dokumentasi yang lengkap dan akurat menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian akreditasi.

3. Implementasi keselamatan pasien
   Perawat berperan dalam penerapan program keselamatan pasien seperti identifikasi pasien, komunikasi efektif, dan pencegahan infeksi.
4. Peningkatan mutu pelayanan
   Perawat turut terlibat dalam kegiatan audit keperawatan, evaluasi mutu pelayanan, dan program peningkatan kualitas pelayanan kesehatan (Huber, 2021).

H. Tantangan Implementasi Standar Keperawatan dalam Akreditasi

Beberapa tantangan yang sering dihadapi dalam implementasi standar keperawatan antara lain:

1. Keterbatasan sumber daya manusia
2. Beban kerja perawat yang tinggi
3. Kurangnya pemahaman tentang standar akreditasi
4. Dokumentasi keperawatan yang belum optimal

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan dukungan manajemen rumah sakit melalui pelatihan, supervisi, serta sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan.

Kasus

Sebuah rumah sakit sedang mempersiapkan proses akreditasi nasional. Tim surveyor menemukan bahwa dokumentasi asuhan keperawatan belum lengkap dan beberapa standar keselamatan pasien belum diterapkan secara konsisten.

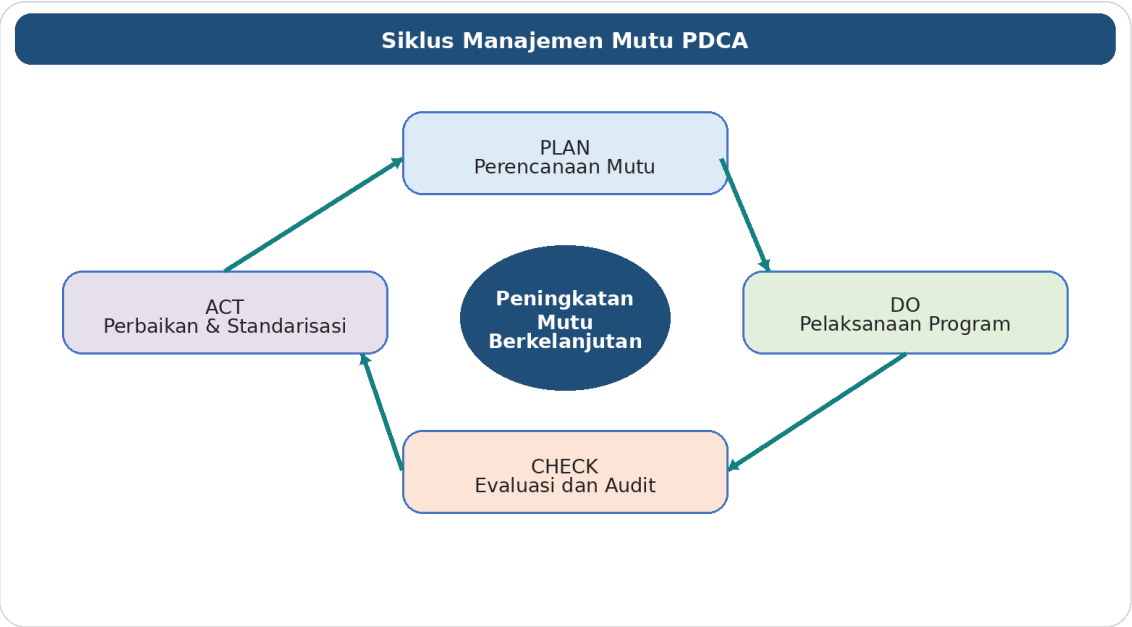
Pertanyaan Diskusi

1. Apa saja masalah manajemen keperawatan yang terjadi pada kasus tersebut?
2. Bagaimana peran kepala ruang dalam meningkatkan kesiapan akreditasi?
3. Strategi apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan perawat terhadap standar dokumentasi?

Tabel 6. 1 Keterkaitan Standar Akreditasi dengan Praktik Keperawatan

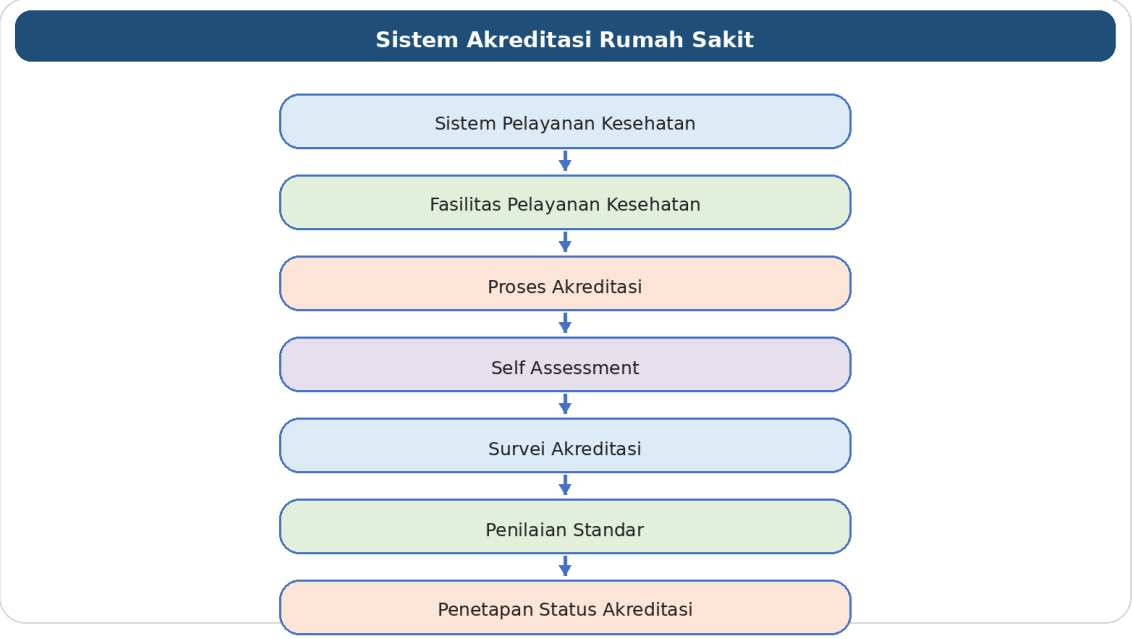
No	Standar Akreditasi	Implementasi dalam Praktik Keperawatan
1	Sasaran Keselamatan Pasien	Perawat melakukan identifikasi pasien menggunakan dua identitas sebelum tindakan
2	Komunikasi Efektif	Perawat menggunakan metode komunikasi SBAR dalam serah terima pasien
3	Pencegahan Infeksi	Perawat menerapkan prosedur cuci tangan dan penggunaan APD

No	Standar Akreditasi	Implementasi dalam Praktik Keperawatan
4	Penggunaan Obat yang Aman	Perawat melakukan prinsip 6 benar dalam pemberian obat
5	Pendidikan Pasien	Perawat memberikan edukasi kesehatan kepada pasien dan keluarga
6	Dokumentasi Pelayanan	Perawat mencatat seluruh tindakan keperawatan secara lengkap
7	Manajemen Risiko	Perawat melaporkan insiden keselamatan pasien melalui sistem pelaporan

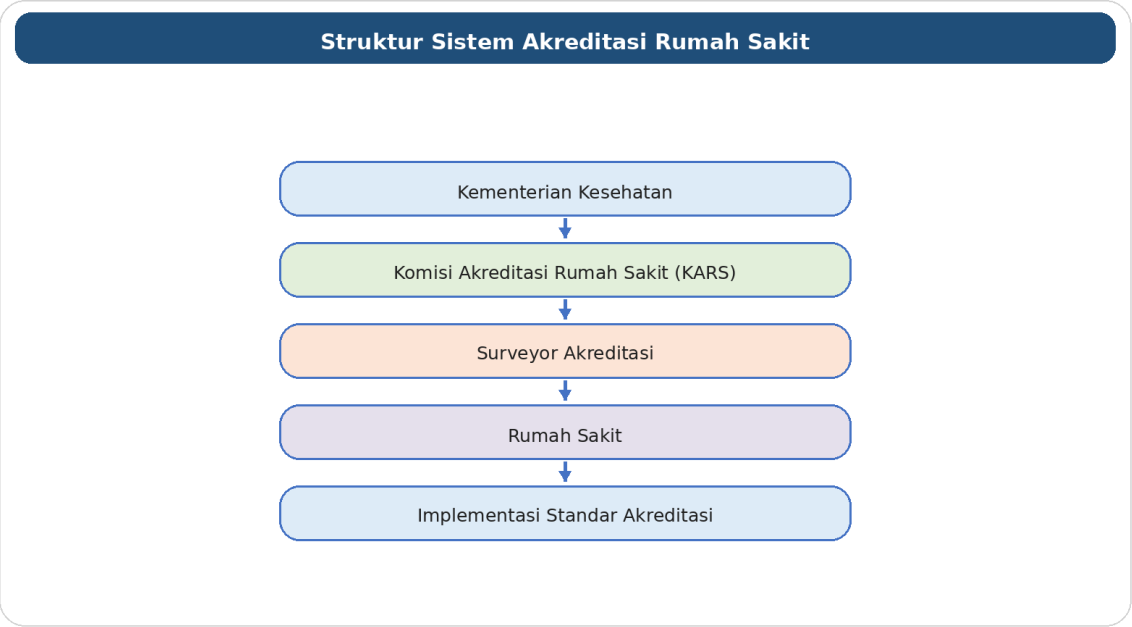


Gambar 6. 1 Siklus Manajemen Mutu Rumah Sakit Berbasis PDCA

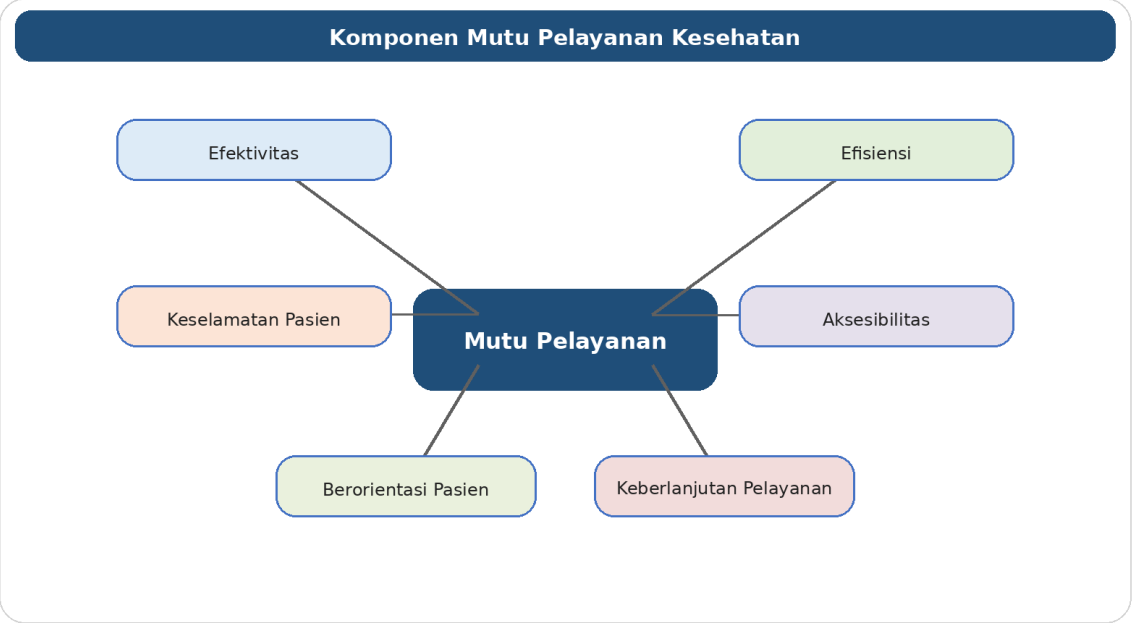
Keterangan: Siklus PDCA menggambarkan proses perencanaan mutu, pelaksanaan program, evaluasi melalui audit, dan tindak lanjut perbaikan sebagai dasar peningkatan mutu berkelanjutan.



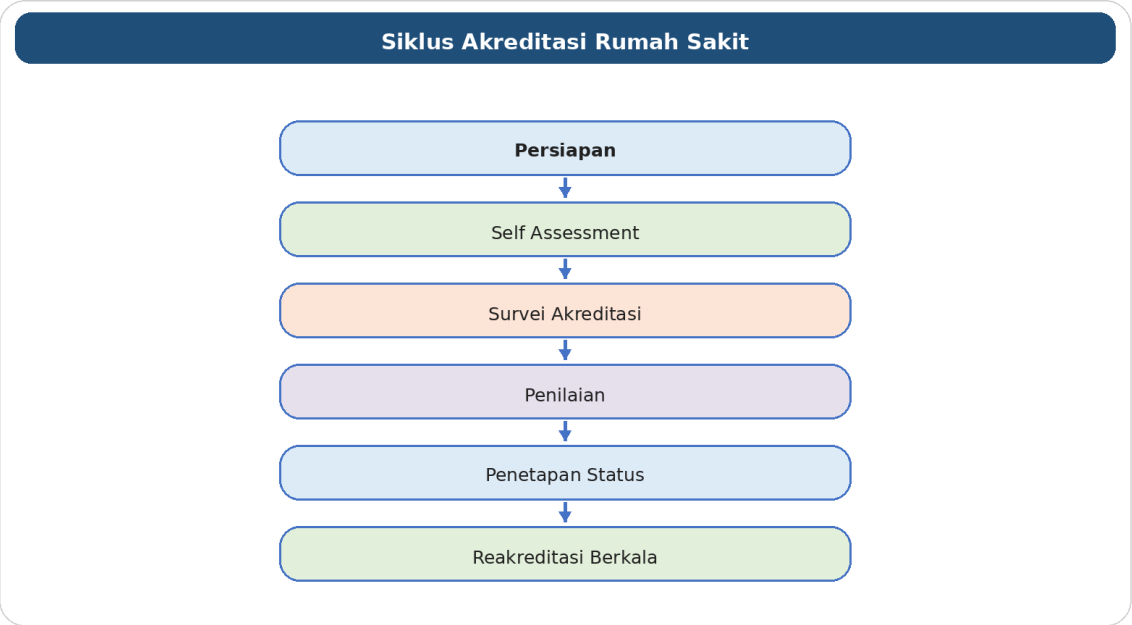
Gambar 6. 2 Sistem Akreditasi Rumah Sakit



Gambar 6. 3 Struktur Sistem Akreditasi Rumah Sakit

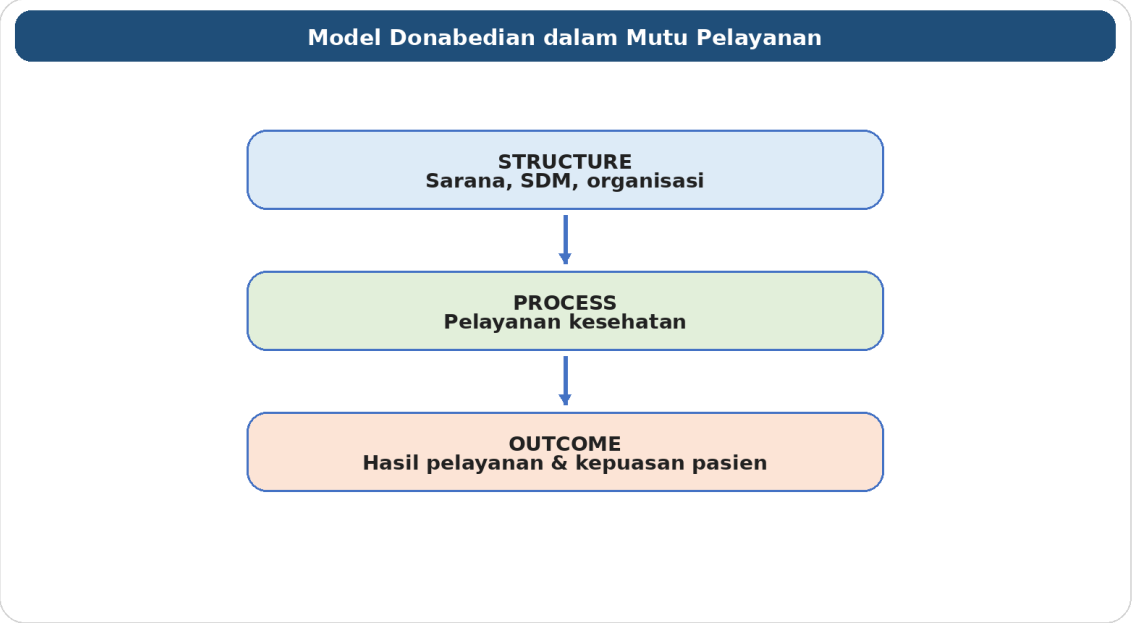


Gambar 6. 4 Komponen Mutu Pelayanan Kesehatan

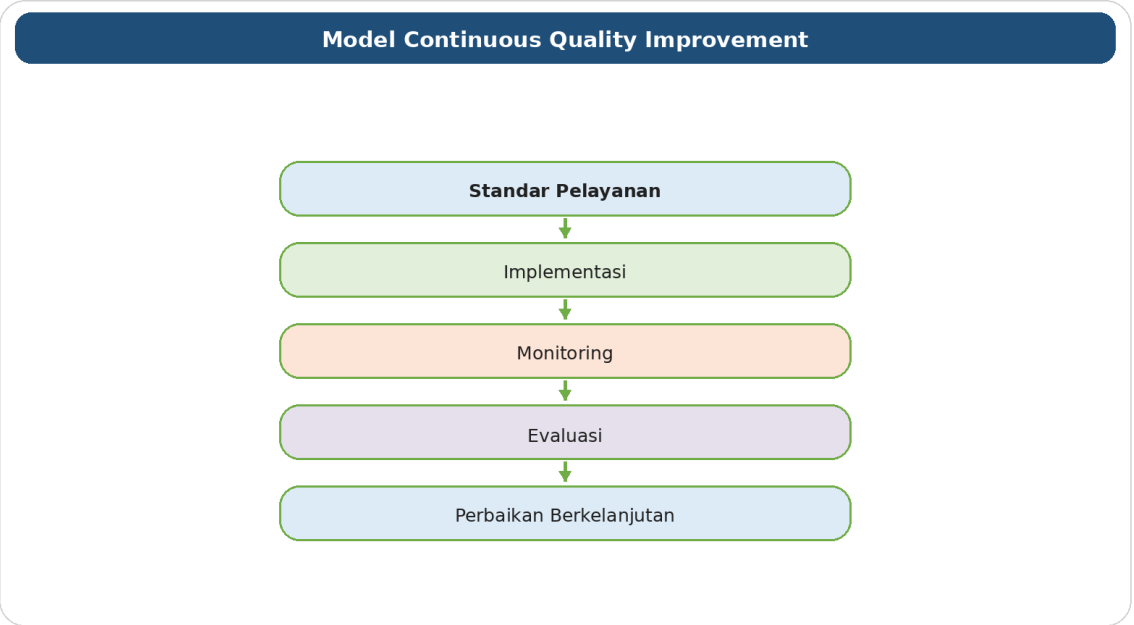


Gambar 6. 5 Siklus Akreditasi Rumah Sakit

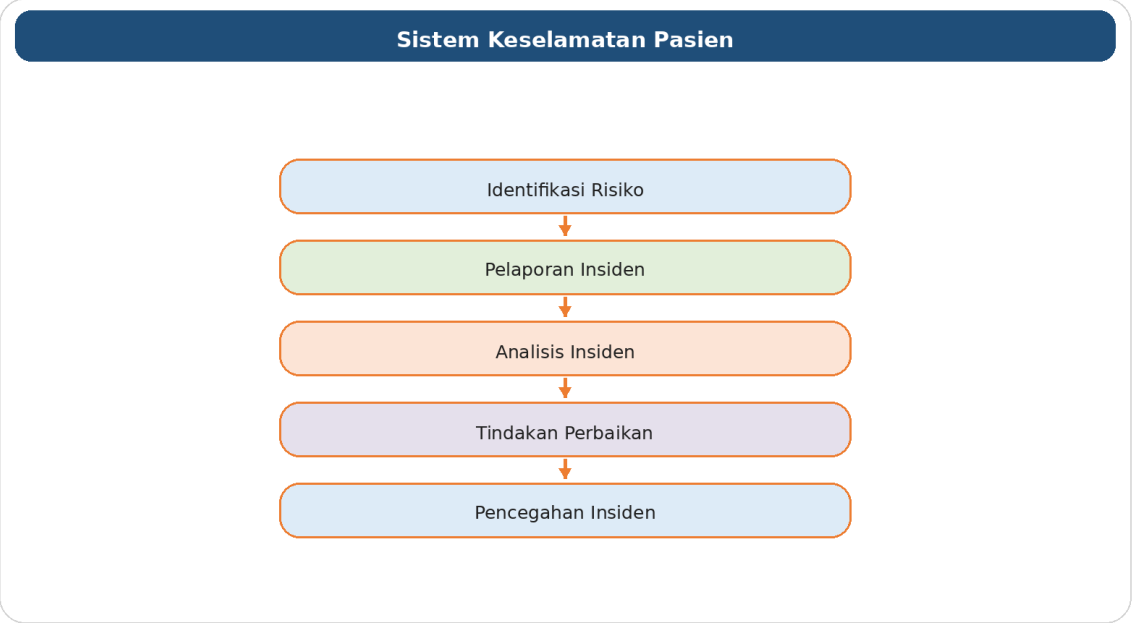
Keterangan: Akreditasi rumah sakit dilaksanakan secara berkala sebagai mekanisme penguatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.



Gambar 6. 6 Model Donabedian dalam Mutu Pelayanan



Gambar 6. 7 Model Continuous Quality Improvement



Gambar 6. 8 Sistem Keselamatan Pasien



Gambar 6. 9 Peran Perawat dalam Akreditasi



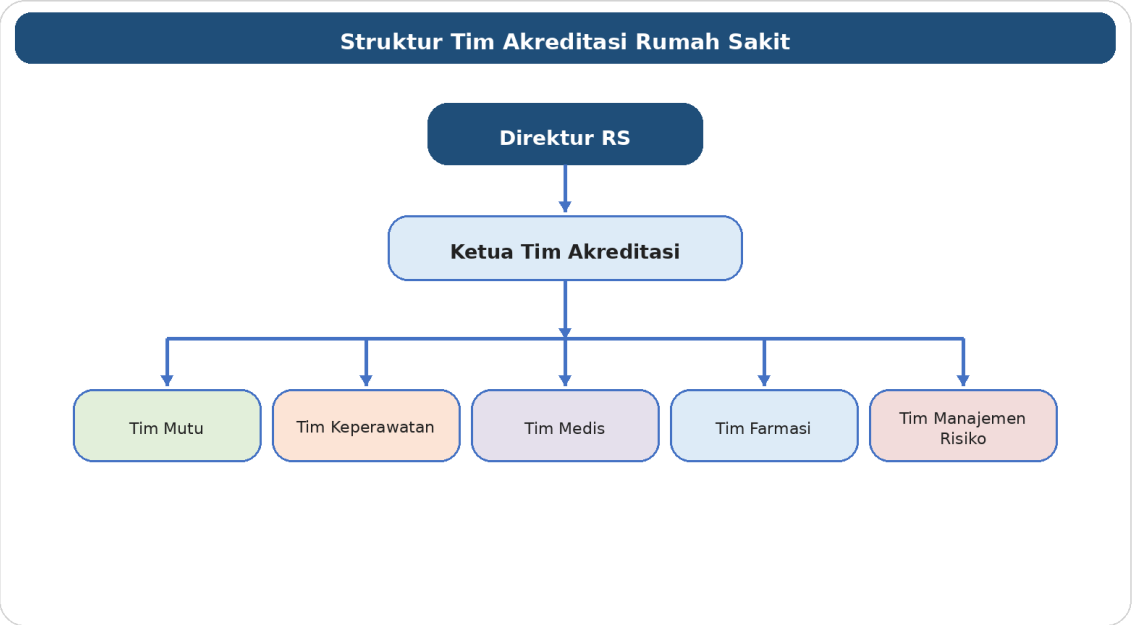
Gambar 6. 10 Hubungan Standar Akreditasi dan Asuhan Keperawatan



Gambar 6. 11 Sistem Manajemen Risiko Rumah Sakit



Gambar 6. 12 Integrasi Pendidikan dan Pelayanan Rumah Sakit



Gambar 6. 13 Struktur Tim Akreditasi Rumah Sakit

Tabel 6. 2 Standar KARS (SNARS) yang Relevan dengan Keperawatan

Kelompok Standar SNARS	**Fokus Standar**	**Peran Keperawatan**
Sasaran Keselamatan Pasien (SKP)	Pencegahan kesalahan medis	Identifikasi pasien, komunikasi efektif

Kelompok Standar SNARS	Fokus Standar	Peran Keperawatan
Pelayanan Berfokus Pasien (PBP)	Pelayanan holistik pasien	Asuhan keperawatan komprehensif
Manajemen Komunikasi dan Informasi (MKI)	Sistem informasi pelayanan	Dokumentasi keperawatan
Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK)	Lingkungan pelayanan aman	Pencegahan infeksi
Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP)	Program mutu rumah sakit	Audit keperawatan
Manajemen SDM (MSDM)	Kompetensi tenaga kesehatan	Pengembangan kompetensi perawat
Pendidikan Pasien dan Keluarga (PPK)	Edukasi kesehatan	Edukasi pasien
Program Nasional	Prioritas kesehatan nasional	Pencegahan stunting, TB, dll

Standar akreditasi rumah sakit nasional disusun oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) melalui Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) yang mengacu pada standar internasional dan berfokus pada pelayanan berpusat pada pasien serta keselamatan pasien. (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia).

I. DESAIN ASESMEN BERDASARKAN PIRAMIDA MILLER

LEVEL 1 – KNOWS (Pengetahuan)

Fokus: Mengingat konsep dasar akreditasi dan standar keperawatan

Indikator:

a) Definisi akreditasi
b) Tujuan akreditasi
c) Prinsip dasar akreditasi
d) Standar keperawatan

Soal LEVEL KNOWS

1) Akreditasi fasilitas kesehatan adalah…
   A. Proses internal rumah sakit
   B. Penilaian eksternal berdasarkan standar tertentu
   C. Evaluasi keuangan rumah sakit
   D. Pemeriksaan pasien

E. Audit internal keperawatan

2) Tujuan utama akreditasi adalah…
   A. Meningkatkan keuntungan rumah sakit
   B. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan
   C. Menambah jumlah pasien
   D. Mengurangi tenaga kerja
   E. Meningkatkan promosi
3) Prinsip dasar akreditasi yang paling utama adalah…
   A. Profit rumah sakit
   B. Kepuasan tenaga kesehatan
   C. Keselamatan pasien
   D. Administrasi
   E. Infrastruktur

LEVEL 2 – KNOWS HOW (Aplikasi & Analisis)

Fokus: Mampu memahami dan menerapkan konsep

Indikator:

a) Menghubungkan standar akreditasi dengan praktik keperawatan
b) Mengidentifikasi peran perawat
c) Mengaplikasikan konsep PDCA

Soal LEVEL KNOWS HOW

1) Seorang perawat menggunakan metode SBAR saat serah terima pasien. Ini merupakan implementasi standar…
   A. Manajemen SDM
   B. Komunikasi efektif
   C. Manajemen keuangan
   D. Promosi kesehatan
   E. Administrasi
2) Perawat melakukan audit dokumentasi keperawatan sebagai bagian dari peningkatan mutu. Tahap PDCA yang sesuai adalah…
   A. Plan
   B. Do
   C. Check
   D. Act
   E. Implement
3) Dalam akreditasi, perawat berperan dalam…
   A. Menentukan tarif layanan
   B. Melakukan dokumentasi dan keselamatan pasien

C. Mengatur keuangan rumah sakit
D. Menentukan kebijakan nasional
E. Mengelola farmasi

LEVEL 3 – SHOWS HOW (Demonstrasi)

Fokus: Menunjukkan kemampuan klinis (simulasi)

Indikator:

a) Menentukan tindakan sesuai standar
b) Mengaplikasikan keselamatan pasien
c) Menyusun tindakan sesuai standar keperawatan

Soal LEVEL SHOWS HOW

1) Dalam simulasi, perawat memeriksa dua identitas pasien sebelum tindakan. Ini termasuk…
   A. Manajemen SDM
   B. Sasaran keselamatan pasien
   C. Administrasi
   D. Edukasi pasien
   E. Dokumentasi
2) Perawat menerapkan cuci tangan sebelum dan sesudah tindakan. Ini merupakan bagian dari…
   A. Manajemen risiko
   B. Pencegahan infeksi\
   C. Komunikasi efektif
   D. Dokumentasi
   E. Audit
3) Dalam simulasi akreditasi, perawat menyusun rencana perbaikan mutu berdasarkan hasil audit. Ini termasuk tahap…
   A. Plan
   B. Do
   C. Check
   D. Act
   E. Evaluate

LEVEL 4 – DOES (Praktik Nyata)

Fokus: Kinerja nyata di praktik klinik

Indikator:

a) Implementasi standar akreditasi
b) Continuous quality improvement

c) Peran aktif dalam mutu pelayanan

Soal LEVEL DOES

1) Di ruang rawat, ditemukan dokumentasi keperawatan tidak lengkap. Tindakan terbaik perawat adalah…
   A. Mengabaikan
   B. Menyalahkan staf lain
   C. Melakukan perbaikan dan monitoring dokumentasi
   D. Melaporkan ke pasien
   E. Menghentikan pelayanan
2) Perawat terlibat dalam program peningkatan mutu berkelanjutan. Hal ini menunjukkan penerapan…
   A. Administrasi
   B. Continuous Quality Improvement
   C. Promosi
   D. Manajemen keuangan
   E. Audit sederhana
3) Perawat melaporkan insiden keselamatan pasien melalui sistem pelaporan. Ini merupakan bagian dari…
   A. Dokumentasi biasa
   B. Manajemen risiko
   C. Promosi kesehatan
   D. Administrasi umum
   E. Edukasi pasien

Latihan Soal Evaluasi

A. Pilihan Ganda

1. Akreditasi fasilitas kesehatan bertujuan utama untuk …
   A. meningkatkan jumlah tenaga kesehatan
   B. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan
   C. meningkatkan pendapatan rumah sakit
   D. meningkatkan jumlah pasien
2. Lembaga yang bertanggung jawab terhadap akreditasi rumah sakit di Indonesia adalah …
   A. WHO
   B. Kementerian Pendidikan
   C. Komisi Akreditasi Rumah Sakit
   D. Persatuan Perawat Nasional Indonesia
3. Fokus utama dalam standar akreditasi rumah sakit adalah …
   A. profit rumah sakit
   B. keselamatan pasien
   C. promosi rumah sakit
   D. persaingan rumah sakit
4. Dokumentasi keperawatan penting dalam akreditasi karena …
   A. sebagai bukti hukum dan mutu pelayanan
   B. sebagai laporan keuangan
   C. sebagai promosi rumah sakit
   D. sebagai arsip administratif
5. Prinsip "6 benar" dalam pemberian obat termasuk dalam standar …
   A. keselamatan pasien
   B. manajemen keuangan
   C. administrasi rumah sakit
   D. manajemen logistik
6. Salah satu metode komunikasi efektif dalam pelayanan kesehatan adalah …
   A. SOAP
   B. SBAR
   C. SWOT
   D. PDCA
7. Model peningkatan mutu yang sering digunakan dalam manajemen kesehatan adalah …
   A. SWOT
   B. PDCA
   C. PICO

D. SBAR

8. Tahap pertama dalam siklus PDCA adalah …
   A. Do
   B. Plan
   C. Check
   D. Act
9. Salah satu indikator mutu pelayanan keperawatan adalah …
   A. jumlah tenaga medis
   B. kelengkapan dokumentasi keperawatan
   C. jumlah kamar pasien
   D. jumlah dokter spesialis
10. Perawat memiliki peran penting dalam akreditasi karena …
    A. perawat memiliki jabatan structural
    B. perawat memiliki interaksi paling lama dengan pasien
    C. perawat menentukan kebijakan rumah sakit
    D. perawat mengelola keuangan rumah sakit

B. Soal Esai

1. Jelaskan pengertian akreditasi fasilitas kesehatan.
2. Sebutkan tujuan utama akreditasi rumah sakit.
3. Jelaskan hubungan antara standar keperawatan dan akreditasi rumah sakit.
4. Jelaskan konsep PDCA dalam manajemen mutu pelayanan kesehatan.
5. Sebutkan peran perawat dalam mendukung keberhasilan akreditasi fasilitas kesehatan.
6. Jelaskan pentingnya dokumentasi keperawatan dalam proses akreditasi.
7. Sebutkan tiga tantangan dalam implementasi standar akreditasi di rumah sakit.
8. Jelaskan hubungan antara keselamatan pasien dan akreditasi rumah sakit.
9. Jelaskan peran manajer keperawatan dalam peningkatan mutu pelayanan.
10. Jelaskan pentingnya pelatihan bagi perawat dalam menghadapi akreditasi.

J. Ringkasan

Perkembangan sistem pelayanan kesehatan modern menuntut tenaga kesehatan, khususnya perawat, untuk memiliki kemampuan manajerial yang baik dalam memberikan pelayanan yang berkualitas, efektif, dan berorientasi pada keselamatan pasien. Manajemen keperawatan menjadi salah satu kompetensi penting yang harus dimiliki oleh mahasiswa keperawatan agar mampu mengelola pelayanan keperawatan secara profesional di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan.

Buku ajar Manajemen Keperawatan ini disusun untuk membantu mahasiswa keperawatan memahami konsep, prinsip, dan penerapan manajemen dalam praktik keperawatan. Materi dalam buku ini mencakup berbagai aspek penting dalam pengelolaan pelayanan keperawatan, mulai dari konsep dasar manajemen keperawatan, fungsi-fungsi manajemen dalam keperawatan (perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian), kepemimpinan dalam keperawatan, manajemen sumber daya manusia keperawatan, manajemen mutu pelayanan kesehatan, hingga akreditasi fasilitas kesehatan dan standar praktik keperawatan.

Selain membahas konsep teoritis, buku ini juga dilengkapi dengan berbagai komponen pembelajaran seperti peta konsep, istilah penting, tabel praktis, ilustrasi diagram manajemen pelayanan kesehatan, studi kasus, serta latihan soal evaluasi untuk membantu mahasiswa memahami materi secara lebih komprehensif dan aplikatif. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis mahasiswa dalam menghadapi berbagai tantangan manajemen di lingkungan pelayanan kesehatan.

Buku ini disusun berdasarkan literatur nasional dan internasional terkini serta mengacu pada standar pelayanan kesehatan dan standar praktik keperawatan yang berlaku, sehingga relevan digunakan sebagai sumber pembelajaran bagi mahasiswa keperawatan, dosen, maupun praktisi keperawatan yang ingin memperdalam pengetahuan di bidang manajemen keperawatan.

Dengan hadirnya buku ini, diharapkan mahasiswa keperawatan dapat memahami dan mengaplikasikan konsep manajemen keperawatan secara efektif dalam praktik pelayanan kesehatan, sehingga mampu berkontribusi dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien.

Glosarium

Istilah	Definisi
Akreditasi	Proses penilaian eksternal terhadap fasilitas kesehatan berdasarkan standar yang telah ditetapkan untuk menjamin mutu pelayanan
Standar Pelayanan	Pedoman yang digunakan untuk memastikan pelayanan kesehatan dilakukan secara konsisten dan berkualitas
Keselamatan Pasien	Sistem yang bertujuan untuk mencegah kesalahan medis dan cedera pada pasien
Manajemen Mutu	Upaya sistematis untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
Dokumentasi Keperawatan	Catatan tertulis mengenai proses asuhan keperawatan yang diberikan kepada pasien
Audit Keperawatan	Evaluasi sistematis terhadap kualitas pelayanan keperawatan
Continuous Quality Improvement	Proses peningkatan mutu pelayanan secara berkelanjutan
Standar Praktik Keperawatan	Pedoman profesional bagi perawat dalam memberikan asuhan keperawatan
Surveyor Akreditasi	Tenaga profesional yang melakukan penilaian terhadap fasilitas kesehatan dalam proses akreditasi
Evidence-Based Practice	Praktik pelayanan kesehatan yang didasarkan pada bukti ilmiah terbaik

Referensi

American Nurses Association. (2021). *Nursing: Scope and standards of practice* (4th ed.). American Nurses Association.

Greenfield, D., & Braithwaite, J. (2018). Health sector accreditation research: A systematic review. *International Journal for Quality in Health Care*, 30(1), 13–20.

Huber, D. L. (2021). *Leadership and nursing care management* (7th ed.). Elsevier.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Standar akreditasi rumah sakit nasional*. Kemenkes RI.

Komisi Akreditasi Rumah Sakit. (2022). *Standar nasional akreditasi rumah sakit edisi terbaru*. KARS.

Shaw, C. D., Groene, O., Mora, N., & Sunol, R. (2019). Accreditation and ISO certification: Do they explain differences in quality management in European hospitals? *International Journal for Quality in Health Care*, 31(2), 131–138.

World Health Organization. (2022). *Quality of care in health services*. WHO Press.

American Nurses Association. (2021). *Nursing: Scope and standards of practice*. ANA.

Braithwaite, J., et al. (2017). Health service accreditation as a predictor of clinical and organisational performance. *BMJ Open*, 7(1).

Donabedian, A. (2005). Evaluating the quality of medical care. *Milbank Quarterly*.

Greenfield, D., & Braithwaite, J. (2018). Health sector accreditation research. *International Journal for Quality in Health Care*.

Huber, D. (2021). *Leadership and nursing care management*. Elsevier.

Joint Commission International. (2023). *Joint Commission International accreditation standards for hospitals*.

Marquis, B., & Huston, C. (2021). *Leadership roles and management functions in nursing*. Wolters Kluwer.

McSherry, R., & Pearce, P. (2018). *Clinical governance*. Wiley Blackwell.

Mosadeghrad, A. (2015). Healthcare service quality. *International Journal of Health Care Quality Assurance*.

Shaw, C. (2019). Accreditation in health care. *International Journal for Quality in Health Care*.

World Health Organization. (2022). *Quality of care in health services*. WHO Press.

World Health Organization. (2021). *Patient safety global action plan 2021–2030*.

Institute of Medicine. (2001). *Crossing the quality chasm*. National Academy Press.

BAB 7

STUDI KASUS MANAJERIAL DAN PROYEK MINI PENINGKATAN MUTU

A. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menguasai konsep dasar manajemen keperawatan, peran perawat manajer, serta etika–legal dalam pengelolaan pelayanan.	CPMK-1; CPMK-2
CPL-2	Mampu menganalisis organisasi pelayanan keperawatan dan sistem layanan kesehatan untuk mendukung tata kelola dan kesinambungan layanan.	CPMK-2; CPMK-7
CPL-3	Mampu menerapkan kepemimpinan keperawatan, komunikasi efektif, kolaborasi, dan manajemen konflik serta perubahan dalam tim.	CPMK-3; CPMK-5
CPL-4	Mampu merencanakan dan mengelola SDM keperawatan (kebutuhan, penjadwalan, delegasi, supervisi) secara adil, aman, dan efisien.	CPMK-4; CPMK-5
CPL-5	Mampu menerapkan manajemen mutu, keselamatan pasien, manajemen risiko, PPI, dan K3 sebagai budaya kerja untuk peningkatan layanan.	CPMK-6; CPMK-7
CPL-6	Mampu memanfaatkan dokumentasi, informatika, standar–akreditasi, serta data kinerja untuk evaluasi, pelaporan, dan perbaikan mutu berkelanjutan.	CPMK-7; CPMK-2; CPMK-6

B. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menjelaskan konsep dasar manajemen keperawatan, fungsi manajemen, peran perawat manajer, serta etika–legal dalam pelayanan.
CPMK-2	Menganalisis organisasi pelayanan keperawatan dan sistem layanan kesehatan (tata kelola, standar, kebijakan) untuk mendukung pengambilan keputusan manajerial.
CPMK-3	Menerapkan kepemimpinan keperawatan, manajemen perubahan, komunikasi efektif, kolaborasi, dan manajemen konflik dalam pengelolaan tim.
CPMK-4	Merencanakan kebutuhan dan penjadwalan SDM keperawatan berdasarkan beban kerja, kompetensi, dan prinsip keadilan–keselamatan.
CPMK-5	Mengelola manajemen asuhan keperawatan melalui delegasi, supervisi, koordinasi, serta pemanfaatan sumber daya/logistik secara efisien.
CPMK-6	Menerapkan manajemen mutu, keselamatan pasien, manajemen risiko klinis, PPI, dan K3 dalam peningkatan kinerja pelayanan keperawatan.

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-7	Menggunakan dokumentasi, informatika, audit data, dan pelaporan untuk evaluasi kinerja serta menyusun proyek mini peningkatan mutu berbasis data.

I. Pemetaan

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 7. Studi Kasus Manajerial dan Proyek Mini Peningkatan Mutu	7.1 Mengintegrasikan data layanan untuk menyusun analisis masalah manajerial dan alternatif solusi.	7.2 Menyusun proyek mini peningkatan mutu dengan indikator baseline–target–evaluasi hasil.	CPMK-7	CPMK-3; CPMK-6

J. Asesmen (berbasis CPMK)

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-3	Simulasi kepemimpinan & konflik (role play) + checklist	Skor kinerja komunikasi terstruktur dan efektivitas resolusi konflik (checklist perilaku).	15	Video/rekaman; lembar penilaian
CPMK-6	Simulasi fasilitasi/kemitraan (role play)	Kualitas fasilitasi partisipasi + kejelasan rencana kolaborasi/advokasi (skor rubrik).	15	Lembar penilaian; rencana kemitraan
CPMK-7	Proyek mini peningkatan mutu + portofolio laporan	Kelengkapan laporan berbasis data (baseline–target–hasil) dan kualitas rekomendasi perbaikan terukur.	15	Laporan proyek; portofolio data; refleksi

Rubrik CPMK-1

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
1.1 Ketepatan konsep fungsi manajemen (% benar)	<60% benar; miskonsepsi dominan	60–74% benar; miskonsepsi masih ada	75–89% benar; kesalahan minor	≥90% benar; konsisten
1.2 Ketepatan penerapan peran–akuntabilitas pada skenario	Keliru/tidak relevan	Relevan sebagian; alasan lemah	Tepat; alasan logis	Tepat; alasan kuat dan komprehensif

Rubrik CPMK-2

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
2.1 Ketepatan pemetaan struktur & alur layanan	Tidak akurat; komponen inti hilang	Cukup akurat; masih ada kekeliruan bermakna	Akurat; kekeliruan minor	Sangat akurat; komprehensif dan jelas
2.2 Ketepatan gap analysis & prioritas perbaikan	Gap tidak sesuai standar; prioritas acak	Gap sebagian tepat; prioritas kurang konsisten	Gap tepat; prioritas jelas	Gap sangat tepat; prioritas sangat logis & berbasis risiko

Rubrik CPMK-3

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
3.1 Kinerja kepemimpinan & manajemen perubahan (checklist)	≤60% perilaku tercapai; tidak terarah	61–75% tercapai; arah sebagian jelas	76–90% tercapai; terarah & konsisten	>90% tercapai; adaptif, memotivasi, terstruktur
3.2 Komunikasi efektif & resolusi konflik (checklist)	Konflik tidak tertangani; komunikasi tidak jelas	Ada upaya; solusi belum disepakati	Solusi disepakati; komunikasi runtut	Solusi kuat; komunikasi sangat efektif & menjaga hubungan kerja

Rubrik CPMK-4

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
4.1 Akurasi perhitungan kebutuhan tenaga	Banyak kesalahan; asumsi tidak jelas	Cukup tepat; masih ada kesalahan bermakna	Tepat; kesalahan minor	Sangat tepat; asumsi jelas & dapat dipertanggungjawabkan
4.2 Kualitas jadwal dinas (cakupan, aturan, pemerataan)	Cakupan tidak aman; melanggar aturan	Cakupan cukup; pemerataan kurang	Cakupan aman; aturan dipatuhi; cukup adil	Cakupan sangat aman; patuh aturan; sangat adil & minim risiko kelelahan

Rubrik CPMK-5

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
5.1 Ketepatan keputusan delegasi & rencana supervisi	Delegasi tidak sesuai kompetensi/risiko	Delegasi cukup sesuai; supervisi kurang spesifik	Delegasi sesuai; supervisi jelas	Delegasi sangat tepat; supervisi terukur & antisipatif risiko
5.2 Ketepatan rencana pengendalian logistik	Tidak berbasis kebutuhan; rawan kekosongan	Berbasis kebutuhan sebagian; kontrol kurang	Berbasis data; kontrol memadai	Berbasis data komprehensif; kontrol sangat efektif (minim stockout/overstock)

Rubrik CPMK-6

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
6.1 Ketepatan indikator & analisis temuan audit	Indikator tidak tepat; analisis tidak sesuai	Indikator cukup; analisis terbatas	Indikator tepat; analisis jelas	Indikator sangat tepat; analisis kritis berbasis data/tren
6.2 Kelayakan rencana mitigasi risiko/PPI/K3 (terukur)	Rencana umum; tidak terukur	Ada rencana; indikator belum jelas	Rencana spesifik; indikator terukur	Rencana sangat spesifik, terukur, realistis; prioritas berbasis risiko

Rubrik CPMK-7

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
7.1 Kelengkapan laporan berbasis data (baseline–target–hasil)	Data tidak lengkap; tidak dapat dievaluasi	Data cukup; hubungan baseline–hasil kurang jelas	Data lengkap; evaluasi jelas	Data sangat lengkap; evaluasi kuat dan transparan
7.2 Kualitas proyek mini peningkatan mutu (rencana–uji–evaluasi)	Tidak sistematis; tanpa evaluasi hasil	Sistematis sebagian; evaluasi terbatas	Sistematis; evaluasi hasil memadai	Sangat sistematis; evaluasi kuat; rekomendasi implementatif & berkelanjutan

A. Konsep Dasar Studi Kasus Manajerial

Definisi Studi Kasus Manajerial

Studi kasus manajerial dalam keperawatan merupakan pendekatan analitis yang digunakan untuk mengeksplorasi secara mendalam suatu fenomena, masalah, atau dinamika pada tingkat unit pelayanan, organisasi, atau sistem kesehatan dengan tujuan memahami proses manajerial serta dampaknya terhadap mutu pelayanan (Nursalam, 2015; Wahyuningsih, 2025). Pendekatan ini berfokus pada bagaimana fungsi-fungsi manajemen-meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi-diterapkan dalam konteks nyata pelayanan kesehatan untuk menghasilkan keputusan yang efektif dan berbasis bukti (Swanburg, 2001; Nursalam, 2015). Dalam perspektif metodologis, studi kasus memungkinkan analisis kontekstual yang mendalam terhadap praktik manajemen di lingkungan nyata, sehingga sangat relevan dalam memahami kompleksitas sistem pelayanan kesehatan modern (Flyvbjerg, 2013; Montgomery et al., 2023).

Karakteristik Studi Kasus Manajerial

Studi kasus manajerial memiliki sejumlah karakteristik utama yang membedakannya dari pendekatan lain (Flyvbjerg, 2013; Wahyuningsih, 2025). Pertama, studi ini berfokus pada level sistem atau organisasi, bukan pada individu pasien, sehingga menekankan analisis terhadap struktur, proses, dan outcome pelayanan (Nursalam, 2015; Swanburg, 2001). Kedua, pendekatan yang digunakan bersifat *problem-solving oriented*, dengan mengintegrasikan fungsi manajemen dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah pelayanan (Swanburg, 2001; Nursalam, 2015). Ketiga, studi kasus manajerial bersifat berbasis data (*data-driven*) dengan memanfaatkan berbagai sumber data seperti indikator mutu (misalnya *Bed Occupancy Rate*, *Length of Stay*, dan insiden keselamatan pasien), audit dokumentasi, serta observasi praktik keperawatan (Montgomery et al., 2023; Shanafelt et al., 2024).

Keempat, pendekatan ini menggunakan triangulasi data untuk meningkatkan validitas analisis, sehingga hasil yang diperoleh lebih komprehensif dan kontekstual (Flyvbjerg, 2013; Yin, 2018). Kelima, studi kasus manajerial berorientasi pada perbaikan mutu berkelanjutan (*continuous quality improvement*), yang menekankan siklus evaluasi dan peningkatan secara sistematis (Deming, 1986; Montgomery et al., 2023). Terakhir, studi ini mempertimbangkan kompleksitas lingkungan organisasi, termasuk faktor sumber daya manusia, budaya organisasi, dan kebijakan institusi, sehingga hasil analisis lebih aplikatif dalam praktik manajemen keperawatan (Nursalam, 2015; Wahyuningsih, 2025; Shanafelt et al., 2024).

1. Perbedaan studi kasus klinik dan manajerial

   Studi kasus klinik dan studi kasus manajerial memiliki perbedaan mendasar dalam fokus, tujuan, dan pendekatan analisisnya. Studi kasus klinik berfokus pada individu pasien dengan tujuan utama menegakkan diagnosis keperawatan dan menentukan intervensi yang tepat melalui pendekatan proses keperawatan, sehingga bersifat *patient-centered*. Sebaliknya, studi kasus manajerial berorientasi pada sistem atau organisasi pelayanan dengan tujuan meningkatkan mutu dan efisiensi pelayanan melalui pengelolaan sumber daya, sehingga bersifat *system-centered*. Data yang digunakan dalam studi kasus klinik umumnya berupa data klinis pasien, sedangkan studi kasus manajerial memanfaatkan data indikator mutu, kinerja organisasi, serta aspek sumber daya manusia. Dengan demikian, perawat dalam studi kasus klinik berperan sebagai *care provider*, sedangkan dalam studi kasus manajerial berperan sebagai *manager* atau *leader* yang mengambil keputusan strategis berbasis data (Craven & Hirnle, 2000; Nursalam, 2015; Wahyuningsih, 2025).
2. Peran studi kasus dalam manajemen keperawatan

   Studi kasus manajerial memiliki peran strategis dalam mendukung praktik manajemen keperawatan yang efektif dan berbasis evidence. Pertama, studi kasus berfungsi sebagai alat analisis untuk mengidentifikasi akar masalah dalam sistem pelayanan, seperti tingginya beban kerja perawat, rendahnya kepatuhan terhadap standar operasional prosedur, atau meningkatnya insiden keselamatan pasien. Kedua, studi kasus menjadi dasar dalam pengambilan keputusan manajerial karena menyediakan data dan informasi yang relevan untuk merancang intervensi yang tepat, termasuk dalam pengelolaan sumber daya manusia dan perbaikan alur pelayanan. Ketiga, dalam konteks pendidikan, studi kasus berperan sebagai metode pembelajaran berbasis pengalaman (*experiential learning*) yang mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan pengambilan keputusan mahasiswa keperawatan. Keempat, studi kasus mendukung upaya peningkatan mutu pelayanan melalui pendekatan *continuous quality improvement*, dengan memungkinkan proses identifikasi masalah, implementasi solusi, dan evaluasi outcome secara sistematis. Oleh karena itu, studi kasus menjadi jembatan penting antara teori manajemen dan praktik klinik nyata (Flyvbjerg, 2013; Swanburg, 2001; Wahyuningsih, 2025).
3. Pendekatan *data-driven analysis* dalam pelayanan Kesehatan

   Pendekatan *data-driven analysis* dalam pelayanan kesehatan merujuk pada penggunaan data objektif, baik klinis maupun operasional, sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang lebih akurat, efektif, dan efisien. Pendekatan ini melibatkan proses pengumpulan data dari berbagai sumber seperti rekam medis

elektronik (*Electronic Health Records*), indikator mutu pelayanan, serta sistem informasi manajemen rumah sakit, yang kemudian dianalisis menggunakan metode statistik atau teknologi analitik untuk menghasilkan *insight* yang relevan. Karakteristik utama pendekatan ini meliputi penggunaan data real-time, pemanfaatan teknologi digital, orientasi pada outcome, serta kemampuan prediktif dalam mengantisipasi risiko klinis maupun manajerial. Dalam praktik keperawatan, pendekatan *data-driven* terbukti mampu meningkatkan kualitas pelayanan, mengurangi kesalahan medis, mengoptimalkan beban kerja perawat, serta mendukung implementasi *evidence-based practice*. Lebih lanjut, pendekatan ini memiliki relevansi kuat dengan teori manajemen modern seperti *Job Demands–Resources Model* dan *Conservation of Resources Theory*, yang menekankan pentingnya pengelolaan beban kerja dan sumber daya secara berbasis data untuk mencegah burnout dan meningkatkan kinerja perawat (Bennett et al., 2012; Montgomery et al., 2023; Shanafelt et al., 2024).

B. Konsep Dasar Proyek Mini Peningkatan Mutu

1. Definisi Quality Improvement (QI)

   Quality Improvement (QI) merupakan pendekatan sistematis yang digunakan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan melalui perbaikan proses secara berkelanjutan (Centers for Medicare & Medicaid Services, 2026). QI menekankan penggunaan data dan pengujian perubahan dalam praktik nyata untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta keselamatan pelayanan kesehatan (Johns Hopkins Medicine, 2024). Selain itu, QI juga dipahami sebagai upaya terstruktur dan berbasis data untuk meningkatkan kualitas dan keselamatan pelayanan kesehatan secara menyeluruh (Sowell, 2024). Dalam konteks keperawatan, QI merupakan proses strategis yang melibatkan evaluasi praktik pelayanan untuk meningkatkan outcome pasien dan kualitas asuhan keperawatan (Nevada State University, 2024).
2. Tujuan dan manfaat proyek mutu dalam keperawatan

   Proyek peningkatan mutu dalam keperawatan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, keselamatan pasien, serta efisiensi sistem pelayanan kesehatan melalui pendekatan yang sistematis dan berbasis data (Sowell, 2024). Selain itu, proyek mutu juga bertujuan untuk mengurangi kesalahan medis, meningkatkan kepatuhan terhadap standar praktik, serta memperbaiki outcome klinis pasien (Nevada State University, 2024). Manfaat implementasi proyek mutu meliputi peningkatan keselamatan pasien, efisiensi operasional, serta optimalisasi penggunaan sumber daya dalam pelayanan

kesehatan (IntelyCare, 2025) . Lebih lanjut, proyek mutu juga berkontribusi dalam meningkatkan kepuasan pasien dan tenaga kesehatan serta memperkuat budaya keselamatan dalam organisasi pelayanan kesehatan (Sowell, 2024).

3. Prinsip continuous quality improvement (CQI)

   Continuous Quality Improvement (CQI) merupakan pendekatan yang menekankan perbaikan proses pelayanan secara berkelanjutan melalui siklus evaluasi dan peningkatan yang berulang (O'Donnell & Gupta, 2023). Prinsip utama CQI meliputi penggunaan data sebagai dasar pengambilan keputusan, fokus pada proses, serta penerapan siklus iteratif seperti Plan-Do-Study-Act (PDSA) untuk menguji dan menyempurnakan intervensi (Johns Hopkins Medicine, 2024). Selain itu, CQI menekankan pentingnya kolaborasi tim, keterlibatan seluruh tenaga kesehatan, serta pendekatan berbasis evidence dalam setiap tahap perbaikan (IntelyCare, 2025). CQI juga berorientasi pada peningkatan outcome pasien, efisiensi sistem, dan keberlanjutan perubahan melalui evaluasi yang terus-menerus (O'Donnell & Gupta, 2023).

4. Peran perawat dalam peningkatan mutu dan patient safety

   Perawat memiliki peran yang sangat strategis dalam peningkatan mutu dan keselamatan pasien karena merupakan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan secara langsung dan berkelanjutan selama 24 jam (Patrician et al., 2024). Dalam praktiknya, perawat berperan dalam mengidentifikasi masalah pelayanan, mengumpulkan dan menganalisis data, serta mengimplementasikan intervensi berbasis evidence untuk meningkatkan kualitas asuhan (Nevada State University, 2024). Selain itu, perawat juga berfungsi sebagai agen perubahan (*change agent*) yang mendorong budaya keselamatan dan kolaborasi tim dalam organisasi pelayanan kesehatan (Davies et al., 2025). Lebih lanjut, keterlibatan aktif perawat dalam program mutu terbukti berkontribusi terhadap peningkatan outcome pasien, penurunan insiden keselamatan, serta peningkatan efisiensi pelayanan kesehatan secara keseluruhan (Sowell, 2024)

C. Data Layanan Kesehatan sebagai Dasar Analisis

1. Jenis dan sumber data layanan:
   a. Indikator mutu (BOR, LOS, dll)

      Indikator mutu merupakan data kuantitatif yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan kesehatan dalam memenuhi standar yang telah ditetapkan (Kementerian Kesehatan RI, 2022). Indikator ini mencerminkan aspek efisiensi, efektivitas, keselamatan, dan kepuasan pasien dalam sistem pelayanan kesehatan (WHO, 2023). Contoh indikator mutu yang sering

digunakan di rumah sakit antara lain *Bed Occupancy Rate* (BOR) untuk mengukur tingkat pemanfaatan tempat tidur dan *Length of Stay* (LOS) untuk menilai efisiensi lama perawatan pasien (Warmadewa Hospital, 2025). Data indikator mutu memiliki peran penting dalam evaluasi kinerja, identifikasi masalah, serta dasar perbaikan mutu pelayanan secara berkelanjutan (Kemenkes RI, 2022).

b. Data keselamatan pasien (KTD, KNC)

Data keselamatan pasien merupakan informasi yang berkaitan dengan insiden yang terjadi selama proses pelayanan kesehatan, termasuk kejadian tidak diharapkan (KTD) dan kejadian nyaris cedera (KNC) (Kemenkes RI, 2017). Keselamatan pasien didefinisikan sebagai kondisi dimana pasien terbebas dari cedera atau risiko bahaya yang tidak seharusnya terjadi selama pelayanan kesehatan (AIHW, 2009). Data ini digunakan untuk mengidentifikasi risiko, menganalisis penyebab insiden, serta merancang strategi pencegahan untuk meningkatkan keselamatan pelayanan (Komite Keselamatan Pasien, 2024). Selain itu, pelaporan insiden keselamatan pasien menjadi bagian penting dalam program peningkatan mutu karena berkaitan langsung dengan kualitas pelayanan dan perlindungan pasien (Farahdila, 2025).

c. Data beban kerja

Data beban kerja merupakan informasi yang menggambarkan jumlah dan kompleksitas tugas yang harus diselesaikan oleh tenaga keperawatan dalam periode tertentu (Nursalam, 2015). Data ini mencakup rasio perawat-pasien, tingkat ketergantungan pasien, serta kompleksitas tindakan keperawatan yang dilakukan (Sutejo et al., 2021). Pengukuran beban kerja sangat penting untuk memastikan distribusi tugas yang seimbang serta mencegah kelelahan dan burnout pada perawat (Montgomery et al., 2023). Selain itu, data beban kerja digunakan sebagai dasar dalam perencanaan kebutuhan tenaga keperawatan dan pengambilan keputusan manajerial terkait alokasi sumber daya (Nursalam, 2015).

d. Audit dan dokumentasi

Audit dan dokumentasi merupakan sumber data penting dalam evaluasi mutu pelayanan keperawatan yang dilakukan melalui penilaian sistematis terhadap catatan asuhan keperawatan dan proses pelayanan (Marquis & Huston, 2000; Nursalam, 2014). Audit keperawatan bertujuan untuk menilai kesesuaian praktik dengan standar yang telah ditetapkan serta mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan (Nursalam, 2014). Dokumentasi keperawatan sendiri mencerminkan kualitas asuhan yang diberikan karena mencakup seluruh proses keperawatan mulai dari pengkajian

hingga evaluasi (Depkes RI, 1993). Oleh karena itu, audit dan dokumentasi tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi, tetapi juga sebagai bukti legal dan dasar pengambilan keputusan dalam peningkatan mutu pelayanan keperawatan (Marquis & Huston, 2000; Nursalam, 2014).

2. Pengolahan dan interpretasi data

Pengolahan dan interpretasi data dalam pelayanan kesehatan merupakan proses sistematis yang melibatkan pengumpulan, pengorganisasian, analisis, dan transformasi data menjadi informasi yang bermakna untuk mendukung pengambilan keputusan (Tandon et al., 2025). Data yang awalnya berupa fakta mentah perlu dianalisis dan dikontekstualisasikan agar menghasilkan informasi yang relevan dan dapat digunakan dalam praktik manajerial maupun klinis (Public Health Foundation, 2024). Proses pengolahan data mencakup tahapan seperti *data cleaning*, analisis deskriptif, hingga analisis diagnostik untuk mengidentifikasi pola dan akar penyebab masalah dalam pelayanan kesehatan (Förstel et al., 2024). Interpretasi data selanjutnya berperan dalam menerjemahkan hasil analisis menjadi *insight* yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, efisiensi sistem, dan outcome pasien (Tandon et al., 2025). Oleh karena itu, pengolahan dan interpretasi data menjadi komponen kunci dalam pendekatan *data-driven decision making* yang mendukung praktik keperawatan berbasis evidence (Lighterness et al., 2024).

3. Konsep *gap analysis* (standar vs realita)

Gap analysis merupakan metode analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi aktual (realita) dengan standar atau target yang diharapkan dalam pelayanan kesehatan (Health Service Executive, 2024). Pendekatan ini memungkinkan organisasi untuk menilai sejauh mana kinerja pelayanan telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan serta mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan (WHO, 2025). Dalam praktiknya, gap analysis dilakukan dengan membandingkan data kinerja aktual dengan indikator standar sehingga dapat diketahui deviasi atau ketidaksesuaian yang terjadi dalam sistem pelayanan (Abt Global, 2025). Hasil analisis kesenjangan ini kemudian digunakan sebagai dasar dalam merancang intervensi peningkatan mutu yang lebih terarah dan berbasis data (Health Service Executive, 2024). Dengan demikian, gap analysis menjadi alat penting dalam *continuous quality improvement* karena membantu organisasi dalam melakukan evaluasi kinerja secara objektif dan sistematis untuk mencapai standar pelayanan yang optimal (Abt Global, 2025).

D. Analisis Masalah Manajerial (S7.1)

1. Identifikasi masalah berbasis data

   Identifikasi masalah berbasis data merupakan proses sistematis dalam mengenali permasalahan pelayanan kesehatan dengan menggunakan data objektif sebagai dasar analisis (WHO, 2025). Pendekatan ini menekankan penggunaan indikator kinerja, data mutu, serta informasi operasional untuk memastikan bahwa masalah yang diidentifikasi bersifat nyata dan terukur (Montgomery et al., 2023). Identifikasi masalah berbasis data memungkinkan tenaga kesehatan untuk menghindari bias subjektif dan meningkatkan akurasi dalam menentukan prioritas perbaikan (Public Health Foundation, 2024). Selain itu, penggunaan data dalam identifikasi masalah juga mendukung pendekatan *pengambilan keputusan berdasarkan bukti* yang menjadi dasar dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan modern (Shanafelt et al., 2024). Oleh karena itu, identifikasi masalah berbasis data menjadi langkah awal yang krusial dalam siklus *quality improvement* untuk memastikan intervensi yang dilakukan tepat sasaran dan efektif (WHO, 2025).

2. Analisis penyebab masalah:

   a. Root Cause Analysis (RCA)

      Root Cause Analysis (RCA) merupakan pendekatan sistematis yang digunakan untuk mengidentifikasi penyebab utama dari suatu masalah atau kejadian yang tidak diharapkan dalam pelayanan kesehatan (Behrhorst, 2023). Metode ini berfokus pada pengungkapan faktor sistemik yang mendasari terjadinya masalah, bukan hanya gejala yang tampak di permukaan (Behrhorst, 2023). RCA bertujuan untuk menghasilkan solusi jangka panjang dengan menghilangkan akar penyebab sehingga kejadian serupa dapat dicegah di masa depan (Andersen et al., 2009). Dalam praktiknya, RCA dilakukan melalui proses pengumpulan data, analisis kronologi kejadian, serta identifikasi hubungan sebab-akibat secara sistematis (ISO, 2019; Andersen et al., 2009). Oleh karena itu, RCA menjadi alat penting dalam peningkatan keselamatan pasien dan manajemen risiko di fasilitas pelayanan kesehatan (Behrhorst, 2023).

   b. Fishbone Diagram

      Fishbone Diagram atau diagram sebab-akibat merupakan alat analisis visual yang digunakan untuk mengidentifikasi berbagai faktor penyebab suatu masalah secara sistematis (Kumah, 2024). Diagram ini membantu tim dalam mengelompokkan penyebab masalah ke dalam kategori tertentu seperti manusia, metode, mesin, material, lingkungan, dan manajemen (Tagaram,

2024). Fishbone Diagram digunakan sebagai bagian dari proses *root cause analysis* untuk memetakan hubungan antara masalah dan faktor penyebabnya secara komprehensif (CMS, 2013). Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih terstruktur dan membantu tim mengidentifikasi penyebab yang mungkin tidak terlihat secara langsung (Kumah, 2024). Dengan demikian, Fishbone Diagram menjadi alat penting dalam meningkatkan efektivitas analisis masalah dalam program peningkatan mutu pelayanan kesehatan (Tagaram, 2024)

c. SWOT Analysis

SWOT analysis merupakan metode analisis strategis yang digunakan untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja organisasi, yaitu *strengths*, *weaknesses*, *opportunities*, dan *threats* (Gürel & Tat, 2017). Pendekatan ini membantu organisasi dalam memahami posisi strategisnya serta merumuskan strategi yang tepat dalam menghadapi tantangan pelayanan kesehatan (Helms & Nixon, 2010). Dalam konteks pelayanan kesehatan, SWOT analysis digunakan untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan internal organisasi serta peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal (Montgomery et al., 2023). Analisis ini mendukung pengambilan keputusan strategis yang lebih komprehensif dan berbasis konteks organisasi (Gürel & Tat, 2017). Oleh karena itu, SWOT analysis menjadi alat penting dalam perencanaan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan secara berkelanjutan (Helms & Nixon, 2010).

3. Penentuan prioritas masalah:

a. Impact

Impact merupakan kriteria dalam penentuan prioritas masalah yang mengacu pada sejauh mana suatu masalah mempengaruhi kualitas pelayanan, keselamatan pasien, dan outcome kesehatan (WHO, 2025). Masalah dengan dampak yang tinggi biasanya menjadi prioritas utama karena berpotensi menyebabkan kerugian besar baik bagi pasien maupun organisasi (Montgomery et al., 2023). Penilaian impact membantu dalam mengalokasikan sumber daya secara efektif untuk masalah yang memiliki konsekuensi paling signifikan (Shanafelt et al., 2024). Oleh karena itu, analisis dampak menjadi komponen penting dalam proses pengambilan keputusan manajerial berbasis data (WHO, 2025).

b. Urgency

Urgency merujuk pada tingkat kebutuhan untuk segera menangani suatu masalah berdasarkan tingkat risiko dan potensi konsekuensi yang ditimbulkan (WHO, 2025). Masalah dengan tingkat urgensi tinggi memerlukan intervensi segera untuk mencegah terjadinya dampak yang lebih serius terhadap

keselamatan pasien (Behrhorst, 2023). Penentuan urgensi membantu organisasi dalam merespons masalah secara cepat dan tepat waktu dalam sistem pelayanan kesehatan yang dinamis (Montgomery et al., 2023). Dengan demikian, urgency menjadi salah satu kriteria penting dalam menentukan prioritas tindakan dalam program peningkatan mutu (WHO, 2025).

c. Feasibility

Feasibility merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu solusi atau intervensi dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan sumber daya, waktu, dan kapasitas organisasi (WHO, 2025). Penilaian kelayakan mencakup aspek teknis, finansial, serta dukungan organisasi terhadap implementasi solusi yang direncanakan (Montgomery et al., 2023). Masalah yang memiliki solusi dengan tingkat feasibility tinggi cenderung diprioritaskan karena lebih mudah diimplementasikan dan memberikan hasil yang nyata dalam waktu relatif singkat (Shanafelt et al., 2024). Oleh karena itu, feasibility menjadi faktor penting dalam memastikan keberhasilan implementasi program peningkatan mutu pelayanan kesehatan (WHO, 2025).

E. Pengambilan Keputusan Manajerial Berbasis Eviden

1. Konsep evidence-based decision making

Evidence-based decision making merupakan pendekatan sistematis dalam pengambilan keputusan yang mengintegrasikan bukti terbaik yang tersedia dengan keahlian profesional dan kebutuhan konteks pelayanan kesehatan (Sackett et al., 1996; Melnyk & Fineout-Overholt, 2023). Pendekatan ini menekankan penggunaan data empiris dan hasil penelitian sebagai dasar utama dalam merumuskan kebijakan dan intervensi pelayanan (Brownson et al., 2018; WHO, 2025). Evidence-based decision making bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, keselamatan pasien, serta efisiensi sistem kesehatan melalui keputusan yang lebih akurat dan terukur (Shanafelt et al., 2024). Selain itu, pendekatan ini membantu mengurangi variasi praktik yang tidak berbasis bukti serta meningkatkan konsistensi dalam pelayanan keperawatan (Melnyk & Fineout-Overholt, 2023). Oleh karena itu, evidence-based decision making menjadi fondasi penting dalam manajemen keperawatan modern yang berorientasi pada mutu dan keselamatan pasien (WHO, 2025).

2. Integrasi:

a. Data layanan

Data layanan merupakan sumber utama dalam pengambilan keputusan berbasis eviden karena mencerminkan kondisi aktual pelayanan kesehatan

secara objektif (Montgomery et al., 2023). Data ini meliputi indikator mutu, data keselamatan pasien, serta data operasional yang digunakan untuk mengidentifikasi masalah dan mengevaluasi kinerja pelayanan (WHO, 2025). Pemanfaatan data layanan memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih akurat dan sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan (Shanafelt et al., 2024). Oleh karena itu, integrasi data layanan menjadi langkah awal yang penting dalam proses evidence-based decision making (Montgomery et al., 2023).

b. Evidence ilmiah

Evidence ilmiah merupakan hasil penelitian yang telah teruji secara metodologis dan digunakan sebagai dasar dalam menentukan intervensi yang efektif dan aman (Melnyk & Fineout-Overholt, 2023). Penggunaan evidence ilmiah membantu memastikan bahwa keputusan yang diambil memiliki dasar ilmiah yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan (Brownson et al., 2018). Dalam praktik keperawatan, evidence ilmiah digunakan untuk memilih intervensi terbaik yang telah terbukti meningkatkan outcome pasien (Shanafelt et al., 2024). Dengan demikian, integrasi evidence ilmiah sangat penting untuk meningkatkan kualitas dan keselamatan pelayanan kesehatan (WHO, 2025).

c. Konteks organisasi

Konteks organisasi mencakup faktor internal seperti sumber daya manusia, budaya organisasi, kebijakan, serta struktur pelayanan yang mempengaruhi implementasi keputusan (Schein, 2017). Pengambilan keputusan yang efektif harus mempertimbangkan konteks organisasi agar intervensi yang direncanakan dapat diimplementasikan secara realistis (WHO, 2025). Faktor seperti ketersediaan sumber daya, dukungan manajemen, dan kesiapan tim menjadi penentu keberhasilan implementasi keputusan berbasis eviden (Shanafelt et al., 2024). Oleh karena itu, integrasi konteks organisasi memastikan bahwa keputusan tidak hanya berbasis bukti, tetapi juga aplikatif dan berkelanjutan (Montgomery et al., 2023).

3. Peran kepemimpinan dan kolaborasi tim

Kepemimpinan memiliki peran kunci dalam mendorong implementasi pengambilan keputusan berbasis eviden dalam organisasi pelayanan kesehatan (Shanafelt et al., 2024). Pemimpin keperawatan bertanggung jawab dalam menciptakan budaya organisasi yang mendukung penggunaan evidence dalam praktik sehari-hari (Schein, 2017). Selain itu, kolaborasi tim multidisiplin sangat penting untuk mengintegrasikan berbagai perspektif dan keahlian dalam proses pengambilan keputusan (WHO, 2025). Kerja sama tim yang efektif memungkinkan identifikasi masalah yang lebih komprehensif serta pengembangan solusi yang lebih inovatif dan tepat sasaran (Montgomery et al.,

2023). Dengan demikian, kepemimpinan yang kuat dan kolaborasi tim yang baik menjadi faktor kunci dalam keberhasilan implementasi evidence-based decision making (Shanafelt et al., 2024).

4. Penentuan solusi prioritas

   Penentuan solusi prioritas merupakan tahap penting dalam pengambilan keputusan manajerial yang bertujuan untuk memilih intervensi yang paling efektif dan efisien dalam mengatasi masalah (WHO, 2025). Proses ini melibatkan analisis berbagai alternatif solusi berdasarkan kriteria seperti dampak, urgensi, dan kelayakan implementasi (Montgomery et al., 2023). Solusi yang diprioritaskan adalah intervensi yang memiliki potensi dampak terbesar terhadap peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien (Shanafelt et al., 2024). Selain itu, pertimbangan terhadap sumber daya dan konteks organisasi menjadi faktor penting dalam menentukan solusi yang realistis dan berkelanjutan (Schein, 2017). Oleh karena itu, penentuan solusi prioritas memastikan bahwa intervensi yang dipilih dapat memberikan hasil optimal dalam program peningkatan mutu pelayanan kesehatan (WHO, 2025).

F. Perumusan Alternatif Solusi

1. Prinsip solusi:
   a. Realistis

      Prinsip realistis dalam perumusan solusi menekankan bahwa setiap alternatif yang dikembangkan harus dapat dilaksanakan sesuai dengan kondisi sumber daya yang tersedia dalam organisasi (WHO, 2025). Solusi yang realistis mempertimbangkan keterbatasan tenaga, waktu, biaya, serta kapasitas sistem pelayanan kesehatan yang ada (Montgomery et al., 2023). Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa intervensi yang dirancang tidak hanya ideal secara konsep, tetapi juga dapat diimplementasikan secara nyata di lapangan (Shanafelt et al., 2024). Dengan demikian, prinsip realistis menjadi kunci dalam meningkatkan keberhasilan implementasi program peningkatan mutu (WHO, 2025).

   b. Kontekstual

      Prinsip kontekstual menekankan bahwa solusi harus disesuaikan dengan kondisi spesifik organisasi, termasuk budaya kerja, kebijakan, serta karakteristik pasien dan tenaga kesehatan (Schein, 2017). Setiap organisasi pelayanan kesehatan memiliki dinamika yang berbeda sehingga solusi yang efektif di satu tempat belum tentu dapat diterapkan secara langsung di tempat lain (WHO, 2025). Pendekatan kontekstual membantu memastikan bahwa solusi yang

dipilih relevan dengan kebutuhan lokal dan dapat diterima oleh seluruh pemangku kepentingan (Montgomery et al., 2023). Oleh karena itu, mempertimbangkan konteks organisasi merupakan faktor penting dalam keberhasilan implementasi perubahan (Shanafelt et al., 2024).

c. Berbasis eviden

Prinsip berbasis eviden mengharuskan bahwa setiap solusi yang dirumuskan didasarkan pada bukti ilmiah terbaik yang tersedia serta data aktual dari pelayanan kesehatan (Melnyk & Fineout-Overholt, 2023). Pendekatan ini memastikan bahwa intervensi yang dipilih telah terbukti efektif dan aman dalam meningkatkan kualitas pelayanan (Brownson et al., 2018). Penggunaan evidence juga membantu mengurangi risiko kegagalan intervensi serta meningkatkan kepercayaan terhadap keputusan yang diambil (WHO, 2025). Dengan demikian, solusi berbasis eviden menjadi fondasi utama dalam praktik manajemen keperawatan modern (Shanafelt et al., 2024).

2. Penyusunan beberapa alternatif solusi

Penyusunan alternatif solusi merupakan proses pengembangan berbagai pilihan intervensi yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah yang telah diidentifikasi (Guo, 2008). Tahap ini melibatkan proses berpikir kreatif dan analitis untuk menghasilkan lebih dari satu solusi yang memungkinkan (Montgomery et al., 2023). Pengembangan beberapa alternatif solusi penting untuk memberikan fleksibilitas dalam pengambilan keputusan serta menghindari ketergantungan pada satu pendekatan saja (WHO, 2025). Selain itu, alternatif solusi yang beragam memungkinkan organisasi untuk membandingkan efektivitas, efisiensi, dan risiko dari setiap pilihan yang tersedia (Shanafelt et al., 2024). Oleh karena itu, tahap ini menjadi bagian penting dalam proses pengambilan keputusan yang rasional dan sistematis (Guo, 2008).

3. Pemilihan solusi terbaik

Pemilihan solusi terbaik merupakan tahap akhir dalam perumusan alternatif solusi yang bertujuan untuk menentukan intervensi paling efektif berdasarkan kriteria tertentu (WHO, 2025). Proses ini melibatkan evaluasi setiap alternatif solusi berdasarkan aspek dampak, urgensi, dan kelayakan implementasi (Montgomery et al., 2023). Solusi yang dipilih adalah yang memberikan manfaat terbesar terhadap peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien dengan risiko yang minimal (Shanafelt et al., 2024). Selain itu, pemilihan solusi juga mempertimbangkan kesesuaian dengan konteks organisasi dan ketersediaan sumber daya (Schein, 2017). Dengan demikian, pemilihan solusi terbaik memastikan bahwa keputusan yang diambil bersifat optimal, rasional, dan dapat

diimplementasikan secara berkelanjutan dalam praktik pelayanan kesehatan (WHO, 2025)

G. Proyek Mini Peningkatan Mutu (S7.2)

1. Konsep proyek mini berbasis data

   Proyek mini peningkatan mutu berbasis data merupakan kegiatan perbaikan pelayanan kesehatan dalam skala kecil yang menggunakan data sebagai dasar utama dalam setiap tahap perencanaan dan implementasi (Puri et al., 2023). Pendekatan ini menekankan bahwa setiap intervensi harus didasarkan pada masalah yang teridentifikasi melalui analisis data yang objektif dan terukur (Mahoney, 2024). Proyek mini dirancang untuk memungkinkan pengujian perubahan secara bertahap dan sistematis sehingga meminimalkan risiko serta meningkatkan peluang keberhasilan implementasi (Health Service Executive, 2024). Selain itu, pendekatan berbasis data memungkinkan evaluasi yang lebih akurat terhadap dampak intervensi terhadap mutu pelayanan dan keselamatan pasien (Puri et al., 2023). Oleh karena itu, proyek mini berbasis data menjadi strategi efektif dalam mendukung *continuous quality improvement* di fasilitas pelayanan kesehatan (Endalamaw et al., 2024).
2. Komponen proyek mutu:
   a. Masalah prioritas

      Masalah prioritas dalam proyek mutu merupakan isu utama yang dipilih berdasarkan analisis data dan memiliki dampak signifikan terhadap kualitas pelayanan kesehatan (Health Service Executive, 2024). Penentuan masalah prioritas dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat risiko, frekuensi kejadian, serta dampaknya terhadap keselamatan pasien dan efisiensi pelayanan (Mahoney, 2024). Masalah yang dipilih harus spesifik, terukur, dan relevan dengan kebutuhan organisasi agar intervensi yang dirancang dapat memberikan hasil yang optimal (Puri et al., 2023). Selain itu, fokus pada satu masalah prioritas membantu tim dalam mengarahkan sumber daya secara efektif dan meningkatkan keberhasilan proyek mutu (Health Service Executive, 2024).

   b. Tujuan

      Tujuan dalam proyek mutu merupakan pernyataan yang menggambarkan hasil yang ingin dicapai melalui intervensi yang direncanakan (Puri et al., 2023). Tujuan harus dirumuskan secara spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu (*SMART*) untuk memastikan kejelasan arah proyek (Puri et al., 2023). Perumusan tujuan yang jelas membantu tim

dalam memfokuskan upaya perbaikan serta memudahkan proses evaluasi keberhasilan intervensi (Mahoney, 2024). Selain itu, tujuan yang terdefinisi dengan baik menjadi dasar dalam menentukan indikator dan strategi implementasi proyek mutu (Health Service Executive, 2024).

c. Intervensi

Intervensi dalam proyek mutu merupakan tindakan atau perubahan yang dirancang untuk mengatasi masalah yang telah diidentifikasi (Puri et al., 2023). Intervensi biasanya dikembangkan berdasarkan evidence ilmiah, pengalaman praktik, serta analisis konteks organisasi untuk memastikan efektivitasnya (Mahoney, 2024). Dalam implementasinya, intervensi diuji melalui siklus *Plan-Do-Study-Act (PDSA)* untuk mengevaluasi dampak dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan (Health Service Executive, 2024). Pendekatan ini memungkinkan perubahan dilakukan secara bertahap dan terkontrol sehingga meningkatkan keberhasilan implementasi (Puri et al., 2023).

3. Indikator proyek:

a. Baseline

Baseline merupakan data awal yang digunakan sebagai titik acuan untuk menilai kondisi sebelum dilakukan intervensi dalam proyek mutu (Johns Hopkins, 2023). Data baseline penting untuk memahami tingkat masalah yang ada serta menentukan kebutuhan intervensi yang tepat (NHS Improvement, 2014). Selain itu, baseline digunakan sebagai pembanding untuk mengevaluasi perubahan yang terjadi setelah implementasi intervensi (Johns Hopkins, 2023). Oleh karena itu, pengumpulan data baseline yang akurat menjadi langkah penting dalam memastikan validitas hasil proyek mutu (NHS Improvement, 2014).

b. Target

Target merupakan standar atau capaian yang ingin diraih dalam proyek mutu sebagai hasil dari intervensi yang dilakukan (Puri et al., 2023). Penentuan target harus realistis, terukur, dan selaras dengan tujuan proyek agar dapat dicapai dalam waktu yang telah ditentukan (Health Service Executive, 2024). Target berfungsi sebagai tolok ukur keberhasilan intervensi serta sebagai motivasi bagi tim dalam melaksanakan proyek mutu (Mahoney, 2024). Selain itu, target yang jelas memudahkan proses monitoring dan evaluasi selama pelaksanaan proyek (Puri et al., 2023).

c. Outcome

Outcome merupakan hasil akhir yang menunjukkan dampak dari intervensi terhadap kualitas pelayanan dan keselamatan pasien (Puri et al., 2023). Outcome digunakan untuk menilai efektivitas intervensi serta

menentukan apakah tujuan proyek telah tercapai (Johns Hopkins, 2023). Dalam proyek mutu, outcome dapat berupa perubahan indikator klinis, peningkatan keselamatan pasien, atau peningkatan efisiensi pelayanan (Mahoney, 2024). Oleh karena itu, pengukuran outcome menjadi komponen penting dalam evaluasi keberhasilan dan keberlanjutan proyek peningkatan mutu (Endalamaw et al., 2024).

H. Metode Peningkatan Mutu: PDSA Cycle

1. Plan:

   Tahap *Plan* merupakan fase awal dalam siklus peningkatan mutu yang berfokus pada identifikasi masalah secara sistematis menggunakan data yang tersedia (Taylor et al., 2023). Identifikasi masalah dilakukan untuk memastikan bahwa isu yang diangkat bersifat nyata, terukur, dan relevan dengan kebutuhan pelayanan kesehatan (WHO, 2025). Selain itu, pada tahap ini ditetapkan tujuan yang harus memenuhi kriteria *SMART* (*specific, measurable, achievable, relevant, time-bound*) agar arah perbaikan menjadi jelas dan terukur (Doran, 1981; Puri et al., 2023). Perencanaan intervensi kemudian disusun berdasarkan analisis masalah dan evidence yang tersedia untuk memastikan efektivitas tindakan yang akan dilakukan (Melnyk & Fineout-Overholt, 2023). Dengan demikian, tahap *Plan* menjadi fondasi penting dalam memastikan keberhasilan seluruh siklus peningkatan mutu (Taylor et al., 2023).
2. Do:

   Tahap *Do* merupakan fase implementasi dari intervensi yang telah direncanakan dalam skala terbatas atau uji coba awal (Taylor et al., 2023). Implementasi terbatas bertujuan untuk mengurangi risiko serta memungkinkan penyesuaian sebelum diterapkan secara luas dalam sistem pelayanan (WHO, 2025). Selama proses pelaksanaan, dokumentasi dilakukan secara sistematis untuk mencatat setiap langkah, perubahan, serta kendala yang terjadi (Puri et al., 2023). Dokumentasi ini penting untuk memastikan bahwa proses dapat dievaluasi secara objektif pada tahap berikutnya (Montgomery et al., 2023). Oleh karena itu, tahap *Do* berperan dalam menguji kelayakan intervensi dalam kondisi nyata pelayanan kesehatan (Taylor et al., 2023).
3. Study:

   Tahap *Study* merupakan fase evaluasi yang bertujuan untuk menilai hasil dari implementasi intervensi berdasarkan data yang telah dikumpulkan (Taylor et al., 2023). Evaluasi hasil dilakukan dengan membandingkan data sebelum dan sesudah intervensi untuk mengetahui tingkat keberhasilan perubahan yang

dilakukan (Puri et al., 2023). Analisis data pada tahap ini membantu dalam mengidentifikasi apakah intervensi memberikan dampak yang diharapkan atau memerlukan penyesuaian lebih lanjut (Montgomery et al., 2023). Selain itu, interpretasi hasil evaluasi menjadi dasar dalam menentukan langkah selanjutnya dalam siklus peningkatan mutu (WHO, 2025). Dengan demikian, tahap *Study* memastikan bahwa keputusan yang diambil berbasis pada data dan evidence yang valid (Taylor et al., 2023).

4. Act:

   Tahap *Act* merupakan fase tindak lanjut yang bertujuan untuk melakukan perbaikan atau penyesuaian terhadap intervensi berdasarkan hasil evaluasi (Taylor et al., 2023). Jika intervensi terbukti efektif, maka langkah selanjutnya adalah melakukan standarisasi agar praktik tersebut dapat diterapkan secara konsisten dalam pelayanan (WHO, 2025). Sebaliknya, jika hasil belum optimal, maka dilakukan modifikasi atau perbaikan intervensi sebelum diuji kembali dalam siklus berikutnya (Puri et al., 2023). Proses standarisasi penting untuk memastikan keberlanjutan perubahan dan integrasi ke dalam sistem pelayanan kesehatan (Montgomery et al., 2023). Oleh karena itu, tahap *Act* menjadi kunci dalam memastikan bahwa perbaikan mutu bersifat berkelanjutan dan berdampak jangka panjang (Taylor et al., 2023).

I. Evaluasi dan Monitoring Mutu

1. Audit keperawatan

   Audit keperawatan merupakan proses evaluasi sistematis terhadap kualitas asuhan keperawatan yang dilakukan dengan membandingkan praktik yang berlangsung dengan standar yang telah ditetapkan (Nursalam, 2015). Audit ini bertujuan untuk menilai kesesuaian dokumentasi, tindakan, serta hasil asuhan keperawatan dengan pedoman profesional dan standar pelayanan (Marquis & Huston, 2021). Melalui audit keperawatan, organisasi dapat mengidentifikasi kesenjangan antara praktik aktual dan standar sehingga dapat dilakukan perbaikan yang tepat (WHO, 2025). Selain itu, audit keperawatan juga berfungsi sebagai alat pengendalian mutu dan peningkatan kinerja tenaga keperawatan secara berkelanjutan (Montgomery et al., 2023). Oleh karena itu, audit keperawatan menjadi komponen penting dalam sistem manajemen mutu pelayanan kesehatan (Nursalam, 2015).

2. Monitoring indikator mutu

   Monitoring indikator mutu merupakan proses pengumpulan dan analisis data secara berkelanjutan untuk menilai kinerja pelayanan kesehatan berdasarkan

indikator yang telah ditetapkan (WHO, 2025). Indikator mutu seperti BOR, LOS, dan insiden keselamatan pasien digunakan untuk menggambarkan efisiensi, efektivitas, dan keselamatan pelayanan (Montgomery et al., 2023). Proses monitoring memungkinkan deteksi dini terhadap penyimpangan atau penurunan kualitas pelayanan sehingga dapat segera dilakukan tindakan perbaikan (Shanafelt et al., 2024). Selain itu, monitoring indikator mutu membantu organisasi dalam mengevaluasi keberhasilan intervensi yang telah dilakukan (Puri et al., 2023). Dengan demikian, monitoring indikator mutu menjadi bagian penting dalam siklus *continuous quality improvement* (WHO, 2025).

3. Evaluasi berbasis data (pre–post)

   Evaluasi berbasis data *pre–post* merupakan metode penilaian yang dilakukan dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah intervensi untuk mengukur efektivitas perubahan yang dilakukan (Harris et al., 2006). Pendekatan ini memungkinkan pengukuran dampak intervensi secara objektif dengan menggunakan data kuantitatif yang terstandar (Montgomery et al., 2023). Evaluasi *pre–post* membantu dalam mengidentifikasi apakah intervensi yang diterapkan memberikan perubahan yang signifikan terhadap indikator mutu atau outcome pasien (WHO, 2025). Selain itu, metode ini mendukung pengambilan keputusan berbasis evidence karena hasil evaluasi dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan keberlanjutan intervensi (Shanafelt et al., 2024). Oleh karena itu, evaluasi berbasis data *pre–post* menjadi pendekatan penting dalam penelitian dan praktik peningkatan mutu pelayanan kesehatan (Harris et al., 2006).

4. Interpretasi hasil

   Interpretasi hasil merupakan proses memahami dan memberikan makna terhadap data yang telah dianalisis untuk mendukung pengambilan keputusan (Tandon et al., 2025). Proses ini melibatkan penilaian terhadap apakah hasil yang diperoleh sesuai dengan tujuan dan target yang telah ditetapkan (Montgomery et al., 2023). Interpretasi yang tepat memungkinkan identifikasi keberhasilan maupun kelemahan intervensi yang telah dilakukan (WHO, 2025). Selain itu, interpretasi hasil membantu dalam merumuskan rekomendasi perbaikan serta strategi lanjutan dalam peningkatan mutu pelayanan (Shanafelt et al., 2024). Dengan demikian, interpretasi hasil menjadi tahap akhir yang krusial dalam memastikan bahwa data yang dihasilkan dapat digunakan secara optimal dalam praktik manajerial berbasis evidence (Tandon et al., 2025).

J. Integrasi Patient Safety dan Manajemen Risiko

1. Konsep keselamatan pasien

   Keselamatan pasien merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk mencegah terjadinya cedera atau harm pada pasien selama proses pelayanan kesehatan (WHO, 2025). Konsep ini menekankan identifikasi, pelaporan, dan pembelajaran dari insiden keselamatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan (Agency for Healthcare Research and Quality, 2023). Keselamatan pasien mencakup upaya sistematis dalam mengurangi risiko kesalahan medis melalui penerapan standar dan prosedur yang tepat (Joint Commission International, 2024). Selain itu, budaya keselamatan (*safety culture*) menjadi elemen penting dalam mendukung praktik pelayanan yang aman dan berkualitas (Pronovost et al., 2023). Oleh karena itu, keselamatan pasien menjadi prioritas utama dalam sistem pelayanan kesehatan modern yang berorientasi pada mutu (WHO, 2025).

2. Manajemen risiko klinis

   Manajemen risiko klinis merupakan proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko yang dapat mempengaruhi keselamatan pasien dan kualitas pelayanan (ISO, 2019). Pendekatan ini melibatkan identifikasi potensi bahaya serta evaluasi tingkat risiko untuk menentukan strategi mitigasi yang tepat (WHO, 2025). Manajemen risiko klinis bertujuan untuk meminimalkan kejadian tidak diharapkan serta meningkatkan keamanan dalam proses pelayanan kesehatan (Vincent & Amalberti, 2016). Selain itu, implementasi manajemen risiko yang efektif membutuhkan keterlibatan seluruh tenaga kesehatan dalam pelaporan dan pembelajaran dari insiden (Pronovost et al., 2023). Dengan demikian, manajemen risiko klinis menjadi komponen penting dalam mendukung sistem keselamatan pasien yang berkelanjutan (WHO, 2025).

3. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)

   Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) merupakan upaya sistematis untuk mencegah dan mengurangi risiko penularan infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan (WHO, 2024). Program PPI mencakup penerapan praktik seperti kebersihan tangan, penggunaan alat pelindung diri, serta sterilisasi peralatan medis (Centers for Disease Control and Prevention, 2023). PPI bertujuan untuk melindungi pasien, tenaga kesehatan, dan lingkungan dari risiko infeksi yang dapat terjadi selama pelayanan (WHO, 2024). Selain itu, implementasi PPI yang efektif terbukti mampu menurunkan angka infeksi nosokomial dan meningkatkan keselamatan pasien (Allegranzi et al., 2023). Oleh karena itu, PPI menjadi bagian

integral dalam sistem manajemen mutu dan keselamatan pasien di rumah sakit (WHO, 2024).

4. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

   Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) merupakan upaya untuk melindungi tenaga kerja dari risiko cedera dan penyakit akibat kerja di lingkungan pelayanan kesehatan (International Labour Organization, 2023). K3 bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif bagi tenaga kesehatan (WHO, 2025). Program K3 mencakup identifikasi bahaya, penilaian risiko, serta penerapan langkah-langkah pencegahan untuk mengurangi potensi kecelakaan kerja (ISO, 2018). Selain itu, penerapan K3 yang baik berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan karena tenaga kesehatan dapat bekerja secara optimal tanpa risiko yang tinggi (International Labour Organization, 2023). Dengan demikian, K3 menjadi komponen penting dalam mendukung keselamatan tenaga kesehatan sekaligus keselamatan pasien dalam sistem pelayanan kesehatan (WHO, 2025).

K. Implementasi dalam Praktik dan Pendidikan

1. Penerapan di unit pelayanan keperawatan

   Implementasi peningkatan mutu dalam unit pelayanan keperawatan merupakan proses penerapan konsep manajemen mutu dan keselamatan pasien dalam praktik sehari-hari pelayanan klinis (WHO, 2025). Penerapan ini melibatkan penggunaan data indikator mutu, audit keperawatan, serta evaluasi berbasis evidence untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan (Montgomery et al., 2023). Selain itu, perawat sebagai pelaksana utama pelayanan berperan dalam mengidentifikasi masalah, merancang intervensi, serta melakukan evaluasi terhadap hasil pelayanan (Shanafelt et al., 2024). Integrasi praktik peningkatan mutu di unit pelayanan juga membutuhkan dukungan kepemimpinan dan sistem organisasi yang kondusif (Schein, 2017). Dengan demikian, implementasi di unit pelayanan keperawatan menjadi kunci dalam memastikan keberhasilan program peningkatan mutu secara berkelanjutan (WHO, 2025).

2. Peran mahasiswa dalam proyek mutu

   Mahasiswa keperawatan memiliki peran penting dalam proyek peningkatan mutu sebagai bagian dari proses pembelajaran berbasis praktik (*practice-based learning*) (Benner et al., 2010). Keterlibatan mahasiswa dalam proyek mutu memungkinkan mereka untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan pengambilan keputusan berbasis data (Melnyk & Fineout-Overholt, 2023). Selain itu, mahasiswa dapat berperan dalam pengumpulan data, analisis

masalah, serta implementasi intervensi sederhana di bawah supervisi pembimbing klinik (WHO, 2025). Pengalaman ini membantu mahasiswa memahami secara langsung dinamika sistem pelayanan kesehatan dan tantangan dalam peningkatan mutu (Montgomery et al., 2023). Oleh karena itu, keterlibatan mahasiswa dalam proyek mutu menjadi strategi efektif dalam membentuk kompetensi profesional dan kesiapan kerja di bidang keperawatan (Shanafelt et al., 2024).

3. Integrasi dalam pembelajaran Ners

   Integrasi konsep peningkatan mutu dalam pembelajaran Ners merupakan upaya untuk mempersiapkan lulusan yang kompeten dalam praktik keperawatan berbasis evidence (Melnyk & Fineout-Overholt, 2023). Kurikulum pendidikan Ners perlu mengakomodasi pembelajaran terkait *quality improvement*, patient safety, dan manajemen risiko sebagai bagian dari kompetensi inti perawat profesional (WHO, 2025). Pendekatan pembelajaran berbasis kasus dan proyek mutu memungkinkan mahasiswa mengaplikasikan teori ke dalam praktik nyata secara sistematis (Benner et al., 2010). Selain itu, integrasi ini mendukung pengembangan kemampuan kepemimpinan, kolaborasi tim, serta pengambilan keputusan manajerial dalam konteks klinis (Schein, 2017). Dengan demikian, integrasi peningkatan mutu dalam pembelajaran Ners menjadi strategi penting dalam menghasilkan perawat yang adaptif, kompeten, dan siap menghadapi tantangan sistem pelayanan kesehatan modern (Shanafelt et al., 2024).

A. Asesmen

1. Mini Case

Judul Kasus:

Peningkatan Kejadian Pasien Jatuh di Ruang Rawat Inap

Narasi Kasus:

Dalam tiga bulan terakhir, ruang rawat inap RS Y mengalami peningkatan kejadian pasien jatuh. Kepala ruangan melaporkan bahwa beberapa perawat merasa kelelahan akibat beban kerja yang tinggi dan kurangnya supervisi. Selain itu, kepatuhan terhadap prosedur keselamatan pasien belum optimal, terutama dalam penggunaan alat bantu dan pengawasan pasien risiko tinggi. Manajemen rumah sakit meminta dilakukan analisis masalah dan penyusunan rencana peningkatan mutu berbasis data.

Data Layanan:

a. *Bed Occupancy Rate (BOR)*: 88%
b. *Length of Stay (LOS)*: meningkat dari 4 hari menjadi 7 hari
c. *Kejadian Tidak Diharapkan (KTD)*: 6 kasus pasien jatuh
d. *Kejadian Nyaris Cedera (KNC)*: 8 kasus
e. Kepatuhan hand hygiene: 55%
f. Dokumentasi keperawatan tidak lengkap: 50%
g. Rasio perawat : pasien = 1 : 11

Pertanyaan Analisis:

1. Identifikasi masalah utama berdasarkan data pada kasus di atas
2. Lakukan analisis penyebab masalah menggunakan pendekatan Fishbone atau Root Cause Analysis (RCA)
3. Tentukan satu masalah prioritas menggunakan kriteria *impact, urgency,* dan *feasibility*
4. Rancang satu solusi berbasis evidence untuk mengatasi masalah tersebut
5. Susun rencana proyek mini menggunakan pendekatan *Plan-Do-Study-Act (PDSA)*
6. Tentukan indikator evaluasi yang meliputi baseline, target, dan outcome

Kunci Jawaban Mini Case

2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan data kasus, masalah utama yang dapat diidentifikasi adalah:

1. Terjadinya peningkatan *Kejadian Tidak Diharapkan (KTD)* berupa pasien jatuh (6 kasus) → masalah keselamatan pasien
2. *Length of Stay (LOS)* meningkat → menunjukkan penurunan efisiensi pelayanan
3. Kepatuhan hand hygiene rendah (55%) → risiko infeksi meningkat

4. Dokumentasi keperawatan tidak lengkap (50%) → masalah mutu asuhan
5. Rasio perawat : pasien tinggi (1 : 11) → beban kerja meningkat
6. Keluhan kelelahan dan kurangnya supervisi → masalah manajemen SDM

Kesimpulan: Masalah utama berkaitan dengan keselamatan pasien, mutu pelayanan, dan beban kerja perawat.

3. Analisis Penyebab Masalah (Fishbone / RCA)

Man (SDM):

a. Beban kerja tinggi
b. Kelelahan perawat
c. Kurangnya kesadaran patient safety

Method (Metode):

a. SOP keselamatan pasien tidak diterapkan optimal
b. Pengkajian risiko jatuh tidak konsisten

Material:

a. Alat bantu pasien terbatas
b. Dokumentasi tidak optimal

Environment:

a. BOR tinggi → ruangan padat
b. Pengawasan pasien kurang optimal

Management:

a. Supervisi kepala ruangan kurang
b. Monitoring mutu tidak rutin

Root Cause Utama:

Beban kerja tinggi + kurangnya supervisi → penurunan kepatuhan terhadap patient safety → peningkatan pasien jatuh

4. Penentuan Prioritas Masalah

Masalah prioritas:

Peningkatan kejadian pasien jatuh (KTD)

Analisis:

Kriteria	Penilaian
Impact	Tinggi (berisiko cedera/kematian)
Urgency	Tinggi (harus segera ditangani)
Feasibility	Sedang–tinggi

Kesimpulan: Masalah keselamatan pasien menjadi prioritas utama

5. Perumusan Solusi

Alternatif solusi:

1. Edukasi patient safety kepada perawat
2. Implementasi checklist risiko jatuh
3. Peningkatan supervisi kepala ruangan
4. Penataan beban kerja

Solusi terbaik:

Implementasi program pencegahan pasien jatuh berbasis checklist + supervisi rutin

Alasan:

a. Berdampak langsung pada keselamatan pasien
b. Mudah diterapkan
c. Berbasis evidence
d. Dapat dimonitor

6. Rencana Proyek Mini (PDSA)

Plan

a. **Masalah:** Tingginya kejadian pasien jatuh
b. **Tujuan (SMART):**
c. Menurunkan kejadian pasien jatuh sebesar 50% dalam 1 bulan
d. **Intervensi:**
   - Edukasi perawat
   - Checklist risiko jatuh
   - Supervisi harian

Do

a. Implementasi di satu ruangan
b. Edukasi selama 1 minggu
c. Monitoring harian

Study

a. Evaluasi *pre–post*
b. Contoh hasil:
   - Sebelum: 6 kasus
   - Sesudah: 2–3 kasus

Terjadi penurunan signifikan

ACT

a. Jika berhasil → standarisasi
b. Jika belum → perbaikan intervensi

7. Indikator Evaluasi

Baseline

a. KTD pasien jatuh: 6 kasus
b. Kepatuhan hand hygiene: 55%

Target
Penurunan KTD ≥ 50%
Kepatuhan ≥ 80%
Outcome
Penurunan kejadian pasien jatuh
Peningkatan keselamatan pasien
Peningkatan kepatuhan SOP
Kesimpulan Model Jawaban

Masalah utama adalah keselamatan pasien akibat beban kerja tinggi dan kurangnya supervisi. Pendekatan berbasis data dan PDSA terbukti efektif dalam menurunkan kejadian pasien jatuh serta meningkatkan mutu pelayanan secara berkelanjutan.

8. **DOPS (Direct Observation of Procedural Skills)**

Judul:
Observasi Analisis Masalah Mutu dan Implementasi Intervensi Peningkatan Mutu Berbasis Data
Tujuan DOPS
Mahasiswa mampu:
1. Mengidentifikasi masalah mutu berbasis data
2. Melakukan analisis penyebab masalah
3. Menentukan prioritas masalah
4. Menyusun dan mengimplementasikan intervensi sederhana
5. Menunjukkan perhatian terhadap keselamatan pasien

Deskripsi Kegiatan
Mahasiswa melakukan observasi dan praktik langsung di unit pelayanan keperawatan (atau simulasi kelas) dengan fokus pada:
1. Analisis masalah mutu
2. Penggunaan data layanan
3. Implementasi intervensi sederhana (misal: hand hygiene audit / checklist patient safety)

Waktu: 10–15 menit / mahasiswa
Instruksi untuk Mahasiswa
Lakukan langkah berikut secara langsung (diamati oleh dosen):
1. Mengidentifikasi masalah mutu berdasarkan data
2. Menjelaskan penyebab utama masalah
3. Menentukan prioritas masalah

4. Menjelaskan intervensi yang akan dilakukan
5. Menunjukkan langkah implementasi sederhana
6. Menjelaskan aspek keselamatan pasien

L. Ringkasan

Bab ini membahas secara komprehensif konsep studi kasus manajerial dan proyek mini peningkatan mutu sebagai pendekatan strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan berbasis data. Studi kasus manajerial dipahami sebagai metode analisis sistematis yang berfokus pada permasalahan organisasi dan unit pelayanan dengan tujuan menghasilkan solusi berbasis fungsi manajemen dan evidence. Dalam implementasinya, analisis masalah dilakukan melalui pendekatan data-driven dengan memanfaatkan berbagai sumber data seperti indikator mutu, data keselamatan pasien, dan audit keperawatan. Proses analisis dilanjutkan dengan identifikasi penyebab masalah menggunakan berbagai metode analitis untuk memperoleh gambaran komprehensif tentang faktor penyebab.

Selanjutnya, pengambilan keputusan manajerial dilakukan dengan pendekatan pengambilan keputusan berdasarkan bukti yang mengintegrasikan data layanan, evidence ilmiah, serta konteks organisasi untuk menghasilkan keputusan yang tepat dan efektif. Perumusan alternatif solusi dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip realistis, kontekstual, dan berbasis eviden, serta melalui proses seleksi untuk menentukan solusi terbaik yang dapat diimplementasikan. Proyek mini peningkatan mutu kemudian dirancang sebagai bentuk implementasi praktis yang mencakup penentuan masalah prioritas, tujuan, intervensi, serta indikator evaluasi seperti baseline, target, dan outcome.

Pelaksanaan proyek mutu dilakukan melalui siklus Plan-Do-Study-Act (PDSA) yang memungkinkan perbaikan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Evaluasi proyek dilakukan melalui audit keperawatan, monitoring indikator mutu, serta analisis data pre-post untuk menilai efektivitas intervensi yang dilakukan. Selain itu, integrasi patient safety dan manajemen risiko menjadi komponen penting dalam memastikan bahwa setiap intervensi tidak hanya meningkatkan mutu, tetapi juga menjamin keselamatan pasien.

Dalam konteks praktik dan pendidikan, implementasi konsep ini diterapkan di unit pelayanan keperawatan serta diintegrasikan dalam proses pembelajaran mahasiswa dan pendidikan profesi Ners untuk meningkatkan kompetensi berbasis evidence. Dengan demikian, Bab ini menegaskan bahwa studi kasus manajerial dan proyek mini peningkatan mutu merupakan pendekatan yang esensial dalam membentuk perawat yang mampu berpikir kritis, mengambil keputusan berbasis

data, serta berkontribusi dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan secara berkelanjutan.

Referensi

Abt Global. (2025). *Gap analysis for health systems strengthening*. Abt Associates Inc.

Agency for Healthcare Research and Quality. (2023). *Patient safety primer*. U.S. Department of Health and Human Services.

Allegranzi, B., et al. (2023). Infection prevention and control in healthcare: A systematic review. *The Lancet Infectious Diseases*, 23(4), e123–e134.

Andersen, H. B., Fagerhaug, T., & Beltz, M. (2009). *Root cause analysis: Simplified tools and techniques* (2nd ed.). ASQ Quality Press.

Behrhorst, J. (2023). Root cause analysis in healthcare improvement initiatives. *Journal of Healthcare Quality*, 45(2), 78–85.

Bennett, C. C., Doub, T. W., & Selove, R. (2012). EHRs connect research and practice: Where predictive modeling, artificial intelligence, and clinical decision support intersect. *Health Affairs*, 31(5), 962–969.

Brownson, R. C., Fielding, J. E., & Green, L. W. (2018). Building capacity for evidence-based public health. *Annual Review of Public Health*, 39, 27–53.

Centers for Medicare & Medicaid Services. (2026). *Quality improvement framework*. CMS.gov.

Centers for Disease Control and Prevention. (2023). *Guideline for infection prevention and control in healthcare settings*. CDC.

Craven, R. F., & Hirnle, C. J. (2000). *Fundamentals of nursing: Human health and function* (3rd ed.). Lippincott Williams & Wilkins.

Davies, H., Nutley, S., & Mannion, R. (2025). Organizational culture and patient safety improvement. *BMJ Quality & Safety*, 34(1), 12–20.

Deming, W. E. (1986). *Out of the crisis*. MIT Press.

Depkes RI. (1993). *Pedoman dokumentasi keperawatan*. Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

Endalamaw, A., et al. (2024). Implementation of quality improvement interventions in healthcare: A systematic review. *BMC Health Services Research*, 24(1), 112.

Farahdila, F. (2025). Patient safety incident reporting systems in hospitals. *Journal of Patient Safety*, 21(2), 145–152.

Flyvbjerg, B. (2013). Case study research. *The Sage Handbook of Qualitative Research* (4th ed.). Sage Publications.

Förstel, M., et al. (2024). Healthcare data analytics and decision-making systems. *Journal of Medical Systems*, 48(3), 45–59.

Guo, K. L. (2008). *Decision making and problem solving in healthcare management*. Jones & Bartlett Learning.

Gürel, E., & Tat, M. (2017). SWOT analysis: A theoretical review. *The Journal of International Social Research*, 10(51), 994–1006.

Health Service Executive. (2024). *Quality improvement toolkit*. HSE Ireland.

Helms, M. M., & Nixon, J. (2010). Exploring SWOT analysis – Where are we now? *Journal of Strategy and Management*, 3(3), 215–251.
IntelyCare. (2025). *Quality improvement in nursing practice*. IntelyCare Publications.
International Organization for Standardization. (2018). *ISO 45001: Occupational health and safety management systems*. ISO.
International Organization for Standardization. (2019). *ISO 31000: Risk management guidelines*. ISO.
Johns Hopkins Medicine. (2024). Quality improvement methods and tools. Johns Hopkins University.
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2017). *Pedoman keselamatan pasien rumah sakit*. Kemenkes RI.
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Indikator mutu pelayanan kesehatan*. Kemenkes RI.
Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit. (2024). *Pedoman pelaporan insiden keselamatan pasien*. KKPRS.
Kumah, E. (2024). Application of fishbone diagram in healthcare quality improvement. *International Journal of Health Planning and Management*, 39(2), 345–356.
Mahoney, J. (2024). Healthcare quality improvement strategies: A practical approach. *Journal of Healthcare Management*, 69(1), 25–37.
Marquis, B. L., & Huston, C. J. (2000). *Leadership roles and management functions in nursing* (4th ed.). Lippincott Williams & Wilkins.
Melnyk, B. M., & Fineout-Overholt, E. (2023). *Evidence-based practice in nursing and healthcare* (5th ed.). Wolters Kluwer.
Montgomery, A., et al. (2023). Workload, burnout, and healthcare system performance. *The Lancet*, 402(10405), 1234–1245.
Nevada State University. (2024). *Quality improvement in nursing education*. Nevada State Press.
Nursalam. (2014). *Manajemen keperawatan: Aplikasi dalam praktik keperawatan profesional*. Salemba Medika.
Nursalam. (2015). *Manajemen keperawatan* (5th ed.). Salemba Medika.
O'Donnell, A., & Gupta, S. (2023). Continuous quality improvement in healthcare systems. *International Journal for Quality in Health Care*, 35(1), mzad012.
Patrician, P. A., et al. (2024). Nursing contributions to patient safety outcomes. *Journal of Nursing Administration*, 54(2), 89–96.
Public Health Foundation. (2024). *Using data for public health improvement*. PHF Press.
Puri, N., et al. (2023). Quality improvement project implementation in healthcare. *BMJ Open Quality*, 12(3), e002123.
Sackett, D. L., et al. (1996). Evidence-based medicine: What it is and what it isn't. *BMJ*, 312(7023), 71–72.
Schein, E. H. (2017). *Organizational culture and leadership* (5th ed.). Wiley.

Shanafelt, T. D., et al. (2024). Burnout and healthcare system improvement. *The Lancet*, 403(10430), 987–998.

Sowell, R. (2024). Quality improvement and patient outcomes in nursing practice. *Nursing Outlook*, 72(1), 101–110.

Sutejo, et al. (2021). Workload analysis in nursing practice. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 24(3), 145–152.

Swanburg, R. C. (2001). *Introduction to nursing administration* (4th ed.). Jones & Bartlett Learning.

Tagaram, P. (2024). Fishbone analysis in healthcare quality improvement. *International Journal of Quality & Reliability Management*, 41(2), 456–470.

Tandon, A., et al. (2025). Healthcare data interpretation for decision-making. *Health Policy and Technology*, 14(1), 100789.

Warmadewa Hospital. (2025). *Hospital performance indicators report*. Warmadewa Hospital.

Wahyuningsih, S. (2025). *Manajemen keperawatan berbasis mutu*. Penerbit Deepublish.

World Health Organization. (2023). *Quality of care indicators*. WHO Press.

World Health Organization. (2024). *Infection prevention and control*. WHO Press.

World Health Organization. (2025). *Global patient safety action plan*. WHO Press.

Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Sage Publications.

Profil Penulis



Dr. Aemilianus Mau., S.Kep., Ns., M.Kep.

Penulis yang akrab dipanggil Willy ini lahir di Malaka-NTT, 27 Mei 1972. Memiliki Riwayat Pendidikan: Akper PEMDA Kupang, tamat tahun 1996, Ners Unair tamat tahun 2004, S2 Keperawatan Unair, tamat tahun 2010, S3 Keperawatan UI, tamat tahun 2023. Penulis sebagai staf dosen tetap pada Program Studi Pendidikan Profesi Ners Poltekkes Kemenkes Kupang. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai pengajar, penulis buku, publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, aktif mengikuti seminar, pertemuan nasional/internasional. Riwayat organisasi: sebagai Ketua DPW PPNI Provinsi NTT, Anggota Bidang Diklat DPP PPNI, Anggota Kolegium Keperawatan Indonesia.
Email Penulis: aemilianusmau58@gmail.com



Muhammad Saefulloh, S.Kep., Ners., M.Kep.

Penulis lahir di Cilacap pada tanggal 2 Mei 1976. Penulis menyelesaikan Pendidikan Profesi Keperawatan di PSIK FK UGM tahun 2004 dan S2 Keperawatan di FIK Universitas Indonesia, tahun 2009, mengambil peminatan Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan. Karir sebagai dosen diawali pada tahun 2005, dengan diangkat sebagai Dosen PNS DPK Kopertis Wilayah 4 Jawa Barat dan Banten dan ditempatkan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Indramayu. Selama bertugas di STIKes Indramayu, penulis pernah menjabat sebagai Ketua Program Studi Sarjana Keperawatan, Profesi Ners, dan Ketua STIKes Indramayu.

Bulan Oktober 2022 penulis pindah homebase ke Prodi Sarjana Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Penulis sudah mempublikasikan beberapa hasil karya dan beberapai HaKI. Penulis juga aktif di AIPNI Regional Jawa Barat dan sebagai reviewer soal-soal uji kompetensi ners keilmuan manajemen keperawatan. Email penulis: mumet_plumbon@yahoo.co.id

Profil Penulis



Ns. Devanda Faiqh Albyn,M.Kep.,M.M(c)

seorang Occupational Health Nurse (OHN), akademisi, penulis, dan praktisi kesehatan kerja yang aktif berkontribusi dalam pengembangan edukasi dan standar keperawatan okupasi di Indonesia.

Identitas dan Riwayat Hidup

Nama lengkap: Ns. Devanda Faiqh Albyn, M.Kep., M.M©

Tempat, tanggal lahir: Pemalang, 28 Maret 1994.

Domisili: Jakarta dan Bogor, Indonesia.

Pendidikan

S1 Keperawatan & Profesi Ners: STIKES Banyuwangi (lulus 2018).

Magister Keperawatan (M.Kep.): Universitas Brawijaya, konsentrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta Human Capital Management (2023).

Magister Manajemen Konsentrasi Kesehatan (M.M©): sedang menempuh program di International Europa University (IEU) Surabaya melalui jalur scholarship.

Posisi dan Pengalaman Kerja

Clinic Operasional Manager Mining Area PT. Anitech Prima Medica,LLC.(Agustus 2026)

Occupational Health Nurse (OHN):

Bekerja di PalmCo Holding PT Perkebunan Nusantara III (Persero), Jakarta Selatan, dalam divisi Operasional SDM, khususnya pada manpower planning dan organisasi.

Memiliki pengalaman kerja di berbagai departemen keperawatan: KMB, GADAR, OHN, holistik-komplementer, mental health, K3, dan nursing informatics.

Dosen / Praktisi Mengajar: Tenaga Dosen di program S1 Keperawatan, Institut Kesehatan dan Bisnis Annisa, Kab. Bogor.

Terpilih dalam Program Praktisi Mengajar oleh Kemendikbudristek RI sebagai Dosen Praktisi.

Pengalaman profesi lain:

- Pernah menjadi tenaga pendidik PMI dan terlibat dalam paramedic event sejak masa kuliah.
- Bekerja di klinik, rumah sakit, serta lingkungan perusahaan sebelum fokus pada bidang OHN.

Organisasi dan Keanggotaan

Organisasi profesi di Indonesia:

- Ketua Umum APPOKI (Akademi Praktisi Perawat Okupasi Indonesia).

- Anggota INOSHPRO (Indonesian Network of Occupational Safety and Health Professionals).
- Anggota AHKKI (Asosiasi HIPERKES & Keselamatan Kerja Indonesia).

Sebelumnya aktif sebagai Kadept Kesejahteraan & Ventura sekaligus Sekretaris (tanpa SK) di PP PERKESJA 2022–2023.
Organisasi internasional:
Anggota AAOHN (American Association of Occupational Health Nurses).
Anggota IFERP (Institute for Educational Research and Publication).

Platform dan Inisiatif Edukasi
Founder @ohnurseedu, platform digital pertama di Indonesia yang fokus pada edukasi Occupational Health Nursing / perawat okupasi / perawat industri.

Aktif menulis artikel dan berbagi pengetahuan tentang nursepreneur, edukasi OHN, dan manajemen kesehatan kerja di blog serta situs keperawatan.

Karya Tulis, Buku, dan Publikasi
Penulis dan editor buku kesehatan, termasuk:
Dasar-dasar Keperawatan: Pengantar Teori dan Praktik.
Buku dan book chapter terkait keselamatan pasien, keselamatan kesehatan kerja, kepemimpinan hijau (Green Leader), dan topikɔ.

Penulis dan editor buku nonfiksi bersertifikasi LSP PEP (sertifikasi Penulis dan Editor Profesional BNSP).
Aktif dalam publikasi jurnal serta konferensi internasional, termasuk sebagai pembicara di 3rd Nursing Global Conference (Filipina, 2025) terkait inovasi e-learning bagi OH nurses.

Sertifikasi dan Penghargaan
Sertifikasi BNSP dan profesional:
Ahli K3 Umum.
Human Capital Management / Human Capital Staff.
Penulis dan Editor Profesional (Penulisan Buku Nonfiksi) – LSP PEP.
Sertifikasi lain: HIPERKES dan Kesehatan Kerja bagi P2K3, Industrial Relation, Management Keperawatan, Leadership & Komunikasi, Vaccinator, PJK3, dan lain-lain.
Penghargaan:
Peraih penghargaan sebagai inovator berdampak bagi peningkatan SDM K3 (OHN) pada 1st OSH ASIA Summit 2024 di Sanur, Bali.

Kerelawanan dan inovasi TJSL:
Relawan Bhakti BUMN, terpilih oleh Menteri BUMN dari 9.870 karyawan BUMN aktif, dengan penempatan di komunitas Suku Baduy, Lebak, Banten.
Terpilih dalam Program Inovasi TJSL (Tanggung Jawab Sosial Lingkungan).
Bidang Keahlian dan Fokus Profesional
Occupational Health Nursing (OHN) dan keperawatan okupasi/industri.
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), HIPERKES, dan manajemen risiko kesehatan kerja.
Human Capital Management, workforce planning, dan manajemen SDM di lingkungan perusahaan.
Kesehatan mental, keperawatan holistik-komplementer, dan wellbeing–wellness program.
Pengembangan kurikulum, e-learning, dan inovasi pendidikan keperawatan.

Secara keseluruhan, Ns. Devanda Faiqh Albyn, M.Kep., M.M© merupakan figur yang menonjol dalam perkembangan Occupational Health Nursing di Indonesia, baik melalui praktik klinis, pendidikan, penulisan, maupun pengorganisasian profesi OHN nasional dan internasional.
Motto : *Life long learning*

Profil Penulis

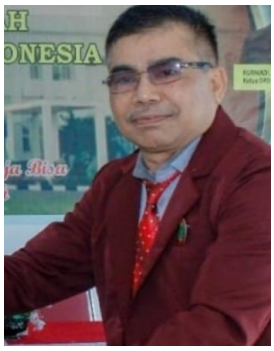


Nama : Ns. Junita Maratur Silitonga, M.Kep.
Tempat/Tanggal Lahir : P.Siantar 13,juni 1969
Riwayat Pendidikan :S2 Mangemen Keperawawatan
Memiliki pengalaman kerja sebaagai Manager dan Komite di RS Hermina ,Departemen Keperawatan dan departemen Diklat .Pengajar dan penguji manajemen keperawatan dan CI di Dep. Keperawatan Hermina Hospital Group. Dosen dan Wadir II Akper Hermina Manggala Husada dan saat ini
Dosen Institut Keshatan Hermina Diploma tiga keperawatan. (Lektor Kepala).Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi sebagai pengajar,penulis buku dan publikasi hasil penelitian,pengabdian masyarakat,aktif mengikuti seminar .Sebagai anggota Organisasi Himpunan Perawat Managemen Indonesia dan



Ns. Revi Yulia., M. Kep.
Penulis yang akrab dipanggil Revi ini lahir di padang, 16 Juli 1988. Memiliki Riwayat Pendidikan: sarjana keperawatan dan pendidikan profesi ners di sekolah tinggi ilmu kesehatan ford de kock bukittinggi, tamat tahun 2010. kemudian penulis melanjutkan pendidikan magister keperawatan dengan konsentrasi manajemen keperawatan di universitas andalas tahun 2013 dan menyelesaikan pendidikan pada tahun 2015. penulis saat ini menjadi sekretaris LPPM di Politeknik Kaltara. dan aktif mengajar dan melakuakn tridharma di program studi diploma tiga keperawatan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai pengajar, penulis buku, publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, aktif mengikuti seminar, pertemuan nasional/internasional. Riwayat organisasi: sebagai anggota organisasi Himpunan perawat manajerial indosia sampai sekarang
Email penulis: reviyulia341@gmail.com

Profil Penulis



Syaiful SKep. Ns, MPd., MKes.

lahir di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, pada 23 Mei 1968. Penulis merupakan dosen keperawatan pada Poltekkes Kemenkes Mataram dengan jabatan akademik Lektor Kepala. Penulis memiliki pengalaman panjang hampir empat dekade dalam pendidikan keperawatan, pengembangan akademik, dan pengabdian kepada masyarakat. Sejak tahun 2000, penulis mengabdi di Program Studi Keperawatan Bima yang sebelumnya berada di bawah Akper Depkes Mataram dan kini menjadi bagian dari Poltekkes Kemenkes Mataram.

Pendidikan tinggi penulis ditempuh pada Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Airlangga Surabaya dan lulus tahun 2002. Penulis kemudian menyelesaikan pendidikan magister di Universitas Adibuana Surabaya dengan gelar M.Pd. pada tahun 2009, serta memperoleh gelar M.Kes. dari Universitas Badaruddin Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, pada tahun 2023.

Dalam kegiatan akademik, penulis mengampu mata kuliah Metodologi Penelitian, Konsep Dasar Keperawatan, Manajemen Keperawatan, Keperawatan Jiwa, serta Keperawatan Keluarga dan Komunitas. Bidang minat akademik penulis berfokus pada manajemen keperawatan, keperawatan komunitas, promosi kesehatan, pemberdayaan keluarga dan masyarakat, serta penguatan peran perawat dalam pencegahan penyakit berbasis lingkungan dan perilaku.

Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, antara lain penulisan buku, publikasi ilmiah, kegiatan seminar dan workshop sebagai narasumber, serta pengabdian kepada masyarakat. Penulis dapat dihubungi melalui email: syaiful6823mpd@gmail.com.

Motto: Belajar bukan sekadar menghafal, tetapi proses memahami pengalaman secara mendalam dan menerapkannya untuk memberi manfaat bagi masyarakat.

Profil Penulis



Ns. Endra Amalia, M. Kep.
merupakan dosen Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Perintis Indonesia, Sumatera Barat, yang telah mengabdi sejak tahun 1993. Beliau pernah menjabat sebagai Ketua Program Studi Diploma III Keperawatan STIKes Perintis Padang pada periode 2006–2010 dan 2014–2020. Sejak tahun 2020 hingga saat ini, beliau menjabat sebagai Ketua Program Studi Diploma III Keperawatan Universitas Perintis Indonesia. Beliau menyelesaikan pendidikan di Akademi Keperawatan Perintis Bukittinggi (1993), Sarjana Keperawatan dan Profesi Ners di Universitas Brawijaya (2002), serta Magister Keperawatan peminatan Manajemen Keperawatan di Universitas Andalas (2012). Saat ini beliau sedang menempuh pendidikan Doctor of Philosophy (PhD) in Nursing di Lincoln University College, Malaysia.Bidang keahlian beliau meliputi Manajemen Keperawatan dan Keperawatan Dasar. Selain aktif dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, beliau juga telah menulis beberapa buku chapter dan publikasi ilmiah di bidang keperawatan. Pada tahun 2015 dan 2016, beliau memperoleh hibah penelitian dari DIKTI.

Email: amaliaendra23@gmail.com

Sinopsis

Buku Ajar *Manajemen Keperawatan* disusun sebagai sumber pembelajaran bagi mahasiswa keperawatan, dosen, praktisi, serta tenaga kesehatan yang membutuhkan pemahaman komprehensif mengenai konsep, prinsip, dan penerapan manajemen dalam pelayanan keperawatan. Buku ini membahas berbagai aspek penting dalam pengelolaan pelayanan keperawatan, mulai dari mutu pelayanan, keselamatan pasien, pengendalian infeksi, manajemen sumber daya, dokumentasi, hingga akreditasi fasilitas kesehatan.

Pembahasan dalam buku ini dirancang secara sistematis agar pembaca mampu memahami peran manajerial perawat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Setiap bab menyajikan konsep dasar, penerapan dalam praktik, serta contoh kasus yang relevan dengan kondisi pelayanan keperawatan di fasilitas kesehatan. Dengan demikian, buku ini tidak hanya memberikan landasan teori, tetapi juga mendorong kemampuan berpikir kritis, analitis, dan aplikatif dalam menghadapi permasalahan manajemen keperawatan.

Bab 1 membahas manajemen mutu pelayanan keperawatan, mencakup konsep mutu, indikator mutu, standar pelayanan, serta strategi peningkatan mutu secara berkelanjutan. Bab 2 menguraikan keselamatan pasien dan manajemen risiko klinis, termasuk identifikasi risiko, pencegahan kejadian tidak diharapkan, budaya keselamatan, dan pelaporan insiden. Bab 3 menjelaskan pengendalian infeksi dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di pelayanan keperawatan sebagai upaya menciptakan lingkungan pelayanan yang aman bagi pasien, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya.

Selanjutnya, Bab 4 membahas manajemen sumber daya dan logistik keperawatan, meliputi perencanaan kebutuhan tenaga, pengaturan jadwal kerja, pengelolaan sarana, serta pemanfaatan logistik secara efektif dan efisien. Bab 5 mengkaji manajemen dokumentasi, informatika, dan rekam medis yang berperan penting dalam kesinambungan asuhan, aspek legal, komunikasi antarprofesi, serta pengambilan keputusan berbasis data. Bab 6 membahas akreditasi fasilitas kesehatan dan standar keperawatan, termasuk pentingnya kepatuhan terhadap regulasi, standar mutu, dan evaluasi pelayanan. Bab 7 menyajikan studi kasus manajerial dan proyek mini peningkatan mutu sebagai bentuk penerapan konsep yang telah dipelajari dalam situasi nyata pelayanan keperawatan.

Melalui buku ajar ini, pembaca diharapkan mampu memahami dan menerapkan prinsip-prinsip manajemen keperawatan secara profesional, etis, dan bertanggung jawab. Buku ini juga diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan kompetensi manajerial perawat untuk mendukung terciptanya pelayanan keperawatan yang bermutu, aman, efektif, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan pasien.

Buku Ajar Manajemen Keperawatan disusun sebagai sumber pembelajaran bagi mahasiswa keperawatan, dosen, praktisi, serta tenaga kesehatan yang membutuhkan pemahaman komprehensif mengenai konsep, prinsip, dan penerapan manajemen dalam pelayanan keperawatan. Buku ini membahas berbagai aspek penting dalam pengelolaan pelayanan keperawatan, mulai dari mutu pelayanan, keselamatan pasien, pengendalian infeksi, manajemen sumber daya, dokumentasi, hingga akreditasi fasilitas kesehatan.

Pembahasan dalam buku ini dirancang secara sistematis agar pembaca mampu memahami peran manajerial perawat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Setiap bab menyajikan konsep dasar, penerapan dalam praktik, serta contoh kasus yang relevan dengan kondisi pelayanan keperawatan di fasilitas kesehatan. Dengan demikian, buku ini tidak hanya memberikan landasan teori, tetapi juga mendorong kemampuan berpikir kritis, analitis, dan aplikatif dalam menghadapi permasalahan manajemen keperawatan.

Bab 1 membahas manajemen mutu pelayanan keperawatan, mencakup konsep mutu, indikator mutu, standar pelayanan, serta strategi peningkatan mutu secara berkelanjutan. Bab 2 menguraikan keselamatan pasien dan manajemen risiko klinis, termasuk identifikasi risiko, pencegahan kejadian tidak diharapkan, budaya keselamatan, dan pelaporan insiden. Bab 3 menjelaskan pengendalian infeksi dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di pelayanan keperawatan sebagai upaya menciptakan lingkungan pelayanan yang aman bagi pasien, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya.

Selanjutnya, Bab 4 membahas manajemen sumber daya dan logistik keperawatan, meliputi perencanaan kebutuhan tenaga, pengaturan jadwal kerja, pengelolaan sarana, serta pemanfaatan logistik secara efektif dan efisien. Bab 5 mengkaji manajemen dokumentasi, informatika, dan rekam medis yang berperan penting dalam kesinambungan asuhan, aspek legal, komunikasi antarprofesi, serta pengambilan keputusan berbasis data. Bab 6 membahas akreditasi fasilitas kesehatan dan standar keperawatan, termasuk pentingnya kepatuhan terhadap regulasi, standar mutu, dan evaluasi pelayanan. Bab 7 menyajikan studi kasus manajerial dan proyek mini peningkatan mutu sebagai bentuk penerapan konsep yang telah dipelajari dalam situasi nyata pelayanan keperawatan.

Melalui buku ajar ini, pembaca diharapkan mampu memahami dan menerapkan prinsip-prinsip manajemen keperawatan secara profesional, etis, dan bertanggung jawab. Buku ini juga diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan kompetensi manajerial perawat untuk mendukung terciptanya pelayanan keperawatan yang bermutu, aman, efektif, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan pasien.

Penerbit:
PT OPTIMAL UNTUK NEGERI
Kencana Tower Lt. Mezzanine
Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005
Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620

ISBN 978-634-7756-74-9 (PDF)